

Primaria en Salud (APS)

Fundación Dr. Gustavo Pineda

Proyecto Autogestorado de Atención
Integral de Salud (PA.A.I.S.)

Programa de Atención Primaria en Salud (APS) Fundación Dr. Gustavo Pineda

Proyecto Autogestionado de Atención
Integral de Salud (P.A.A.I.S.)

Sistema Local de Salud
Hospital de la Misericordia
basado en la APS Dr. Gustavo Pineda

Abril 2026

PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS)
FUNDACIÓN DR. GUSTAVO PINEDA.
Proyecto Autogestionado de Atención Integral de Salud (P.A.A.I.S.).
Sistema Local de Salud Hospital de la Misericordia basado en la APS Dr. Gustavo Pineda

Coordinación general:	Dr. Franz De Armas
Autor principal:	Dr. Franz De Armas
Co-autores:	Dra. Leydis Puentes de López Dra. Ana Ebratt Tovinson Dra. Eglee Josefina Vargas Acosta Dra. Ana María Castellano Dra. Mairely Nuvárez de De Armas
Asesores:	Dra. Nelía Sánchez de Pérez Dra. Eligia Chirino Quintero
Prólogo:	Dra. Nelía Sánchez de Pérez
Corrección y estilo:	Dra. Eglee Josefina Vargas Acosta Dr. Franz De Armas Dra. Mairely Nuvárez de De Armas
Diseño, diagramación y portada:	Ediciones Astro Data, S.A. edicionesastrodata@gmail.com

© 2026. Fundación Dr. Gustavo Pineda
[\[fundapinedaoficial@gmail.com\]](mailto:fundapinedaoficial@gmail.com) [Sitio web]

ISBN 978-980-8180-00-88 (libro electrónico)
Depósito legal ZU2026000184 (libro electrónico)

Condiciones de uso: El presente programa es de acceso abierto y descarga gratuita. Se autoriza su uso, reproducción y distribución con fines académicos, científicos o de gestión sanitaria, siempre que se respete la integridad del contenido y se cite obligatoriamente la fuente original. Queda prohibida su comercialización sin autorización expresa del titular de los derechos.

Descarga disponible en: [\[Insertar URL aquí\]](#)

Cómo citar esta obra (Vancouver): De Armas Barletta FG, coordinador general; Puentes de López L, Ebratt Tovinson A, Vargas-Acosta EJ, Castellano AM, Nuvárez de De Armas, M. Programa de atención primaria en salud (APS) Fundación Dr. Gustavo Pineda. Proyecto Autogestionado de Atención Integral de Salud (P.A.A.I.S.). Sistema Local de Salud Hospital de la Misericordia basado en la APS Dr. Gustavo Pineda [Internet]. Sánchez de Pérez N, Chirino Quintero E, asesores. Maracaibo: Fundapineda; 2026. Disponible en: [\[Insertar URL aquí\]](#)

Contenido

xiii	Ficha Técnica	
xxi	Prólogo	
xxiii	Presentación	
xxv	Equipo responsable	
xxvii	Acrónimos y otras siglas	
1	Introducción	
3	1. El problema. Disponibilidad y acceso a servicios de salud	
	1.1 Situación epidemiológica	5
	1.2 Condiciones socioeconómicas y ambientales	6
	1.3 Necesidades identificadas	7
9	2. Justificación	
11	3. Fundamentos teóricos y antecedentes	
15	4. Objetivos	
	4.1 Objetivo general.	15
	4.2 Objetivos específicos.	15
17	5. Población objeto	
	5.1 Criterios de inclusión	17
	5.2 Criterios de permanencia	17
	5.3 Criterios de exclusión	17
19	6. Componentes	
	6.1 Organización y participación.	19
	6.2 Diagnóstico	20
	6.3 Planificación	21
	6.4 Promoción	22
	6.5 Prevención	23
	6.5 Asistencia médico-sanitaria.	24

25	7. Estrategia de intervención	
	7.1 Territorialización	28
	7.2 Organización funcional	30
	7.3 Censo socio sanitario y ficha familiar	31
	7.4 Historia clínica personal	31
	7.5 Tamizaje	31
	7.6 Diagnóstico grupal de salud	31
	7.7 Plan de salud	32
	7.8 Promoción	32
	7.9 Prevención	34
	7.10 Educación e información para la salud	35
	7.11 Rehabilitación y prevención secundaria	35
	7.12 Asistencia médica primaria	35
	7.13 Atención pre hospitalaria y el traslado de pacientes	36
	7.14 El registro electrónico de datos	36
37	8. Sistema y operacionalización de variables	
49	9. Costos	
51	10. Análisis	
	10.1 Análisis económico- administrativo	51
	10.2 Análisis organizativo	51
	10.3 Análisis legal	52
	10.4 Análisis de sensibilidad	52
	10.5 Análisis de sostenibilidad	53
55	11. Monitoreo y evaluación	
59	12. Bibliografía	
65	ANEXOS	
	1. Manifestación de adscripción voluntaria familiar al Programa Autogestionado de Atención Integral de Salud (P.A.A.I.S.)	68
	2. Ficha social de salud	70
	3. Tabulador de ficha social de salud	73
	4. Tabla de códigos de ficha social de salud. Características del grupo familiar	84
	5. Modelo de historia clínica	90
	5.1-. Consentimiento Informado	91
	5.2-. Historia Clínica General	92
	5.3-. Historia Psicosocial	98
	5.4-. Evaluación y Seguimiento del Paciente	99
	5.5-. Hoja de Egreso	100
	6. Hojas de trabajo	102
	6.1-. Consulta	102
	6.2-. Solicitud de Biopsia	103

6.3-. Solicitud de Exámenes de Emergencia.	104
6.4-. Solicitud de Parasitología	105
6.5-. Solicitud de Perfil 20	106
6.6-. Solicitud de Bioquímica Sanguínea	107
6.7-. Radiodiagnóstico	108
6.8-. Solicitud de Uroanálisis.	109
7. Matriz de tamizaje basada en “Recommendations for Preventive Services in Primary Care” y “Screening guidelines for disease prevention”.	111
7.1-. Plan de despistaje preventivo para pacientes menores de 1 año del P.A.A.I.S., según el USPSTF	111
7.2-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 1-4 años del P.A.A.I.S., según el USPSTF	112
7.3-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 5-9 años del P.A.A.I.S., según el USPSTF	113
7.4-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras, del P.A.A.I.S., según el USPSTF	114
7.5-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF . . .	118
7.6-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF	122
7.7-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF.	124
7.8-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF.	127
7.9-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF . . .	134
7.10-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF.	141
7.11-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF.	147
7.12-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF.	153
7.13-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF . . .	160
7.14-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF.	167
7.15-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF . . .	172
7.16-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF.	177

7.17-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF . . . 185

7.18-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF. 193

7.19-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF . . . 202

7.20-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF. 211

7.21-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF . . . 218

7.22-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF. 229

7.23-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF. 238

7.24-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF. 247

7.25-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF . . . 257

7.26-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF. 267

7.27-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF . . . 279

7.28-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años femeninas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF 291

7.29-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años femeninas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF 301

7.30-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años femeninas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF 311

7.31-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años femeninas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF. 323

7.32-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años femeninas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF 336

7.33-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años femeninas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF 346

7.34-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años femeninas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF 357

7.35-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años femeninas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF 365

7.36-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años femeninas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF 374

7.37-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años femeninas, sexualmente activas y fumadoras, del P.A.A.I.S. según el USPSTF 382

7.38-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años femeninas, sexualmente no activas y no fumadoras, del P.A.A.I.S., según el USPSTF 390

7.39-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años femeninas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según EL USPSTF 396

7.40-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 402

7.41-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 405

7.42-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 408

7.43-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 410

7.44-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 412

7.45-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 417

7.46-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 422

7.47-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 426

7.48-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 430

7.49-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 436

7.50-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 442

7.51-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 447

7.52-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 452

7.53-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 460

7.54-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF 469

7.55. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF	476
7.56. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF	483
7.57-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF	490
7.58-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF	498
7.59-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF	504
7.60-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF.	511
7.61-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF	516
7.62-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF	521
7.63-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF.	525
8. Planes específicos de prevención y control de enfermedades	530
8.1-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan ampliado de inmunizaciones	530
8.2-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención a lactantes y preescolares	534
8.3-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención al escolar . . .	535
8.4-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan de atención a adolescentes	536
8.5-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención al adulto . . .	537
8.6-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención al adulto mayor .	538
8.7-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención materno-neonatal.	539
8.8-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de planificación familiar .	540
8.9-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad	543
8.10-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de enfermedades infecto-contagiosas (salmonelosis, brucelosis, hepatitis, EDA)	547

8.11-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de enfermedades crónicas (ETS/VIH/SIDA, enfermedades respiratorias -EPOC, TB, AB-, enfermedades cardiovasculares -HTA, ICC, arritmias, enfermedad vascular periférica-, enfermedad renal crónica, enfermedades hematológicas -anemias, linfomas, leucemia-, enfermedades autoinmunes -lupus, artritis reumatoide- 548

8.12-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de enfermedades neoplásicas (Ca de mama, Ca de cuello cérvico-uterino, próstata) 549

8.13-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo para el manejo y control de las zoonosis (rabia, leptospirosis, accidentes ofídicos) 553

8.14-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de accidentes y hechos violentos. 555

8.15-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de enfermedades tropicales (chagas, dengue, malaria, paludismo, toxoplasmosis) 557

8.16-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de infecciones por coronavirus. 558

8.17-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y manejo de la salud mental 561

8.18-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y manejo de la salud bucal. 562

8.19-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y manejo de adicciones. 564

8.20-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control nutricional 565

8.21-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de salud ambiental 566

8.22-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de los trastornos del neurodesarrollo. 568

8.23-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan de prevención, diagnóstico y manejo precoz de la sepsis 570

8.24-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención a la ciudadanía 573

8.25-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan rehabilitación y prevención secundaria 581

583 Bibliografía (Anexo 8)

Índice de tablas

Tabla 1 Grupos etarios a ser atendidos por el programa de APS, en el SILOS, por Grupos Etarios y Sexo, según la pirámide poblacional de Venezuela 2013	29
Tabla 2 Pacientes esperados en programa de APS de Fundapineda por Grupos Etarios Ampliados, según la pirámide poblacional de Venezuela 2013	29
Tabla 3 Grupos etarios a ser atendidos por el programa de APS, en una ZIS, por Grupos Etarios y Sexo, según la pirámide poblacional de Venezuela 2013	30
Tabla 4 Costo en personal del programa, según tipo de personal	49
Tabla 5 Costo de recursos materiales del programa por renglones y porcentaje	50
Tabla 6 Costo de recursos materiales del programa.	50
Tabla 7 Costo total del programa por renglones y porcentaje.	50

Índice de figuras

Figura 1	
Pirámides poblacionales de la República Bolivariana de Venezuela, años 2000 y 2024.....	5
Figura 2	
Axioma de Kerr White.	11
Figura 3	
Sectorización de la ciudad de Maracaibo.	28
Figura 4	
Pacientes esperados en el Programa de APS de Fundapineda por Grupos Etarios, según la pirámide poblacional de Venezuela 2013.....	29
Figura 5	
Pacientes esperados en el Programa de APS de Fundapineda por Grupos Etarios Ampliados, según la pirámide poblacional de Venezuela 2013.....	30
Figura 6	
Organización funcional del Sistema Local de Salud Hospital de la Misericordia, basado en la APS Dr. Gustavo Pineda.	31

Índice de cuadros

Cuadro 1
Elementos a desarrollar por capítulos 33

Cuadro 2
Componentes del plan de acción 33

Cuadro 3
Ejemplo de un plan de promoción de salud 34

Cuadro 4
Operacionalización de unidades de análisis 38

Cuadro 5
Matriz de riesgos y escenarios proyectados 53

Cuadro 6
Indicadores del modelo. 56

Cuadro 7
Síntesis del plan operativo aplicado al programa. 56

Cuadro 8
Matriz de control y evaluación del programa 57

Ficha Técnica

Propósito

Brindar atención integral biopsicosocial y espiritual de salud a las familias asociadas al SILOS, con base en estrategias de participación, promoción, prevención, educación y autorresponsabilidad. Esto se realizará mediante la oferta de servicios de atención primaria dignos, eficientes, eficaces, perfectibles y sostenibles en el ámbito personal. La articulación con la atención hospitalaria de moderada y alta complejidad permitirá ampliar la calidad de vida, felicidad, bienestar y longevidad de los usuarios. De este modo, se busca incrementar la productividad y la armonía social.



Población objetivo

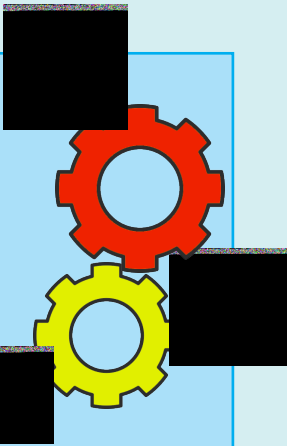


Individuos que conformarían el “SILOS Hospital de la Misericordia basado en la APS, Dr. Gustavo Pineda” (300.000 personas o 60.000 familias) que hayan manifestado disposición a sumarse a su proyecto de salud.

Programa de Atención Primaria en Salud (APS) de la Fundación Gustavo Pineda

Componentes Principales

- Territorialización.
- Organización y participación.
- Diagnóstico.
- Planeación.
- Promoción.
- Prevención.
- Asistencia médico-sanitaria primaria.



Instituciones Responsables

- FUNDAPINEDA.
- Empresa Social de Salud.
- Universidad del Zulia.
- Sistema Regional de Salud.
- MPPS.
- Organizaciones no gubernamentales.
- Organismos multilaterales.

Instituciones vinculantes

Cobertura Geográfica



Maracaibo,
Estado Zulia
República Bolivariana
de Venezuela.

Programa de Atención Primaria en Salud (APS) de la Fundación Gustavo Pineda



Recursos Necesarios



Unidades Básicas de APS (UBAPS):
1 Médic@ general
1 Enfermer@
1 Promotor(a) social.

Unidades Integrales de APS (UIAPS):
UBAPS + Odontólog@,
Médic@ Veterinari@,
Psicólog@ o Psiquiatra.

Ambas unidades con apoyo de consulta médica especializada. Esto corresponde a cada una de las unidades que se replican en la totalidad del sistema, de acuerdo al número de familias que se inscriben en el programa.

Botiquines.



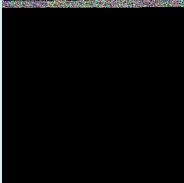
Software.



Material educativo.



Medios de transporte.



Marco Normativo

- CRBV (Art. 83-85).
- Ley Orgánica de Salud.
- Declaración de Alma-Ata y Astana.
- Planes Nacionales de Salud vigentes.
- ODS 3: Salud y bienestar.
- Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Programa de Atención Primaria en Salud (APS) de la Fundación Gustavo Pineda

Financiamiento



- Capital semilla aportado por asociados.
- Recursos producto de venta de servicios.
- Transferencias o créditos de entes públicos o privados locales, regionales nacionales o internacionales.
- Apoyo técnico de OPS/OMS + cooperación con organizaciones humanitarias (UNICEF, ACNUR, Cruz Roja).
- Articulación con alcaldías/comunidades organizadas.
- Cuotas mínimas de financiamiento de los adscritos al programa.

Cronograma por Fases

Fase	Año	Objetivos Clave	Indicadores
1	Año 1	Organización, diagnóstico, inicio de servicios	100% geo-referenciación, 25% asociación familiar
2	Año 2	Expansión de servicios y convenios	100% aplicación del plan de salud
3	Año 3	Consolidación del SILOS	100% funcionamiento según Kerr White
4	Año 4	Evaluación y ajustes	80% satisfacción de usuarios

Programa de Atención Primaria en Salud (APS) de la Fundación Gustavo Pineda



Programa de Atención
Primaria en Salud (APS)
de la Fundación Gustavo
Pineda

Indicadores
Esperados

- 100% de familias ubicadas catastral y geo-referencialmente.
- 25% de asociación familiar.
- 100% de equipos y estructuras funcionales para población asociada.
- 100% de familias censadas y 100% de fichas familiares realizadas.
- 100% de historias clínicas personales realizadas.
- 100% de tamizaje realizado.
- 100% de DSS realizado.
- 100% de plan de salud elaborado.
- 50% de aplicación de los planes de promoción, prevención, educación e información, rehabilitación y prevención secundaria.
- 100% de consultas médicas primarias domiciliarias realizadas.
- 50% de la capacidad de atención prehospitalaria y traslado apropiado de pacientes.
- Satisfacción en 20% de la demanda de servicios en micro hospital.
- 100% de recopilación y almacenamiento de datos.
- 20% de la capacidad de comercialización.
- Realización de convenio con al menos un ente regional, nacional, internacional y multilateral.
- Realización de convenios que cubran al menos 20% de requerimientos financieros funcionales.

FASE 1

Objetivos
Clave

- Delimitación geográfica y demográfica.
- Organización funcional.
- Asociación de familias.
- Recopilación de información detallada.
- Diagnóstico grupal de salud (DSS).
- Formulación de plan de Salud.
- Inicio de promoción de la salud
- Inicio de prevención en todos sus niveles.
- Inicio de educación e información para la salud.
- Inicio de rehabilitación y prevención secundaria.
- Inicio de consultas médicas primarias.
- Inicio de atención prehospitalaria y el traslado apropiado de pacientes hacia otros centros asistenciales.
- Recopilación y almacenamiento de datos.
- Inicio de venta de servicios al mercado local de salud.
- Realización de convenios inter institucionales.

Programa de Atención Primaria en Salud (APS) de la Fundación Gustavo Pineda

FASE 2

- Avance en un 50% del plan de salud local, respecto al año anterior.
- Inicio de consultas especializadas.
- Inicio de servicio de atención pre hospitalaria y traslado de pacientes.
- Inicio de servicios brindados en micro hospital del SILIOS.
- Totalización de organización funcional.
- Totalización de asociación de familias.
- Totalización de información detallada.
- Totalización de recopilación y almacenamiento de datos.
- Ampliación de venta de servicios al mercado local de salud.
- Ampliación de convenios inter institucionales.

Objetivos Clave

Indicadores Esperados

- 100% del plan de salud aplicado.
- 100% de asociación familiar.
- 100% de equipos y estructuras funcionales para población asociada.
- -100% de nuevas familias censadas y 100% de nuevas fichas familiares realizadas.
- 100% de nuevas historias clínicas personales realizadas.
- 100% de nuevo tamizaje realizado.
- 100% de nuevo DSS realizado.
- 100% de aplicación de los planes de promoción, prevención, educación e información, rehabilitación y prevención secundaria.
- 100% de consultas médicas primarias domiciliarias y especializadas, de consultorio realizadas.
- 100% de la capacidad de atención prehospitalaria y traslado apropiado de pacientes.
- Satisfacción en 50% de la demanda de servicios en micro hospital.
- 100% de recopilación y almacenamiento de datos.
- 50% de la capacidad de comercialización.
- Ampliación de al menos 100 de los convenios de asociación realizados el año previo.
- Realización de nuevos convenios que cubran al menos 50% de requerimientos financieros funcionales.

Programa de Atención Primaria en Salud (APS) de la Fundación Gustavo Pineda

FASE 3

Objetivos Clave

- Avance en un 100% del plan de salud local, respecto al año anterior.
- Consolidación de consultas generales y especializadas.
- Consolidación de servicio de atención pre hospitalaria y traslado de pacientes.
- Consolidación de servicios brindados en micro hospital del SILOS.
- Consolidación de organización funcional.
- Consolidación de asociación de familias.
- Consolidación de sistema de información, recopilación y almacenamiento de datos.
- Ampliación de venta de servicios al mercado local de salud al 100%.
- Ampliación de convenios interinstitucionales al 80%.

Indicadores Esperados

- 100% de funcionamiento del SILOS conforme al axioma de Kerr White.
- 100% del plan de salud aplicado.
- 100% de consultas médicas primarias domiciliarias y especializadas, de consultorio realizadas.
- 100% de la capacidad de atención prehospitalaria y traslado apropiado de pacientes.
- Satisfacción en 100% de la demanda de servicios en micro hospital.
- 100% de la capacidad de comercialización.
- 100% de los convenios de asociación requeridos.
- 60% de requerimientos financieros funcionales cubiertos por convenios de asociación.

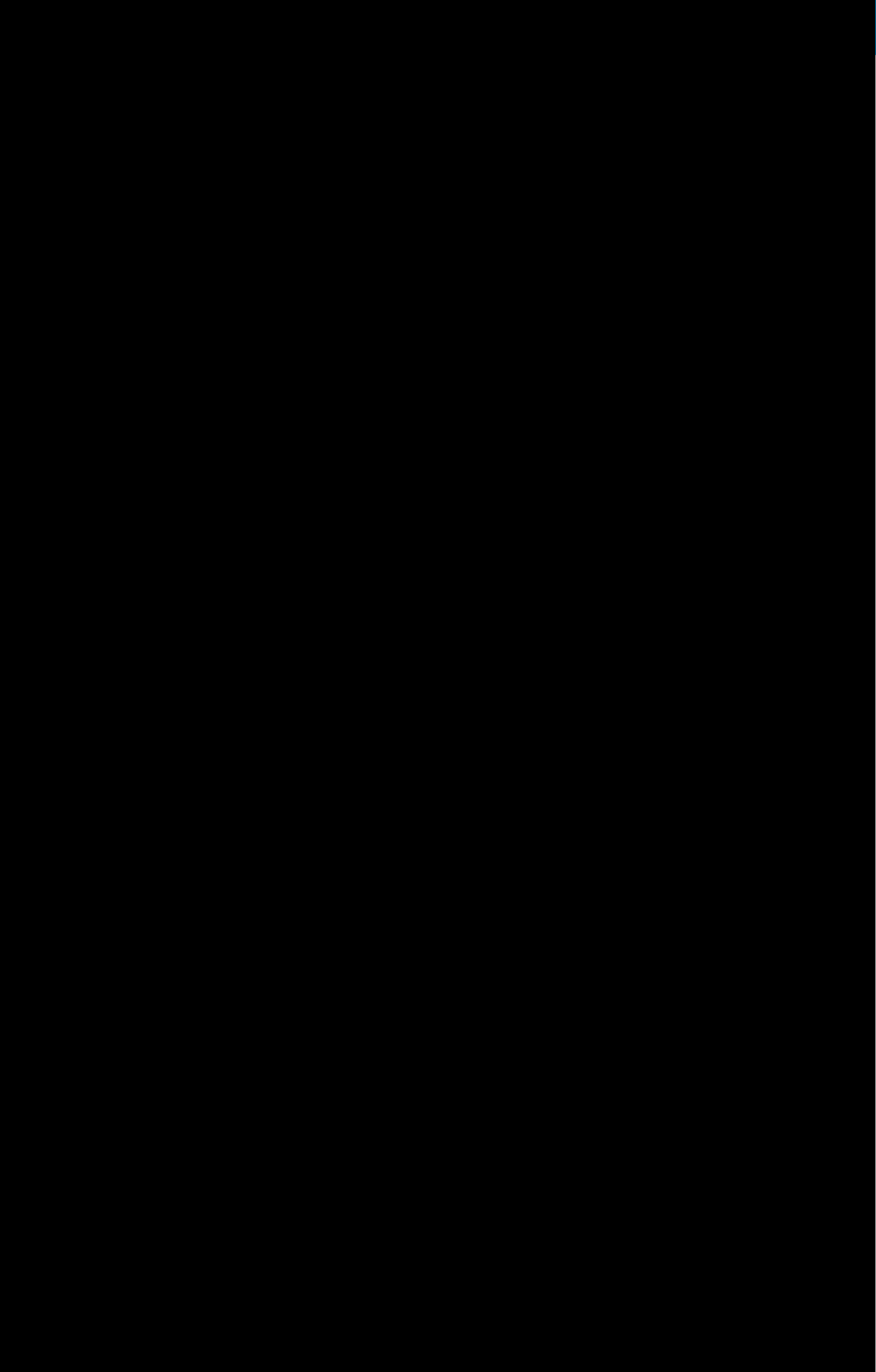
FASE 4

Objetivo Clave

Evaluación del programa, ajustes, formación continua y fortalecimiento de redes funcionales.

Indicadores Esperados

- 80% de satisfacción de usuarios.
- 80% reducción de hospitalizaciones evitables



Prólogo

Desde su enunciado en el contexto de la Convención de Almata en 1978, la atención primaria en salud (APS) ha tenido una trayectoria tortuosa determinada por acontecimientos geopolíticos, económicos, y de variaciones en las políticas públicas de las naciones que han impedido, en líneas generales, que su meta de salud para todos no haya sido alcanzada; sin embargo, por contener valores supremos como la preponderancia en la prevención, la organización y el empoderamiento ciudadano, características que definen su naturaleza y mantienen en plena vigencia la indicada estrategia de atención, la APS obtiene mayor relevancia en naciones con poblaciones vulnerables como las nuestras, por cuanto las crisis estructurales sostenidas imposibilitan la existencia de recursos suficientes para la resolución de los problemas de salud, planteando como opción la organización ciudadana en la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria.

Es en ese sentido de significativa importancia, desde la participación cívica, que en el estado

Zulia un grupo de ciudadanos propongan el proyecto de salud Hospital de la Misericordia Dr. Gustavo Pineda, cuya visión organizativa es la conformación de un Sistema Local de Salud con base fundamental en un robusto programa de APS que garantice a una gran mayoría de la población mantenerse saludable y donde solo una minoría deba afrontar circunstancias de morbilidad, morbimortalidad y siniestralidad.

Desde mi experiencia como sanitarista y formadora de profesionales de la salud, estoy firmemente convencida de que los retos que afrontamos hoy en Venezuela requieren el enfoque que se propone en este manual. Este programa de atención primaria constituye un esfuerzo valioso donde se han revisado tanto experiencias a nivel global como los documentos oficiales emanados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); del mismo modo, se han tomado en cuenta las experiencias que se han llevado a cabo en el contexto

venezolano. Un aporte importante lo constituye la sistematización del proceso de atención básica preventiva integrándola a procedimientos de alta complejidad como lo es el tamizaje.

El equipo de personas que constituyen la comisión que ha elaborado a lo largo de casi dos años este documento es de un valor incalculable. Está conformado por profesores universitarios en distintas áreas, especialmente en las sociales, y por médicos especialistas de alto nivel. Por otra parte, los lectores de esta publicación tendrán la oportunidad de disponer de una guía de acción para que su trabajo sea de impacto en la salud integral. Además, la comunidad científica dispondrá de un espacio para la investigación constante a partir de la información que arrojen los indicadores seleccionados de los diversos instrumentos que el programa ofrece.

Sin duda alguna, la propuesta del Sistema de Salud Hospital de la Misericordia Dr. Gustavo Pineda, el Proyecto Autogestionado de Atención Integral de Salud y el Programa de Atención Primaria debe tomarse en

cuenta para replicarse a gran escala, permitiendo la integración operativa desde abajo hacia arriba en un poderoso sistema nacional de salud en Venezuela y al mismo tiempo, constituirse en una

referencia para la salud pública latinoamericana y mundial. Recordemos que: **TODOS SOMOS SOCIOS EN NUESTRA SALUD.**

Nuestros deseos permanentes en el tiempo para todos los participantes

en el camino del éxito y con bondades y bendiciones de la Providencia en este tan loable proyecto: “Fundación Dr. Gustavo Pineda, Hospital de la Misericordia”, muy especialmente a su creador Dr. Franz De Armas.

Dra. Nelia Sánchez

Docente e Investigadora de la Universidad del Zulia (LUZ) y comprometida con la salud pública.

Presentación

El Programa de Atención Primaria en Salud (APS) del Sistema Local de Salud del Hospital de la Misericordia “Dr. Gustavo Pineda” constituye uno de los cinco componentes del Proyecto Autogestionado de Atención Integral de Salud (P.A.A.I.S.), el cual comprende cinco programas: APS, Atención Pre Hospitalaria y Traslado de Pacientes, Atención Hospitalaria, Rehabilitación-Prevención Secundaria y Cuidados Paliativos. Su elaboración ha estado a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales comprometidos con una visión integradora de la salud, centrada en el ser humano y orientada por el principio del derecho universal a una atención digna, equitativa y continua.

Este programa asume la APS como la estrategia central para organizar los servicios de salud en torno al primer nivel de atención, garantizando accesibilidad, resolutivez y participación comunitaria. En tal sentido, se inspira en los postulados de Keer White, que resaltan la racionalidad en la distribución del esfuerzo sanitario, así como en

el modelo de niveles de prevención desarrollado por Leavell y Clark, que amplía la mirada del sistema más allá de lo asistencial, hacia lo promocional y lo preventivo.

Bajo esta perspectiva, el programa se estructura en torno a los cinco niveles de prevención: la promoción de la salud y la protección específica e inespecífica, de modo de fortalecer las capacidades individuales y colectivas para el autocuidado y la prevención de enfermedades; la detección precoz y tratamiento oportuno, a los efectos de interrumpir tempranamente el curso natural de las patologías; la limitación del daño, mediante intervenciones terapéuticas eficaces y seguras y la rehabilitación integral, para favorecer la recuperación funcional y la reinserción social de las personas afectadas.

Como elemento novedoso se agregan en el proyecto los cuidados paliativos a los fines de ampliar la atención integral más allá de los parámetros actuales, incluyendo aquellas situaciones en las cuales

la medicina no puede ofrecer opciones curativas y se demanda minimizar el sufrimiento y permitir una muerte digna.

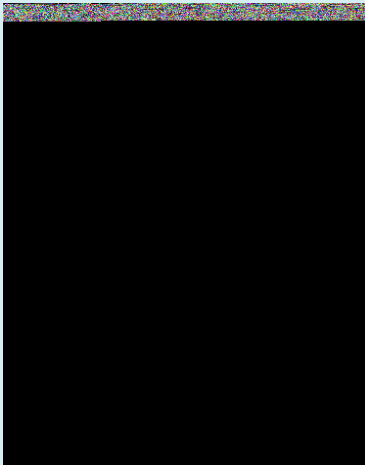
La implementación del programa prioriza acciones comunitarias, intersectoriales y participativas, con énfasis en la atención domiciliaria, la educación para la salud, la vigilancia epidemiológica activa y la articulación con redes sociales e institucionales. Se busca así construir una APS resolutivez, centrada en las personas, culturalmente pertinente, adaptada a las realidades de cada territorio, y garantizar todos los principios de la práctica sanitaria, especialmente el de la universalidad.

En resumen, este documento representa una apuesta concreta por un modelo de salud orientado a la equidad, la eficiencia y la prevención, en el marco de un sistema sanitario que reconozca a la atención primaria como puerta de entrada, eje articulador y garante de continuidad en el cuidado integral de la salud de la población.

Dr. Franz De Armas
Coordinador General
Vice Presidente de FundaPineda



Equipo responsable



Franz G. De Armas Barletta

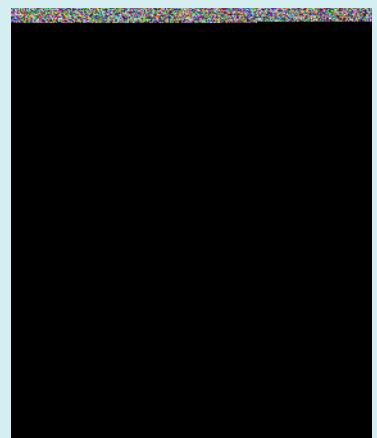
Médico Cirujano, Especialista en Medicina Interna, Especialista en Medicina Crítica, Abogado, Economista, Máster en Gerencia Pública, Candidato, Ex director del Sistema Regional de Salud del Estado Zulia/Venezuela. Articulista en el área de Salud Pública y otros temas. Actualmente ejerce como Médico Adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Maicao, Departamento de la Guajira, Colombia. franzdearmas0@gmail.com

Leydis Puentes de López

Doctora en Medicina de la Universidad de La Habana. Especialista en primer grado en Medicina familiar. Máster en Medios Diagnósticos, mención Gastroenterología. Médico cirujano de la Universidad Francisco de Miranda. Medicina Biológica integrativa y Ozonoterapia. Especialista en Estética facial y corporal. lpuentes3071@gmail.com

Ana María Ebratt Tovinson

Médica egresada de la Universidad del Zulia, con 35 años de experiencia en la Atención Primaria en Salud: Médico Interno en Hospital de Machiques. Médico jefe del Ambulatorio La Pastora. Médico Interno en el Hospital Manuel Noriega Trigo. Médico Supervisor del Impas de los Profesores del IPSIUTM. Médico II en Ambulatorio Panamericano. Médico Coordinador de los Servicios médicos UPTMA. ebratttovinson@gmail.com



Eglee Josefina Vargas Acosta

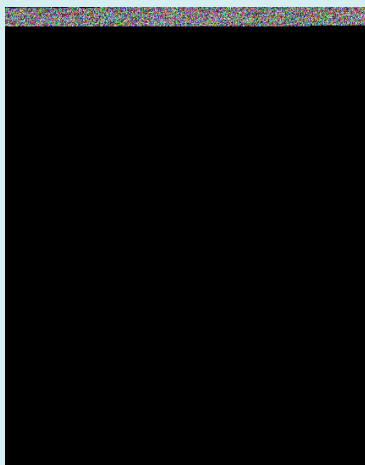
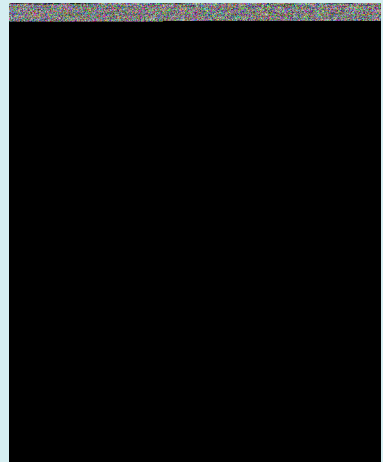
Licenciada en Trabajo Social. Maestría en Ciencias, mención Orientación en Sexología. Doctora en Ciencia Política. Docente Universitaria. egleevargasacosta@gmail.com

Ana María Castellano

Licenciada en Trabajo Social, magíster en Educación y doctora en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia (LUZ), con diplomado en Investigación Cualitativa y en Mindfulness y Terapias basadas en la Atención Plena.

Docente e investigadora de la escuela de Trabajo Social y miembro del Comité Académico de la Maestría en Intervención Social de LUZ. Autora de libros y artículos científicos arbitrados. Premio a la investigación: Andrés Bello y Francisco Eugenio Bustamante.

castellano.anamaria@gmail.com



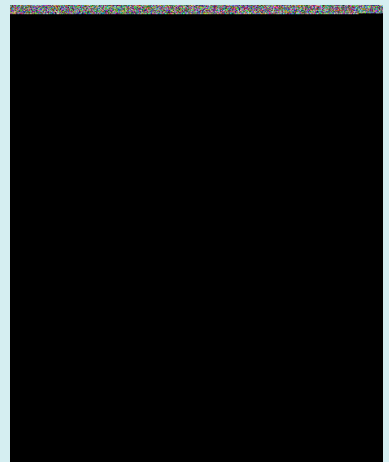
Mairely Nuvárez de De Armas

Licenciada en Trabajo Social, Magister en Intervención Social, Doctora en Ciencia Política de la Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo, Venezuela. Experiencia profesional en diversas áreas entre ellas salud cardiovascular y programas comunitarios en la Gerencia Pública. Docente titular de LUZ, donde se ha desempeñado en diversos cargos como Secretaria Docente (2010-2015), miembro de la Comisión de Currículo de pregrado (2014) y posgrado de Maestría en Intervención Social (2021-2014), y Coordinadora de la Maestría en Intervención Social (2017-2024).

mairelynuvarez@gmail.com

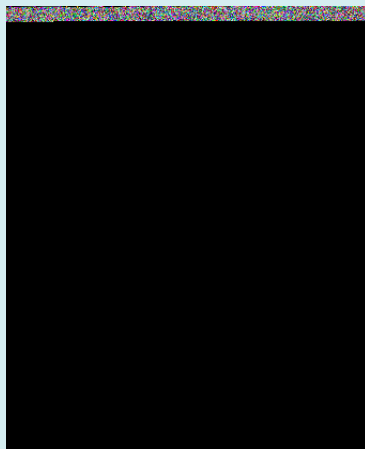
Nelia Sánchez de Pérez

Doctora en Ciencias Médicas. Doctora en Ciencias, mención Investigación. Máster en Administración del sector Salud mención Epidemiología. Profesora Titular Emeritus de la facultad de Medicina con 30 años de servicio. Profesora de Metodología de la investigación de la División de estudios para graduados desde hace 20 años hasta la actualidad. Consejera del consejo de la facultad de Medicina desde hace 15 años. neliasanchez@hotmail.com



Eligia Chirino Quintero

Médico cirujano, Especialista en Psiquiatría, Estudios en Psicoanálisis, Certificaciones de Psicoterapeuta por la Asociación Venezolana de Psicoterapia y Certificación Latinoamericana de Psicoterapia. Voluntaria de la Cruz Roja en actividades clínicas, docencia e investigación. Directora (E) del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo (1996/1997). Profesora Emérita de la Facultad de Medicina de LUZ. Asesora del Diplomado de Iniciación en Psicoterapia en la Universidad Rafael Belloso Chacín (2026). Investigadora responsable ante el Consejo Científico y Humanístico (CONDES) de LUZ del Trabajo Psicoanálisis y Literatura. Presidenta del Capítulo Zuliano de Psicoterapia Avepsi. eligiachirinoq@gmail.com



Acrónimos y otras siglas

APHA	Asociación Americana de Salud Pública.	ICC	Insuficiencia Cardíaca Congestiva.
APS	Atención Primaria en Salud.	IMC	Índice de Masa Corporal.
ASAM	Ambulancia de Soporte Avanzado Medicalizado.	ITS	Infecciones de Transmisión Sexual.
ASBPM	Ambulancia de Soporte Básico Paramédico.	MPPS	Ministerio del Poder Popular para la Salud.
CA	Carcinoma.	OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
CAPS	Centros de Atención Primaria de Salud.	ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CAS	Centros de Atención Secundaria.	OMS	Organización Mundial de la Salud.
CDC	Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (EE. UU.).	OPS	Organización Panamericana de la Salud.
CRBV	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.	PAAIS (P.A.A.I.S.)	Programa Autogestionado de Atención Integral de Salud.
DSS	Diagnóstico Situacional de Salud.	PCI	Prevención y Control de Infecciones.
EDA	Enfermedad Diarreica Aguda.	SAPH	Servicio de Atención Prehospitalaria.
ENT	Enfermedades No Transmisibles.	SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
EPS	Equipo de Promoción de Salud.	SILOS	Sistemas Locales de Salud.
HTA	Hipertensión Arterial.		

SPHTP

Sistema de Atención Prehospitalaria y Traslado de Pacientes.

TB

Tuberculosis.

UIAPS

Unidades Integrales de Atención Primaria en Salud.

UBAPS

Unidades Básicas de Atención Primaria en Salud.

USPSTF

Grupo de Tarea de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (*U.S. Preventive Services Task Force, siglas en inglés*).

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana.

ZIS

Zonas Integrales de Salud.

Introducción

La salud es el bien máspreciado y la principal necesidad de todo ser humano, por cuanto es esencial para realizar cualquier actividad. Su concepto ha evolucionado con el tiempo, desde una percepción mágico-religiosa, hasta un enfoque científico, social y político, cuya garantía ha pasado a ser responsabilidad del Estado y de la sociedad organizada ⁽¹⁻⁴⁾.

El garantismo en salud fue parte de la estrategia del estado benefactor que emergió después de la Segunda Guerra Mundial. Así, la salud se consolidó como un derecho humano fundamental, reconocido en la mayoría de las constituciones del mundo ⁽⁵⁾. En el caso venezolano, este derecho ha sido consagrado en las constituciones vigentes desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la Carta Magna de 1961 y en la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual establece en sus artículos 83 al 85 que la salud es un derecho social fundamental, vinculado al derecho a la vida, bajo la rectoría del estado, regulado, además, por la Ley Orgánica de Salud (1998) y los tratados y convenios internacionales suscritos por Venezuela, en el marco de

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos multilaterales. Esta debe ser garantizada en consecuencia, a través de un sistema público nacional, intersectorial, descentralizado, participativo y articulado al sistema de seguridad social. Este sistema debe regirse por principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad, con prioridad en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, y con obligación estatal de asegurar su financiamiento.

En conjunto, este marco otorga plena legitimidad a un programa orientado a garantizar el acceso justo a la salud, fomentar la corresponsabilidad individual y comunitaria en el autocuidado, fortalecer la prevención y detectar tempranamente enfermedades, canalizando solo los casos que lo ameriten hacia la atención hospitalaria especializada.

En este contexto, el presente Programa de APS se propone como un instrumento estratégico para la consolidación del derecho a la salud en el ámbito local. Se sustenta en un enfoque holístico y dinámico, integrador de los postulados de Keer L.

White y Leavell y Clark ⁽⁶⁻⁸⁾. El programa se alinea también con los principios de la Declaración de Alma-Ata (1978), que definió la APS como la asistencia sanitaria esencial, accesible a todas las personas y familias de la comunidad, mediante su plena participación, con un costo asumible para la sociedad y el país, constituyéndose como núcleo del sistema nacional de salud y parte integral del desarrollo socioeconómico ⁽⁹⁾.

Con su implementación, se espera reducir la carga de enfermedades evitables, disminuir la mortalidad (especialmente la materno infantil), prolongar la longevidad saludable de la población contribuyendo a una mayor equidad social, felicidad colectiva y productividad nacional.

1. El problema.

Disponibilidad y acceso a servicios de salud

Venezuela tuvo un excelente sistema de salud público entre las décadas de los sesenta y ochenta del siglo pasado. El desaparecido Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), desarrolló en sus inicios una adecuada política sanitaria, que condujo a importantes logros para el país. Gracias a un ejército de sanitaristas encabezados por el Dr. Arnoldo Gabaldón, la mayoría de las epidemias recurrentes del siglo XIX fueron erradicadas, a través de programas de fumigación, suministro de agua potable y construcción de letrinas y viviendas rurales. Igualmente se diseminó la construcción de Ambulatorios, en los cuales se ejecutó la APS, mucho antes de que ésta fuera enunciada por la OMS en 1978 y finalmente se construyó una amplia red de hospitales, que garantizaron la oferta de cerca de 3 camas de hospitalización por cada mil habitantes, tal y como sucede en los países de desarrollo medio.

En 1956 Venezuela fue reconocida por la OMS como el primer país en erradicar la viruela y en 1961, el paludismo en 2/3 partes del territorio nacional. Sus servicios de salud llegaron a ser tomados como referencia mundial para la década de los sesenta del siglo pasado.

No obstante, a partir de ese momento, el concepto global del estado de bienestar comenzó a resquebrajarse, debido a la crisis que desencadenó la elevación de los precios de los productos energéticos en la mayoría de los países europeos, lo que condujo a la necesidad de aplicar políticas de ajustes del gasto público social para contener la inflación y reducir el déficit del estado ⁽⁵⁾.

Estos nuevos enfoques comenzaron a ser aplicados en Venezuela, desde mediados de los años 80, toda vez agotado el boom

petrolero ocasionado por la guerra árabe-israelí de los sesenta y siete, lo cual tuvo su repercusión en la salud, como una de las áreas de gestión pública. Los indicadores positivos exhibidos en las dos décadas previas, comenzaron a deteriorarse progresivamente a partir de medidas asociadas al manejo de la crisis fiscal recién iniciada y a los ajustes neoliberales implementados durante los años siguientes.

La década de los 90 estuvo también impactada por la regencia de los centros de salud por fundaciones impulsadas por algunos de sus miembros, en la intención de permitir la funcionalidad de los mismos, pero lamentablemente, en muchos casos devino en una cuasi privatización, debido a la imposición de tarifas y cobro directo, lo que terminó por limitar aún más el acceso a los mismos a los sectores mayoritarios y más desposeídos de la población.

Se inició así una crisis sanitaria continua, que se ha expresado en el deterioro sostenido en la salud de los venezolanos, con un continuo déficit presupuestario, insuficiencia en la dotación de insumos y materiales, gran conflictividad laboral, deterioro de las instalaciones, falta de equipos u obsolescencia de los mismos, cierre de servicios y serios problemas de infraestructura; todos los cuales se han cronificado. Ha habido, en fin, una evidente pérdida de la calidad en la atención sanitaria a la población, inaccesibilidad a dichos servicios y una marcada insatisfacción de la demanda.

Los cambios políticos ocurridos en los 90 devinieron en la aprobación de una nueva constitución que reafirmó el garantismo en salud. Bajo dicho enfoque, se refaccionó y dotó de equipos, material y medicamentos a la mayoría de los hospitales y se creó

la llamada misión Barrio Adentro, que a partir del año 2003 creó Módulos de Medicina Integral Comunitaria, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y Salas de Rehabilitación Integral (SRI), junto con la atención en masa, tanto en la República de Cuba como en nuestro país de centenares de pacientes quirúrgicos, a través de la llamada Misión Milagro, todo lo cual mejoró sustancialmente la situación.

No obstante, a partir del año 2013 la situación económica nacional vuelve a tornarse crítica, debido a la caída de las exportaciones y los precios petroleros, lo cual causa una marcada escasez de divisas, caída de las importaciones, espiral hiperinflacionaria y devaluación sostenida de nuestro signo monetario, lo que junto a la impericia, malas prácticas de gestión y corrupción administrativa, anulan el efecto de las mejoras recientes y generan un deterioro hacia estadios peores a los presentados durante las décadas de los 80-90.

Debido a la disminución marcada de las condiciones de trabajo, sobre todo, la precarización salarial, comienza adicionalmente desde ese momento una emigración progresiva y cada vez más acentuada de personal sanitario calificado, especialmente médicos y enfermeras, hacia otras naciones de la región y el mundo, lo que condujo a una mínima expresión la disposición y oferta de este recurso para el país.

A partir del año 2016 se suman las medidas producto del bloqueo y restricciones contra el gobierno nacional impuestas por la administración estadounidense y finalmente, en el año 2020 aparece la pandemia del virus SARS-CoV2 cuyos impactos parecen tener un efecto mucho más devastador sobre este país, dado las grandes vulnerabilidades del sistema, la terrible crisis económica y las tensiones políticas.

Actualmente la red de atención primaria y ambulatoria se encuentra prácticamente afuncional, no existe un sistema de atención prehospitalario y traslado adecuado de pacientes. La red hospitalaria está totalmente deteriorada, sin dotación de medicamentos, reactivos y material médico quirúrgico, el parque de equipos diagnósticos-terapéuticos es casi inexistente, las edificaciones totalmente desatendidas e insalubres, faltan los recursos humanos y existe un déficit de camas de hospitalización que supera las 70000 unidades y aproximadamente 15000 camas de cuidados intensivos, con éstas últimas, que no superan las 100 unidades en todo el territorio nacional.

El déficit de insumos ha llegado a tal punto, que no se dispone de medicamentos

o materiales básicos, como analgésicos simples, guantes o jeringas, todos los cuales deben ser adquiridos por los pacientes o sus familiares, al igual que estudios radiológicos, de laboratorio y traslados, generando un gasto bolsillo que ronda por un orden cercano al 100% en medio de una de las más altas inflaciones del planeta.

Esta situación no es exclusiva del sector público. El sector privado, que en el pasado reciente fue hipertrofiándose progresivamente, sobre el cadáver de la salud pública, se encuentra hoy igualmente diezmado a su menor expresión. Además, adolece de una serie de carencias, fallas y equívocos, que en conjunto contribuyen a hacer más grave la problemática. Para la fecha, la gran mayoría de las clínicas privadas han cerrado sus puertas y solo algunas se encuentran prestando servicios, con muchas dificultades.

De tal manera, que la población venezolana que continúa en el territorio nacional, prácticamente carece en estos momentos de un sistema sanitario al cual poder acudir para solventar sus demandas más urgentes de asistencia médica y mucho menos para avanzar hacia el estado saludable ideal que enuncia el concepto de la OMS, lo cual ha causado en quienes carecen totalmente de recursos financieros mucho sufrimiento, y en quienes disponen de éstos, a hacer de sus hogares su centro de hospitalización.

Tal situación plantea un gran reto, tanto para la población que requiere servicios accesibles, gratuitos y de calidad, como para los prestadores, que requieren remuneraciones justas y condiciones de trabajo dignas, para el Estado, que se ha visto desbordado por la imposibilidad de cumplir con su obligación, en los términos que manda la Constitución Bolivariana de Venezuela y aun para el mismo sector empresarial, cuyos planes de hospitalización, cirugía y maternidad de sus trabajadores, dejaron de ser factibles.

Dado que ninguno de estos actores es capaz, por sí solo, de encontrar una salida a la problemática de salud, es imperioso que confluyan sinérgicamente en la búsqueda de una alternativa que ayude a mitigar el sufrimiento humano y a brindar opciones para mejorar la salud de los venezolanos. Tal salida puede ser construida a partir de la transversalización de diversas categorías en el ámbito organizacional, jurídico y económico, así como en la concurrencia de todos los actores en el tema de la salud.

En 1984 la OMS se distancia del concepto de salud como una condición estática y plantea el modelo dinámico que la presenta como un proceso, tal y como lo expresa la

Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, en 1986, "...la promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente" ⁽¹⁰⁾.

Se requiere entonces de modelos alternativos que mantengan las premisas consagradas en la actual Constitución, aprovechen el marco jurídico interno y los nuevos términos de referencia en el orden externo que se han generado durante los años recientes, y reviertan la crisis descrita, desde iniciativas con grupos poblacionales específicos que generen respuesta a los aspectos particulares de la problemática desde una perspectiva convergente, de unión y sinergia entre todos los actores involucrados.

El presente programa forma parte de una propuesta más amplia, que busca establecer un novedoso Modelo de Atención Local de Salud, para una población objeto y al mismo tiempo, ser una referencia a considerar en la solución de la crisis sanitaria actual en la República Bolivariana de Venezuela.

El Programa de Atención Primaria en Salud busca iniciar la constitución de un Sistema Local de Salud (SILOS), por medio de la estructuración de una de sus partes o unidades, en la cual se espera atender integralmente la salud de las primeras 75000 personas ò 15000 familias.

1.1 Situación epidemiológica

Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de la plataforma salud en las Américas ⁽¹¹⁾, la

República Bolivariana de Venezuela tuvo entre el año 2000 y 2024 importantes transformaciones demográficas y sanitarias (Fig. 1).

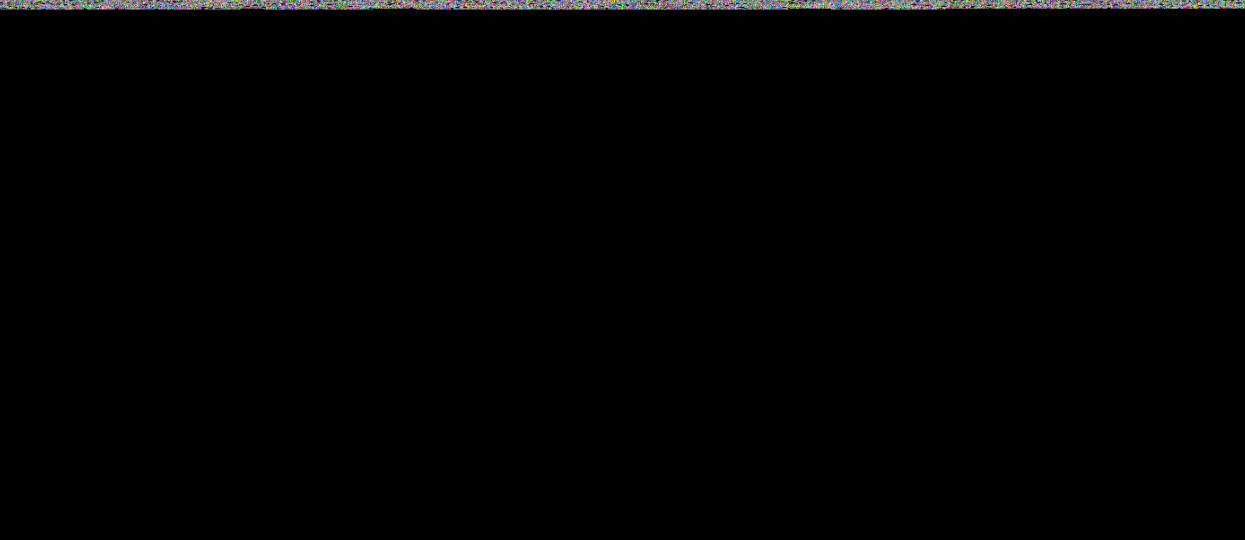
La población total creció un 15,8%, alcanzando 28.405.543 millones de habitantes, con un aumento notable de la población mayor de 65 años, que pasó de representar el 4,7% al 9,7% del total.

La mortalidad infantil disminuyó levemente de 19,4 a 18,28 por mil nacidos vivos y los nacimientos con bajo peso se incrementaron del 8,7% a 9,5%. La cobertura de vacunación contra el sarampión cayó a 68% en 2021. La mortalidad materna subió drásticamente, de 92,4 a 259,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (incremento del 180,5%). La fecundidad general bajó a 2,1 hijos por mujer y la fecundidad adolescente se redujo 24,3%. Entre 2011 y 2017, la atención prenatal de cuatro consultas o más creció del 47% al 82,9% y el 99,1% de los partos fueron atendidos por personal calificado.

En enfermedades transmisibles, se registraron 35 casos nuevos de tuberculosis por 100.000 habitantes en 2022, con una tasa de mortalidad de 2,7 por esa causa en 2019. La incidencia del VIH fue de 17,5 por 100.000 habitantes en 2020, con una mortalidad de 26,1 por 100.000 en 2019, aunque esta última disminuyó un 215,6% desde 2000. No se reportaron casos de rabia humana.

En enfermedades crónicas, el sobrepeso afectó al 53,5% de los mayores de 15 años en 2022 y un 31,4% declaró baja actividad física en 2016. La hipertensión arterial sistémica bajó de 25,5% en 2000 a 18,6% en 2015, pero la diabetes aumentó de 8,8% a 9,5% en 2014.

La mortalidad prematura evitable alcanzó 337,9 por 100.000 habitantes en 2019, con 124,3 muertes tratables, muy por encima



Fuente de datos: Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Población. World Population Prospects 2024. Rev. 1. Nueva York: Naciones Unidas; 2024. Disponible en: <https://population.un.org/wpp>

Figura 1. Pirámides poblacionales de la República Bolivariana de Venezuela, años 2000 y 2024.

del promedio regional. Las enfermedades no transmisibles fueron responsables del 65,1% de las muertes, las transmisibles del 15,6% y las causas externas del 19,4%. El cáncer de próstata, pulmón y colon fueron las principales causas de muerte en hombres y cáncer de mama, pulmón y colon en mujeres.

1.2 Condiciones socioeconómicas y ambientales

Según el mismo informe de la OPS, la población económicamente activa (15-64 años) constituye el 64,8%, y la relación de dependencia bajó de 63,1 a 54,3 personas pasivas por cada 100 activas. La esperanza de vida se incrementó levemente de 72,4 a 72,7 años.

El promedio de escolarización aumentó a 10,3 años, y la alfabetización alcanzó el 98,7% (99,1% en hombres y 98,4% en mujeres). La tasa de desempleo en 2023 fue de 5,9%, ligeramente mayor en mujeres (6,5%) que en hombres (5,5%). La pobreza según la línea nacional bajó de 41,6% en 2000 a 33,1% en 2015, aunque el 7,1% de la población vivía con menos de US \$ 2,15 diarios en 2006. Pese a ello, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) se mantuvo estancado en 0.699, sin variaciones en más de dos décadas, a diferencia de los avances regionales e internacionales.

El gasto público en salud en 2021 fue de solo 1,35% del PIB, con un elevado gasto de bolsillo (28%). La cobertura de Internet creció notablemente, del 3,4% en 2000 al 61,6% en 2017.

La prolongada crisis política y económica ha impactado gravemente las condiciones de vida de la población. Altos niveles de pobreza multidimensional, inseguridad alimentaria, desempleo, migración forzada y pérdida de poder adquisitivo han generado un entorno desfavorable para la salud. La malnutrición –tanto por déficit como por exceso– es una realidad creciente, especialmente en niños y adultos mayores. La situación se agrava con el deterioro de los determinantes sociales de la salud, como el acceso a agua potable, saneamiento básico, educación y vivienda adecuada, factores esenciales para prevenir enfermedades y mantener una buena calidad de vida.

Se evidencia una marcada degradación de los ecosistemas urbanos y rurales, con acumulación de desechos sólidos, contaminación de fuentes de agua, proliferación de vectores y cambios climáticos que favorecen la propagación de enfermedades endémicas. La falta de planificación territorial y el debilitamiento de las instituciones ambientales han impedido una gestión adecuada de los riesgos sanitarios derivados del entorno, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables.

1.3 Necesidades identificadas

Tomando en cuenta la situación descrita se identifican una serie de necesidades que requieren una intervención integral e inmediata basada en la APS tal y como establecen los organismos rectores de salud.

El envejecimiento poblacional, junto con el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes y el sobrepeso, demanda el fortalecimiento de estrategias de prevención, promoción de estilos de vida saludables y control de enfermedades no transmisibles, especialmente en adultos mayores y personas en riesgo. Asimismo, la elevada mortalidad prematura evitable y la carga de enfermedades tratables indican debilidades en el acceso y calidad de los servicios de salud, que deben ser corregidas mediante el refuerzo del primer nivel de atención con equipos multidisciplinarios, acciones comunitarias y redes integradas de servicios.

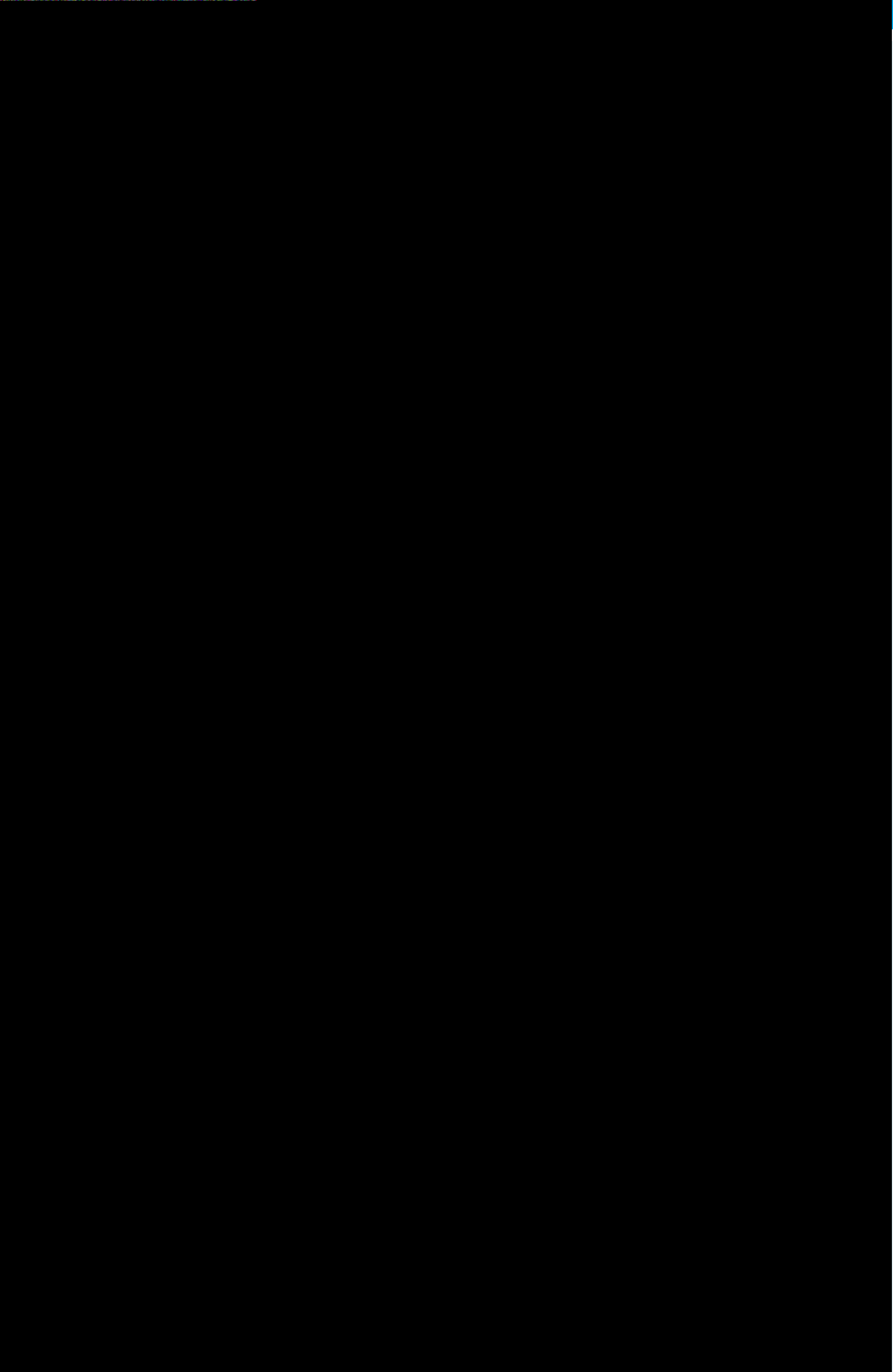
En el área de salud materno-infantil, los datos muestran una necesidad urgente de intervenciones focalizadas: la alarmante alza en la mortalidad materna y el incremento de nacimientos con bajo peso señalan brechas críticas en la atención prenatal, nutricional y perinatal. Aunque la mayoría de los partos son atendidos por personal calificado, persisten desafíos relacionados con el seguimiento continuo del embarazo, acceso a insumos esenciales y educación materna. Desde la APS, es imprescindible implementar programas de atención integral a la mujer y al niño, con enfoque intercultural, comunitario y preventivo, que garanticen atención oportuna, adecuada y humanizada desde la gestación hasta el desarrollo infantil temprano.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, si bien algunas muestran control relativo, como la rabia humana (sin casos reportados), otras representan un desafío, como la tuberculosis y el VIH, que

mantienen tasas de incidencia y mortalidad significativas. La caída de la cobertura de vacunación contra el sarampión a un 68% representa una amenaza real de reemergencia de enfermedades prevenibles. En este sentido, el programa de la APS debe priorizar la vigilancia epidemiológica activa, la inmunización universal, la educación comunitaria y el acceso gratuito a pruebas y tratamientos, fortaleciendo la articulación entre los servicios de salud, las escuelas y las organizaciones comunitarias.

Las condiciones socioeconómicas y ambientales adversas, producto de una prolongada crisis estructural, han agravado los determinantes sociales de la salud, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. La pobreza multidimensional, la inseguridad alimentaria, la falta de agua potable y saneamiento, junto con la degradación ambiental, crean un entorno propicio para enfermedades y limitan el impacto de cualquier acción curativa. Desde la APS, se requiere una respuesta intersectorial e integrada, con énfasis en promoción de salud, participación activa de los sujetos involucrados en la tarea de promover la equidad y el empoderamiento de los mismos.

Las demandas sanitarias actuales de la población venezolana requieren una respuesta estructurada, sostenida y adaptada a las condiciones reales del país. Es prioritario fortalecer la APS como estrategia central, que garantice servicios de promoción, prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, así como recuperar las capacidades del sistema hospitalario para manejar casos de mayor complejidad. Se requiere además una política pública que articule salud, educación, alimentación, agua, vivienda y participación, enfocada en los derechos humanos y la sostenibilidad.



2. Justificación

Todos los programas de APS se justifican por su carácter preventivo, por los procesos educativos que implementan y por garantizar la cobertura sanitaria de un país. En el caso de Venezuela y específicamente en el estado Zulia, nuestro programa contribuirá al bienestar de la población asociada y a reducir la compleja carga sobre los servicios de atención secundaria y terciaria.

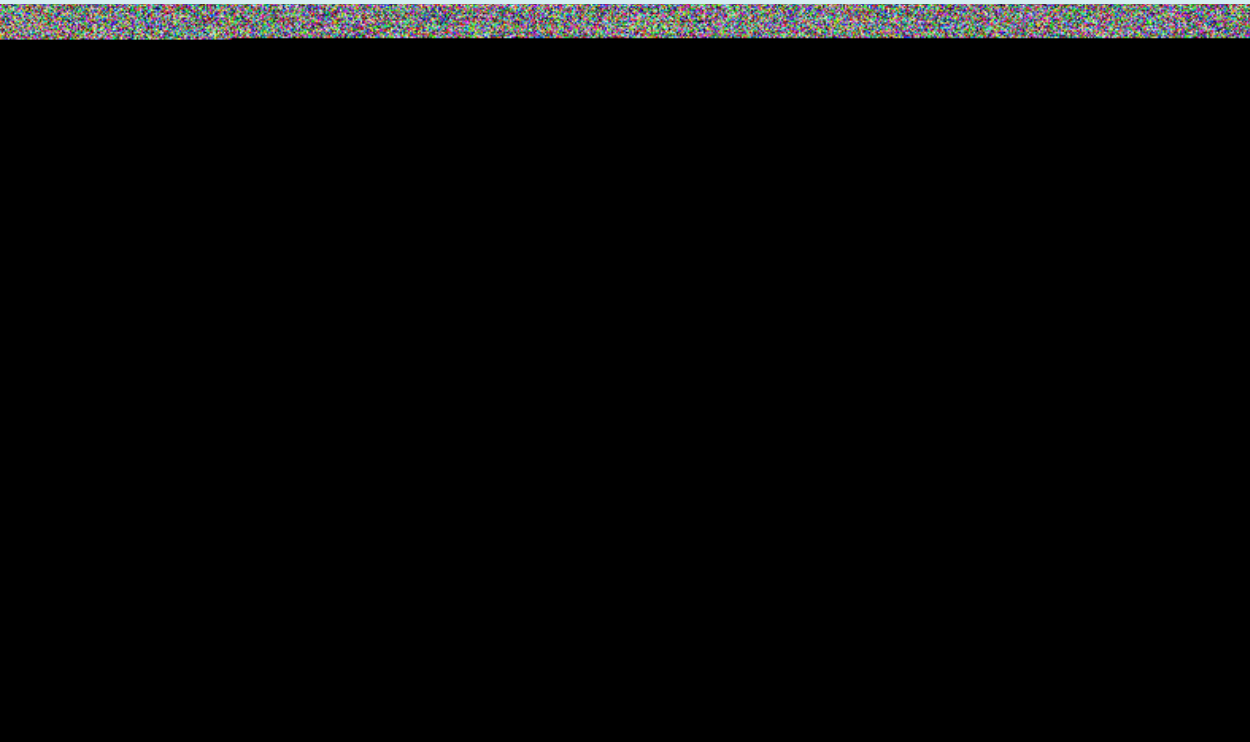
La APS implica cumplir con los derechos, entre ellos, el derecho a la salud, consagrados en las normativas, que a propósito de este tema existen en Venezuela y en el resto del mundo. Su importancia descansa en la prevención de enfermedades y en la promoción de hábitos saludables, en identificar las necesidades y las soluciones, culturalmente relevantes y adaptadas a los modos de vida nacionales, regionales y locales. Su enfoque integral permite concebir al ser humano como un ser biológico, psicológico, social y espiritual.

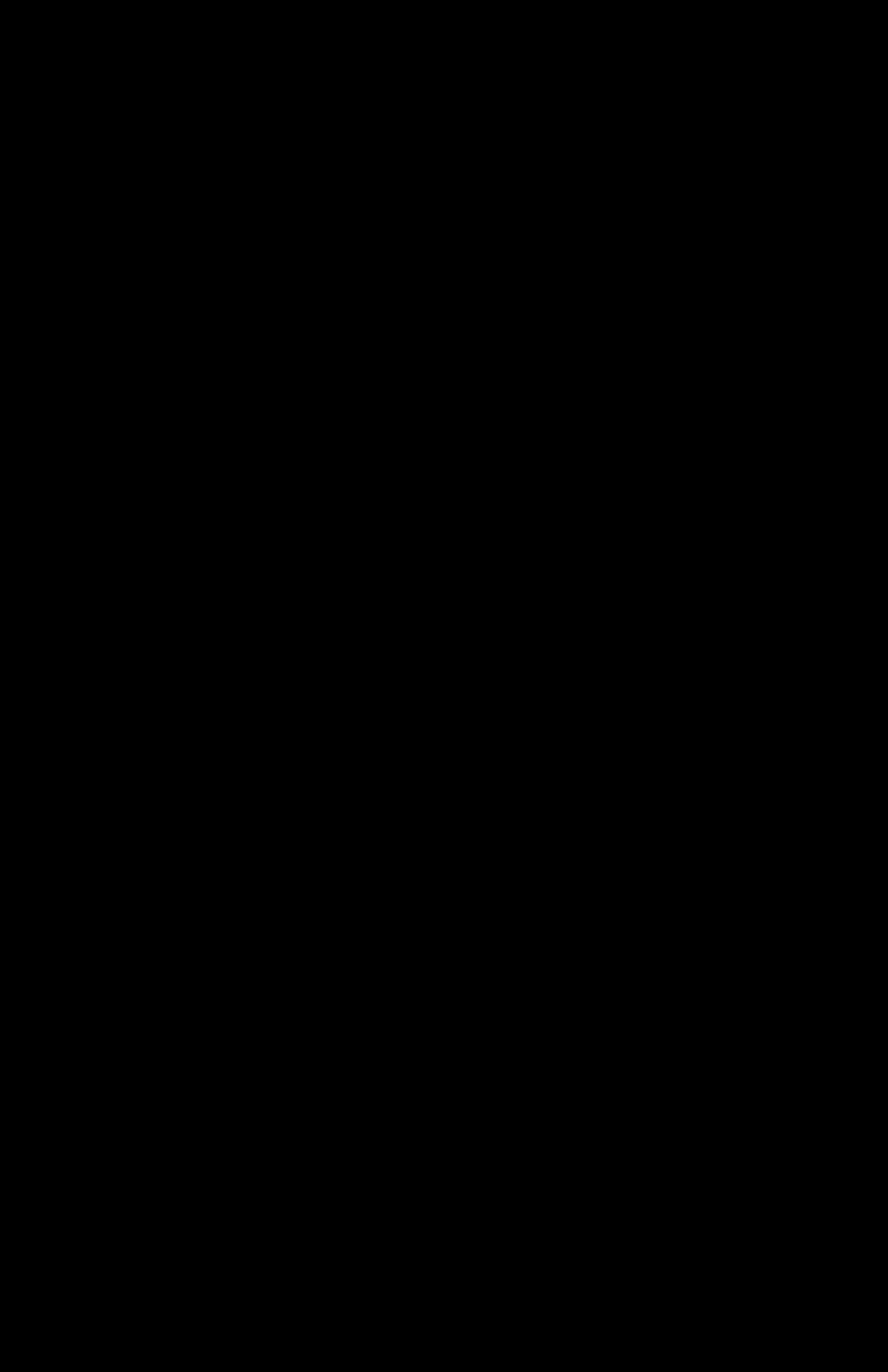
La APS contribuye a la disminución de las desigualdades en salud, en tanto, ofrece

una atención justa y equitativa. Su enfoque no es inmediateista, ya que se propone construir procesos resilientes y comunidades sanas, caracterizándose por la continuidad sostenida de acciones educativas, que de una forma intencional convocan a la participación.

Este Programa de APS está totalmente justificado, debido al aporte directo que dará a la prevención de la salud, a la educación, a la longevidad y a la felicidad de las personas. Concretamente su contribución se expresa en:

- El fortalecimiento del sistema de salud.
- El ahorro económico, al reducir los costos.
- La garantía de equidad y acceso.
- La promoción de la formación, participación familiar y comunitaria.
- La sostenibilidad de la salud y de una vida con calidad, a partir del desarrollo de procesos educativos y de autocuidado.
- La prevención de enfermedades y la promoción de la salud.





3. Fundamentos teóricos y antecedentes

Todo sistema se rige por uno o varios axiomas que determinan su funcionamiento, para que así, los elementos que procesa (Input), lo sean de la manera más efectiva y se obtenga el mejor resultado (Output). En el caso de la salud, los axiomas de Kerr White y Leavell y Clark, determinan este proceso (Fig. 2).

White demostró en 1960 que "...por cada mil personas, alrededor de 750, presentan algún tipo de síntoma los últimos 30 días, 30% de ellos, consultan a un médico, de los cuales, solo 9 requirieren alguna valoración especializada, 5 necesitan internación en un hospital general y apenas 1, ser ingresado en un centro de alta complejidad" ^(6, 7).

Lo anterior demuestra, que la mayoría de las demandas de asistencia sanitaria, pueden ser satisfechas comunitariamente y por tanto, todo sistema sanitario debe constituirse como el engranaje de subsistemas locales piramidales o SILOS, con un robusto primer nivel de atención como base, donde se concentren las acciones esenciales de promoción, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno,

articulado con servicios hospitalarios como vértice del sistema, donde se brinde atención más compleja solo cuando sea necesario ⁽¹²⁾.

Leavell y Clark, por su parte, establecieron cinco niveles de prevención en salud: la promoción de condiciones de vida saludables; la protección específica e inespecífica contra enfermedades (como inmunización y saneamiento ambiental); el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno; la limitación del daño mediante intervenciones efectivas; y la rehabilitación integral para favorecer la reinserción social y funcional de la persona, asignando a cada nivel, un conjunto de medidas preventivas que se ejecutan para evitar la enfermedad e interceptar el curso de la misma en cualquier fase de su evolución ⁽⁸⁾.

Seguidamente, se detalla lo que corresponde a cada nivel:

- Primer nivel: la promoción de la salud, por medio del incentivo a una adecuada alimentación, vivienda, educación, condiciones de trabajo, educación para la salud y realización de exámenes periódicos.

Fuente: Proyecto Sistema de Salud-Hospital de la Misericordia Dr. Gustavo Pineda.

Figura 2. Axioma de Kerr White.

- Segundo nivel: promueve la protección inespecífica y específica de enfermedades en particular, mediante las inmunizaciones, la higiene personal, el saneamiento ambiental, la potabilización del agua, la nutrición apropiada y el lavado de manos, entre otros.
- Tercer nivel: incluye la realización de un diagnóstico precoz, y tratamiento oportuno para detener tempranamente el avance y difusión de una enfermedad por medio de análisis clínicos y radiológicos, entre otros.
- Cuarto nivel: propone limitar el daño por medio de tratamientos adecuados, rápidos y efectivos, para detener la enfermedad e impedir su avance a un estado crítico y desenlace fatal.
- Quinto nivel: se refiere a las acciones de rehabilitación brindadas a las personas a fin de que puedan utilizar sus capacidades remanentes y de esta manera, reintegrarse a la sociedad.

Por otro lado, desde la realización de la Convención de Alma Ata, en Tayikistán, extinta URSS, en el año 1978, se enunció que la APS es la estrategia adecuada para mejorar las condiciones de salud de la población, aún en situaciones extremas y permitir que el sistema de salud funcione según las premisas anteriormente señaladas, tal y como se expresa en el siguiente enunciado:

“La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad”
(13, 14).

La actualización conceptual de la salud y de la APS, son una condición necesaria para el establecimiento de los SILOS. Durante estos 50 años, se han formulado en consecuencia diversas nuevas versiones sobre el concepto de salud, muchas de las cuales no han sido lo suficientemente funcionales, lo cual explica en parte la situación sanitaria mundial.

La definición proclamada por la OMS en 1948 fue un hito al incluir el bienestar físico, mental y social como metas sanitarias (15, 16). Esta perspectiva supuso un avance al incorporar determinantes sociales como la pobreza, el acceso a la educación o el entorno familiar, y promover una visión holística del individuo. Sin embargo, esa visión, aunque progresista, resulta hoy insuficiente. Su carácter idealista y estático,

centrado en el “completo bienestar”, ha sido objeto de críticas por su difícil aplicabilidad práctica, la imposibilidad de medirla objetivamente y el riesgo de medicalizar excesivamente la vida cotidiana.

Expertos como Milton Terris consideraron que esa definición generaba expectativas utópicas (17, 18), mientras que Talcott Parsons propuso una visión funcional, donde salud implicaba la capacidad de asumir roles sociales (19). León Kass también advirtió sobre la sobrecarga de responsabilidades impuestas al sistema de salud por esta definición idealizada (20, 21).

Instituciones como la OCDE, los CDC de EE. UU., la APHA y la Escuela de Salud Pública de Harvard han coincidido en que el concepto de “completo bienestar” no es operativo ni universal. En cambio, proponen enfoques más realistas centrados en la funcionalidad, la calidad de vida, la resiliencia, y la capacidad adaptativa de los individuos.

Diversos académicos y organismos han propuesto redefinir la salud para adaptarse mejor a los desafíos contemporáneos (22-29). Machteld Huber sugiere entender la salud como la “capacidad para adaptarse y autogestionarse frente a desafíos físicos, emocionales y sociales” (30). Este paradigma dinámico se ha implementado en varios países europeos y sirve como base para modelos centrados en enfermedades crónicas y salud integrativa.

Venkatapuram, apoyado en la teoría de capacidades de Sen y Nussbaum, define la salud como la posibilidad de alcanzar metas funcionales básicas, orientando el debate hacia la justicia social y los derechos humanos (31). Por su parte, Bircher y Hahn la describen como un equilibrio adaptativo entre los individuos y su entorno físico, biológico, social y cultural, destacando así el carácter ecológico y contextual del bienestar (32).

Otros autores, como Jadad y O’Grady, agregan la dimensión emocional y afectiva, entendiendo la salud como la capacidad de “gestionar y amar la vida”, una propuesta especialmente influyente en salud mental y medicina humanista (33).

Daniel Callahan introduce la noción de “equilibrio funcional” como clave para evaluar la salud en personas con enfermedades crónicas (34).

La Fundación Rockefeller y la Comisión Lancet han impulsado el concepto de “salud planetaria”, que vincula la salud humana con la sostenibilidad ambiental (35). El modelo Meikirch, de Bircher y Kuruvillab, integra componentes biológicos y adquiridos, demandas de la vida y determinantes

sociales y ambientales, estableciendo una visión holística en constante interacción ⁽³⁶⁾.

Los nuevos enfoques transforman la salud de un estado estático a una acción continua. Es decir, “saludear”, más que estar sano. Esta metáfora subraya la responsabilidad del individuo en su proceso de salud, destacando la resiliencia, adaptabilidad y autorregulación como claves del bienestar ⁽³⁷⁻³⁹⁾.

Este viraje hacia la autogestión también se explica por el agotamiento del modelo del Estado de Bienestar, que tras la Segunda Guerra Mundial asumió responsabilidades totales sobre el bienestar ciudadano. Las crisis económicas, la fragmentación política y el colapso de paradigmas geopolíticos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), debilitaron su capacidad de garantizar salud universal, incrementando desigualdades, sobrecargas familiares, exclusión sanitaria y desprotección frente a crisis ⁽⁴⁰⁻⁴⁵⁾.

Ante ello, la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986) impulsó una transición hacia el empoderamiento individual y comunitario. Este documento propone cinco estrategias: habilitación (empoderamiento), creación de entornos favorables, reorientación de servicios de salud, desarrollo de habilidades personales y acción comunitaria. Todo ello apunta a compartir la responsabilidad de la salud entre el Estado, las instituciones y los ciudadanos ⁽⁴⁶⁾.

Por otro lado, el fracaso de la OMS en lograr su meta de “Salud para todos en el año 2000”, evidencia que el modelo clásico de APS, formulado en Alma-Ata (1978) y revalidado en Astaná (2018), no ha respondido adecuadamente a los desafíos actuales ⁽⁴⁷⁻⁴⁹⁾.

Hoy, el envejecimiento poblacional, el auge de enfermedades crónicas y no transmisibles, las nuevas amenazas epidemiológicas y las brechas de equidad requieren una APS más robusta, integrada y adaptativa. Esta debe incorporar tecnologías digitales, telemedicina, participación comunitaria y modelos sostenibles, centrados en la persona, siendo el enlace que permite que permite la integración de comunidades específicas con el sistema nacional de salud, representando el eje central de los sistemas sanitarios modernos ⁽⁵⁰⁾.

Para ello, la APS debe enfocarse en la promoción de la salud, la prevención, el tamizaje, la atención integral y la rehabilitación desde una lógica participativa y territorial. Además, debe coordinarse con los servicios hospitalarios, garantizar acceso oportuno y responder de manera flexible a los determinantes sociales de la salud.

Autores destacados como Barbara Starfield, en su obra “Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology”, subrayan que la APS debe ser accesible, integral, continua y coordinada, asegurando una relación duradera entre el equipo de salud y la comunidad para mejorar los resultados en salud y reducir inequidades ^(51, 52). Por otro lado, Margaret Whitehead y Göran Dahlgren, en su modelo sobre los determinantes sociales de la salud, resaltan la importancia de una APS organizada y a través de su modelo de los determinantes sociales de la salud, enfatizan la importancia de intervenciones organizadas desde la APS para reducir las brechas en salud, causadas por desigualdades sociales, económicas y ambientales ⁽⁵³⁾.

Instituciones como la OMS, la OPS, la UNICEF y el Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard coinciden en que el fortalecimiento de la APS mejora la cobertura sanitaria, contribuye al desarrollo sostenible de la salud, reduce su gasto en los grupos familiares, garantiza sistemas más resilientes, fortaleciendo así los sistemas de salud al integrar servicios preventivos, diagnósticos y terapéuticos en una plataforma accesible y asequible ^(54, 55).

La APS no es un conjunto aislado de servicios, sino un proceso que incluye múltiples componentes que interactúan de manera sinérgica como un proceso dinámico y sucesivo de una serie de intervenciones que incluyen actos organizativos, diagnósticos, de tamizaje, educativos, informativos y asistenciales, orientados a satisfacer las necesidades de una comunidad determinada ⁽⁵⁶⁻⁵⁸⁾.

El programa presentado define la APS como “...el proceso por medio del cual se desarrollan, en condiciones de reconocimiento, respeto y valoración de todos los actores, el conjunto de actividades de organización, información, promoción, tamizaje, prevención, asistencia sanitaria inicial y rehabilitación, requeridas para el alcance de los objetivos fundamentales de la salud” ⁽⁵⁹⁾. Este enfoque reconoce a la APS como columna vertebral del sistema de salud, esencial para articular acciones preventivas y curativas, responder a determinantes estructurales de salud y empoderar a las comunidades en su propio proceso de bienestar.

Asimismo, la Atención Primaria en Salud se fundamenta en principios deontológicos y enfoques rectores que promueven el respeto absoluto a la vida y a la dignidad humana. Bajo esta premisa, el modelo presentado se alinea con el reconocimiento de todas las personas, como protagonistas de su bienestar, al mismo tiempo que garantiza un trato equitativo, inclusivo y libre de

discriminación por razones de género, edad y discapacidad. Se parte de un profundo respeto cultural y territorial, sustentado en la valoración de la diversidad étnica y el arraigo de los pueblos a sus espacios geográficos. Además, se asumen imperativos ineludibles como: la *Acción sin Daños*, el *Interés Superior de la Infancia* y la *Tolerancia Cero* ante cualquier forma de violencia. Finalmente, su práctica clínica cuenta con el estricto respaldo de los pilares de la bioética –autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia– y de las normativas históricas globales, como el Código de Núremberg (1947), la Declaración de Helsinki (1964) y el Informe Belmont (1979). Este sólido marco ético asegura la protección, la confidencialidad y la aplicación del consentimiento informado, como una auténtica garantía de la libertad individual. También la APS, en absoluta concordancia con el ordenamiento jurídico del país, especialmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y la Ley Orgánica de Salud (1998), consagra la asistencia sanitaria como un derecho social fundamental, equitativo, integral y participativo. Se trata de un compromiso inquebrantable, que reafirma el derecho irrenunciable a la salud. La articulación de estos principios y normativas consolida una Atención Primaria en Salud, que involucra la intervención médica, la consolidación de una alianza indisoluble entre el cuidado preventivo, la atención holística y el empoderamiento individual, familiar y comunitario. Se asume la APS como un crisol de humanidad, de corresponsabilidad, de visión interdisciplinaria y de esperanza compartida.

Experiencias exitosas a nivel mundial como el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) ⁽⁶⁰⁾, el modelo brasileño del SUS con sus equipos de salud de la familia ⁽⁶¹⁾, o el enfoque cubano centrado en la medicina comunitaria ⁽⁶²⁾, demuestran que un modelo fuerte de APS permite resolver el 80-90% de los problemas de salud, reducir costos hospitalarios, mejorar la equidad y aumentar la satisfacción ciudadana.

También destacan los sistemas escandinavos, en donde la coordinación entre niveles de atención, la digitalización del sistema y la implicación comunitaria han sido clave para enfrentar envejecimiento poblacional y enfermedades crónicas con eficiencia y calidad ⁽⁶³⁾.

La salud no puede seguir siendo comprendida como un estado fijo, ni la APS como una política vertical y rígida. Ambas deben ser entendidas como procesos dinámicos, con enfoque biopsicosocial, fundamentadas en la resiliencia, adaptabilidad, participación y corresponsabilidad ciudadana.

Reconceptualizar la salud implica integrar determinantes estructurales, relaciones humanas, capacidades individuales y condiciones ambientales. Por su parte, la APS debe actualizarse como la estrategia organizadora del sistema de salud, diseñada para responder con equidad, eficiencia y participación a los desafíos del presente.

Con esta nueva visión, salud y APS se transforman en herramientas fundamentales para el desarrollo humano, el bienestar colectivo y la sostenibilidad de los sistemas locales de salud en el siglo XXI.

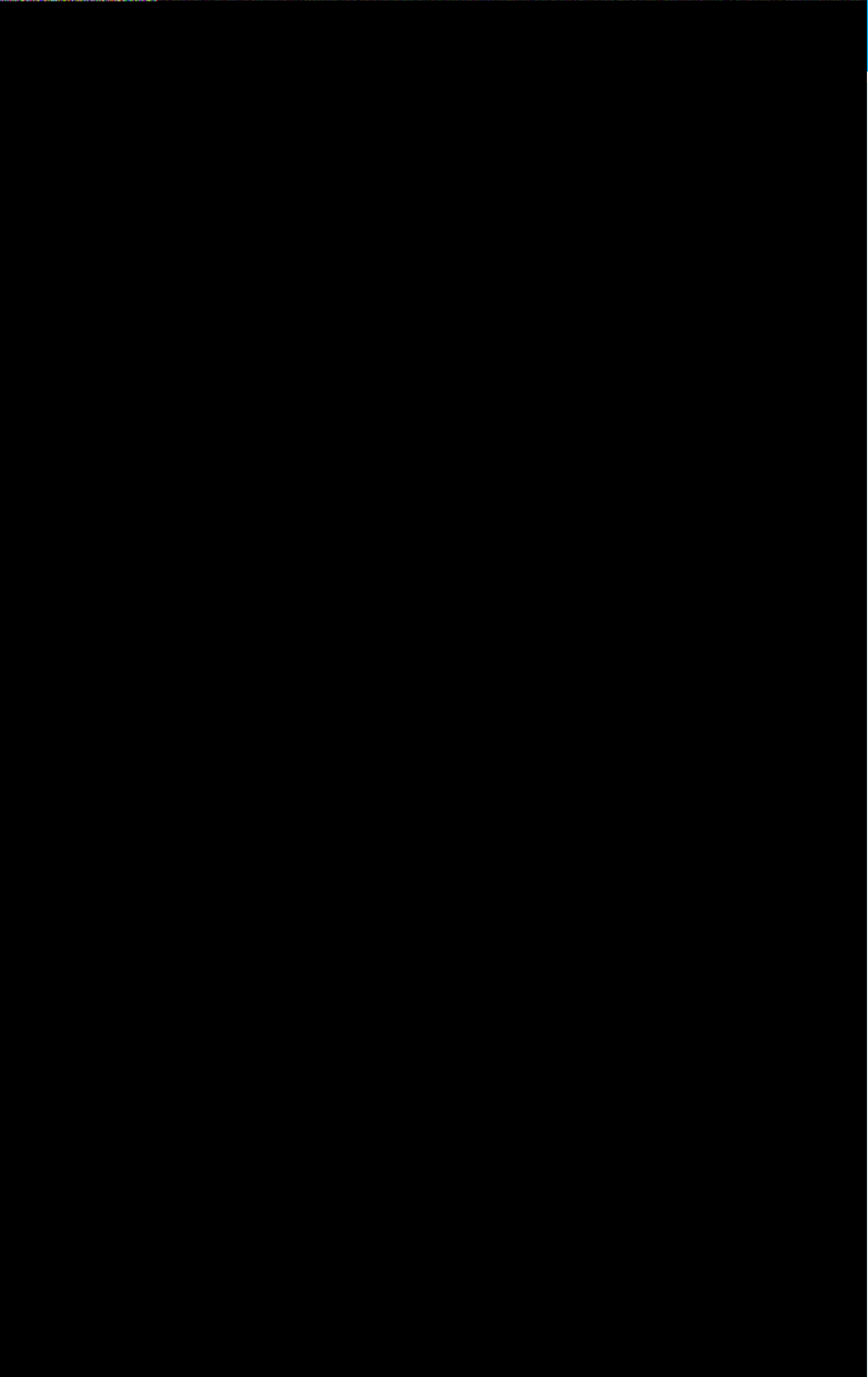
4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Brindar atención integral biopsicosocial y espiritual de salud a las familias asociadas al SILOS, con base a estrategias de participación, promoción, prevención, educación y autorresponsabilidad, mediante la oferta de servicios de atención primaria dignos, eficientes, eficaces, perfectibles, sostenibles, en el ámbito de la persona, articulados con servicios pre y hospitalarios de moderada y alta complejidad, para ampliar su calidad de vida, felicidad, bienestar y longevidad e incrementar la productividad y armonía social.

4.2 Objetivos específicos

- Ubicar georreferencialmente a cada grupo familiar.
- Realizar el censo socio sanitario del grupo comunitario adscrito al programa.
- Caracterizar a cada grupo familiar de la comunidad.
- Elaborar historia clínica a cada miembro de la familia.
- Construir la pirámide poblacional del grupo comunitario.
- Aplicar el tamizaje a los subgrupos poblacionales de riesgo.
- Diseñar el Plan Sanitario de la población.
- Ejecutar los planes preventivos de salud específicos pautado por las autoridades sanitarias según corresponda.
- Ejecutar programas educativos en cada grupo de riesgo y enfermos específicos.
- Promocionar la salud en las personas y grupos poblacionales, para modificar los factores ambientales, que inciden de manera negativa.
- Brindar asistencia médica primaria a la población.
- Proporcionar alternativas de rehabilitación y prevención secundaria.
- Crear un banco de suero antiofídico.
- Garantizar que la casuística de morbilidad se corresponda con los enunciados del axioma de Kerr White.
- Vincular a la población asistida con los niveles de atención del sistema nacional de salud, en los casos que corresponda.
- Asegurar tasas de morbilidad inferiores a la media nacional.
- Lograr adecuados tiempos de respuesta en todos los servicios demandados.
- Brindar una atención general que se corresponda con los estándares internacionales en todos y cada uno de los servicios ofertados.
- Brindar al personal que labore en la ejecución del programa todos los medios requeridos para el cumplimiento de sus funciones.
- Alcanzar una remuneración al personal en divisa extranjera acorde con el promedio región continental según su área y funciones.
- Lograr costos operativos eficientes, asociados a altos niveles de rendimiento, indicadores sanitarios de excelencia y elevada satisfacción de usuarios.



5. Población objeto

La población a atender se encuentra contenida dentro del número total de individuos que conformarían el “SILOS Hospital de la Misericordia basado en la APS, Dr. Gustavo Pineda”, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, de la República Bolivariana de Venezuela.

Este sistema pretende atender a trescientas mil (300.000) personas o sesenta mil (60.000) familias de la ciudad de Maracaibo que hayan manifestado disposición a sumarse al proyecto de salud, caracterizado por la autogestión, la vinculación a un modelo de “medicina anticipativa”. Basado, a su vez, en el autocuidado, organización y participación, que busca cumplir las premisas de acompañamiento del programa, actuando junto al médico y al equipo de salud en la aplicación del mismo, así como de las modificaciones de hábitos de vida autodestructivos y la asunción de estilos de vida saludables, para prevenir la aparición de procesos mórbidos, aumentar la longevidad e incrementar la felicidad personal y familiar, equilibrio y productividad social.

En una primera etapa, el programa estará dirigido hacia la población contenida en uno de los cuatro cuadrantes en que se dividiría la ciudad, es decir setenta y cinco mil (75.000) personas.

5.1 Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión serán: personas independientemente de su sexo y edad, con cualquier condición morbil preexistente, grupo etario, étnico, estrato socioeconómico, nacionalidad y nivel de instrucción, asentados en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, durante el periodo en el cual se llevará a cabo la ejecución del presente programa. Estas personas se asociarán al proyecto a través de la adquisición de una acción simple nominativa de una Empresa Social de Salud que será constituida para la gestión del proyecto.

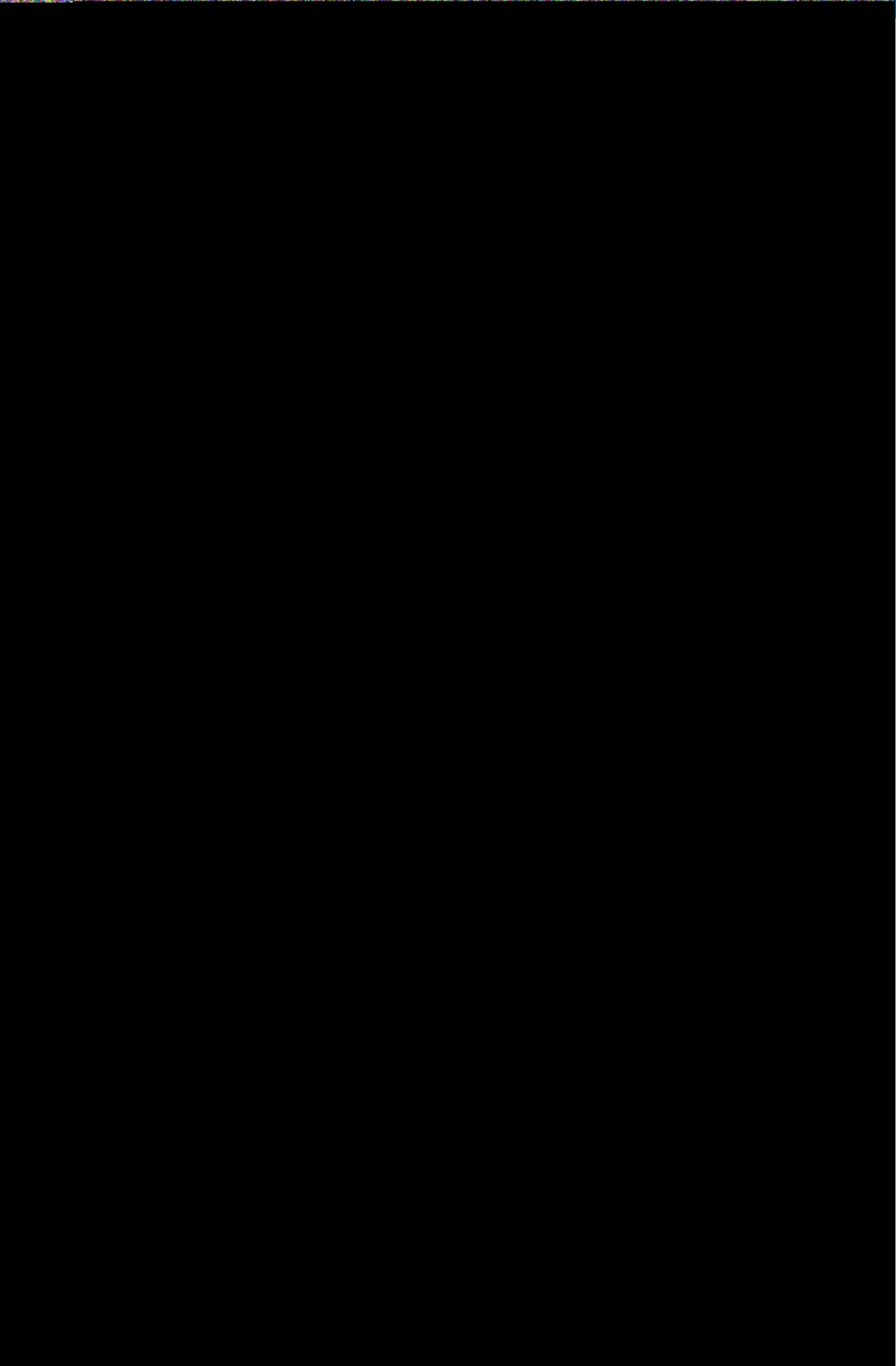
5.2 Criterios de permanencia

El cumplimiento de las estrategias de salud y bienestar del plan individual de salud, indicado por el equipo multidisciplinario.

Cumplimiento de las obligaciones administrativas establecidas por la empresa social.

5.3 Criterios de exclusión

Los únicos criterios de exclusión serán: el incumplimiento de los criterios de permanencia, el desplazamiento fuera de la jurisdicción durante más de tres meses o, el retiro voluntario presentado formalmente al programa.



6. Componentes

Desde su formalización en la Declaración de Alma-Ata, la APS ha sido reconocida como la estrategia más efectiva y equitativa para mejorar la salud poblacional. Esta es el proceso que permite la integración de comunidades específicas con el sistema nacional de salud, que representa el eje central de los sistemas sanitarios.

La APS no es un conjunto aislado de servicios, sino un proceso que incluye múltiples componentes que interactúan de manera sinérgica dinámica y sucesiva, por medio de una serie de intervenciones que contiene actos organizativos, participativos, diagnósticos, de planeación, promoción, prevención y de asistencia médico-sanitaria primaria, los cuales se desarrollan mediante procesos educativos, informativos y asistenciales, orientados a satisfacer las necesidades de una población determinada.

Este programa asume estos seis componentes básicos de acción, a los fines de su operativización, los cuales serán desarrollados conforme a la estrategia de acción que se ha fijado.

6.1 Organización y participación

Los actos organizativos se refieren a la planificación, administración, identificación, distribución y coordinación de los recursos humanos y materiales en salud disponibles, para asegurar que los servicios sean accesibles, equitativos y sostenibles. Esto incluye la ubicación-territorialización de los grupos humanos a ser atendidos, la asignación y organización de equipos multidisciplinarios, redes de referencia, así como los sistemas de financiamiento que prioricen las necesidades de las poblaciones más vulnerables.

Se requiere de la atención primaria, con un modelo de gestión integrado, que asegure la relación entre el apoyo clínico, el manejo administrativo, los recursos humanos competentes, así como los sistemas de comunicación presenciales y virtuales, así como la participación de la comunidad.

La organización y la participación en la APS son fundamentales para garantizar un acceso equitativo y eficiente de los servicios de salud. Según la OMS, la atención primaria debe ser accesible, integral y centrada en las personas, como ser biopsicosocial y espiritual ⁽⁶⁴⁾. Esto exige, la participación comunitaria, como un factor esencial para identificar las necesidades de salud y desarrollar estrategias efectivas.

Son coparticipes de la APS: su personal, los pacientes y las comunidades involucradas en las acciones de prevención y promoción de la salud. Los dos últimos actores no son concebidos como simples beneficiarios de un servicio, sino como corresponsables de operacionalizar la atención primaria, en las áreas que les compete, a partir de la construcción de un “nosotros”, sin perder de vista las funciones especiales que a cada uno de los que conforma la APS, le corresponde cumplir.

La participación en la APS es inclusiva y exige a sus miembros la capacidad de desarrollar un relacionamiento respetuoso de los saberes de los otros, de comunicarse, de informar y de trabajar en conjunto. A los responsables de gestionar el programa de la APS, le corresponde la tarea de contribuir a la formación de todos los que constituyen parte de esta experiencia de búsqueda y mantenimiento de la salud.

Un estudio realizado sobre la participación social en la APS arrojó un conjunto de dimensiones que deben ser abordadas para que se puedan desarrollar acciones efectivas y soluciones viables frente a la responsabilidad de prevención: dispositivo institucional, empoderamiento de la comunidad y encarnación de la experiencia colectiva ⁽⁶⁵⁾.

Como dispositivo institucional, la participación social exige una relación horizontal con la comunidad, que reconoce la importancia de la territorialidad, envuelta en los dominios subjetivos de los espacios físicos, en la encarnación de las necesidades y aportes específicos que realizan a la

APS las personas y los grupos de las comunidades.

La dimensión referida al empoderamiento exige asumir que la comunidad es parte activa en la toma de decisiones en lo que compete a la APS, más allá de las declaraciones que versan sobre la necesidad de valorar el aporte comunitario. Esto implica participar en la determinación y priorización de las necesidades y en el desarrollo de acciones emprendidas para alcanzar resultados vinculados a la prevención de la salud.

Como encarnación de experiencias colectivas, la APS se nutre continuamente de la participación social concreta de las comunidades, cuyas acciones han tenido éxito en la prevención y promoción de la salud. Se trata de una experiencia dialógica entre los diferentes actores, que logran conquistar y resolver problemas en sus espacios colectivos, en torno a la salud.

Concebimos entonces el componente de organización y participación, como el encuentro de todos los actores del proceso de la APS para desarrollarlo en el mismo territorio donde se encuentran las comunidades, por medio de un autorreconocimiento y en condiciones de horizontalidad y gobernanza.

6.2 Diagnóstico

Basados en la concepción manejada en el Programa de APS, el diagnóstico no solo abarca la identificación temprana de enfermedades y sus consecuentes factores de riesgo, para detectar enfermedades prevalentes como la hipertensión, diabetes o cáncer en estadios iniciales, sino que se asume un enfoque integral, que incluye los aspectos biomédicos, mentales, los psicosociales y ambientales que forman parte de la vida de los pacientes, permitiendo de este modo intervenciones oportunas y costo-efectivas.

Dentro del diagnóstico se contempla el tamizaje sanitario, debido a que no es suficiente la información aportada por la población objeto del programa a través del censo sociosanitario, las fichas familiares y las historias clínicas elaboradas por el personal sanitario. Es necesario complementar esta información con una investigación adicional, con el fin de identificar grupos de riesgo a padecer potenciales procesos mórbidos.

El tamizaje sanitario, cribado o screening, como también se le conoce, consiste en una evaluación utilizada en salud pública y en instituciones de esta naturaleza, para descartar precozmente posibles enfermedades, infecciones o factores de

riesgo en personas aparentemente sanas. Es como un “filtro de salud” que nos ayuda a reconocer a las personas que podrían tener alguna padecimiento o riesgo, incluso si parecen estar bien. La idea es detectar problemas a tiempo en personas con probabilidad de padecerlos, para tratarlos cuanto antes y evitar que se conviertan en algo más grave o que se propaguen a otras personas.

Gracias a la detección temprana por medio del tamizaje muchas enfermedades pueden ser tratadas a tiempo, con lo cual disminuye la gravedad de las mismas, se reduce el costo de los tratamientos a largo plazo y se mejora la calidad de vida de las personas.

La APS utiliza varios métodos para llevar a cabo el tamizaje sanitario, tales como exámenes y pruebas de rutina (medición de presión arterial para detectar hipertensión arterial sistémica, glucemia, para el diagnóstico de diabetes mellitus, perfil lipídico, para diagnosticar dislipidemias y control de peso y medición del índice de masa corporal (IMC), para obesidad, entre otros), que permiten descartar condiciones mórbidas comunes o de alto impacto.

Pueden realizarse programas de tamizaje para enfermedades específicas, tales como:

- Cáncer: de mama (mediante mamografías o ecogramas mamarios en mujeres a partir de cierta edad o en aquellas con antecedentes familiares), cáncer cervical (mediante citologías o pruebas de Papanicolaou en mujeres en edad reproductiva, para detectar células anormales), cáncer de colon (con pruebas de sangre oculta en heces o colonoscopias en personas mayores o con antecedentes familiares).
- Problemas metabólicos o genéticos que pueden ser tratados desde los primeros días de vida (neonatal).
- Hábitos de vida como el consumo de tabaco y alcohol.
- Evaluación del estado emocional, ansiedad o depresión e historia familiar para identificar riesgos hereditarios (entrevistas y cuestionarios),
- Prevención de enfermedades infecciosas en poblaciones de riesgo y mujeres embarazadas (pruebas de VIH).
- Educación en salud y autoevaluación por medio de la capacitación a la comunidad para reconocer señales de alerta y realizar autoexámenes (autoexamen de mama, autoidentificación de signos de enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares, para que las personas busquen ayuda temprana.
- Otros.

En el campo del tamizaje sanitario existen múltiples referentes teóricos, entre ellos Geoffrey Rose, quien en su obra principal “The Strategy of Preventive Medicine”, explora cómo este en el marco de la prevención puede impactar positivamente en la comunidad, al identificar factores de riesgo temprano y desarrollar estrategias de intervención ⁽⁶⁶⁾. Rafael Bengoa enfatiza en la importancia de programas preventivos y la detección temprana en la atención de enfermedades crónicas ⁽⁶⁷⁾.

Muir Gray, un referente en la implementación de programas de tamizaje basados en la evidencia en “Screening: Evidence and Practice”, aborda sus fundamentos, la evaluación de su eficacia y cómo las prácticas de cribado deben ser integradas en la atención primaria de manera ética y eficiente ⁽⁶⁸⁾.

David Mant demuestra la efectividad del cribado para enfermedades cardiovasculares y el uso de la APS para la prevención de enfermedades crónicas ⁽⁶⁹⁾. Christopher P. Morley y sus colaboradores, han aportado numerosos estudios y revisiones sobre el tamizaje de cáncer en el mismo nivel de atención ⁽⁷⁰⁾.

Michael Marmot ha contribuido particularmente en el estudio de cómo las desigualdades afectan el acceso y la efectividad de los programas de tamizaje en diferentes poblaciones, resaltando la necesidad de implementar estrategias de screening equitativas en APS ^(71, 72). Barbara Starfield destaca que los servicios sanitarios deben priorizar la prevención y la detección temprana para disminuir la carga de las enfermedades crónicas, resaltando la relevancia del tamizaje en la atención primaria como medio para mejorar la equidad ^(52, 59).

Por su parte Iona Heath, médica y académica de APS, ha reflexionado sobre los beneficios y limitaciones de estas prácticas, analizando de manera crítica sus implicaciones éticas y fácticas, defendiendo una aplicación responsable y consciente en la atención paliativa ⁽⁷³⁾.

El “United States Preventive Services Task Force” (USPSTF) constituye una referencia clave al ofrecer guías basadas en evidencia para la detección temprana de patologías frecuentes, como cáncer, hipertensión y diabetes. Documentos como *Recommendations for Preventive Services in Primary Care* y *Screening Guidelines for Disease Prevention* establecen principios y criterios para programas efectivos y éticos, aportando un marco sólido para la prevención en salud pública ⁽⁷⁴⁾. Este último referente se asume como base para operacionalizar el componente de

tamizaje en nuestro programa. Asimismo, se incorporarán diagnósticos sociales orientados a identificar necesidades y riesgos comunitarios, fortaleciendo así la acción preventiva.

6.3 Planificación

La planificación es un proceso dinámico y sistemático que, en el caso especial de la APS, implica una acción basada en los supuestos (externos e internos) o condiciones necesarias óptimas para que los objetivos puedan ser viables. Requiere la definición de la situación que se quiere alcanzar, de las estrategias, de los recursos, de los actores y de la valoración de las fuerzas intervinientes en el éxito del referido programa. La consideración de los escenarios es esencial para la ejecución, el monitoreo, la evaluación constante y la inclusión de los cambios necesarios.

Este componente es fundamental para la identificación y jerarquización de las necesidades de salud establecidas en aras de alcanzar la prevención, promoción y asistencia médico-sanitaria, a partir de la participación activa de quienes forman parte de este programa.

Las intervenciones en esta área deben adecuarse a las culturas de las comunidades circundantes lo mismo que a la infraestructura donde funciona la APS y ser concebidas como prácticas sostenibles, que no comprometan el futuro de la humanidad y del medio ambiente, lo que implica en todo momento la responsabilidad social en la prestación de servicios de salud que contribuyan a garantizar una vida con calidad, lo cual involucra la satisfacción de necesidades básicas, participación y felicidad ^(75, 76).

Esto exige manejar un enfoque de planificación que sea integral, participativo, flexible, basado en evidencias, manteniendo relaciones interinstitucionales, concentrado en los procesos y resultados, teniendo como centro al ser humano, asumido como una entidad biológica, psicológica, social y espiritual. Por lo tanto, se reconoce el papel decisivo de la comunidad en las acciones para lograr un estado saludable. Para ello, se requiere que con la información sanitaria inherente a la población objeto, luego de ser analizada y sistematizada, se elabore el respectivo plan sanitario, que será desarrollado por los actores involucrados, durante un período corriente y que guíe las decisiones que conduzca al mejoramiento de las condiciones ambientales que inciden directamente en la salud de las personas, el bienestar de los grupos familiares y el estado saludable de cada uno de sus integrantes.

6.4 Promoción

La promoción de la salud es un planteamiento de intervención holística que propone generar un movimiento social, desde la perspectiva de las propias personas para alcanzar su salud y bienestar, con una actitud responsable, individual y social, que busca alinear los componentes conductuales con los contextos ecológicos, económicos y sociales del entorno ⁽⁷⁷⁾. Es por tanto un ámbito de intervención multisectorial que requiere una conceptualización amplia de la salud y una orientación al autocuidado de los ciudadanos.

Es un proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su salud y mejorarla, por medio de acciones que van más allá de los tratamientos individuales de enfermedades, abordando los factores determinantes de la salud (sociales, económicos y ambientales) para prevenirlas.

La principal función de la promoción de la salud es crear las condiciones actitudinales y contextuales que la promuevan, ocasionando cambios en la conducta de las personas, así como en la política local, nacional e internacional ⁽⁷⁸⁾. La promoción se fundamenta en los principios de la Carta de Ottawa de la OMS de 1986, la cual identificó como estrategias básicas: la abogacía por la salud (crear las condiciones sanitarias esenciales); la facilitación del desarrollo del potencial de salud de las personas y, la mediación a favor de la salud entre los distintos intereses encontrados en la sociedad.

Estas estrategias se orientan hacia cinco áreas de acción clave: la construcción de políticas públicas saludables, la creación de entornos que apoyen la salud, el reforzamiento de la acción comunitaria, el desarrollo de habilidades personales y la reorientación de los servicios de salud ⁽¹⁰⁾.

El enfoque integral de la salud que maneja la APS, busca garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales y de calidad, con énfasis en la prevención, el tratamiento oportuno y el involucramiento de la comunidad.

La promoción de la salud se integra en el programa de APS propuesto, a través del impulso de políticas públicas saludables mediante:

- La integración de leyes y normativas que promuevan estilos de vida (como las leyes antitabaco, promover la actividad física y la alimentación sana e implementar campañas de inmunización masiva y educación sobre enfermedades prevenibles),
- La creación de entornos que apoyen la salud: mejorar las condiciones físicas del entorno, por medio de la provisión de agua potable, el saneamiento básico, la reducción de la contaminación ambiental y la generación de espacios comunitarios para la recreación y el deporte,
- El impulso de la participación comunitaria: involucra a las comunidades en la identificación de problemas de salud y la toma de decisiones para resolverlos, capacitando a promotores de salud comunitarios para difundir mensajes de prevención y promoción,
- Educación para la salud: elaboración de programas educativos que fortalezcan las habilidades de las personas para tomar decisiones saludables (talleres sobre prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial sistémica),
- Reorientación de los servicios de salud: centrando los servicios de salud en la prevención y la promoción, más allá de la atención curativa, estableciendo consultas preventivas regulares y chequeos de rutina.

Un programa de promoción de la salud requiere, además de ser técnicamente bien diseñado y asimilado por la población objeto, para ello debe considerar la cultura de las comunidades donde incursiona, como garantía de funcionamiento, en tanto, la intervención se adecua a los destinatarios clave. Por eso, la promoción de la salud y en especial la promoción de metas sociales, tales como los estilos de vida saludables, requieren del uso de métodos de comunicación efectivos y respetuosos de los modos de vida.

En tal sentido, resulta permisible el uso del marketing social –entendido como la aplicación de las técnicas del marketing comercial– para el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de los planes destinados a influir en el comportamiento voluntario de nuestra audiencia objetivo, en búsqueda de mejorar su bienestar personal y el de la sociedad ⁽⁷⁹⁾, dado que el mismo nos sirve para estudiar e investigar las características de nuestros destinatarios (sus preferencias, necesidades, expectativas) con el fin de satisfacerlas, por medio de preguntas y escuchas, captando lo que dicen, piensan, desean y necesitan, para lo cual usaremos diversas técnicas, tales como las encuestas, entrevistas y de ser necesario grupos focales de discusión.

Del mismo modo es perentorio el uso de los medios de comunicación, la publicidad, las redes sociales y otras estrategias de comunicación masiva, dado que estas

pueden ser efectivas para promover hábitos alimentarios, sexuales e higiénicos (a pesar de las limitaciones económicas contextuales), al tener poderosos efectos en la introducción de mensajes saludables en estilos de vida y promoción de la salud sobre nuestra población, ampliando y generando cambios en sus conocimientos, actitudes y prácticas, y a partir de allí, poder influir en las instancias de decisión política.

La educación e información sanitaria, son componentes fundamentales de la promoción de la salud, por medio de las cuales se pretende formar a las personas para que sean capaces de autocuidarse, conociendo y entendiendo a cabalidad la mayor parte de los aspectos relacionados con las patologías que les afectan. Al mismo tiempo brindan información de avanzada y equilibrada, para que puedan conocer y comprender los adelantos de las ciencias y tópicos de la salud. La Declaración de Yakarta, redactada en julio de 1997 con el objetivo de guiar la promoción de la salud hacia el siglo XXI, resalta entre sus estrategias y áreas de acción esenciales la *“alfabetización y el aprendizaje sanitario”*.

La educación para la salud es un recurso fundamental para que las personas puedan adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan al cuidado y promoción de su bienestar físico, mental, social y fomentar su capacidad para tomar decisiones informadas respecto a su salud, asumir estilos de vida saludables, brindarse autocuidado y prevenir enfermedades.

El acceso a la educación y a la información es determinante para una participación efectiva que permita el empoderamiento de las personas y grupos ⁽⁸⁰⁾, por ello en el marco de APS, es un pilar clave que refuerza los principios de equidad, accesibilidad, participación comunitaria y apropiación de la salud por parte de la población.

La APS, requiere complementar el acceso a servicios sanitarios con la capacidad de las personas para comprender y aplicar medidas preventivas en su vida cotidiana. Desde esta perspectiva, la educación e información plantea orientar y capacitar a los individuos para definir sus propios problemas y necesidades, ser proactivo frente a estos asumiendo las acciones apropiadas para fomentar una vida sana y el bienestar común ⁽⁸¹⁾.

6.5 Prevención

La prevención es el componente central de la APS, transversalmente sostiene a todos los demás y requiere de la participación responsable y continua de todos los actores

del proceso de salud, así como el apoyo y orientación de los profesionales, cuando sea necesario y el cumplimiento de las responsabilidades de los que forman parte del programa de la APS. Los beneficios de la prevención alcanzan a toda la sociedad, pues reduce costos, la mortalidad y la morbilidad, al enfocarse en lograr comunidades sanas y más felices.

El componente preventivo dentro del proceso de la APS, se lleva a cabo por medio de los planes específicos de prevención y control de enfermedades, los cuales son estrategias sistemáticas y organizadas, diseñadas para prevenir su aparición, reducir su incidencia, controlar su propagación y minimizar sus efectos negativos en la población. Estos planes se desarrollan en función de enfermedades prioritarias o de alta carga en un país o región y suelen estar alineados con políticas de salud pública, normativas nacionales e internacionales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ⁽⁸²⁾.

Estos planes son importantes ya que ayudan a reducir la carga de enfermedades, disminuir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud general de la población. Del mismo modo permiten optimizar los recursos del sistema de salud, fortalecer la equidad en salud, asegurar el acceso de poblaciones vulnerables a medidas preventivas y tratamientos adecuados, así como cumplir las metas nacionales e internacionales en materia de salud ⁽⁸³⁾.

La OMS formula estrategias para la prevención y control de enfermedades específicas a nivel global. Promociona marcos de acción y directrices que los países pueden adoptar según sus contextos y necesidades particulares. Se destacan entre éstas los programas de:

- Prevención y control de infecciones (PCI), con el objetivo de reducir la propagación de infecciones asociadas a la atención sanitaria).
- Control de enfermedades no transmisibles (ENT), para abordar la creciente carga de las ENT, tales como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.
- Enfermedades transmisibles, para la prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles, como el VIH, la tuberculosis, la malaria y enfermedades tropicales desatendidas, buscando poner fin a más de 30 enfermedades y afecciones para 2030.
- Prevención y control de infecciones de enfermedades respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica (para

la prevención y control de infecciones respiratorias agudas que pueden generar epidemias o pandemias) ⁽⁸⁴⁾.

En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) implementa diversos planes y programas preventivos para abordar las principales necesidades de salud pública en el país. Entre la lista de los planes preventivos vigentes, se destacan los programas de:

- Salud sexual y reproductiva: enfocado en promover la salud sexual, prevenir enfermedades de transmisión sexual y garantizar servicios de planificación familiar.
- Tuberculosis: dirigido a la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de la tuberculosis para reducir su incidencia y mortalidad.
- Inmunizaciones: para aumentar la cobertura de vacunación y prevenir enfermedades inmunoprevenibles en la población.
- Control de enfermedades transmitidas por vectores: orientada a prevenir y controlar enfermedades como el dengue, malaria y Chikunguña y otras transmitidas por vectores como mosquitos.
- Enfermedades crónicas no transmisibles: Centrada en la prevención y control de enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes.

Estos programas se integran en la Misión Barrio Adentro del Sistema Público Nacional de Salud ⁽⁸⁵⁾.

En nuestro programa de APS se asume el conjunto de 23 planes preventivos establecidos por el MPPS y complementado los mismos con otros que se consideran necesarios para ampliar el espectro preventivo sobre otras patologías, como es el caso de la sepsis y que, si bien es cierto, no han sido formalmente asumidos globalmente, han sido propuestos por múltiples órganos sanitarios a nivel mundial.

La prevención, además de primaria, debe ser también secundaria, es decir, dirigida hacia la detección y tratamiento temprano de complicaciones surgidas luego de la ocurrencia de enfermedades severas, así como a la educación del paciente sobre su enfermedad y orientación acerca de las medidas que puede tomar para mejorar su estado de salud posterior a su padecimiento. Por tal sentido, incorporaremos planes de prevención secundaria, en el marco de nuestro programa de APS.

6.5 Asistencia médico-sanitaria

Las consultas médicas curativas son también uno de los componentes esenciales de la APS. Ellas complementan el marco de atención integral local, brindando asistencia médica inicial y precoz a las personas que presentan alguna enfermedad o condición de salud, conectándolas de forma directa con el nivel de alta complejidad del sistema local de salud en caso de ser necesario ⁽⁸⁶⁾.

El impacto de las consultas curativas en la APS es significativo, ya que contribuyen a la reducción de la morbilidad y la carga de los hospitales, promueven la equidad en el acceso a la salud, fomentan la adherencia a los tratamientos y ofrecen un contacto frecuente y cercano entre el equipo de salud y el paciente, lo que mejora los resultados clínicos y la satisfacción.

Estas consultas están orientadas a diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a las afecciones que ya se han manifestado, con el fin de lograr la recuperación del paciente, en su propio domicilio o ámbito comunitario, a fin de evitar complicaciones y requerimiento de ingreso en un hospital. De igual manera, se enfocan en la prevención secundaria, rehabilitación y cuidados paliativos de pacientes que han sufrido cuadros graves, catastróficos, padecen enfermedades terminales o irreversibles.

Las consultas curativas pueden clasificarse en diferentes tipos, según la naturaleza de la afección que se atiende. Las consultas por enfermedades agudas, como infecciones respiratorias o gastrointestinales, son comunes en la APS y suelen resolverse en el primer nivel de atención. Las consultas por enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas, suelen requerir un seguimiento constante y un manejo integral que incluya la valoración y orientación del especialista, quien debe igualmente estar conectado e interactuar directamente con el médico de APS.

Las consultas de urgencias menores, atienden heridas leves, quemaduras superficiales y alergias locales. Finalmente, las consultas de seguimiento deben realizarse para monitorear el estado de los pacientes después de un tratamiento o para el control de patologías crónicas ⁽⁸⁷⁾.

Las consultas curativas pueden también complementarse con el componente virtual de telemedicina, lo cual permite, en cualquier momento, el contacto virtual, no solo entre el médico de APS, el paciente y sus familiares, sino también con el resto del equipo de APS, los médicos especialistas y el sistema local de salud, en su conjunto.

7. Estrategia de intervención

La estrategia de intervención del presente programa de APS, contienen un conjunto de acciones planificadas y articuladas para poder responder de manera efectiva a las necesidades sanitarias de la población.

Esta estrategia inicia con la territorialización, entendida como la delimitación geográfica y demográfica del área de acción, lo cual permite conocer y clasificar a la población según sus características sociales, ambientales y epidemiológicas.

A partir de esta base, se desarrolla una organización funcional que establece redes y flujos de atención para garantizar el acceso equitativo, continuo y resolutivo a los servicios de salud. Los actos organizativos se refieren a la planificación, administración, identificación, distribución y coordinación de los recursos sanitarios, humanos y materiales disponibles para asegurar que los servicios sean accesibles, equitativos y sostenibles. Esto incluye la ubicación de los grupos humanos a ser atendidos, la asignación y organización de equipos multidisciplinarios, redes de referencia y sistemas de financiamiento que prioricen a las poblaciones más vulnerables.

Una vez que se tiene ubicada territorialmente y organizada la población objeto es preciso recopilar información detallada sobre las condiciones de vida, características demográficas, ambientales, económicas y sanitarias de una comunidad, esto se logra a través del censo sociosanitario y la ficha familiar de salud, la historia clínica personal y el tamizaje sanitario.

A través del censo sanitario se identifican determinantes sociales que afectan la salud, tales como el acceso a servicios básicos, la situación laboral, la escolaridad, el tipo de vivienda y la composición familiar. Esta información posibilita una planificación territorial más precisa que facilita la

distribución equitativa de recursos y servicios de salud con enfoque preventivo y comunitario.

La ficha social de salud complementa el censo, al profundizar en las particularidades de cada grupo familiar. Se trata de un instrumento que registra de manera sistemática la situación sanitaria, hábitos de vida, antecedentes familiares y riesgos específicos a los que están expuestos los integrantes del hogar. Su elaboración permite al equipo de salud obtener una visión integral y contextualizada del entorno familiar, facilitando la identificación temprana de factores de vulnerabilidad y promoviendo acciones focalizadas de promoción, prevención y asistencia.

Ambos instrumentos fortalecen el enfoque de salud colectiva y la corresponsabilidad social. En conjunto, permiten que la atención no se limite a lo clínico-individual, sino que abarque el entorno y las condiciones sociales, priorizando la equidad, la participación comunitaria y la acción intersectorial como principios rectores de la salud pública.

Se requiere particularizar la recolección de datos para la aplicación de la estrategia de APS por medio de la elaboración de una historia clínica a cada persona, ya que permite registrar de manera sistemática y continua la información relevante sobre el estado de salud de cada individuo. Este documento recoge los antecedentes personales y familiares, los hallazgos de los exámenes físicos, diagnósticos, tratamientos recibidos y la evolución clínica de cada sujeto. Su adecuada elaboración facilita la comprensión integral del contexto de salud de cada persona y proporciona una base sólida para la toma de decisiones clínicas informadas.

La historia clínica permite establecer líneas de cuidado individualizadas, adecuadas a las necesidades específicas del paciente, en

concordancia con las comunitarias. Además, sirve como medio de articulación entre los distintos componentes del sistema de salud, para promover la continuidad del cuidado en caso de derivación a niveles superiores. Su correcto uso fortalece la relación médico-paciente, mejora la calidad de los servicios prestados y facilita el monitoreo y la evaluación de las intervenciones en salud pública. En resumen, la historia clínica personal no solo es un registro técnico, sino una herramienta clave para garantizar una atención primaria centrada en la persona y orientada a la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.

La información obtenida debe ser complementada con una investigación adicional para identificar grupos de riesgo. Esto se logra mediante el "tamizaje sanitario". anteriormente descrito.

La información recopilada, es sometida a análisis a los fines de realizar el diagnóstico situacional de salud (DSS) del grupo, permitiendo este identificar los principales problemas y necesidades sanitarias del mismo. A través del DSS se pueden establecer líneas base para comparar avances, elaborar planes de acción basados en evidencia y mejor comprensión de las condiciones de vida, hábitos y causas de enfermedad y muerte en la población lo que permite potenciar la estrategia de intervención. Sobre lo anterior se formula el Plan de Salud, que orienta las acciones sanitarias con base en prioridades consensuadas y metas alcanzables.

Un plan de salud, en el proceso de la APS es un instrumento estratégico que organiza y prioriza las acciones de salud requeridas por una población, comunidad o persona, una vez formuladas las necesidades identificadas en el diagnóstico de salud.

Este plan debe ser factible, flexible, evaluable, cumplir con el principio de nominación contar con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles a este nivel y debe contar con el conocimiento la participación y aprobación de los responsables de su ejecución.

Tiene un carácter ético dado que es una investigación clínica epidemiológica y social que se realiza en el primer nivel de atención por lo que se debe mantener la confidencialidad de la información para que no afecte a los individuos ni las familias.

La implementación del plan se materializa a través de acciones claves como la promoción, la prevención en todos sus niveles; la educación e información para la salud, la rehabilitación y prevención secundaria.

Para que un programa de promoción de la salud sea efectivo, no solo debe estar bien

diseñado desde el punto de vista técnico, sino que debe ser accesible, comprensible y pertinente para la población destinataria. La promoción de metas sociales como el fomento de estilos de vida saludables requiere de métodos de comunicación eficaces, que garanticen la apropiación del mensaje por parte de la comunidad, asegurando así la sostenibilidad del impacto en el tiempo.

Los planes específicos de prevención y control de enfermedades son estrategias sistemáticas que buscan evitar la aparición de dolencias, disminuir su incidencia y limitar sus consecuencias negativas.

La educación para la salud es un recurso fundamental para que las personas puedan adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan al cuidado y promoción de su bienestar físico, mental y social y fomenta su capacidad para tomar decisiones informadas respecto a su salud, asumir estilos de vida saludables, brindarse autocuidado y prevenir enfermedades. El acceso a la educación y a la información es determinante para una participación efectiva y empoderamiento de las personas y comunidades ⁽⁹³⁾.

En el marco de APS, la información para la salud es un pilar clave que refuerza los principios de equidad, accesibilidad, participación comunitaria y apropiación de la salud por parte de la población. También complementa el acceso a servicios sanitarios con la capacidad de las personas para comprender y aplicar medidas preventivas en su vida cotidiana. Desde esta perspectiva, la información busca orientar y capacitar a los individuos para definir sus propios problemas y necesidades, ser proactivo frente a esos problemas y asumir las acciones apropiadas para fomentar una vida sana y el bienestar común ⁽⁹⁴⁾.

La información comunitaria tiene que ver con comunicar de manera efectiva a las personas, por medios de estrategias de comunicación culturalmente sensibles y medios accesibles, sobre sus derechos, los recursos disponibles, las prácticas preventivas y los avances generales en las ciencias de la salud, a efectos de empoderarlos comunicacionalmente e involucrarlos en su propio cuidado.

La rehabilitación, entendida como un conjunto de intervenciones orientadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad, es reconocida como un servicio esencial dentro de la Cobertura Sanitaria Universal. En este sentido, la APS debe enfocarse también en garantizar servicios de rehabilitación, y asegurar una adecuada articulación entre el nivel hospitalario y el comunitario, pues muchas

acciones pueden y deben realizarse fuera del entorno hospitalario. La rehabilitación en el marco de la APS es clave para una atención integral que incluya la recuperación funcional y la reintegración social, laboral y familiar de las personas con secuelas o discapacidades.

Los objetivos de la rehabilitación en APS incluyen maximizar la autonomía, restaurar la funcionalidad física y mental mediante intervenciones personalizadas (fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicológico), prevenir nuevas discapacidades a través del control adecuado de condiciones crónicas, promover el autocuidado y asegurar la continuidad de la rehabilitación en el hogar.

La rehabilitación y la prevención secundaria permiten reducir las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de enfermedades crónicas, discapacidades o secuelas de eventos agudos. Busca, además, restablecer o mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de las personas, lo cual promueve su reintegración familiar, laboral y comunitaria.

Por su parte, la prevención secundaria se enfoca en la detección temprana y el tratamiento oportuno a fin de evitar su progresión o complicaciones, una vez sucedidos eventos mórbidos altamente discapacitantes.

De este modo, la rehabilitación y la prevención secundaria no solo mejoran los resultados en salud, sino que también contribuyen a la equidad, al permitir que incluso las personas con condiciones limitantes puedan mantener su autonomía y participación activa en la sociedad.

Las consultas médicas curativas constituyen un componente esencial de la APS, ya que permiten brindar asistencia médica inicial, precoz y de seguimiento a personas con enfermedades o condiciones de salud, tanto nuevas como crónicas. Estas consultas no solo facilitan la recuperación del paciente en su entorno domiciliario, sino que evitan complicaciones y hospitalizaciones innecesarias, y articulan también la atención con niveles superiores de complejidad cuando se requiere. Además, desempeñan un papel clave en la prevención secundaria, al abordar complicaciones posteriores a enfermedades graves y educar al paciente sobre su autocuidado y medidas para mejorar su salud.

Estas consultas se clasifican en agudas, crónicas, urgencias menores y de seguimiento, cada una con abordajes específicos. Su impacto es significativo, pues mejoran la equidad en el acceso a la salud, reducen la morbilidad y la sobrecarga hospitalaria, y fortalecen el vínculo médico-paciente, favoreciendo mejores resultados

clínicos y mayor satisfacción en la atención. Esta estructura permite que el seguimiento de casos se realice en el entorno cotidiano del paciente, reduciendo hospitalizaciones innecesarias y fortaleciendo el vínculo entre el usuario y el sistema de salud.

Así, el médico de APS cumple una función clave en la integración entre el hogar, la comunidad y los servicios especializados, asegurando un modelo de atención centrado en la persona, oportuno, resolutivo y territorial.

La atención prehospitalaria y el traslado apropiado de pacientes permite brindar respuestas inmediatas y eficaces ante situaciones de urgencia o emergencia fuera del ámbito hospitalario y el direccionamiento apropiado de las víctimas hacia un centro de atención compleja. Esta atención temprana facilita la estabilización del paciente en el sitio del evento, reduce los riesgos de complicaciones graves y mejora significativamente las probabilidades de recuperación. Además, garantiza un primer contacto técnico calificado con el sistema de salud, particularmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde los servicios médicos especializados pueden estar distantes.

El transporte sanitario adecuado es clave para asegurar la continuidad de la atención, permitiendo el traslado seguro y oportuno de pacientes desde sus comunidades hacia centros de mayor complejidad cuando el caso lo requiere. Este debe realizarse en unidades equipadas, personal entrenado y protocolos claros de referencia y contrarreferencia, que articulen eficazmente los niveles de atención. En el marco de la APS, el transporte sanitario no solo cumple una función logística, sino que se convierte en una herramienta estratégica para garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales, optimizar recursos y reducir la mortalidad evitable, especialmente en contextos de emergencia médica o desastres.

La incorporación de los servicios prehospitales y el traslado adecuado de pacientes dentro de la APS fortalece el enfoque integral y continuo de la atención, en coherencia con los principios de accesibilidad, equidad y oportunidad.

Toda la información y datos generados en el marco del programa de APS, deben ser recopilados, almacenados y sistematizados electrónicamente. El registro electrónico de datos y la creación de una base de datos centralizada son herramientas fundamentales para el fortalecimiento de un programa de APS. Estos sistemas permiten recopilar, almacenar y gestionar de forma eficiente y segura la información clínica, epidemiológica y social de la población atendida, lo que facilita el seguimiento

continuo de cada paciente, la detección temprana de riesgos, la planificación de intervenciones y la coordinación entre los distintos niveles de atención. Además, garantizan la trazabilidad de los servicios prestados, promueven la equidad en el acceso a la atención y mejoran la calidad de las decisiones clínicas al ofrecer información completa y actualizada en tiempo real.

La base de datos generada a partir de estos registros constituye un recurso estratégico para el análisis situacional de salud, la vigilancia epidemiológica, la identificación de grupos vulnerables y la evaluación de los resultados en salud. Permite también optimizar la asignación de recursos, diseñar políticas basadas en evidencia y establecer indicadores de desempeño para el monitoreo y mejora continua del programa. Así, el uso adecuado del registro electrónico de datos no solo moderniza y agiliza los procesos asistenciales, sino que también transforma la APS en un sistema más eficiente, transparente.

7.1 Territorialización

El universo de familias será distribuido equitativamente en cuatro cuadrantes en el que se dividirá hipotéticamente la ciudad: dos al sur y dos al norte, estableciéndose como hito norte-sur la avenida La Limpia y como hito este-oeste, la Circunvalación número uno y Delicias, con prolongación Fuerzas Armadas. En cada uno de dichos cuadrantes se asentarán setenta y cinco mil (75000) personas o quince mil (15000) familias. En su conjunto constituirán 4 Zonas Integrales de Salud (ZIS) (Fig. 3).

A cada una de dichas familias se les asignará un número catastral, de la misma

manera que se le designará un número de identificación sanitaria a cada individuo del universo poblacional. Tal información será contenida en un sistema georreferencial digitalizado, de registro y manejo de datos electrónicos.

Un equipo de promoción de salud realizará la sectorización sanitaria, ubicando geográficamente los grupos de quinientas (500) familias bajo su responsabilidad. De esta manera, se construirá la pirámide poblacional del universo en cuestión, de conformidad, con la pirámide poblacional de la nación, según la cual, los grupos etarios a ser atendidos dentro de la población incluida en el proyecto-programa, se encontrarán distribuidos como se muestra en la tabla 1.

En la tabla 1 se puede observar que la población universo a ser atendida por el programa, en ocho (8) subpoblaciones en correspondencia con la pirámide poblacional de la nación, responden a una distribución gaussiana, encontrando en el centro de la curva el subgrupo mayoritario constituido por los adultos jóvenes, los cuales representan el 44% de la población total. Hacia el extremo izquierdo de la curva se ubicarán los subgrupos de menor edad, integrados por los infantes y preescolares, escolares, púberes y adolescentes con un valor porcentual, cada uno, entre 8 y 9%. Hacia el extremo derecho de la curva se ubicarán los subgrupos de mayor edad, entre los que se incluyen los adultos menores, los adultos mayores y los ancianos, con valores porcentuales que van de entre un 12%, para el segmento menos longevo de estos subgrupos y un 4%, para el más longevo, en el cierre de la curva, tal y como puede observarse en la figura 4.

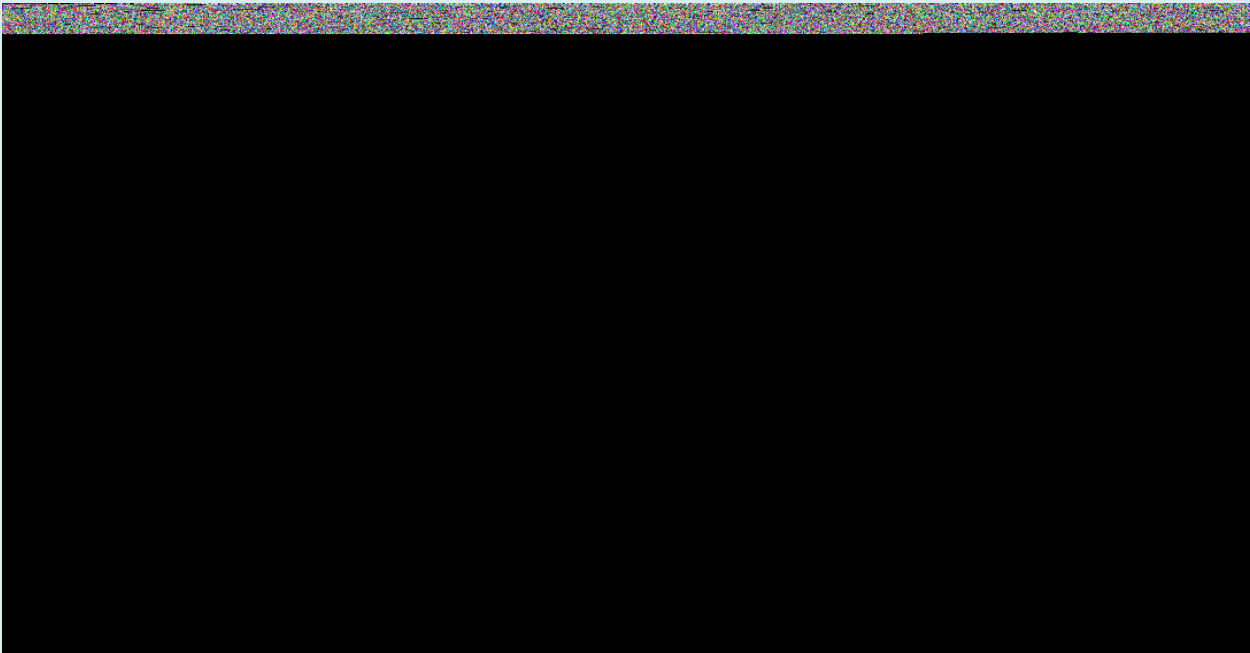


Figura 3. Sectorización de la ciudad de Maracaibo.

Al ampliar dichos grupos etarios a ser atendidos, la población universo del programa, quedará dividida en 4 subpoblaciones ampliadas, tal y como puede observarse en la tabla 2.

Estos grupos mantienen una distribución gaussiana, teniendo el centro de la curva el subgrupo mayoritario constituido por los adultos, los cuales representan el 62% de la población total. Hacia el extremo izquierdo de la curva se ubicarán los subgrupos de menor edad, integrados

por los niños y jóvenes, con un valor porcentual, cada uno del 18 y el 16% respectivamente. Hacia el extremo derecho de la curva se ubicará el subgrupo de mayor edad, conformado por los ancianos, con un valor porcentual del 4%, como se muestra en la figura 5.

Al aplicar la misma composición de la pirámide poblacional venezolana a una Zona Integral de Salud (ZIS), se obtiene como resultado la población que se espera atender (tabla 3).

TABLA 1
GRUPOS ETARIOS A SER ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APS, EN EL SILOS, POR GRUPOS ETARIOS Y SEXO, SEGÚN LA PIRÁMIDE POBLACIONAL DE VENEZUELA 2013

Grupo	Total	%	Masculinos	%	Femeninos	%
Infantes y Pre escolares (< de 4 años)	27000	9	13770	51	13230	49
Escolares	27000	9	13770	51	13230	49
Púberes	24000	8	12240	51	11760	49
Adolescentes	24000	8	12240	51	11760	49
Adultos jóvenes (20-49 años)	132000	44	66000	50	66000	50
Adultos menores (50-60 años)	36000	12	17640	49	18360	51
Adultos mayores (60-70 años)	18000	6	8640	48	9360	52
Ancianos (>70)	12000	4	5160	43	6840	57
Total	300000	100	149463	-	150540	-

Fuente: Elaboración propia.

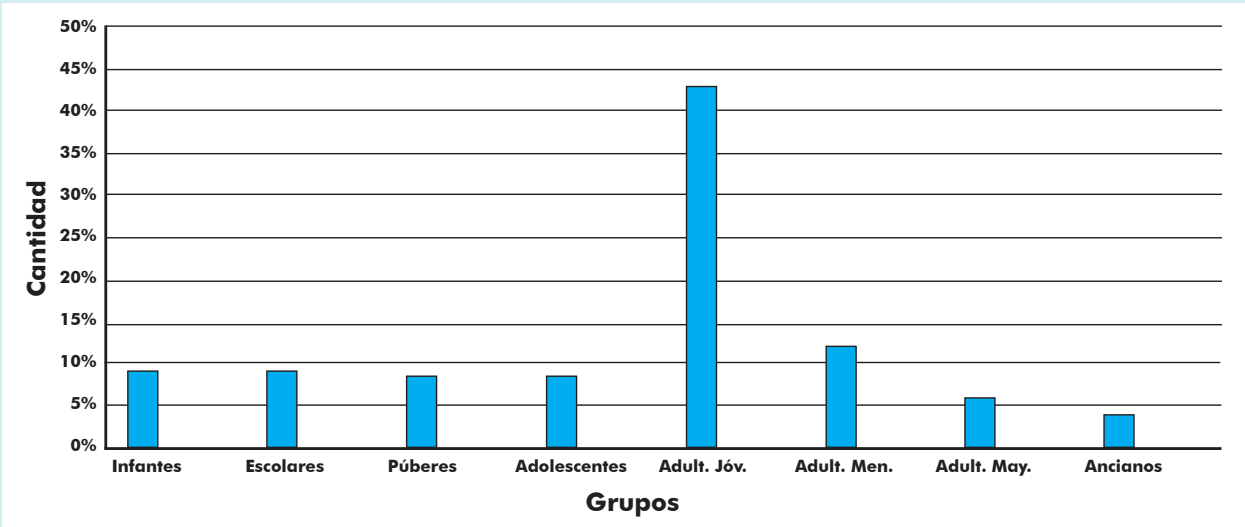


Figura 4. Pacientes esperados en el Programa de APS de Fundapineda por Grupos Etarios, según la pirámide poblacional de Venezuela 2013.

TABLA 2
PACIENTES ESPERADOS EN PROGRAMA DE APS DE FUNDAPINEDA POR GRUPOS ETARIOS AMPLIADOS, SEGÚN LA PIRÁMIDE POBLACIONAL DE VENEZUELA 2013

Grupo	Total	%	Masculinos	%	Femeninos	%
Niños	54000	18	26460	49	27540	51
Jóvenes	48000	16	23520	49	24480	51
Adultos	186000	62	94860	51	91140	49
Ancianos	12000	4	6864	57	5160	43
Total	300000	100	151680	-	148320	-

Fuente: Elaboración propia.

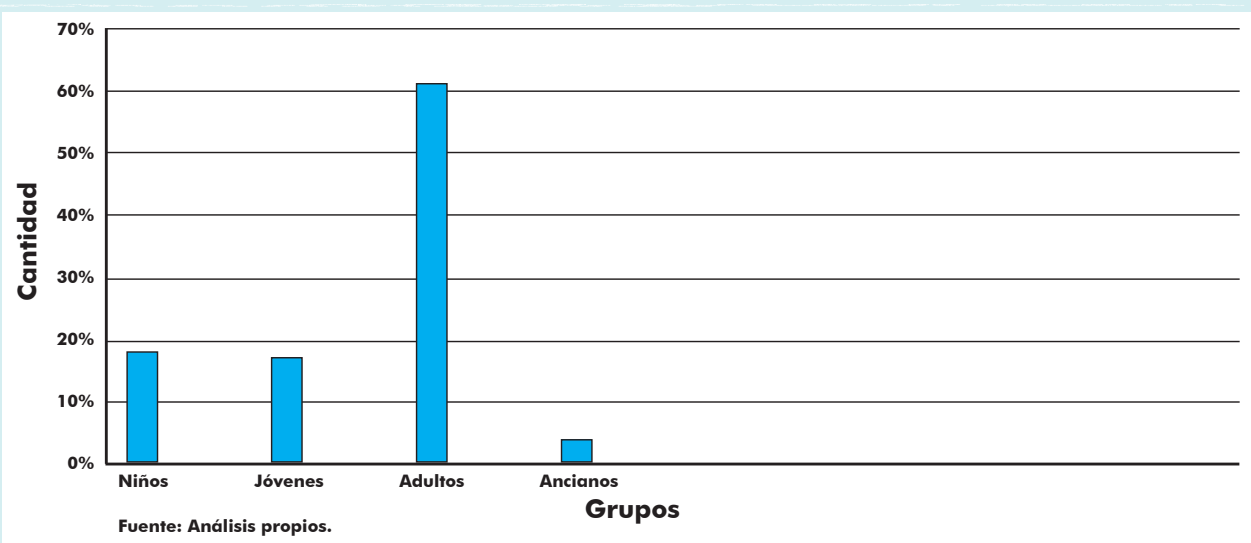


Figura 5. Pacientes esperados en el Programa de APS de Fundapineda por Grupos Etarios Ampliados, según la pirámide poblacional de Venezuela 2013.

TABLA 3
GRUPOS ETARIOS A SER ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APS, EN UNA ZIS, POR GRUPOS ETARIOS Y SEXO, SEGÚN LA PIRÁMIDE POBLACIONAL DE VENEZUELA 2013

Grupo	Total	%	Masculinos	%	Femeninos	%
Infantes y Pre escolares (< de 4 años)	6750	9	3443	51	3307	49
Escolares	6750	9	3443	51	3307	49
Púberes	6000	8	3060	51	2940	49
Adolescentes	6000	8	3060	51	2940	49
Adultos jóvenes (20-49 años)	33000	44	16500	50	16500	50
Adultos menores (50-60 años)	9000	12	4410	49	4590	51
Adultos mayores (60-70 años)	4500	6	2160	48	2340	52
Ancianos (>70)	3000	4	1290	43	1710	57
Total	75000	100	37366	-	37634	-

Fuente: Elaboración propia.

7.2 Organización funcional

La OMS señala que, para garantizar una prestación adecuada de servicios de salud esenciales, se requiere un mínimo de 23 profesionales de salud –incluyendo médicos, enfermeros y obstetras– por cada 10.000 habitantes, lo que equivale a 2.3 profesionales por cada 1.000 personas o 200 familias. Esta cifra, sin embargo, no especifica una proporción exacta de médicos por cada 1.000 habitantes, ya que la composición del personal de salud puede variar según las necesidades y recursos de cada país ⁽⁵⁶⁾. De lo anterior se desprende que una unidad básica de servicios sanitarios deberá estar integrada idealmente por 250 familias y un equipo de salud conformado por al menos un médico, una enfermera y un promotor de APS.

Cada familia deberá manifestar su decisión voluntaria de adscribirse al programa y a través de éste al P.A.A.I.S. y a nuestro sistema local de salud, por medio de un oficio suscrito por el jefe o representante del núcleo familiar (anexo 1).

Las trescientas mil personas o sesenta mil (60.000) familias, que constituirán nuestro SILOS, serán sectorizadas en ciento veinte (120) Unidades Básicas de Atención Primaria en Salud (UBAPS), en las cuales se asignará un Equipo de Promoción de Salud (EPS), integrado por un(a) médico(ca), un(a) enfermero(a) y un(a) promotor(a) comunitario(a), responsable por la salud de grupos de quinientas (500) familias, aplicando un Programa Básico de APS. A este equipo, se sumará un(a) médico(a) odontólogo(a), un(a) médico(a) veterinario(a), un(a) nutricionista, un(a) psiquiatra o psicólogo(a), por cada cuatro (4) UBAPS.

Para conformar las 30 Unidades Integrales de Atención Primaria en Salud (UIAPS), se organizarán con base en diez mil (10000) personas o 2000 familias, en cada una de las cuales se aplicará un Programa Integral de APS, y en su conjunto, conformaran una ZIS. Las unidades funcionales contenidas en cada una de las ZIS, estarán adscritas a una Clínica Integral de salud que, junto al resto de los componentes del sistema, se adscribirá a su vez a un hospital general

–cabecera del SILOS– con 300 camas de hospitalización, todo integrada, por medio de un Sistema de Traslado y Atención Pre hospitalaria de pacientes (SAPHTP) (Fig. 6).

7.3 Censo socio sanitario y ficha familiar

Se elaborará un levantamiento demográfico por medio de un censo socio sanitario, con una ficha social de salud para cada familia (anexos 2-4), para conocer las características de la población y condiciones socioeconómicas, mediante la recolección de datos relacionados con la ubicación, escolaridad, ocupación, clasificación estructural de la vivienda, hacinamiento, necesidades básicas, patologías, riesgo social, cumplimiento del esquema de vacunación, embarazadas, discapacidades, riesgos ambientales, etc. Asimismo, permitirá identificar a cada persona, asignarle una identificación sanitaria, estructurar los grupos poblacionales y grupos con requerimientos de atención.

7.4 Historia clínica personal

A cada sujeto del universo poblacional objeto de este programa de APS, se le elaborará una historia clínica, contentiva de un número de serie, historial de vida (antecedentes alérgicos, patológicos, quirúrgicos, psico-biológicos, gineco obstétricos y familiares), examen físico (signos vitales y hallazgos importantes en por órganos y sistemas corporales), hallazgos de laboratorio, otros paraclínicos diagnósticos (electrocardiografía transtorácica, radiografía de tórax, etc.), diagnósticos principales y tratamientos requeridos (anexos 5 y 6).

7.5 Tamizaje

Para la operativización del diagnóstico, se aplicará como herramienta el protocolo de tamizaje y diagnóstico precoz de enfermedades propuesto por la United States Preventive Services Task Force (USPSTF) ⁽⁷⁴⁾, de manera que, a cada persona, se le aplicará considerando variables como edad, sexo, peso, estado gestacional, tabaquismo y actividad sexual. Esto permitirá establecer una condición clínica, riesgo, prueba a aplicar, actividad preventiva y frecuencia de control, según corresponda durante el ciclo de ejecución del programa (anexo 7).

7.6 Diagnóstico grupal de salud

Se realizará un diagnóstico preliminar sobre el estado de salud de todos los sujetos del grupo, al momento de ingresar al programa, con la finalidad de conocer integralmente las condiciones de vida, los factores de riesgo y las necesidades sanitarias de cada integrante de la población desde la perspectiva grupal.

Con la información recolectada a través de la sectorización sanitaria, el censo sociosanitario, las fichas familiares, las historias clínicas, y el tamizaje sanitario, se realizará el DSS para conocer a fondo la condición morbil y los riesgos de morbimortalidad potenciales de la población objeto.

Toda la información obtenida será vaciada en una plataforma digital de datos, y con base a ella se realizará el análisis y se definirán las líneas de acción para atender a personas, familias y grupos en cada UBAPS, UIAPS y ZIS.

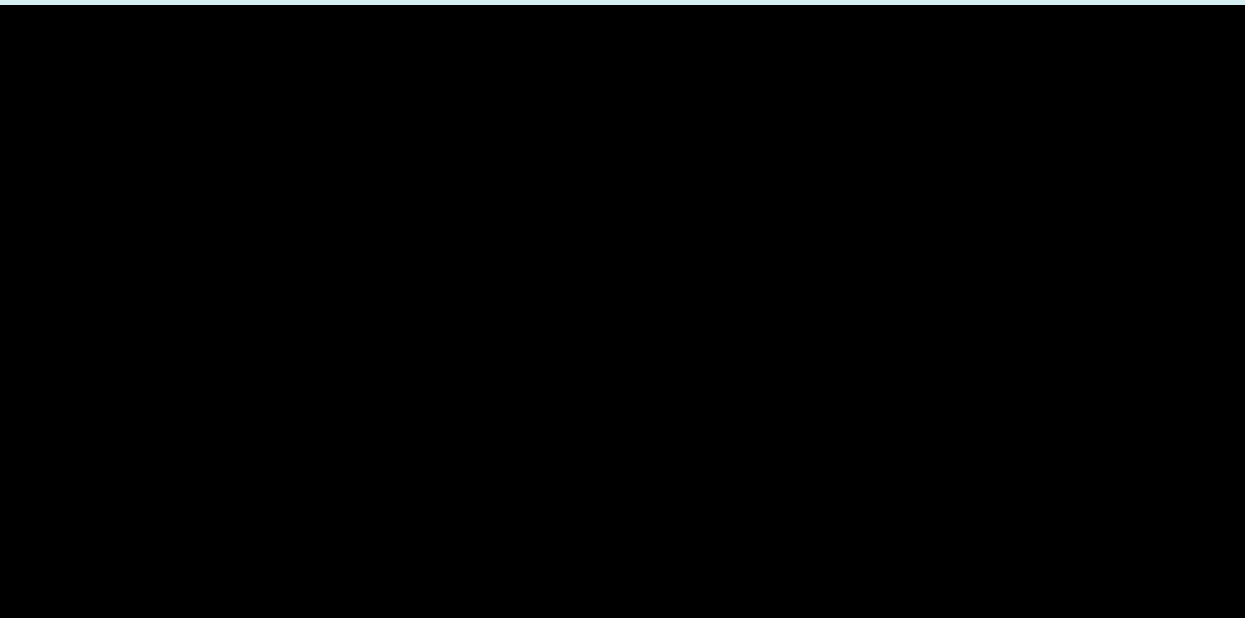


Figura 6. Organización funcional del Sistema Local de Salud Hospital de la Misericordia, basado en la APS Dr. Gustavo Pineda.

El análisis de la situación de salud de cada área se estructurará de la siguiente manera:

- Capítulo I: Caracterización del territorio, teniendo en cuenta la situación geográfica, socio-histórica y económica cultural.
- Capítulo II: Caracterización demográfica según distribución de edad y sexo, con la construcción de la pirámide poblacional.
- Capítulo III: Condiciones de vida social y económica desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud y los enfoques diferenciales y territoriales (Nivel escolar, ocupación, desempleo, ingreso percapita familiar, condiciones de las viviendas, etc.)
- Capítulo IV: Situación de salud y análisis epidemiológico, a partir de la estratificación de la población según categorías de la dispensarización (morbilidad, mortalidad, natalidad, estado inmunológico, cumplimiento de los programas preventivos, principales factores de riesgo, patologías y discapacidades de la población).
- Capítulo V: Atención médica y uso de servicios de salud (consultas médicas, tratamientos, seguimientos a pacientes crónicos, rehabilitación y cuidados paliativos, servicios post hospitalarios, apoyo a adultos mayores, dotación de insumos y capacitación del personal, etc.).
- Capítulo VI: Determinación de problemas con participación comunitaria (identificación de los problemas que afectan a la población, liderazgo comunitario).
- Capítulo VII: Plan de acción. Partirá de la priorización de problemas y necesidades sociales de la salud en el territorio.

Los elementos a desarrollar por capítulos en el DSS, se detallan en el cuadro 1.

7.7 Plan de salud

Los determinantes sociales, epidemiológicos, demográficos y económicos, identificados en el censo socio sanitario serán abordados en el plan de salud o de bienestar social, con el objeto de precisar las necesidades de salud insatisfechas, los riesgos prioritarios y mejorar las condiciones del entorno, que inciden directa e indirectamente en la salud de los grupos comunitarios y familiares.

Los problemas serán priorizados según su magnitud, impacto y capacidad de intervención, las prioridades estratégicas serán seleccionadas basadas en criterios técnicos y participativos, definiendo objetivos y metas específicos y medibles. También se establecerán los tiempos estimados

para su cumplimiento y se diseñarán las intervenciones y acciones, basadas en evidencias (tales como programas de vacunación, control de enfermedades crónicas y educación sanitaria), se identificarán y asignarán los recursos humanos, financieros y logísticos disponibles. Se definirán responsables y cronogramas para cada acción y se diseñará un sistema de seguimiento para medir el progreso hacia los objetivos, se establecerán indicadores de resultado e impacto y se crearán los mecanismos de retroalimentación y reajustes.

Los datos obtenidos de las fichas familiares, historias clínicas de las personas y los protocolos de tamizaje para cada subgrupo poblacional, se correlacionarán con la información brindada en el último informe de morbilidad y mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), con base a lo cual se identificarán y construirán grupos de riesgo en la población objeto y se establecerán objetivos prioritarios de salud para cada grupo, familia y/o personas, sobre la base de las necesidades detectadas.

Se redactará, en consecuencia, un respectivo Plan de Salud para cada quinientas (500) familias o UBAPS y se aplicarán los programas específicos de promoción, prevención, educación, información y asistencia médica primaria, a cada grupo, tanto en el propio domicilio familiar como en las instalaciones de la Clínica Integral de Salud –cuando sea requerido–. Esto se realizará según el cuadro 2.

Cada equipo de promoción de salud (EPS, en general, y cada uno de sus miembros en particular, será el responsable de velar por la atención y acompañamiento en la salud de todos y cada uno de los miembros de las respectivas familias que les han sido asignadas en su respectiva UBAPS, fungiendo como médico, enfermera o promotor de cabecera, a quienes atenderán a través de consultas domiciliarias programadas o por medio de tele consultas regulares y/o comunidades virtuales.

7.8 Promoción

Las acciones de promoción se operacionalizarán mediante acciones, tales como campañas de vacunación, impulso de leyes, decretos y ordenanzas, promover la mejora del saneamiento ambiental, impulsar la participación comunitaria, formación de promotores de salud y realización de consultas preventivas periódicas.

Se utilizará el marketing social –entendido como la aplicación de las técnicas del marketing comercial– para el análisis,

CUADRO 1
ELEMENTOS A DESARROLLAR POR CAPÍTULOS

Capítulo	Descripción
I	<u>Situación geográfica</u>: Límites territoriales, extensión en km2, accidentes geográficos, características climáticas. <u>Recursos naturales</u>: Recursos naturales existentes y beneficios de éstos en la salud de la comunidad. <u>Aspectos históricos</u>: Hechos históricos acaecidos o relacionados con el origen y desarrollo de la comunidad. <u>Organización social</u>: Cantidad de juntas de vecinos, consejos comunales y otras organizaciones comunitarias. <u>Recursos y servicios</u>: Centros de producción y servicios, instituciones educativas, culturales, deportivas religiosas, centros de recreación, expendio de alimentos, medios de trasporte, vías de comunicación, electrificación, acceso a internet.
II	<u>Caracterización demográfica de la población</u>: Distribución según edad y sexo, confección de la pirámide poblacional.
III	<u>Nivel de escolaridad de la población</u>: Analfabetas, primaria sin terminar, primaria, bachillerato sin terminar, bachiller, Técnico superior, universitario, abandono escolar. <u>Dedicación y ocupación</u>: Ocupación, desempleo, ingreso percapita familiar. <u>Dependencia</u>: Personas menores de 18 y mayores de 60 dependientes de la población económicamente activa. <u>Familias</u>: Tipos (Según ontogénesis y número de integrantes) <u>Fecundidad</u>: Mujeres en edad fértil e hijos. <u>Migraciones</u>: Características migratorias.
IV	<u>Dispensarización</u>: categorías (I, II, III y IV) <u>Riesgos</u>: Sociales (Potencial delictivo, marginalidad, drogadicción) laborales (Radiaciones, ruidos, exposición a sustancias nocivas). Genéticos (Sicklemlia, enfermedad de Wilson, síndrome Down). <u>Comportamientos de riesgo a la salud</u>: Tabaquismo, sedentarismo, higiene bucal deficiente, desorganización familiar, violencia. <u>Pesquisaje de cáncer</u>: Cérvico uterino, mama, piel, próstata, bucal y colon. <u>Riesgo pre concepcional</u>: Tipo y si están controladas o no (Método usado). <u>Morbilidad</u>: Principales patologías. <u>Nacimientos en el año</u>: Captación de lactantes (Precoz, tardía). <u>Lactancia materna</u>. <u>Mortalidad</u>: Causas. <u>Atención odontológica</u>: Prevención escolar con flúor, consultas odontológicas, problemas de salud bucal, mal oclusiones y adentes. <u>Nivel inmunitario de la población</u>: Vacunas colocada en el año, según esquema (Las correspondientes y las no colocadas). <u>Accidentes</u>: Por edad y sexo, tipos. <u>Discapacidad</u>: Identificar incidencia y prevalencia por tipo y etiología según sexo y edad.
V	<u>Consultas médicas</u>: Medicina general, pediatría, gineco obstetricia, salud mental. <u>Referencias a otras especialidades</u> <u>Ingresos en el hogar</u> <u>Cuidados paliativos y post hospitalarios</u> <u>Nivel de dotación de insumos y medicamentos</u>

CUADRO 2
COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN

Problemas identificados con orden de prioridad	Propósito y motivación del cambio (esbozo del cambio).	Tareas o actividades (concretas y con participación activa de la población)	Indicadores de evaluación	Diseño del plan de acción fechas de cumplimiento, responsables, recursos
--	--	---	---------------------------	--

planeamiento, ejecución y evaluación de los planes destinados a influir en el comportamiento voluntario de nuestra audiencia objetivo, en búsqueda de mejorar su bienestar personal y el de la sociedad ⁽⁷⁸⁾. Esto dado que, nos servirá para estudiar e investigar las características de nuestros destinatarios (sus preferencias, necesidades, expectativas), con el fin de satisfacerlas, por medio de preguntas y escuchas, con el fin de captar lo que dicen, piensan, desean y necesitan, para lo cual usaremos diversas técnicas, tales como las encuestas y entrevistas.

Del mismo modo, utilizaremos los medios de comunicación, la publicidad y otras estrategias de comunicación masiva, dado que estas pueden ser efectivas para promover hábitos alimenticios, sexuales, higiénicos más saludables, al tener poderosos efectos en la introducción de mensajes saludables en estilos de vida. El objetivo es la promoción de la salud en nuestra población, a partir de la ampliación de sus conocimientos, del fomento de cambios de actitudes y conductas; se aspira influir en los políticos y tomadores de decisión sobre la política de salud.

En el cuadro 3 mostramos un ejemplo de lo que podría ser un plan de promoción de la salud para una comunidad de usuarios adscrita a una UBAPS.

7.9 Prevención

El presente Programa de APS, tiene contenido una lista de 25 planes preventivos específicos (anexo 8), los cuales serán ejecutados sobre cada uno de los grupos de riesgo y enfermos identificados. Entre dichos planes se encuentran todos los pautados

por el MPPS y otros adicionales que hemos considerado adecuado agregar. Estos son:

- 1. Plan ampliado de inmunizaciones.
- 2. Plan preventivo de atención lactantes y preescolares.
- 3. Plan preventivo de atención al escolar.
- 4. Plan de atención a adolescentes.
- 5. Plan preventivo de atención al adulto.
- 6. Plan preventivo de atención al adulto mayor.
- 7. Plan preventivo de atención materno-neonatal.
- 8. Plan preventivo de planificación familiar.
- 9. Plan preventivo de atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad.
- 10. Plan preventivo de atención y control de enfermedades infecto-contagiosas (Salmonelosis, Brucelosis, Hepatitis, EDA).
- 11. Plan preventivo de atención y control de enfermedades crónicas (ITS/VIH/SIDA, enfermedades respiratorias, -TB, AB-, enfermedades cardiovasculares -HTA, ICC, arritmias, enfermedad vascular periférica, enfermedad renal crónica).
- 12. Plan preventivo de atención y control de enfermedades neoplásicas (Ca de mama, Ca de cuello cérvico-uterino, Ca de próstata).
- 13. Plan preventivo para el manejo y control de las zoonosis (rabia, leptospirosis, accidentes ofídicos).
- 14. Plan preventivo de accidentes y hechos violentos.
- 15. Plan preventivo de atención y control de enfermedades tropicales (Chagas, dengue, malaria, paludismo, toxoplasmosis).

CUADRO 3
EJEMPLO DE UN PLAN DE PROMOCIÓN DE SALUD

Área	Intervención	Descripción	Población meta	Resultados esperados
Políticas públicas.	Campaña antitabaco.	Reducción del consumo de tabaco mediante leyes y campañas.	Adolescentes y adultos fumadores.	Disminución de la prevalencia de tabaquismo.
Entornos saludables.	Instalación de parques y áreas recreativas	Promoción de la actividad física en la comunidad.	Niños, jóvenes y adultos.	Incremento de la actividad física regular.
Participación comunitaria.	Promotores de salud comunitarios	Capacitación de líderes locales en prevención y autocuidado.	Líderes comunitarios.	Mayor participación y corresponsabilidad ciudadana.
Educación para la salud.	Talleres sobre alimentación saludable.	Sesiones educativas sobre nutrición y prevención de obesidad.	Mares, niños y adolescentes.	Reducción de los índices de obesidad infantil.
Servicios de salud reorientados	Consultas preventivas regulares	Chequeos anuales de salud para la detección temprana de riesgos.	Población general.	Reducción de enfermedades prevenibles y complicaciones.

16. Plan preventivo de atención y control de infecciones por coronavirus.
17. Plan preventivo de atención y manejo de la salud mental.
18. Plan preventivo de atención y manejo de la salud bucal.
19. Plan preventivo de atención y manejo de adicciones.
20. Plan preventivo de atención y control nutricional.
21. Plan preventivo de salud ambiental.
22. Plan preventivo de atención y control de los trastornos del neurodesarrollo.
23. Plan de prevención, diagnóstico y manejo precoz de la sepsis.
24. Plan preventivo de atención a la ciudadanía.
25. Plan rehabilitación y prevención secundaria.

7.10 Educación e información para la salud

El proceso de educación e información para la salud se cumplirá mediante actividades sistemáticas, como charlas comunitarias sobre tópicos relacionados con alimentación saludable, actividad física, control del estrés, etc.; distribución de material informativo (folletos y cartillas ilustradas que explican cómo identificar los síntomas de alerta de enfermedades y qué hacer en caso de emergencia); talleres de cocina saludable (clases prácticas dirigidas por nutricionistas donde los participantes aprendan a preparar comidas saludables); evaluaciones periódicas de salud (jornadas gratuitas de medición de presión arterial, glucemia y peso corporal, con consejería personalizada para quienes presenten factores de riesgo); formación de líderes comunitarios (capacitación a miembros de la comunidad para que actúen como promotores de salud y fomenten el autocuidado y la participación activa en las actividades del programa); creación de una página web educativa abierta y creación de chat, canales virtuales y emisión de mensajes en redes sociales, entre otras.

7.11 Rehabilitación y prevención secundaria

Se realizarán actividades enfocadas en garantizar la recuperación funcional, social y emocional de las personas que han sufrido eventos de salud crónicos o agudos, como enfermedades cardiovasculares, neurológicas, metabólicas o traumatismos, entre otras. Para ello, se implementarán acciones comunitarias e individuales para la detección precoz de secuelas, la provisión de

terapias físicas, ocupacionales y psicológicas, así como el acompañamiento familiar y social. También es esencial promover la adherencia a tratamientos médicos, el control clínico periódico y la educación sanitaria sobre los signos de alarma para evitar recaídas y nuevas complicaciones.

Estas acciones deben estar integradas al modelo de salud local, a través del trabajo conjunto entre equipos multidisciplinarios de salud, promotores comunitarios, redes familiares y servicios sociales, asegurando la continuidad del cuidado desde el primer nivel. Además, deben establecerse protocolos de seguimiento y evaluación, programas de visitas domiciliarias y espacios comunitarios de apoyo, con énfasis en la equidad y el acceso universal, teniendo como prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad. Con ello se busca reducir la discapacidad, prevenir nuevas hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida de la población afectada, y contribuir al fortalecimiento del enfoque integral de la APS.

7.12 Asistencia médica primaria

El médico general de la APS coordinará y vigilará activamente la salud individual y colectiva en la UBAPS a su cargo, y realizará visitas domiciliarias programadas y por demanda, para identificar factores de riesgo, controlar enfermedades crónicas y promover hábitos saludables. Estas consultas están orientadas al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades, con el objetivo de lograr la recuperación del paciente en su entorno domiciliario o comunitario, evitando complicaciones y hospitalizaciones. También cumplen una función clave en la detección temprana de complicaciones y en la educación del paciente sobre el manejo de su enfermedad.

Se resalta la labor del médico, la cual se complementa con equipos interdisciplinarios que incluyen enfermeros, promotores de salud y técnicos comunitarios, quienes facilitan la conexión directa con las familias y comunidades, recolectan información social y sanitaria y refuerzan la adherencia al tratamiento y autocuidado, personalizadas y culturalmente adecuadas, reforzando la participación activa de la comunidad en el cuidado de su propia salud.

Cuando un(a) paciente demande una consulta curativa por parte de un(a) Médico(a) General o Especialista, la solicitará al EPS y esta se cumplirá vía tele consulta, consulta domiciliaria o, en el consultorio de la Clínica Integral de Salud.

Durante una consulta curativa, el médico de APS recoge la demanda de atención,

consulta el historial clínico y sociofamiliar del paciente y establece un clima de confianza previamente construido a través del contacto cotidiano con las familias atendidas. Luego realiza la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico y el plan de tratamiento, que puede incluir medicamentos, recomendaciones de estilo de vida, remisiones y visitas de control. Estas consultas se clasifican según el tipo de afección: agudas, crónicas, urgencias menores y de seguimiento.

Si se requiere una valoración por un especialista, el médico general actuará como enlace, presentará el caso y solicitará la interconsulta. El médico especialista podrá dar sus sugerencias o podrá asumir el caso, interactuando directamente con el paciente y su familia a través de la video consulta o citar a los mismos al consultorio o Clínica.

Cuando la condición del paciente sobrepase claramente las capacidades resolutorias del primer nivel, el médico general debe articular con los médicos especialistas del sistema local de salud para asegurar la referencia oportuna y efectiva. En situaciones que requieran intervención urgente o traslado, debe activarse el componente de atención prehospitalaria, gestionado por el personal entrenado en emergencias, con medios de transporte adecuados según la gravedad del caso. Este traslado debe garantizar la continuidad del cuidado mediante la entrega de información clínica relevante y la agilización del ingreso al segundo o tercer nivel de atención.

La hoja de ruta se completa con un sistema de contrarreferencia que asegure el regreso del paciente al entorno comunitario con un plan terapéutico, de rehabilitación y de seguimiento supervisado por el médico de cabecera, consolidando un circuito de atención integrado, humanizado y territorializado.

7.13 Atención pre hospitalaria y el traslado de pacientes

En caso de ser requerido, los pacientes serán trasladados hacia la Clínica Integral de salud, hospital o cualquier sitio que sea requerido para consulta de emergencia, valoración por especialista, realización de estudios u hospitalización en caso necesario. Este traslado será hecho por la Unidad de Atención Prehospitalaria (UAPH) en una Ambulancia de Soporte Básico Paramédico

(ASBP) o en una Ambulancia de Soporte Avanzado Medicalizada (ASAM), adecuadas para ello y suficientemente equipadas.

La atención prehospitalaria será brindada por personal capacitado que establezca al paciente en el sitio del evento, brinde los primeros auxilios, valore la gravedad del cuadro clínico y garantice decisiones oportunas de derivación y coordinadas con el sistema de referencia y contrarreferencia, priorizando la continuidad del cuidado, la seguridad del paciente y la comunicación fluida entre el equipo de salud comunitario, el médico general de cabecera y el nivel hospitalario receptor.

Cuando se trate de consulta de emergencia, el paciente dispondrá de una valoración inicial de triaje, a partir de la cual, podrá ser derivado hacia servicios de reanimación, quirófanos, cirugía ambulatoria, hemodinamia, trauma shock, consultorios, reducción y yeso, terapia respiratoria, hospitalización, cuidados intensivos, cuidados coronarios, unidad de quemados, cuidados paliativos o rehabilitación.

Una vez que la condición mórbida del paciente haya sido resuelta o aliviada con los servicios intrahospitalarios, este será remitido a su médico y equipo de APS, quienes continuarán su atención rutinaria y/o de prevención secundaria, en caso de que haya ocurrido una patología con propensión a complicaciones posteriores.

7.14 El registro electrónico de datos

Todo el proceso de atención será documentado e integrado en una plataforma automatizada, compuesta por el censo sociosanitario, las fichas familiares, las historias clínicas electrónicas, tamizaje, un chip personalizado, un sistema geo referencial y un sistema electrónico de registro médico, epidemiológico, administrativo y estadístico.

El sistema permitirá el acceso ágil, actualizado y coordinado a toda la base de datos, garantizando la confidencialidad y seguridad de los datos conforme a las normativas de protección de la información. Además, facilitará la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de pacientes crónicos, la planificación de intervenciones comunitarias y la evaluación de los indicadores de salud.

8. Sistema y operacionalización de variables

Este Programa se realizará sobre la base de las siguientes 16 variables cuantitativas continuas:

1. Ubicación geo-referencial de cada grupo familiar.
2. Realización de censo socio-sanitario del grupo comunitario.
3. Caracterización de cada grupo familiar de la comunidad.
4. Elaboración de historia clínica a cada miembro de la familia.
5. Construcción de la pirámide poblacional.
6. Aplicación de tamizaje en los subgrupos poblacionales.
7. Diseño del plan sanitario.
8. Ejecución de los planes preventivos específicos de salud, pautado por las autoridades sanitarias, según corresponda.
9. Ejecución de programa de educación sanitaria específico, en cada persona y grupo de riesgo.
10. Promoción de la salud, en las personas y grupos poblacionales, para modificar

los factores ambientales, que inciden de manera negativa.

11. Fortalecimiento de las personas, y grupos comunitarios mediante información sanitaria, para la toma de decisiones sobre la salud.
12. Prestación de asistencia médica primaria.
13. Proporcionamiento de alternativas de rehabilitación y prevención secundaria.
14. Casuística de morbilidad según el axioma de Kerr White.
15. Vinculación de la población asistida con los niveles de atención de salud del sistema nacional de salud, en los casos que corresponda.
16. Creación de un banco de suero antiofídico.

Se han establecido 15 unidades de análisis, 16 dimensiones, 83 actividades, 33 metas y 38 indicadores. Estos se asociarán con un conjunto de resultados esperados los cuales se relacionarán con un cronograma, recursos requeridos y responsabilidades, tal y como se ve en el cuadro 4, mostrado en las siguientes páginas.

CUADRO 4
OPERACIONALIZACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Ubicación georeferencial de cada grupo familiar.	Territorialización geográfica.	-Asignación y organización de equipos multidisciplinarios. -Captar 500 familias. -Adscripción de las familias a la unidad básica. -Levantamiento del plano-croquis. -Ubicación de la vivienda. -Caracterización física ambiental (Servicio, área de focos de contaminación). -Organizar una unidad de atención primaria constituida por 500 familias (2500 personas).	-Captar las 500 familias, en un período de 1 mes. -Sectorización sanitaria por cada unidad básica de atención, en un período de 1 mes. -Caracterización física ambiental de las comunidades con mayor agrupación de familias, en un período de 1 mes. -Organización en un período de 3 meses, posterior a su adscripción, de la unidad de atención.	-Número de familias adscritas. -Número de sectorización realizada. -Número de caracterización física ambiental comunitaria. -Organización realizada.	6 meses	-Familias georeferencialmente ubicadas. -Unidad de atención primaria organizada georeferencialmente.	-Talento humano: 1 médico, 1 enfermera, 1 promotor social, 1 coordinador. -Movilización: medios de transporte. -Laptops, internet, teléfonos, cámaras. -Refrigerios, agua potable.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales.	Equipo de salud APS
Realizar el censo socio-sanitario del grupo comunitario.	Censo socio-sanitario	-Aplicar el instrumento del censo socio-sanitario a cada familia. -Procesamiento, análisis de la información sobre las características socio-sanitarias del grupo comunitario. -Jerarquización de los programas y estrategias de abordaje.	-Censar a 500 familias en un período de 1 mes -Procesamiento total en el término de 1 mes, 1 semana.	-Número de familias censadas. -Total de procesamiento	2 meses	-Censo socio-sanitario de la unidad básica de atención primaria. Diagnóstico	Talento humano: 1 técnico en informática, 1 software estadístico, promotores sociales, 1 médico, 1 enfermero.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales.	Equipo de salud APS

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Caracterizar a cada grupo familiar de la comunidad.	Ficha socio-familiar.	-Elaborar la ficha socio-familiar de cada grupo de la comunidad. -Diseñar el plan de abordaje de cada grupo familiar. -Asignar una Identificación sanitaria a cada persona. -Estructurar los grupos poblacionales y grupos vulnerables.	-500 fichas socio-familiares de la unidad básica de atención primaria, en un período de 2 meses. -500 planes familiares en un período de 2 meses.	-Número de fichas socio-familiares de atención primaria elaboradas. -Número de planes familiares diseñados.	10 meses	-Caracterización socio-sanitaria del grupo familiar de la comunidad. -Caracterización de las condiciones socio-económicas de cada grupo familiar.	Talento humano: 1 enfermera, 1 promotor social.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales.	Equipo de salud APS
Elaborar historia clínica a cada miembro de la familia.	Historia clínica personal.	-Entrevistar a cada paciente. -Realizar examen clínico. -Aplicar cuestionario de factores de riesgo. -Elaborar el plan de salud personal.	-2500 historias clínicas elaboradas en un período de 3 meses -2500 planes de salud personalizados, en un período de 3 meses.	-Número de historias clínicas elaboradas. -Número planes de salud personalizados elaborados.	3 meses	Historias clínicas de los miembros de la familia de la UBAPS.	-Talento humano: 1 médico, 1 enfermera. -Recursos materiales: tensiómetro, termómetro, oxímetro, laringoscopio, otoscopio, electrocardiógrafo, peso, estetoscopio, lámparas, cama clínica, batas, guantes, gasa estéril, tapabocas, desinfectante de manos, alcohol, software clínico.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales.	Equipo de salud APS.

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Construir la pirámide poblacional.	Pirámide pobla- cional.	-Clasificar a la población por subgrupos etarios. -Priorizar los programas específicos para cada grupo etario. -Correlacionar la pirámide del grupo con la pirámide nacional.	Construcción en un 75%, de la pirámide poblacional del grupo en un período de 1 mes.	Subgrupos etarios de la población clasificados.		Construcción de la pirámide poblacional.	-Recursos estadísticos: software, laptops. -Talento humano: médico, especialista en estadística.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales	Equipo de salud APS
Aplicar el tamizaje en los subgrupos pobla- cionales.	Tamizaje.	-Ejecutar el modelo de despistaje a los subgrupos poblacionales. -Determinar el riesgo a padecer ciertas condiciones mórbidas. -Detectar riesgos tempranamente. -Aplicar pruebas de rutina y exámenes, medición de hipertensión arterial, entre otros. -Realizar diagnóstico situacional.	75% de avanzado el diagnóstico situacional de riesgo de los subgrupos y población, en un lapso de 3 meses.	-Número de pacientes con detección temprana de riesgo. -Número de pacientes con pruebas de rutinas y exámenes de medición realizados. -Aproximación en un 75% de pacientes diagnosticados	3 meses	Diagnóstico situacional de riesgo de los subgrupos y población.	-Talento humano: 1 medico, 1 enfermera. -Recursos materiales: internet, laptop, insumos para elaborar exámenes de rutina, laboratorio clínico, tensiómetro, cinta métrica.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales.	Equipo de salud APS.

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Diseñar el plan sanitario.	Planificación sanitaria	-Analizar la información recolectada. -Elaborar el Plan de salud bajo un enfoque integral y equitativo para cada persona, familia, grupo etario, grupo de riesgo y comunidad (Meta: 1 año).				Plan de salud bajo un enfoque integral y equitativo.		FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionala les.	Equipo de salud APS
Ejecutar los planes preventivos específicos de salud, pautados por las autoridades sanitarias, según corresponda.	Plan preventivo Sanitario.	-Promocionar la participación de las personas, y grupos comunitarios. -Hacer seguimiento y monitoreo de la ejecución del plan preventivo. -Establecer coordinaciones con los entes y autoridades sanitarias correspondientes.	90% de personas insertos en diferentes planes preventivos, en un lapso de 1 año.	-Número de beneficiarios de cada plan específico. -Número de participantes en los distintos programas. -Número de instituciones públicas y privadas coordinadas mediante los diferentes programas.	1 año	-Participación de las personas en los planes preventivos específicos de salud. -Prevención de enfermedades con base a los programas seleccionados.		FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionala les.	Equipo de salud APS

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Ejecutar programa de educación sanitaria específico, en cada persona y grupo de riesgo.	Educación sanitaria.	-Priorizar estrategias de educación que corresponda a cada persona, sujeto o grupo comunitario. -Capacitar a las personas en las prácticas saludable, tales como: actividades de autoevaluación y establecimiento de hábitos y metas, actividades físicas, manejo de estrés, sueño y descanso, desarrollo de habilidades para la salud (comunicación, socializar).	-Capacitar: realizar 3 cursos de capacitación, en un año. -5 talleres en un año: Estrategias de educación para 1500 familias en el plazo de 1 año.	-Número de personas capacitadas en prácticas saludables. -Número de estrategias priorizadas. -Número de talleres.	1 año	-Ejecución de programas educativos específico para cada persona y grupo de riesgo.	-Talento humano: promotor social, facilitadores. -Espacio video beam. -Refrigerio. -Conocimiento. -Insumos.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales.	Equipo de salud APS

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Promoción de la salud, en las personas y grupos poblacionales, para modificar los factores ambientales que inciden de manera negativa.	Promoción de la salud.	-Capacitar a los promotores comunitarios. -Seleccionar junto con las personas, familias y grupos comunitarios, los factores ambientales del entorno que serán objeto de la intervención. -Coordinar los recursos necesarios para la intervención de los factores ambientales a ser modificados. -Jornadas de atención de salud -Determinar las acciones correspondientes a cada factor ambiental. -Supervisar las actividades del plan. -Evaluar el plan de promoción de la salud.	-Capacitar entre el 85-90% de los promotores comunitarios en un período de 1 año. -Selección de por lo menos el 80% de los factores ambientales del entorno. -4 jornadas de atención a la salud en un período de 1 año.	-Número de promotores comunitarios capacitados. -Número de factores ambientales seleccionados para el abordaje. -Número de jornadas realizadas en el año	1 año	-Modificación de los factores ambientales que inciden negativamente en la salud de las personas y grupos poblacionales. -Promotores comunitarios capacitados. -Resultados de la supervisión y evaluación del plan de promoción de la salud.	-Talento humano: médico, enfermera, promotores sociales. -Espacio video beam. -Refrigerio. -Conocimiento: promotor social, facilitadores. -Insumos. -Recursos de movilización: transporte	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionala les.	Equipo de salud APS.

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Fortalecer a las personas, y grupos comunitarios mediante información sanitaria, para la toma de decisiones sobre la salud.	Información sanitaria.	-Seleccionar los medios de comunicación o canales de información. -Creación de página web educativa. -Creación de canal, chat, redes sociales. -Seleccionar y validar los contenidos. -Crear contenidos sobre la salud. -Divulgar la información. -Medir el nivel de información que reciben las personas, sujetos y grupos comunitarios	-En el término de 1 mes, tener los medios de comunicación o canales de información: al menos 1 red social y 1 chat. -Página web, en el término de 3 meses. -Divulgar información diariamente. -Creación de dos contenidos sobre salud al mes.	-Número de medios de comunicación o canales de información. -Número de contenidos públicos al mes. -Número de contenidos creados. -Número de evaluaciones realizadas. -Número de personas receptores de la información.	3 meses	Personas y grupos comunitarios con información sanitaria completa, útil y oportuna para tomar decisiones sobre su salud.		FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionala les.	Equipo de salud APS.
Brindar asistencia médica primaria.	Asistencia médica primaria.	-Organizar las consultas en tiempo y espacio. -Hacer la pre-clínica (enfermería). -Abrir/revisar la historia clínica según sea el caso. -Realizar entrevista y examen físico. -Realizar consultas de medicina. -Coordinar con los promotores de salud en el caso de consulta intra-comunitaria e intra-domiciliaria, cuando éstas sean demandadas.	-Organizar las consultas en un 80% en un período de 1 mes. -100% de la preclínica de las 500 familias en 3 meses.	-Número de consultas organizadas. -Número de preclínica realizadas a las familias. -Número de consultas de medicinas realizadas.		Asistencia médica primaria brindada a la población objeto de la unidad primaria.	-Tablet, internet. -Talento humano: creador de contenido, comunicador social, un pasante de comunicación social. -Reserva de dominio.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionala les.	Equipo de salud APS.

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Proporcionar alternativas de rehabilitación y prevención secundaria.	Rehabilitación y prevención secundaria.	-Identificar la población objeto. -Referir/atender dependiendo de la disponibilidad del servicio. -Realizar las terapias físicas, ocupacional, lenguaje o la que corresponda, según el diagnóstico. -Educar sobre la condición de salud. -Reconocer signos de alarmas, para saber cuándo buscar atención médica. -Adherencia al tratamiento. -Monitoreo y seguimiento regular. -Programa de autocuidado. -Vacunación. -Asignar citas de seguimiento. -Participar en grupos de apoyo.	Identificación entre un 80% y 95% de la población objeto que requiere de rehabilitación o prevención secundaria, en el término de 1 año.	-Número de casos atendidos. -Números de terapias realizadas. -Número de personas que logran reconocer signos de alarmas para la atención médica. -Número de referidos. -Número de pacientes que se adhieren al tratamiento. -Porcentaje de deserción de consulta. -Porcentaje de participación en grupos de apoyo.	1 año.	Personas y población objeto incorporadas a programas de rehabilitación y prevención secundaria, según corresponda.	-Talento humano: médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras. -Recursos materiales: espacio físico, banco de equipos de apoyo físico, equipos para terapias físicas, banco de instituciones.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales.	Equipo de salud APS.

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Garantizar que la casuística de morbi-mortalidad se corresponda con los enunciados del axioma de Kerr White.	Enunciados: Axioma de Kerr White.	-Analizar la frecuencia de los motivos de la consulta. -Monitorear la cantidad y los motivos de las derivaciones a especialidades. -Evaluar el porcentaje de problemas de los pacientes que se resuelven en el nivel primario sin necesidad de derivación. -Analizar cómo se gestionan las enfermedades crónicas en la gestión primaria. -Evaluar la adherencia a protocolos y guías clínicas del personal de salud. -Aplicar la encuesta de morbilidad sentida y utilización de servicios. -Evaluar satisfacción de los usuarios. -Establecer indicadores de coberturas y acceso. -Evaluar el impacto de las intervenciones implementadas mediante el plan.	Del 100% de las personas que presentan un riesgo cada mes: -El 75% manifiesta algún problema de salud. -El 30% requiera una consulta de medicina general. -El 5% es referido a un especialista. -El 2% de la población requiera hospitalización sencilla. -El 0.4% de la población requiera hospitalización compleja. -Registro del 90% de casos resueltos en el nivel primero de atención.			Correspondencia entre la casuística de morbi-mortalidad y los enunciados del axioma de Kerr White.	-Recursos estadísticos. -Talento humano: médico, estadístico.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales.	Equipo de salud APS.

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Vincular a la población asistida con los niveles de atención de salud del sistema nacional de salud, en los casos que corresponda.	Sistema nacional de salud.	-Identificar los casos. -Hacer las coordinaciones respectivas. -Tener un sistema o banco de referencias. -Hacer seguimiento a los casos referidos. -Retomar su reinserción en el programa.	25% de personas que requieran ser referidas.	-Número de personas referidas. -Número de personas reinsertadas al programa de atención luego de la referencia.	1 año	Población asistida, mediante distintos niveles de atención de salud del sistema nacional de salud.	-Talento humano: médico, enfermera. -Recursos de movilización. -Banco de referencia de instituciones.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionala les.	Equipo de salud APS.

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

Objetivo específico	Dimensión	Actividad	Metas	Indicadores	Tiempo de ejecución	Resultados	Recursos necesarios	Fuente de financiamiento	Responsable
Crear un banco de suero antiofídico.	Zoonosis.	-Identificar las enfermedades zoonóticas presentes en el municipio y en el estado Zulia. -Determinar los casos de picaduras de insectos y mordeduras de animales presentes en el municipio y en el estado Zulia. -Reconocer aquellos pacientes foráneos o rurales que ingresen al hospital Dr. Gustavo Pineda con síntomas febriles y descartar una zoonosis. -Prestar los servicios de laboratorio para la identificación y el diagnóstico de las enfermedades zoonóticas. -Colaborar con los biólogos presentes en el hospital Dr. Gustavo Pineda.	En un año elaborar el diseño del proyecto.	Diseño del proyecto		Creación del banco de suero antiofídico	-Talento humano: médico veterinario, especialistas en el área, entre otros. -Equipos de laboratorio para producción, almacenamiento y mantenimiento de los sueros. -Animales para la producción de anticuerpos.	FUNDAPINEDA, aportes de familias, aportes institucionales.	Equipo de salud APS.

9. Costos

Los costos* anuales del programa por cada 2 Unidades Integrales de Atención Primaria en Salud (UIAPS), es decir 4.000 familias o 20.000 personas son distribuidos de la siguiente manera: Ciento veintiocho mil ochocientos dólares estadounidenses (128.800,00 USD) en costos de personal, según su tipo (Coordinación y auditoría, catorce mil cuatrocientos dólares estadounidenses (14.400,00 USD), médicos de APS cincuenta y siete mil seiscientos dólares estadounidenses (57.600,00 USD), enfermeras de APS, diecinueve mil seiscientos dólares estadounidenses (19.600,00 USD), promotores de APS, nueve mil seiscientos dólares estadounidenses (9.600,00 USD), secretarías, cuatro mil ochocientos dólares estadounidenses (4.800,00 USD), técnicos de sistemas, cuatro mil ochocientos dólares estadounidenses (4.800,00 USD), asesor estadístico, dos mil cuatrocientos dólares estadounidenses (2.400,00 USD), conductores, nueve mil seiscientos dólares estadounidenses (9.600,00 USD), paramédicos, tres mil seiscientos dólares estadounidenses (3.600,00 USD) y almacenista hospitalario dos mil cuatrocientos dólares estadounidenses (2.400,00 USD).

Ciento cincuenta y ocho mil setecientos noventa y seis dólares estadounidenses

(158.796,00 USD) en costo de recursos materiales, según renglones (Equipos electrónicos, de computación y copiado, trece mil ciento cincuenta dólares estadounidenses (13.150,00 USD), material y mobiliario de oficina, cuatro mil setecientos cuarenta dólares estadounidenses (4.740,00 USD), software, cuatro mil ochocientos dólares estadounidenses (4.800,00 USD), equipos médicos, dieciocho mil ciento setenta y seis dólares estadounidenses (18.176,00 USD), automóviles, ochenta mil dólares estadounidenses (80.000,00 USD) y ambulancia, cuarenta mil dólares estadounidenses (40.000,00 USD).

Todo lo anterior, suma un costo total anual para el programa en 2 UIAPS de doscientos ochenta y siete mil quinientos noventa y seis dólares estadounidenses (287.596,00 USD).

Se adiciona un monto adicional de veintiocho mil setecientos cincuenta y nueve con sesenta centavos de dólares estadounidenses (28.759,6 USD), correspondiente al 10% del costo total, para realizar ajustes y cubrir contingencias, lo cual hace una suma total de trescientos dieciséis mil trescientos cincuenta y cinco con sesenta centavos de dólares estadounidenses (316.355,6 USD).

Estos costos son mostrados en las tablas 4-7.

TABLA 4
COSTO EN PERSONAL DEL PROGRAMA, SEGÚN TIPO DE PERSONAL

Recurso humano	Cantidad	Horas semanales por recurso	Costo total mensual/USD	Costo total anual/USD	%
Coordinación y auditoría	2	80	1200	14400	11,1
Médicos de APS	8	640	4800	57600	44,7
Enfermeras de APS	4	160	1600	19600	15,2
Promotores de APS	4	160	800	9600	7,4
Secretarías	2	80	400	4800	3,7
Técnicos de Sistemas	2	80	400	4800	3,7
Asesor estadístico	1	20	200	2400	1,8
Conductores	4	80	800	9600	7,4
Paramédicos	2	80	300	3600	2,7
Almacenista hospitalario	1	40	200	2400	1,8
TOTAL	30	1180 (61360/año)	10.733,33	128800	100

* Los costos serán ajustados de acuerdo con las variables económicas en el contexto de su aplicación.

TABLA 5
COSTO DE RECURSOS MATERIALES DEL PROGRAMA POR RENGLONES Y PORCENTAJE

Renglón / Material	Costo total USD	%
Equipos electrónicos, de computación y copiado	13150	8,2
Material y mobiliario de oficina	4740	2,9
Software	4800	3
Equipos médicos	18176	11,4
Automóviles	80000	50,3
Ambulancia	40000	25,1
TOTAL	158796	100

TABLA 6
COSTO DE RECURSOS MATERIALES DEL PROGRAMA

Material	Cantidad	Costo/und USD	Costo total USD
Tabletas digitales	16	150	2400
Teléfonos inteligentes de 32 gigas de memoria interna	26	250	6500
Computadoras de escritorio	5	600	3000
Impresoras	5	200	1000
Cartucho de tinta	20	70	1400
Copiadora	1	250	250
Resma de papel	20	10	100
Calculadora	4	20	80
Bolígrafos	100	2.5	240
Lápices	100	0.50	50
Carpetas	2000	18	720
Software de gestión de salud	1	150/MES	1800
Programa de análisis estadístico SAS	1	100/MES	1200
Tensiómetro de mercurio	4	50	200
Estetoscopio	4	70	280
Equipo de ORL	4	260	1040
Equipo de cirugía menor	4	35	140
Equipo de primeros auxilios	4	30	120
Linterna	5	50	250
Automóvil	4	20000	80000
Ambulancia	1	40000	40000
Monitor de signos vitales	2	400	400
Ventilador mecánico de traslado	1	2300	2300
Desfibrilador	1	1700	1700
Bomba de infusión	8	1000	8000
Tabla de traslado	1	36	36
Bombona de oxígeno	2	300	600
Manómetro de oxígeno	2	35	70
Laringoscopio	2	200	400
Ambu	2	200	400
Collarín rígido	2	85	170
Mobiliario de oficina	2	1000	2000
TOTAL	-	-	158796

TABLA 7
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA POR RENGLONES Y PORCENTAJE

Descripción	Total / USD	%
Costo de personal	81600	30
Costo de recursos materiales	158796	60
SUBTOTAL	240.396	90
Costos adicionales (10%)	24.039,6	10
TOTAL	264.435,6	100

10. Análisis

10.1 Análisis económico-administrativo

El análisis económico-administrativo del programa se basa en dos componentes clave: costos de personal y costos de recursos materiales, a los cuales se adiciona un porcentaje para contingencias.

Los costos de personal (128.800,00 USD) incluyen los recursos humanos necesarios para la operación del programa. Los médicos de APS representan casi la mitad del gasto en personal, lo cual es coherente con su papel central en la atención médica directa. La inclusión de promotores, técnicos y conductores refleja un enfoque integral, no solo clínico, sino también comunitario y logístico.

Los costos de recursos materiales (158.796,00 USD) destinados a infraestructura tecnológica, movilidad y equipamiento médico. El 75,58% del total de recursos materiales se destina a vehículos (ambulancia y automóviles), lo que muestra una clara orientación a la movilidad para atención domiciliaria, traslados o supervisión en domicilio. Los equipos médicos y electrónicos suman 19,72%, siendo esenciales para garantizar calidad de atención y registro digital.

El monto de contingencia (10%) está bien justificado, ya que permite cubrir inflación, mantenimiento de equipos, repuestos o contratación temporal de personal por bajas imprevistas.

El programa cuenta con una estructura presupuestaria balanceada, con prioridad en recursos humanos (personal clínico y comunitario) y capacidad operativa (vehículos y equipos). La distribución permite garantizar una atención primaria de salud funcional, descentralizada y con posibilidades de respuesta territorial, particularmente en contextos donde se requiere movilidad, coordinación intersectorial y seguimiento en terreno. Sin embargo, en la dinámica futura se evaluará la relación costo-eficiencia de los vehículos,

el fortalecimiento del uso de tecnología (Telemedicina, software estadístico) y la planificación de la sostenibilidad anual según índices inflacionarios y necesidades de ampliación.

10.2 Análisis organizativo

La organización de las 60.000 familias dentro de un SILOS que se apoya en un modelo territorial y funcional, garantiza la cobertura universal, continuidad de cuidados, equidad en el acceso y resolutivez progresiva en los diferentes niveles de atención.

Las UBAPS representan el primer punto de contacto con el sistema de salud y cumplen un papel clave en la atención integral, la vigilancia epidemiológica comunitaria y la identificación temprana de necesidades sanitarias.

Las UIAPS funcionarán como nodos de atención ampliada y especializada, cumpliendo funciones de coordinación, supervisión clínica y administrativa de las UBAPS que se encuentren bajo su ámbito.

Las ZIS constituirán una unidad territorial funcional que centralizará algunas acciones operativas dentro del SILOS, conteniendo una Clínica Integral de Salud, como unidad resolutivez intermedia que ofrecerá servicios de mayor complejidad que los disponibles en las UIAPS y UBAPS, tales como diagnóstico por imágenes, laboratorio especializado, atención de partos no complicados, consultas de especialidades básicas, cirugías ambulatorias, y observación clínica. Esta clínica servirá además como centro de capacitación, referencia y articulación clínica con el hospital cabecera del SILOS.

Toda la red estará adscrita funcionalmente a un Hospital General Cabecera del SILOS, el cual contará con todas las capacidades resolutivez.

La conectividad operativa entre los distintos niveles y unidades del SILOS, se implementará a través del SAPHTP

conformado por ambulancias distribuidas estratégicamente, equipos de respuesta rápida con paramédicos y técnicos en emergencias médicas y una central de coordinación que facilitará la referencia y contrarreferencia de pacientes entre las UBAPS, UIAPS, la Clínica Integral y el Hospital Cabecera. Esta estructura permitirá una respuesta eficaz ante emergencias, traslados programados, seguimiento de casos críticos y cobertura territorial integral las 24 horas del día.

Desde el punto de vista funcional, este modelo organizativo permite una clara distribución de responsabilidades sanitarias por territorio, fortalece la atención en el primer nivel mediante la sectorización familiar y comunitaria y garantiza una adecuada progresión del cuidado según el nivel de complejidad requerido. Además, fomenta la participación comunitaria, la gestión basada en evidencia, la interoperabilidad de los sistemas de información y la articulación intersectorial, elementos fundamentales para una estrategia de APS efectiva, sostenible y centrada en las personas.

Este esquema, alineado con los principios de universalidad, equidad, accesibilidad y resolutivez de la APS, no solo permite acercar los servicios al territorio, sino que contribuye a fortalecer el Sistema Nacional de Salud mediante redes de atención articuladas, descentralizadas y con capacidad operativa para atender integralmente a una población amplia en condiciones diversas. El SILOS aquí descrito representa un modelo replicable, adaptable y escalable, capaz de garantizar una atención continua y de calidad a lo largo del curso de vida de la población.

10.3 Análisis legal

Desde el punto de vista legal y normativo, este programa de APS se fundamenta en los artículos 83-85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) ⁽⁹⁵⁾. El artículo 83 reconoce la salud como un derecho social fundamental, obligación del estado y parte del derecho a la vida. El artículo 84 establece la responsabilidad del estado en organizar un sistema público nacional de salud que sea intersectorial, descentralizado, participativo e integrado. Por su parte, el artículo 85 ordena la asignación prioritaria y suficiente de recursos para garantizar una red pública de salud articulada con la participación comunitaria.

Asimismo, la Ley Orgánica de Salud ⁽⁹⁷⁾ regula los principios rectores y las competencias institucionales en materia de planificación, organización, financiamiento y

control del sistema de salud. En este marco, la organización de un SILOS responde a las disposiciones de territorialización, niveles de atención, accesibilidad y enfoque preventivo integral.

En el plano internacional, la Declaración de Alma-Ata (1978) y la Declaración de Astaná (2018) refuerzan la necesidad de sistemas de salud basados en una atención primaria sólida, con énfasis en la equidad, la universalidad, la participación social y la integración de servicios. Este programa también se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que promueve el acceso universal a servicios de salud de calidad, incluyendo la atención primaria, cobertura sanitaria universal y reducción de la mortalidad evitable ⁽⁸³⁾.

Finalmente, el Plan de la Patria 2019-2025, en su segundo objetivo histórico (2.3.6), plantea la necesidad de consolidar un sistema público nacional de salud que garantice la equidad, gratuidad, prevención y calidad de la atención en todos los niveles. Los SILOS, como modelo estructural y funcional y la APS como estrategia, se insertan plenamente en este mandato programático, reforzando el compromiso del Estado venezolano con el bienestar colectivo, la soberanía sanitaria y la justicia social ⁽⁹⁷⁾.

10.4 Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad, evalúa la manera cómo variaciones en ciertos parámetros críticos pueden afectar el funcionamiento o sostenibilidad del programa, permitiendo, por tanto, establecer márgenes de flexibilidad y diseñar mecanismos de contingencia ante escenarios adversos ⁽⁹⁸⁾.

Este enfoque es clave para garantizar la resiliencia del SILOS frente a fluctuaciones económicas, crisis sanitarias o cambios políticos-administrativos, manteniendo su capacidad de respuesta, su eficiencia técnica y su alineación con los principios constitucionales y de derecho a la salud.

Entre los factores más sensibles que hemos identificado, en nuestro caso, se encuentran la disponibilidad de recursos financieros, la variación poblacional, la situación epidemiológica, la dotación de personal calificado, la cobertura territorial efectiva y la capacidad resolutive en cada nivel del sistema.

Una reducción en la disponibilidad presupuestaria mayor al 10% podría afectar directamente el número de profesionales en las UBAPS o limitar la operatividad del sistema de traslado SAPHTP, reduciendo el alcance y la calidad del servicio. En este

caso se requeriría priorizar los servicios esenciales, optimizar el uso de recursos y ampliar las alianzas intersectoriales.

La ausencia temporal o estructural de personal sanitario tales como especialistas, médicos o enfermeras en las UIAPS también representa un punto crítico que podría comprometer la integralidad del enfoque del programa sanitario. Tal situación podría ser afrontada por medio de la oferta de incentivos laborales, formación local, retención territorial

Los cambios en la tasa de crecimiento poblacional, movilidad interna o la aparición de epidemias locales pueden modificar la demanda asistencial, obligando a ajustes dinámicos en la asignación de recursos y reestructuración de las rutas clínicas a través de un plan de respuesta rápida, creación de un stock de emergencia y establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica.

En resumen, el análisis de sensibilidad y riesgos demuestra que, si bien el modelo es técnicamente robusto, requiere vigilancia sobre variables como el financiamiento, la disponibilidad de personal calificado, la estabilidad institucional y la funcionalidad del sistema de traslado.

En el cuadro 5 se muestra la matriz de riesgos y escenarios proyectados, resume el análisis de sensibilidad del programa, identificando los puntos críticos del mismo, permitiendo anticipar respuestas y promoviendo una gestión sanitaria preventiva, flexible y orientada a resultados sostenibles.

10.5 Análisis de sostenibilidad

La sostenibilidad de nuestro programa de APS depende de tres pilares fundamentales: sostenibilidad financiera, institucional y operativa, los cuales deben mantenerse de forma articulada a lo largo del tiempo para garantizar su funcionamiento continuo y su capacidad de adaptación ante cambios del entorno.

El modelo de atención se apoya en una red escalonada cuyo diseño favorece la eficiencia del gasto público en salud, al priorizar la atención primaria sobre las intervenciones de mayor costo. La sectorización poblacional (500 familias por UBAPS) y la asignación de personal proporcional permite una estimación precisa de los recursos requeridos. Sin embargo, la sostenibilidad dependerá del compromiso de los asociados a hacer sus aportes al capital semilla, de los recursos que pueda destinar el estado, a través de transferencias soportadas en sus obligaciones constitucionales (CRBV art. 85), de la exploración de fuentes complementarias de financiamiento a través de venta de servicios y del establecimiento de mecanismos de cooperación a todos los niveles, participación de misiones sociales y programas mixtos intersectoriales.

En el aspecto institucional, el SILOS se estructura de forma coherente con la CRBV y Ley Orgánica de Salud, lo cual debería garantizar un respaldo jurídico sólido. No obstante, su sostenibilidad requiere de mecanismos de gobernanza

CUADRO 5
MATRIZ DE RIESGOS Y ESCENARIOS PROYECTADOS

Riesgo Potencial	Probabilidad	Impacto	Medida de contingencia
Reducción presupuestaria >10%.	Alta	Alto	Priorización de servicios esenciales, optimización de recursos, alianzas intersectoriales
Fuga de talento médico y enfermería.	Media	Alto	Incentivos laborales, formación local, retención territorial
Saturación del sistema por brotes epidémicos.	Alta	Alto	Plan de respuesta rápida, stock de emergencia, red de vigilancia epidemiológica.
Fallas en el sistema de transporte SAPHTP.	Media	Medio	Mantenimiento preventivo, rutas alternas, uso de tecnología de geolocalización.
Ausencia de especialistas claves en UIAPS.	Alta	Alto	Integración rotativa con clínicas y hospitales, telemedicina
Inestabilidad institucional o política.	Media	Alto	Adaptabilidad normativa, acuerdos comunitarios, continuidad operativa descentralizada
Corte prolongado de servicios básicos (agua, electricidad).	Media	Alto	Infraestructura con sistemas alternos (plantas eléctricas, tanques de reserva)

efectiva: fortalecimiento de consejos de gestión en salud, articulación con el poder comunal y desarrollo de capacidades técnicas en gestión local de servicios. La descentralización funcional y la formación de cuadros técnicos en planificación sanitaria, epidemiología y administración de servicios, serán claves para asegurar la continuidad institucional del modelo, aún ante cambios políticos o administrativos.

En cuanto a la sostenibilidad operativa, el programa incorpora un diseño flexible, escalable y territorializado, que permite su replicabilidad en otros contextos. La existencia de múltiples niveles de atención (UBAPS, UIAPS, Clínica Integral y Hospital Cabecera), articulados por el sistema de referencia y contrarreferencia, garantiza eficiencia y continuidad del cuidado. La interoperabilidad de los registros clínicos, el enfoque comunitario del modelo y el fortalecimiento del recurso humano local –mediante procesos formativos permanentes– aseguran que el conocimiento institucional y la cultura sanitaria se consoliden en el tiempo, reduciendo la dependencia de operadores externos.

Adicionalmente, la sostenibilidad se ve reforzada por el alineamiento del SILOS con marcos internacionales y nacionales como la Declaración de Astaná, el ODS 3 y el Plan de la Patria 2019-2025, lo cual posibilita el acceso a cooperación técnica y validación

global del modelo. También contribuye a su perdurabilidad la participación activa de la comunidad en la gestión, vigilancia y evaluación de los servicios, favoreciendo el empoderamiento social como factor protector de la salud pública.

No obstante, se identifican desafíos importantes que pueden afectar su sostenibilidad, tales como la inestabilidad política y macroeconómica, la migración de la población y personal de salud y la necesidad de actualización tecnológica continua. Por tanto, el diseño incluirá mecanismos de adaptación, evaluación periódica de desempeño y sistemas de alerta temprana que permitan respuestas ágiles ante crisis emergentes.

La implementación de un programa de APS en el marco de la construcción de un SILOS es, por tanto, un modelo estratégico, escalable y replicable que consolida la Atención Primaria en Salud como eje rector del sistema sanitario. Su implementación efectiva puede mejorar de manera sustancial los indicadores de salud, reducir la inequidad territorial y promover una cultura de salud colectiva, participativa y solidaria.

La sostenibilidad del programa se ve fortalecida por su capacidad de adaptación, su inserción comunitaria, su viabilidad financiera a largo plazo y su coherencia con marcos legales internos e internacionales.

11. Monitoreo y evaluación

El monitoreo y evaluación de nuestro programa de APS se realizará por medio de la aplicación del modelo M&E, el cual es compatible con un programa de APS ⁽⁹⁹⁾.

Dicho modelo asume como objetivos monitorear el desempeño operativo del programa de APS (Procesos, actividades y outputs o resultados), evaluar los resultados e impactos en la salud de la población atendida, identificar áreas de mejora para optimizar recursos, garantizar la sostenibilidad y asegurar la calidad, equidad y accesibilidad de los servicios de salud.

El mismo se alinea con los principios de la APS (accesibilidad, integralidad, continuidad, coordinación y participación comunitaria) y estándares internacionales como los de la OMS.

Sus componentes clave incluyen:

- Inputs: recursos humanos, infraestructura, insumos médicos, financiamiento.
- Actividades: consultas médicas, promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención comunitaria.
- Outputs: servicios entregados (e.g., número de consultas, vacunaciones).
- Outcomes: cambios en el estado de salud (e.g., reducción de morbilidad).
- Impacto: mejoras a largo plazo (e.g., aumento en la esperanza de vida, reducción de inequidades).

El modelo se aplicará en 4 fases: Una fase inicial o de planificación, en la cual se definen los objetivos del programa, se establecen los indicadores SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, con Tiempo definido) y se identifican fuentes de datos y responsables; una fase de monitoreo, en la que se hace seguimiento continuo de las actividades y outputs mediante indicadores de proceso y se recolectan datos en tiempo real o periódico para detectar desviaciones; una fase de evaluación, que se cumple por medio

de evaluaciones periódicas (Intermedias y finales) para medir outcomes e impacto y analizar la efectividad, eficiencia, equidad y sostenibilidad y una fase final o de retroalimentación, en la cual se usan los resultados para ajustar el programa, mejorar la toma de decisiones y comunicar hallazgos a las partes interesadas.

En cuanto a los indicadores del modelo, éstos se dividen en tres niveles: proceso, resultados e impacto (cuadro 6).

Los datos recolectados se clasificarán en cuantitativos (Los tomados del sistema de información del SILOS, registros administrativos y encuestas poblacionales) y cualitativos (Entrevistas a profundidad, grupos focales con usuarios y personal de salud y observación directa). Las fuentes de datos serán primarias (Registros del SILOS, encuestas a usuarios y entrevistas con personal, entre otros), secundarias (Bases de datos nacionales o estadísticas de salud, informes de otros programas de APS y literatura científica) y participativas (Retroalimentación de la comunidad a través de consejos de salud, encuestas, llamadas, comunicaciones, sugerencias, etc.).

Entre las herramientas de trabajo se utilizarán sistemas digitales de monitoreo (e.g., software de gestión hospitalaria), encuestas estandarizadas (e.g., WHO Service Availability and Readiness Assessment - SARA) ⁽¹⁰⁰⁾ y fichas de auditoría y checklists para supervisión en campo.

El análisis tendrá 3 dimensiones: Análisis estadístico descriptivo e inferencial (e.g., tasas, proporciones, tendencias, etc.), análisis cualitativo (codificación de entrevistas, identificación de temas, etc.) y modelos de evaluación de impacto (e.g., análisis de costo-efectividad, evaluación cuasiexperimental).

Se elaborará un plan operativo para el modelo de M&E aplicado al programa, el cual se sintetiza en el cuadro 7.

CUADRO 6
INDICADORES DEL MODELO

Nivel	Indicador	Método de Medición	Fuente de Datos	Frecuencia
Proceso	Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben al menos 4 controles prenatales.	Registros de atención.	Sistema de información del SILOS	Mensual
Resultado	Reducción de la anemia en mujeres embarazadas.	Revisión de registros de atención prenatal, encuestas nutricionales y análisis de estadísticas vitales.	Sistema de información del SILOS	Anual
Impacto	Disminución de la tasa de mortalidad materna.	Estudios epidemiológicos.	Sistema de información del SILOS	Anual
Acción	Si el monitoreo detecta baja asistencia a controles prenatales, se implementan campañas comunitarias de sensibilización.			

CUADRO 7
SÍNTESIS DEL PLAN OPERATIVO APLICADO AL PROGRAMA

Actividad	Frecuencia	Responsable	Producto
Recolectar datos de proceso	Mensual/Trimestral.	Equipo de UBAPS	Reportes mensuales
Realizar encuestas de satisfacción	Anual	Equipo de evauación externo	Informe de satisfacción.
Analizar indicadores de resultado	Anual	Coordinador de M&E.	Informe de resultados.
Evaluar impacto	Bianual	Equipo de evaluación externo	Informe de impacto.
Socializar hallazgos	Anual	Coordinador del programa	Plan de acción ajustado.

Para el proceso de evaluación y monitoreo se asignarán diversos roles y responsabilidades; entre éstos un coordinador de M&E (Diseña el modelo, supervisa la recolección y análisis de datos, equipo de la UBAPS (Registra datos de actividades y outputs en el sistema de Información del SILOS), analistas de datos (Procesan y analizan la información recolectada), comunidad (Participa en encuestas y grupos focales, aportando retroalimentación y asociados, directivos patrocinantes y autoridades (Revisan los informes para tomar decisiones de financiamiento y políticas).

En cuanto a las consideraciones éticas del proceso de evaluación y monitoreo, se respetará estrictamente la confidencialidad. En tal sentido, los datos personales de los usuarios serán protegidos según normativas de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Se propiciará la participación comunitaria, involucrando a la población del proyecto en el diseño y evaluación del mismo, para garantizar pertinencia cultural y se asumirá una política de transparencia, compartiendo los resultados con todas las partes interesadas de manera clara y accesible.

Se espera por resultados, por medio del monitoreo, la identificación oportuna de cuellos de botella (e.g., falta de insumos, baja cobertura), por medio de la evaluación, la evidencia de mejoras en indicadores de salud (e.g., reducción de enfermedades prevenibles), con los ajustes, la implementación de estrategias basadas en datos para optimizar el programa y por medios de la sostenibilidad, fortalecer la capacidad institucional y comunitaria para mantener los logros.

A lo largo de la ejecución del programa, se digitalizarán los datos y se desarrollará un sistema de información en salud robusto para facilitar el monitoreo en tiempo real, se capacitará y formará al personal en recolección y análisis de datos, se impulsará la participación e involucramiento de líderes comunitarios para garantizar la aceptación y relevancia del programa y asumirá una actitud flexible para ajustar los indicadores según el contexto local y necesidades emergentes (e.g., enfermedades infecciosas nuevas).

En el cuadro 8, se presenta la matriz de control y evaluación del programa.

CUADRO 8
MATRIZ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Componente	Indicadores Clave	Medios de Verificación	Método de Recolección	Frecuencia	Responsables	Supuestos/Riesgos
Georeferenciación familiar.	Porcentaje de familias georeferenciadas.	Mapa digital, base de datos.	SIG, encuestas domiciliarias.	Mensual.	Unidad de Cartografía.	Acceso a tecnología y personal
Censo sociosanitario.	Porcentaje de familias censadas.	Fichas censales.	Visitas domiciliarias.	Bimensual	Promotores de salud.	Participación comunitaria.
Caracterización familiar.	Porcentaje de fichas familiares registradas	Base de datos SILOS.	Entrevistas estructuradas.	Trimestral.	Equipo técnico.	Colaboración institucional.
Historia clínica individual	Porcentaje de población con historia clínica.	Plataforma clínica digital.	Consulta médica.	Continuo.	Médicos y enfermeros.	Disponibilidad de dispositivos.
Pirámide poblacional.	Pirámide poblacional construida	Informes demográficos.	Procesamiento de datos.	Anual.	Epidemiología	Datos actualizados.
Tamizaje poblacional.	Porcentaje de población tamizada.	Registros de tamizaje.	Jornadas de salud.	Trimestral.	Equipos APS.	Suministros diagnósticos.
Plan sanitario poblacional.	Plan formulado y ejecutado	Documento de planificación.	Revisión documental.	Anual	Comité técnico.	Disponibilidad de datos
Planes preventivos oficiales.	Porcentaje de acciones ejecutadas	Registros del MPPS.	Supervisión de campo.	Mensual.	Coordinación epidemiológica.	Articulación con el MPPS.
Programas educativos.	% de grupos intervenidos.	Informes de talleres.	Evaluaciones educativas	Mensual	Equipo educativo.	Participación comunitaria.
Promoción de salud.	Nº de campañas ejecutadas.	Material educativo.	Observación directa.	Trimestral.	Promotores y entes locales.	Apoyo municipal.
Asistencia médica primaria.	Nº de consultas realizadas.	Historias clínicas.	Consultas en APS.	Continuo.	Personal médico de APS.	Recursos médicos disponibles.
Rehabilitación y prevención secundaria.	Porcentaje de pacientes con plan activo.	Ficha de seguimiento.	Evaluaciones funcionales.	Mensual.	Unidad de rehabilitación.	Alianzas con centros físicos.
Banco de suero antiofídico.	Nº de dosis disponibles.	Inventario actualizado.	Registros farmacéuticos.	Mensual.	Farmacia y red de emergencia.	Suministro garantizado
Casística Kerr White	Porcentaje de morbilidad atendida en APS.	Análisis estadístico.	Revisión clínica.	Trimestral.	Epidemiología APS.	Implementación efectiva de SILOS.

CUADRO 8 (CONTINUACIÓN)

Componente	Indicadores Clave	Medios de Verificación	Método de Recolección	Frecuencia	Responsables	Supuestos/Riesgos
Referencias hospitalarias.	Porcentaje de referencias efectivas	Informes hospitalarios	Contrarreferencia.	Mensual.	Red hospitalaria.	Capacidad instalada.
Cobertura hospitalaria total.	Porcentaje de cobertura en emergencias y cirugías.	Registros hospitalarios	Seguimiento de casos.	Mensual.	Hospitales asociados.	Garantía de acceso.
Tasa de morbi mortalidad.	Tasa menor a media nacional.	Estadísticas oficiales.	Vigilancia epidemiológica.	Anual.	Dirección de Epidemiología.	Condiciones sociales estables.
Tiempos de respuesta.	Tiempo promedio de atención.	Encuestas y cronómetros.	Evaluaciones operativas.	Trimestral	Coordinación de servicios.	Capacitación continua.
Cumplimiento de estándares.	Porcentaje de cumplimiento de normas OMS.	Auditorías clínicas.	Evaluación de calidad.	Trimestral.	Comité de calidad.	Aplicación de protocolos.
Dotación de personal.	Porcentaje de cargos cubiertos.	Nóminas y actas.	Supervisión administrativa.	Mensual.	Talento humano.	Presupuesto asignado.
Remuneración en divisas.	Promedio comparativo regional	Tabulador y contratos.	Análisis salarial.	Anual.	Unidad financiera.	Disponibilidad presupuestaria.
Eficiencia operativa	Costo per cápita y rendimiento.	Indicadores financieros y sanitarios.	Auditorías internas.	Trimestral	Unidad de gestión.	Estabilidad macroeconómica.

12. Bibliografía

1. Gavidia V, Talavera M. La construcción del concepto de salud. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*. 2012; 26:161-175. <https://www.uv.es/comsal/pdf/Re-Esc12-Concepto-Salud.pdf>
2. Vergara Quintero MC. Tres concepciones históricas del proceso salud-enfermedad. *Hacia la promoción de la salud*. 2007; 12:4-50. <http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v12n1/v12n1a03.pdf>
3. Alcántara Moreno G. La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad. *Sapiens*. 2008; 9(1):92-107. <https://www.redalyc.org/pdf/410/41011135004.pdf>
4. Porter D. *Health, Civilization and the State: A History of Public Health from Ancient to Modern Times*. Londres: Routledge; 1997. <https://www.ugr.es/~dynamis/completo19/PDF/23.%20RESENAS.pdf>
5. Van Kersbergen K. The declining resistance of welfare states to change?. En: Kuhnle S, editor. *Survival of the European Welfare State*. Londres: Routledge; 2000 [citado 2 dic 2020]. Disponible en: http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/23248/1/37.%20%20Stein_Kuhnle%5D_Survival_of_the_European_Welfare_St%28BookFi%29.pdf
6. Kerr LW, Franklin W, Bernard G. The Ecology of Medical Care. *N Engl J Med*. 1961; 265:885-892. <https://www.aafpfoundation.org/content/dam/foundation/documents/who-we-are/cfhm/classicsfamilymedicine/EcologyofCareWhite.pdf>
7. Larry AG, George EF, Barbara PY, David L, Susan MD. The Ecology of Medical Care Revisited. *N Engl J Med*. 2001; 344(26):2029-2035. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJM200106283442611?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
8. Seorang Y, Mudah P, Asa T, Pernah M, Seorang P, et al. 5 Level of Prevention (Menurut Leavel and Clark) [Internet]. 2015 [citado 6 ene 2021]. Disponible en: <https://fitafiona.blogspot.com/2015/11/5-level-of-prevention-menurut-leavel.html>
9. Organización Mundial de la Salud. Declaración de Alma-Ata: Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud; 6-12 de septiembre de 1978; Alma-Ata, URSS. Ginebra: OMS; 1978 [citado 2 dic 2023]. https://aesmatronas.com/wp-content/uploads/2017/12/ALMA_ALTA.pdf
10. Organización Mundial de la Salud. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. Ottawa: OMS; 1986 [citado 7 oct 2024]. <https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference>
11. Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Américas, Perfil país: Venezuela [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2025 [citado 5 mar 2025]. Disponible en: <https://hia.paho.org/es/perfiles-de-pais/venezuela>
12. Paganini JM, Capote Mir R. *Los Sistemas Locales de Salud: Conceptos, Métodos, Experiencias*. Washington, D.C.: OPS; 1990. Publicación Científica No. 519 [citado 20 may 2025]. <https://iris.paho.org/items/6498d847-25df-4379-8448-0609227928fc>
13. Organización Mundial de la Salud. Atención Primaria en Salud [Internet]. Ginebra: OMS; 2021 [citado 4 ene 2021]. Disponible en: https://www.who.int/topics/primary_health_care/es/
14. Torres R, Siede J. Atención primaria de la salud [Internet]. Studocu; 2021 [citado 4 ene 2021]. <https://www.studocu.com/bo/document/universidad-autonoma-gabriel-rene-moreno/administracion-publica/atencion-primaria-en-salud/26863932>
15. World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Ginebra: WHO; 1948. <https://www.globalhealthrights.org/instrument/constitution-of-the-world-health-organization-who/>
16. Callahan D. The WHO definition of 'health'. *Hastings Cent Stud*. 1973; 1(3):77-87. https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Callahan-5/publication/18559490_The_WHO_definition_of_health/links/541ac1490cf203f155ae5054/The-WHO-definition-of-health.pdf?_cf_chl_tk=eyfVq.8q8W77uC7lp55QQkOx55LVXQGCoY_Zut5cjY-1772297273-1.0.1.1-kQZjL5zfObmAdR7NQ0EzRceMhPwMQ8DB.ApH42iV7Ms

17. Terris M. The Epidemiologic Tradition and Health Needs. *J Public Health Policy*. 1975; 1(1):18–29. <https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.65.2.161>
18. Terris M. The WHO definition of health: A critique. *J Public Health Policy*. 1980. Consultado en: <file:///C:/Users/maire/Downloads/Promocion%20de%20la%20salud%20una%20antologia.pdf>
19. Parsons T. The Social System. Nueva York: Free Press; 1951. <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/10/The-Social-System-by-Talcott-Parsons.pdf>
20. Kass LR. Regarding the End of Medicine and the Pursuit of Health. *Public Interest*. 1975; 40:11–42. https://nationalaffairs.com/public_interest/detail/regarding-the-end-of-medicine-and-the-pursuit-of-health
21. Kass LR. Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics. San Francisco: Encounter Books; 2002. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11662217/>
22. Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, OCDE. Prestación de servicios de salud de calidad: Un imperativo mundial para la cobertura sanitaria universal. Ginebra: OMS; 2018. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241513906>
23. National Institutes of Health. Strategic Plan for NIH Obesity Research. Bethesda, MD: NIH; 2017. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16002822/>
24. American Public Health Association. Public Health Code of Ethics. Washington, DC: APHA; 2013. https://www.apha.org/getcontentasset/43d5fdee-4ccd-427d-90db-b1d585c880b0/7ca0dc9d-611d-46e2-9fd3-26a4c03ddcbb/code_of_ethics.pdf?language=en
25. Murray CJL, Frenk J. Ranking 37th — Measuring the Performance of the U.S. Health Care System. *N Engl J Med*. 2010; 362(2):98–99. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20054038/>
26. Centers for Disease Control and Prevention. Health-Related Quality of Life (HRQOL): Methods and Measures. Atlanta, GA: CDC; 2018. https://archive.cdc.gov/www_cdc.gov/hrqol/methods_measures.htm
27. National Institute for Health and Care Excellence. Multimorbidity: Clinical Assessment and Management. Londres: NICE; 2016. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng56>
28. National Academy of Medicine. Vital Signs: Core Metrics for Health and Health Care Progress. Washington, DC: The National Academies Press; 2015. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26378329/>
29. Banco Mundial. Invertir en salud: Análisis de la situación de la salud mundial. Washington, DC: Banco Mundial; 2018. <https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/RI55-SG-Documentos-BM-Informe-anual-2018-del-Banco-Mundial.pdf>
30. Huber M, Knottnerus JA, Green L, van der Horst H, Jadad AR, et al. How should we define health? *BMJ*. 2011; 343:d4163. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21791490/>
31. Venkatapuram S. Health Justice: An Argument from the Capabilities Approach. Cambridge: Polity Press; 2011. <https://philpapers.org/rec/VENHJA>
32. Bircher J, Hahn EG. Understanding the nature of health: New perspectives for medicine and public health. *F1000Res*. 2016; 5:167. doi: 10.12688/f1000research.9103.1. https://www.researchgate.net/publication/294277348_Understanding_the_nature_of_health_New_perspectives_for_medicine_and_public_health_Improved_wellbeing_at_lower_costs
33. Jadad AR, O'Grady L. How should health be defined? *BMJ*. 2008; 337:a2900. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19073663/>
34. Callahan D. The Troubled Dream of Life: In Search of a Peaceful Death. Washington, D.C.: Georgetown University Press; 2000. <https://press.georgetown.edu/Book/The-Troubled-Dream-of-Life>
35. Whitmee S, Haines A, Beyrer C, et al. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. *Lancet*. 2015; 386(10007):1973–2028. [https://www.thelancet.com/article/S0140-6736\(15\)60901-1/fulltext](https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(15)60901-1/fulltext)
36. Bircher J, Kuruvilla S. Defining health by addressing individual, social, and environmental determinants: New opportunities for health care and public health. *J Public Health Policy*. 2014; 35(3):363–386. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24943659/>
37. Boorse C. Health as a Theoretical Concept. *Philos Sci*. 1977; 44(4):542–573. <https://www.jstor.org/stable/186939>
38. Huber M, Knottnerus JA, Green L, van der Horst H, et al. How should we define health? *BMJ*. 2011; 343:d4163. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21791490/>
39. Bircher J, Hahn EG. Understanding the nature of health: New perspectives for medicine and public health. *F1000Res*. 2016; 5:167. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4837984/>
40. Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press; 1990. <https://pagotto.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/the-three-worlds-of-welfare-capitalism-1990.pdf>
41. Pierson, Christopher. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare. Cambridge: Polity Press; 1998. https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?docid=alma993408203402676&context=L&vid=41ILO_INST:41ILO_V1&lang=en&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&q

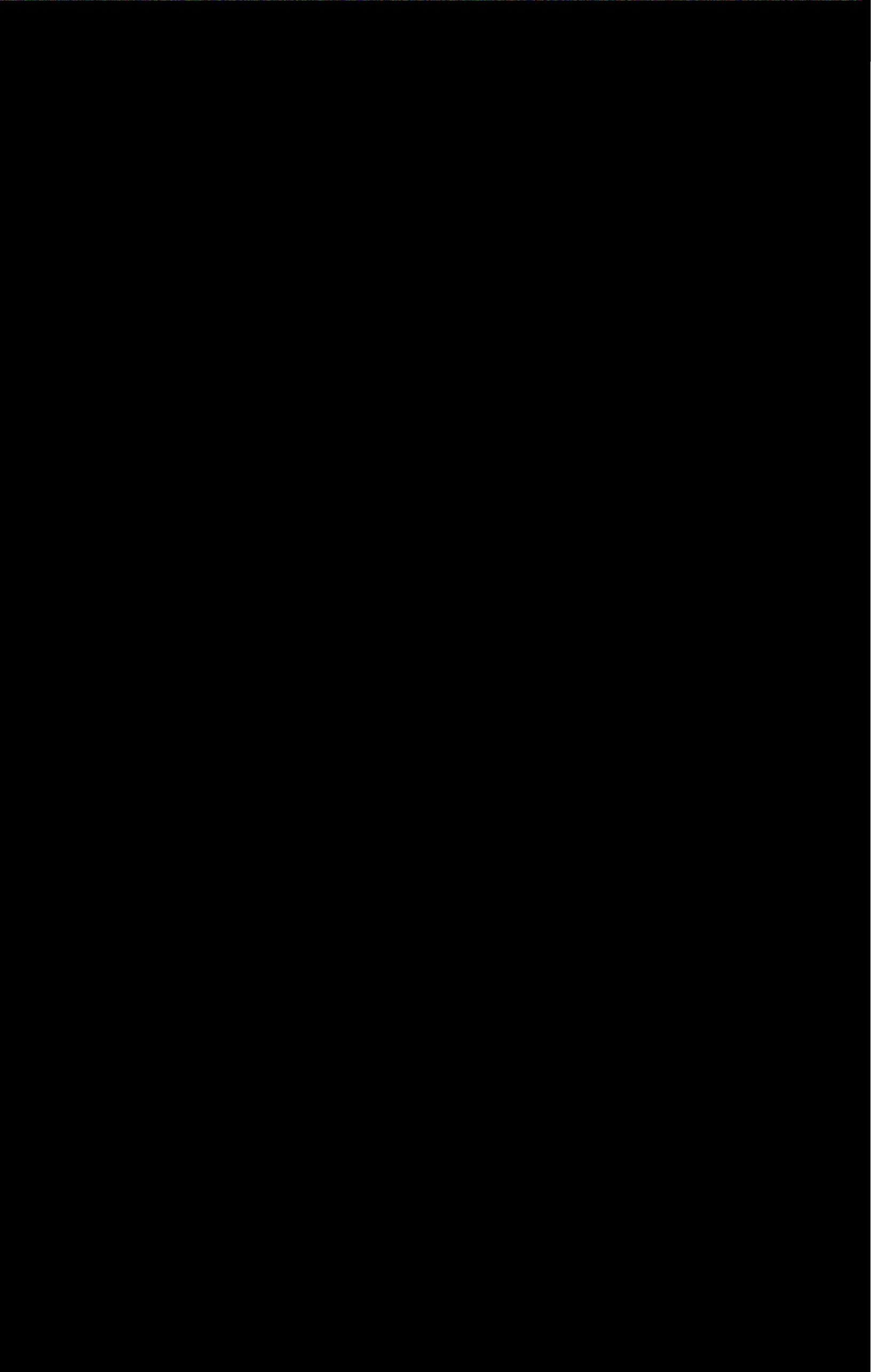
- [very=sub,exact,profesi%C3%B3n%20femenina,AND&mode=advanced](#)
42. Navarro V. Neoliberalism as a New Political Strategy: Policies and Health Outcomes. *Int J Health Serv.* 2007; 37(1):1-14. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17436985/>
 43. World Health Organization. Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage. Ginebra: WHO; 2010. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564021>
 44. Bambra C, Barr B, Milne E. The Role of the Welfare State in Reducing Health Inequalities: A Comparative Study of European Countries. *J Epidemiol Community Health.* 2014; 68:i1-i2. https://www.researchgate.net/publication/23394588_Welfare_state_regimes_unemployment_and_health_A_comparative_study_of_the_relationship_between_unemployment_and_self-reported_health_in_23_European_countries
 45. UNICEF. The Impact of Austerity Measures on Children and Families in Europe. Ginebra: UNICEF; 2017. <https://www.unicef.org/eca/media/5116/file/In%20focus%20ending%20child%20poverty%20.pdf>
 46. World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. Ginebra: WHO; 1986. https://www.naspa.org/images/uploads/kcs/WHPL_Canon_HP_Ottawa_Charter_5.pdf
 47. Kickbusch I. The Contribution of the World Health Organization to a New Public Health and Health Promotion. *Am J Public Health.* 2003; 93(3):383-388. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12604477/>
 48. WHO, UNICEF. Declaration of Alma-Ata. Ginebra: WHO; 1978. <https://www.unicef.org/media/85611/file/Alma-Ata-conference-1978-report.pdf>
 49. World Health Organization. Declaration of Astana. Ginebra: OMS; 2018. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2018.61>
 50. Kruk ME, et al. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *Lancet Glob Health.* 2018; 6(11):e1196-e1252. [http://thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS-2214-109X\(18\)30386-3/fulltext](http://thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS-2214-109X(18)30386-3/fulltext)
 51. Starfield B. Primary Care and Equity in Health: The Importance to Effectiveness and Equity of Health Systems. *J Ambul Care Manage.* 2009; 32(1):65-73. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/016059760903300105>
 52. Starfield B. Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology. Oxford: Oxford University Press; 1998. <https://academic.oup.com/book/54224>
 53. Whitehead M, Dahlgren G. What can be done about inequalities in health? *Lancet.* 1991; 338(8774):1059-1063. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1681366/>
 54. Organización Panamericana de la Salud. Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Washington, D.C.: OPS; 2014. <https://www.paho.org/es/documentos/estrategia-para-acceso-universal-salud-cobertura-universal-salud>
 55. UNICEF, OMS. A vision for primary health care in the 21st century: towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals. Ginebra: OMS; 2018. <https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/vision.pdf>
 56. Organización Mundial de la Salud. Working together for health: The World Health Report 2006. Ginebra: OMS; 2006 [citado 8 abr 2025]. <https://www.who.int/publications/i/item/9241563176>
 57. Rose G. The Strategy of Preventive Medicine. Oxford: Oxford University Press; 1992. <https://global.oup.com/academic/product/roses-strategy-of-preventive-medicine-9780192630971?cc=ve&lang=en&>
 58. Gray JAM. Evidence-Based Healthcare: How to Make Health Policy and Management Decisions. Londres: Churchill Livingstone; 2001. <https://es.scribd.com/document/230168704/Evidence-Based-Healthcare-How-to-Make-Health-Policy-and-Decision>
 59. Starfield B. Is primary care essential? *Lancet.* 2001; 357(9269):1029-1030. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7934497/>
 60. Eduardo G. El médico general en el nivel primario de atención de salud del Reino Unido [Internet]. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; 2022 [citado 4 abr 2025]. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33342/1/BCN2_General_Practitioner_y_la_Atencion Primaria_en_NHS_de_Reino_Unido_en_Plantilla_BCN_Final.pdf
 61. De Sousa MF, Merchán-Hamann E, Machado AV. El Programa Salud de la Familia en el Brasil: de las conquistas a los desafíos. *Rev Fac Nac Salud Pública.* 2012; 30(1):66-74. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2012000100008
 62. Castell-Florit Serrate P. Logros y retos de la Atención Primaria de Salud en Cuba. *Rev haban cienc méd.* 2018; 17(2):168-171. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2018000200001
 63. Eguía HA, et al. La atención primaria en Dinamarca. *Aten Primaria.* 2019; 45(8):552-558. <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-pdf-download-S1138359319300218>
 64. Organización Panamericana de la Salud. Atención primaria de salud [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2025 [citado 5 abr 2025]. <https://www.paho.org/es/temas/atencion-primaria-salud>
 65. Egaña Rojas D, Iglesias Vejar L, Cerda Rioseco R, Molina Carrasco P, Gálvez Espinoza P. Participación social en la atención primaria en salud: tensiones y contradicciones [Internet]. Barcelona: Elsevier; 2020 [citado el 2 mar 2026].

- Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.02.013>
66. Rose G. The Strategy of Preventive Medicine. Oxford: Oxford University Press; 1992. <https://global.oup.com/academic/product/roses-strategy-of-preventive-medicine-9780192630971?cc=ve&lang=en&>
 67. Bengoa R, Kawar R. Transforming Health Care: Trends and Policy Options. Ginebra: World Health Organization; 2017. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3812354/>
 68. Gray JAM. Evidence-Based Healthcare: How to Make Health Policy and Management Decisions. Churchill Livingstone; 2001. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1114687/>
 69. Mant D, Fowler GH. Mass screening: theory and ethics. BMJ. 1990; 300(6737):1251-1253. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2110841/>
 70. Morley CP, et al. Improving Cancer Screening Rates in Primary Care via Practice Facilitation and Academic Detailing. J Patient Cent Res Rev. 2021; 8(4):315-325. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34722799/>
 71. Marmot M. Fair Society, Healthy Lives: The Marmot Review. Londres: University College London; 2010. <https://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/fair-society-healthy-lives-the-marmot-review/fair-society-healthy-lives-full-report-pdf.pdf>
 72. Marmot MG, Wilkinson RG, editors. Social Determinants of Health. Oxford: Oxford University Press; 2006. <https://global.oup.com/academic/product/social-determinants-of-health-9780198565895?cc=ve&lang=en&>
 73. Heath I. Ayudar a morir. Madrid: Editorial Katz; 2009. <https://es.scribd.com/document/386648718/Heath-Ayudar-a-Morir>
 74. US Preventive Services Task Force. USPSTF Recommendations [Internet]. Rockville: USPSTF; 2021 [citado 2026]. Disponible en: www.uspreventiveservicestaskforce.org
 75. Demo P. Ciencias sociales y calidad. Madrid: Editorial Narcea; 1988. <https://www.agapea.com/libros/Ciencias-sociales-y-calidad-9788427708006-i.htm?srsId=AfmBOorSEEqz6z11KWkQWsvclIX1qmRle4aNy6MgVvWDMpDsd7vCDLvA>
 76. Antobeli L. Participación Comunitaria en Salud: la experiencia peruana con los CLAS. En: La Salud Peruana en el Siglo XXI. Lima: CIES; 2002. p. 303-354 [citado 6 abr 2025]. <https://www.future.edu/wp-content/uploads/2018/06/vi-participacion-comunitaria-en-la-salud-jsf.pdf>
 77. Raeburn J. Health promotion research with courtesy: Keeping a people perspective. Can J Public Health. 1992; 83:20-24. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1423119/>
 78. MacDonald TH. Rethinking health promotion: A global approach. Londres: Routledge; 1998. <https://www.routledge.com/Rethinking-Health-Promotion-A-Global-Approach/MacDonald/p/book/9780415164757>
 79. Andreasen A. Social Marketing: Definition and Domain. J Public Policy Mark. 1994; 13:108-114. <https://www.jstor.org/stable/30000176>
 80. Organización Mundial de la Salud. Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI [Internet]. Yakarta: OMS; 1997 [citado 7 abr 2025]. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA51/said2.pdf
 81. Organización Mundial de la Salud. Promoción de la Salud en el Marco de la Atención Primaria de Salud. Ginebra: OMS; 2018. <https://www.who.int/docs/default-source/documents/operational-framework-for-primary-health-care-wha73-sp.pdf>
 82. Organización Mundial de la Salud. Guía de estrategias de prevención y control de enfermedades no transmisibles. Ginebra: OMS; 2021. [https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B3_S23_estrategia_nacional_abordaje_integral_ENTO_2022_2030%20\(1\).pdf](https://extranet.who.int/ncdccs/Data/CRI_B3_S23_estrategia_nacional_abordaje_integral_ENTO_2022_2030%20(1).pdf)
 83. Naciones Unidas. Salud y bienestar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nueva York: ONU; 2021. https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_Spanish.pdf
 84. Organización Panamericana de la Salud. Estrategias de prevención de enfermedades transmisibles en América Latina. Washington, D.C.: OPS; 2022. <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-transmisibles>
 85. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Plan Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Prioritarias. Caracas: MPPS; 2023. <https://mpps.gob.ve/repotencian-planes-de-vacunacion-a-nivel-nacional/#:~:text=Prensa%20MPPS.,pro%20del%20bienestar%20del%20soberano.>
 86. Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO/Ministério da Saúde; 2002. <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0253.pdf>
 87. Organización Panamericana de la Salud. Renovando la Atención Primaria de Salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2005. <https://www.paho.org/sites/default/files/Renovacion-Atencion-Primaria-Salud-Americas-OPS.pdf>
 88. Organización Panamericana de la Salud. Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud en las Américas [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2021 [citado 16 abr 2025]. <https://www.paho.org/es/temas/atencion-primaria-salud>
 89. Organización de las Naciones Unidas. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [Internet]. Nueva York: ONU; 2015 [citado 7 abr 2025]. <https://www.un.org/>

- sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
90. Naciones Unidas. Salud y bienestar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nueva York: ONU; 2021. https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_Spanish.pdf
 91. Organización Panamericana de la Salud. Estrategias de prevención de enfermedades transmisibles en América Latina. Washington, D.C.: OPS; 2022. <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-transmisibles>
 92. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Plan Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Prioritarias. Caracas: MPPS; 2023. <https://mpps.gob.ve/repotencian-planes-de-vacunacion-a-nivel-nacional/#:~:text=Prensa%20MPPS.,pro%20del%20bienestar%20del%20soberano.>
 93. Organización Mundial de la Salud. Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI [Internet]. Yakarta: OMS; 1997 [citado 8 abr 2025]. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA51/said2.pdf
 94. Organización Mundial de la Salud. Promoción de la Salud en el Marco de la Atención Primaria de Salud. Ginebra: OMS; 2018. <https://www.who.int/docs/default-source/documents/operational-framework-for-primary-health-care-wha73-sp.pdf>
 95. Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5.453 (Extraordinaria) de fecha 24 de marzo de 2000 [citado 10 abr 2025]. <https://www.saren.gob.ve/wp-content/uploads/2025/01/GO-24032000-5453.pdf>
 96. Venezuela. Ley Orgánica de Salud. Gaceta Oficial N° 36.579 de fecha 11 de noviembre de 1998 [citado 10 abr 2025]. https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/09/gaceta-oficial-de-la-republica-de_201.html
 97. Venezuela. Gaceta Oficial N° 6.446 (Extraordinario): Plan de la Patria 2019-2025. Caracas: Imprenta Nacional; 2019 [citado 10 abr 2025]. <https://www.traviesoevens.com/wp-content/uploads/gacetas/2019/04-abril/2019-04-08-6446-extraordinario.pdf>
 98. Probabilidad y Estadística. Análisis de sensibilidad [Internet]. 2025 [citado 12 abr 2025]. Disponible en: <https://www.probabilidadyestadistica.net/analisis-de-sensibilidad/>
 99. EMpower. Conceptos básicos de monitoreo y evaluación [Internet]. Nueva York: The Emerging Markets Foundation; 2025 [citado 11 abr 2025]. <https://empowerweb.org/areas-of-focus/>
 100. World Health Organization. Service Availability and Readiness Assessment (SARA). Reference Manual. Ginebra: WHO; 2014 [citado 11 abr 2025]. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-HSI-2014.5-Rev.1>



ANEXOS



ANEXO 1

1. Manifestación de adscripción voluntaria familiar al Programa Autogestionado de Atención Integral de Salud (P.A.A.I.S.)

Yo _____, de nacionalidad _____, portador de la Cédula de Identidad número _____ y del número de Telefonía Celular _____, en mi condición de Jefe de la familia _____, por medio de la presente, manifiesto la voluntad de adscribir mi núcleo familiar al Programa Auto gestionado de Atención Integral de Salud (P.A.A.I.S.) de la Fundación Gustavo Pineda.

Entiendo que el referido programa es una iniciativa ciudadana de autogestión de la salud, que explora nuevas formas de gestión del proceso de salud como alternativa, basándose en paradigmas y enfoques alternativos, tales como el auto regentamiento y auto responsabilidad en salud, la integralidad, prevención, actualización y eficiencia.

Está claro que el referido proyecto constituye un emprendimiento corporativo donde todos sus participantes, tanto receptores como prestadores de servicios, se constituyen en socios igualitarios, comprometidos por igual en el éxito del mismo. En este sentido, todos los participantes serán accionistas de una Empresa Social de Salud sostenible y sustentable, que si bien utilice métodos y prácticas eficientes de negocio, su fin último no es el de generar utilidades financieras para sus propietarios, sino contribuir en la solución del problema social de la salud, produciendo un superávit que sea reinvertido para expandir el emprendimiento, brindando al mismo tiempo servicios de calidad a los pacientes, lo mismo que salarios de mercado y buenas condiciones laborales para sus trabajadores.

Comparto el objetivo del programa de promover y preservar la salud de sus participantes a través de una atención integral, eficaz y digna, para lo cual ejecutará diversos planes que prioricen la Atención Comunitaria Primaria sobre la hospitalaria. En tal sentido, espero junto a mi familia, participar en diversas actividades de organización, diagnóstico, tamizaje, planificación, promoción, educación, prevención, asistencia médica primaria, prevención secundaria y rehabilitación, todas las cuales redunden en nuestro bienestar y generen una baja morbilidad o siniestralidad, que igualmente cuente con una total cobertura de atención hospitalaria, con adecuados tiempos de respuesta y atención estandarizada.

Esta es una adscripción a un grupo de quinientas (500), diez mil personas (10.000), de cualquier sexo, edad, condición morbil pre existente, grupo étnico, estrato socioeconómico, nacionalidad, nivel de instrucción y nacionalidad, residenciadas en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, siendo los dos únicos criterios de exclusión, el desplazamiento fuera de la jurisdicción durante más de tres meses y el abandono voluntario formal del programa.

Finalmente, esta manifestación de voluntad no implica, de ninguna manera, compromiso u obligación financiera alguna por mi parte, ni de ningún miembro de mi familia, para con la Fundación Gustavo Pineda o con algunos de sus miembros, hasta tanto se haya concretado incorporación formal con la adquisición accionaria y firma del respectivo contrato.

En Maracaibo, a la fecha de la adscripción: _____

El Jefe de familia

ANEXO 2

2. Ficha social de salud

Fundación Gustavo Pineda
Programa Autogestionado de Atención Integral de Salud

N° de Familia: _____
Día: _____ Mes: _____ Año: _____

FICHA SOCIAL DE SALUD

I- LOCALIZACIÓN		1 REGIÓN:		2 SUB-REGIÓN:		3 DISTRITO SANITARIO:												
4 PARROQUIA:		5 SECTOR O COMUNIDAD:		6 SUB SECTOR:														
II- DATOS JEFE DE FAMILIA		1 APELLIDOS Y NOMBRES:		2 C.I.:														
3 SITIO DE LABOR:		4 DIRECCIÓN		5 TLF:														
III- CARACTERÍSTICAS SOCIO SANITARIAS DEL GRUPO FAMILIAR																		
1 APELLIDOS Y NOMBRES		2 SEXO	3 EDAD	4 FILIACIÓN	5 ESTADO CIVIL	6 NACIONALIDAD	7 NSTRUCCIÓN	8 PROFESIÓN U OFICIO	9 SITUACIÓN OCUPAC.	10 TIPO DE TRABAJO	11 INGRESO MENSUAL	12 DEPORTES	13 ESPARCIMIENTO	14 ACTIVIDAD CULTURAL	15 AFILIADO A	16 INMUNIZACIONES	17 OBSERVACIONES	
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
IV- RIESGOS DE SALUD		V- ANTECEDENTES DE SALUD																
VI- VIVIENDA		01 TIPO	02 TENENCIA	03 TECHO	04 PAREDES	06 N° AMBIENTES	05 PISO	07 DÓNDE DUERMEN	08 No. DE UNIDADES									

Ficha social de salud (Continuación)

09 ANIMALES DOMÉSTICOS			VII- SERVICIOS		01 AGUA	02 EXCRETAS	03 BASURA	04 ELECTRICIDAD		05 EQUIPOS	
VIII- MOVILIDAD	01 TIEMPO EN EL SECTOR		02 RESIDENCIA ANTERIOR		03 PIENSA MUDARSE?		04 DÓNDE?		05 POR QUÉ?		
IX- INGRESOS	USD	X- EGRESOS	USD	XI- SINTESIS DE LA SITUACIÓN SOCIO SANITARIA DEL GRUPO FAMILIAR							
01 SUELDO/SALARIO		01 VIVIENDA									
02 BECAS/SUBSIDIOS		02 ALIMENTACIÓN									
03 JUBILACIÓN		03 SALUD									
04 PENSIÓN		04 SERVICIOS									
05 RENTAS		05 EDUCACIÓN									
06 TRABAJOS EXTRAS		06 SEGUROS									
07 AYUDA PARTICULAR		07 AHORROS									
08 REMESAS		08 RECREACIÓN									
09 OTROS		09 OTROS									
TOTAL		TOTAL		XII- EVALUACIÓN		0	1		2		

ANEXO 3

Tabulador de ficha social de salud (Continuación)

[illegible]

Tabulador de ficha social de salud (Continuación)

[illegible]

Tabulador de ficha social de salud (Continuación)

[illegible]

Tabulador de ficha social de salud (Continuación)

[illegible]

Tabulador de ficha social de salud (Continuación)

[illegible]

ANEXO 4

4. Tabla de códigos de ficha social de salud.
Características del grupo familiar

04 EDAD

- 01** Menores de un año
- 02** 1 a 4 años
- 03** 5 a 9 años
- 04** 10 a 14 años
- 05** 15 a 19 años
- 06** 20 a 24 años
- 07** 25 a 29 años
- 08** 30 a 34 años
- 09** 35 a 39 años
- 10** 40 a 44 años
- 11** 45 a 49 años
- 12** 50 a 54 años
- 13** 55 a 59 años
- 14** 60 a 64 años
- 15** 65 a 69 años
- 16** 70 a 74 años
- 17** 75 a 79 años
- 18** 80 a 84 años
- 19** 85 a 89 años
- 20** 90 a 94 años
- 21** Más de 95 años
- 22** Sin información

05 FILIACIÓN

- 01** Esposa(o)
- 02** Unión de hecho
- 03** Padre
- 04** Madre
- 05** Padrastro
- 06** Madrastra
- 07** Hijo
- 08** Hijastro
- 09** Abuelo
- 10** Bisabuelo
- 11** Nieto
- 12** Hermano
- 13** Tío
- 14** Sobrino
- 15** Suegro
- 16** Cuñado
- 17** Yerno o nuera
- 18** Criado
- 19** Otros
- 99** Sin información
- 00** No aplicable

06 ESTADO CIVIL

- 01** Soltera(o)
- 02** Casada(o)
- 03** Divorciada(o)
- 04** Viuda(o)
- 99** Sin información
- 00** No aplica

07 NACIONALIDAD

- 01** Venezolana
- 02** Colombiana
- 03** Ecuatoriana
- 04** Peruana
- 05** Argentina
- 06** Chilena
- 07** Brasileña
- 08** Italiana
- 09** Portuguesa
- 10** Española
- 11** China
- 12** Trinitaria
- 13** Haitiana
- 14** Otra
- 99** Sin información

08 INSTRUCCIÓN

- 01** Analfabeta mayor de 12 años
- 02** Alfabeta
- 03** Preescolar
- 04** Educación básica incompleta
- 05** Educación básica completa
- 06** Educación media diversificada incompleta
- 07** Educación media diversificada completa
- 08** Educación superior incompleta
- 09** Educación superior completa
- 10** Especialidad de postgrado
- 11** Doctorado
- 12** Postdoctorado
- 13** Sin instrucción
- 00** No aplica
- 99** Sin información

09 PROFESIÓN U OFICIO

- 01** Profesionales técnicos y personas con ocupaciones afines
- 02** Gerentes administradores y funcionarios directivos
- 03** Empleados de oficina calificados
- 04** Empleados de oficina no calificado
- 05** Agricultores, Pescadores o trabajadores afines

06 Hacendados, ganaderos e industriales	12 INGRESO MENSUAL
07 Obreros especializados	01 Entre 01 y 300
08 Obreros no especializados	02 Entre 301 y 600
09 Comerciante	03 Entre 601 y 900
10 Vendedores especializados y no especializados a destajo	04 Entre 901 y 1200
11 Conductores de medios de transportes, Comunicaciones y afines	05 Entre 1201 y 1500
12 Artesanos especializados y no especializados	06 Entre 1501 y 1800
13 Pequeños y medianos industriales	07 Entre 1801 y 1900
14 Trabajadores de la cultura, el deporte y otras recreaciones	08 Mayores a 1900
15 Docentes	09 Ningún ingreso
16 Amas de casa	10 Sin información
17 Estudiantes	00 No aplica
18 Funcionarios de cuerpos de seguridad	13 DEPORTES
19 Emprendedor	01 Béisbol-Softball
20 Influencer	02 Voleibol
21 Ocupaciones no definidas y no declaradas	03 Fútbol-Futbolito
99 Sin información	04 Basquetbol
00 No aplica mayores de 95 años y menores de 15 años.	05 Natación
10 SITUACIÓN OCUPACIONAL	06 Ajedrez
01 Ocupado	07 Ciclismo
02 Empleado fijo	08 Gimnasia
03 Empleado a destajo	09 Ping-pong
04 Trabaja por su cuenta	10 Atletismo
05 Trabaja y estudia	11 Caminatas
06 Estudiantes	12 Trotes
07 Labores del hogar	13 Bolas criollas
08 Empleado contratado	14 Coleo de toros
09 Desocupado	15 Artes marciales
10 Buscando trabajo	16 Aerobios
11 Jubilados	17 Otros
12 Pensionados	88 Ninguno
13 Rentistas	99 Sin información
14 Impedido	00 No aplicable
15 Otros	14 ESPARCIMIENTO
99 Sin información	01 Parques y paseos
00 No aplica	02 Cines
11 TIPO DE INGRESO	03 Teatro
01 Fijo	04 Playa o río
02 Temporal	05 Campo-montaña
03 Variable	06 Fiesta
88 Ninguno	07 Parrandas
99 Sin información	08 Juegos de mesa
00 No aplicable menores de 7 años	09 Lecturas
	10 Espectáculos
	11 Audición musical
	12 Audición radial
	13 Televisión
	14 Visitas y tertulias
	15 Juegos infantiles
	16 Actividades grupales
	17 Otros

- 88** Ninguno
- 99** Sin información
- 00** No aplica

15 ACTIVIDADES CULTURALES

- 01** Interpretación musical
- 02** Teatro y danza y afines
- 03** Títeres y marionetas
- 04** Pintura o dibujo
- 05** Literatura y poesía
- 06** Manualidades
- 07** Actividades periodísticas
- 08** Mágico religiosas
- 09** Otros
- 88** Ninguno
- 99** Sin información
- 00** No aplica

16 AFILIACIÓN A

- 01** IVSS
- 02** IPASME
- 03** Privado
- 04** Colectivo
- 05** Colegiado
- 06** Club
- 07** ONG
- 08** Otros
- 88** Ninguno
- 99** Sin explicación, Sin información

17 INMUNIZACIONES

- 01** Todas
- 02** Incompletas
- 88** Ninguna
- 99** Sin información
- 00** No aplica

18 RIESGO DE SALUD

- 01** Obesidad
- 02** Desnutrición
- 03** Sedentarismo
- 04** Consumo de alcohol
 - 04.1** A diario
 - 04.2** Casi a diario
 - 04.3** Los fines de semana
 - 04.4** Ocasional
- 05** Hipercolesterolemia
- 06** Uso de auto o motocicleta
- 07** Riesgo laboral
- 08** Hábitos de salud bucal inadecuados
- 09** Hacinamiento
- 10** Viviendas en zonas de peligro
 - 10.1** Orilla de Río quebrada

- 10.2** Junto a cables de alta tensión
- 10.3** Zona de derrumbe
- 10.4** Junto a aguas residuales y/o basurero

- 10.5** Junto A tuberías o depósito combustibles
- 10.6** Cerca de industrias contaminantes

- 11** Fauna nociva
 - 11.1** Rata y ratones
 - 11.2** Cucarachas y chiripas
 - 11.3** Moscas
 - 11.4** Zancudos
 - 11.5** Avispas y abejas escorpiones y alacranes
 - 11.7** Chipos
 - 11.8** Serpientes

- 12** Rabia animal
 - 12.1** Perros
 - 12.2** Gatos
 - 12.3** Vampiros
 - 12.4** Otros transmisores

- 13** Farmacodependencia y/o drogas de abuso
 - 13.1** Medicamentos
 - 13.2** Marihuana
 - 13.3** Cocaína
 - 13.4** Basuco
 - 13.5** Éxtasis
 - 13.6** Otra

- 14** Hábitos de fumar
- 15** Vivienda desaciada
- 16** Niños descalzos y desnudos
- 17** Otros
- 00** Sin información

ANTECEDENTES FAMILIARES DE SALUD

- 01** Diabetes
- 02** Hipertensión arterial
- 03** Obesidad
- 04** Infarto del miocardio
- 05** Accidente cerebrovascular (Derrame cerebral, trombosis)
- 06** Cáncer de mama
- 07** Otro tipo de cáncer
- 08** Enfermedades respiratorias (Neumonía, bronconeumonía, EBPOC, asma)
- 09** Alergias
- 10** Enfermedades mentales
- 11** Retardos mental, síndrome de Down
- 12** Epilepsia
- 13** Arresto por delito grave
- 14** Enfermedades de transmisión sexual

- 15 Farmacodependencia
- 16 Alcoholismo y farmacodependencia
- 18 Otros
- 19 Ninguna
- 99 Sin información

VIVIENDA

TIPO

- 01 Quinta
- 02 Casa
- 03 Apartamento
- 04 Habitación
- 05 Rancho
- 06 Otro
- 99 Sin información

TENENCIA

- 01 Propia
- 02 Propia pagando
- 03 Alquilada
- 04 Alquilada con opción a compra
- 05 Cedida
- 06 Invasada
- 07 Al cuido
- 08 Otro
- 99 Sin información

TECHO

- 01 Platabanda
- 02 Asbesto
- 03 Zinc
- 04 Teja
- 05 Paja, cartón o barro
- 06 Otro
- 99 Sin información

PAREDES

- 01 Ladrillo o bloque
- 02 Adobes
- 03 Bahareque
- 04 Tablas
- 05 Caña o Palma
- 06 Cartón
- 07 Zinc
- 00 Otro
- 99 Sin información

PISO

- 01 Mármol-cerámica
- 02 Mosaico-ladrillo
- 03 Granito
- 04 Vinil

- 05 Cemento
- 06 Tabla
- 07 Tierra
- 08 Otro
- 99 Sin información

Nº DE AMBIENTES

- 01 Uno
- 02 Dos
- 03 Tres
- 04 Cuatro
- 05 Cinco
- 06 Seis y mas
- 99 Sin información

EN QUÉ DUERMEN

- 01 Cama
- 02 Catre
- 03 Hamaca
- 04 Colchón
- 05 Suelo
- 06 Otros
- 99 Sin información

NÚMERO DE UNIDADES

- 01 Una unidad por persona
- 02 Más de una unidad por persona
- 03 Menos de una unidad por persona
- 99 Sin información

ANIMALES DOMÉSTICOS

- 01 Perros
- 02 Gatos
- 03 Aves
- 04 Monos
- 05 Serpientes
- 06 Roedores
- 07 Otros
- 00 Ninguno
- 99 Sin información

AGUA

- 01 Intra domiciliaria
- 02 Pila pública
- 03 Camión cisterna
- 04 Río o quebrada
- 05 Lluvia
- 06 Aljibe, pozo o Manantial
- 07 Otros
- 99 Sin información

EXCRETAS

- 01** Cloacas
- 02** Pozo séptico
- 03** Letrina
- 04** Suelo
- 99** Sin información

BASURA

- 01** Aseo urbano
- 02** Relleno sanitario
- 03** Acumulado
- 04** Quemada
- 05** Contenedor
- 06** Reciclada
- 07** Otro
- 99** Sin información

ELECTRICIDAD

- 01** Instalada
- 02** Tomada
- 03** Planta casera
- 99** Ningunas
- 00** Sin información

EQUIPOS

- 01** Televisión
- 02** Radio
- 03** Toca-discos
- 04** Equipo de sonido
- 05** Cocina
- 06** Lavadora
- 07** Máquina de coser
- 08** Automóvil
- 09** Motocicleta
- 10** Aire acondicionado
- 11** Ventilador
- 12** Nevera
- 13** Teléfonos celulares
- 13** Otros
- 99** Sin información

MOVILIDAD

TIEMPO EN EL SECTOR

- 01** Menos de un año
- 02** 1 y 4 años
- 03** 4 y 8 años
- 04** 9 y 12 años
- 05** 13 y 16 años
- 06** 17 años y más
- 99** Sin información

RESIDENCIA ANTERIOR

- 01** En el mismo sector o comunidad
- 02** Otra comunidad o sector del mismo Distrito Sanitario
- 03** Otro Distrito Sanitario del mismo estado
- 04** Otro estado
- 05** Otro país
- 06** Sin información

PIENSA MUDARSE

- 01** Sí
- 02** No
- 99** Sin información

A DÓNDE

- 01** En el mismo sector o comunidad
- 02** Otro sector o comunidad del mismo Distrito sanitario
- 03** Otro Distrito sanitario del mismo estado
- 04** Otro estado
- 05** Otro país
- 99** Sin información

POR QUÉ

- 01** Por trabajo
- 02** Por adquisición de vivienda
- 03** Por estar alquilado
- 04** Por problemas familiares
- 05** Vivienda inadecuada
- 06** Por rechazo a la comunidad
 - 06.1** Sector peligroso
 - 06.2** Razón ambiental
 - 06.3** Razón social
- 07** Por desalojo
- 08** Otro
- 99** Sin información
- 00** No aplicable

ANEXO 5

5. Modelo de historia clínica

FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA
PROGRAMA AUTOGESTIONADO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD

CARÁTULA DE HISTORIA CLÍNICA

NÚMERO DE LA UBPSS: _____

NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA: _____

APELLIDO(S): _____ NOMBRE(S): _____

FECHA DE NACIMIENTO: _____ CÉDULA DE IDENTIDAD: _____

EDAD: _____ SEXO: _____ ETNIA: _____

TELÉFONO: _____ DIRECCIÓN: _____

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A: _____

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): _____

TELÉFONO: _____ DIRECCIÓN PARTICULAR: _____

FECHA DE INGRESO: _____ FECHA DE EGRESO: _____

DIAGNÓSTICO(S) DE INGRESO: _____

MÉDICO QUE REALIZA EL INGRESO: _____

FIRMA

5.1-. Consentimiento Informado

YO, _____ , con Cédula de Identidad _____
 , estoy de acuerdo en ingresar en el Programa Autogestionado de Atención Integral de
 Salud (P.A.A.I.S.) de la FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA y realizarme todos los procedimientos
 (procedimientos?), investigaciones y tratamientos médicos necesarios para la promoción,
 prevención, restitución y rehabilitación de mi salud.

Firma del paciente
o familiar responsable

5.2-. Historia Clínica General

ENFERMEDAD ACTUAL: _____

ANTECEDENTES PERSONALES:

PATOLÓGICOS: _____

ALÉRGICOS: _____

QUIRÚRGICOS: _____

PSICOBIOLOGICOS: _____

REVISIÓN DE ÓRGANOS Y SISTEMAS:

VISUAL: _____

ORL: _____

RESPIRATORIO: _____

CARDIOVASCULAR: _____

DIGESTIVO: _____

GENITOURINARIO: _____

ENDOCRINO: _____

GINECO OBSTÉTRICOS: _____

LOCOMOTOR: _____

NEUROLÓGICO: _____

OTROS ANTECEDENTES DE INTERÉS: _____

Examen Físico General

	N	P	NE	DESCRIBIR LO POSITIVO
HÁBITO CORPORAL				
FACIE				
MARCHA				
PIEL				
MUCOSAS				
TCS				

N: NEGATIVO, P: POSITIVO y NE: NO EXPLORADO.

PESO: TALLA: VALORACIÓN NUTRICIONAL:

	N	P	NE	DESCRIBIR LO POSITIVO
CRÁNEO Y CARA				
CUELLO				
TORAX				
ABDOMEN				
COLUMNA				
EXTREMIDADES				

N: NEGATIVO, P: POSITIVO y NE: NO EXPLORADO.

Examen Físico por Aparatos

	N	P	NE	DESCRIBIR LO ANORMAL
A. RESPIRATORIO				
INSPECCIÓN				
PALPACIÓN				
PERCUSIÓN				
AUSCULTACIÓN				
F. RESPIRATORIA				
A.C.V.				
INSPECCIÓN				
PALPACIÓN				
PERCUSIÓN				
AUSCULTACIÓN				
F. RESPIRATORIA				
A. DIGESTIVO				
INSPECCIÓN				
PALPACIÓN				
PERCUSIÓN				
AUSCULTACIÓN				
F. RESPIRATORIA				
A. GENITO URINARIO				
INSPECCIÓN				
PALPACIÓN				
PERCUSIÓN				
AUSCULTACIÓN				
F. RESPIRATORIA				
A. HEMOLINFO				
INSPECCIÓN				
PALPACIÓN				
A. ENDOCRINO				
INSPECCIÓN				
PALPACIÓN				
SOMA				
INSPECCIÓN				
PALPACIÓN				
S. N. C.				
FACIE				
MARCHA				
ACTITUD ANTE EL HECHO				
TONO Y TROFISMO				
FUERZA MUSCULAR				
REFLECTIVIDAD				
SENSIBILIDAD				
PARES CRANEALES				

N: NEGATIVO, P: POSITIVO y NE: NO EXPLORADO.

Discusión Diagnóstica

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Resultados de Complementarios Indicados

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

5.3-. Historia Psicosocial

[illegible]

5.4.-. Evaluación y Seguimiento del Paciente

INDICACIONES MÉDICAS

FECHA / HORA	INDICACIONES MÉDICAS	3 pm – 11 pm	11 pm – 7 am

5.5-. Hoja de Egreso

MOTIVO DE INGRESO: _____

RESUMEN SINDRÓMICO: _____

DATOS POSITIVOS AL EXAMEN FÍSICO: _____

EVOLUCIÓN: _____

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: _____

RECOMENDACIONES PARA SU SEGUIMIENTO: _____

INDICACIONES MÉDICAS: _____

FECHA DE INGRESO: ____ / ____ / ____ HORA: _____

FECHA DE EGRESO: ____ / ____ / ____ HORA: _____

ESTADÍA: _____

Dr. (a). _____

ANEXO 6

6. Hojas de trabajo

FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA
PROGRAMA AUTOGESTIONADO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD

6.1-. Consulta

CONSULTA SOLICITADA AL: _____

MOTIVO DE LA CONSULTA: _____

Fecha de la solicitud

Firma del médico tratante

INFORME
(ANOTAR EN EL SIGUIENTE ORDEN:
HALLAZGOS, DIAGNÓSTICOS Y RECOMENDACIONES)

Fecha de la solicitud

Firma del médico tratante

FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA
PROGRAMA AUTOGESTIONADO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD

6.2-. Solicitud de Biopsia*

RECIBIDA

Muestra de: _____

Sitio de la lesión: _____

Tiempo de evolución: _____

Diagnóstico clínico: _____

Datos clínicos: _____

Periodo del ciclo (si el material es ginecológico): _____

¿Biopsia anterior? SÍ ☐ NO ☐

Desde fecha: _____

Firma del médico

Fecha y hora: _____

Recibido por:
SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

FIRMA

* Esta solicitud debe ir acompañada de 2 (dos) hojas informe-contestación de BIOPSIA, selladas en su lugar, con la placa de identificación del paciente.

	FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA PROGRAMA AUTOGESTIONADO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD
---	---

6.3-. Solicitud de Exámenes de Emergencia

FECHA: ____ / ____ / ____

NOMBRE: _____ EDAD: _____

SERVICIO: _____ CAMA: _____ HORA DE SOLICITUD: _____

DOCTOR: _____

MUESTRAS TOMADAS A LAS ____ m. RECIBIDO A LAS ____ m

EXÁMENES SOLICITADOS:

DIAGNÓSTICO CLÍNICO:

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL MÉDICO

FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA
PROGRAMA AUTOGESTIONADO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD

6.4-. Solicitud de Parasitología

FECHA: ____ / ____ / ____

NOMBRE: _____

- ☐ Examen de heces

☐ Concentrado (Ritchie)

☐ Contaje de huevos

☐ Sangre oculta

☐ Bilirrubina fecal

☐ Esterco bilina

☐ Esterco bilinógenr

☐ Grasas totales cualitativas
- ☐ Glucosa fecal

☐ Investigación leishmaniasis

☐ Investigación microfilmariás

☐ Investigación de Tripanosomas

☐ Flujo vaginal

☐ Clasif. Parásitos adultos

☐ Clasif. Ectoparásitos

☐ pH

OTROS:

OBSERVACIONES:

Firma

FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA
PROGRAMA AUTOGESTIONADO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD

6.5-. Solicitud de Perfil 20

FECHA: ____ / ____ / ____

NOMBRE: _____

- ☐ Hematología Completa
- ☐ Glicemia
- ☐ Urea
- ☐ Creatinina
- ☐ Ácido Úrico
- ☐ TGO, TGP
- ☐ Bilirrubina total y fraccionada
- ☐ Fosfatasa alcalina y ácida
- ☐ Proteograma
- ☐ Perfil lipídico
- ☐ Calcio sérico
- ☐ Ionograma
- ☐ Examen de orina

OBSERVACIONES:

Firma

FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA
PROGRAMA AUTOGESTIONADO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD

6.6-. Solicitud de Bioquímica Sanguínea

FECHA: ____ / ____ / ____

NOMBRE: _____

- ☐ Urea

☐ Glicemia

☐ Creatinina

☐ Fosfatasa Ácida

☐ Fosfatasa Alcalina

☐ Proteograma

☐ Transaminasa R

☐ Transaminasa P

☐ Hierro Sérico

☐ TIBC

☐ Gamma Glutamil Transferasa

☐ Cloro

☐ Sodio

☐ Potasio

☐ Magnesio
- ☐ Ácido Úrico

☐ Colesterol

☐ Calcio

☐ Fósforo

☐ Bilirrubina

☐ Fibrinógeno

☐ Deshidrogenasa Láctica

☐ Amilasas

☐ Amonio

☐ C.P.K.

☐ Triglicéridos

OTROS:

OBSERVACIONES:

Firma

	FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA PROGRAMA AUTOGESTIONADO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD
---	---

6.7-. Radiodiagnóstico

FECHA: ____ / ____ / ____
NOMBRE: _____

Hallazgos clínicos:

Examen solicitado:

_____	_____
Fecha y hora de la solicitud	Firma del médico tratante

Solicitud recibida: _____ Citado para: _____
Paciente examinado: _____

I N F O R M E

_____	_____
Fecha del informe	Firma del Médico Radiólogo

FUNDACIÓN GUSTAVO PINEDA
PROGRAMA AUTOGESTIONADO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD

6.8-. Solicitud de Uroanálisis

FECHA: ____ / ____ / ____

NOMBRE: _____

- ☐ Orina completa

☐ Urobilinógeno

☐ Urea

☐ Creatinina

☐ Sodio

☐ Cuerpos cetónicos

☐ Espermograma

☐ Fósforo

☐ Recuento minutado
- ☐ Dosificación de Glucosuria

☐ Dosificación de Proteínas.

☐ Amilasa

☐ Calcio

☐ Depuración de creatinina

☐ Potasio

☐ Cálculo renal (composición)

☐ Pruebas de embarazo.

OTROS:

OBSERVACIONES:

Firma del Médico

ANEXO 7

7. Matriz de tamizaje basada en “Recommendations for Preventive Services in Primary Care” y “Screening guidelines for disease prevention”.

7.1-. Plan de despistaje preventivo para pacientes menores de 1 año del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Oftalmía gonocócica neonatal: Profilaxis ocular con ungüento oftálmico de eritromicina.	Dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento.	-No hay información disponible actualmente sobre factores de riesgo.
2-. Caries: Barnizado de flúor a los dientes primarios para prevenir caries dental.	A partir de la edad de erupción del diente primario y luego una vez al año o cada 6 meses.	-Algunas organizaciones han abogado por restringir su uso a los niños con “mayor riesgo”, pero ninguna herramienta de evaluación del riesgo de caries ha sido validada en el ámbito de la atención primaria, ni los estudios existentes demuestran que las herramientas utilizadas, pueden diferenciar entre los niños que desarrollarán caries dental y los que no. -No hay evidencia clara sobre el incremento de caries al realizar el barnizado cada 6 meses versus una vez al año.
3-. Caries: Suministro de suplementos orales de flúor para prevenir caries dental.	A partir de los 6 meses de edad para niños cuyo suministro de agua es deficiente en flúoruro.	-Ningún estudio ha abordado específicamente la dosis y el momento de la administración. -Todos los niños corren un riesgo potencial de caries dental. Aquellos cuyo suministro de agua principal es deficiente en flúoruro (<0.6 ppm F) corren un riesgo particular. -No existen herramientas de detección multivariante validadas para determinar qué niños tienen un mayor riesgo de caries dental. -Hay una serie de factores individuales que elevan el riesgo, tales como. exposición frecuente al azúcar, alimentación inadecuada con biberón, defectos de desarrollo del esmalte dental, sequedad de boca y antecedentes de caries previa. Los factores maternos y familiares también pueden aumentar el riesgo de los niños, estando entre éstos la higiene oral deficiente, nivel socioeconómico bajo, caries materna reciente, caries en hermanos y picoteo frecuente. Los factores adicionales asociados con la caries dental en niños pequeños incluyen la falta de acceso a la atención dental; medidas preventivas inadecuadas, como la falta de uso de pastas dentales que contengan flúor; y la falta de conocimiento de los padres sobre la salud oral. -La mayor prevalencia y gravedad de la caries dental se encuentran entre los niños de minorías y económicamente desfavorecidos.
4-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Aplicable a tipos de piel clara.

7.2.- Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 1-4 años del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Caries: Barnizado de flúor a los dientes primarios para prevenir caries dental.	A partir de la edad de erupción del diente primario y luego una vez al año o cada 6 meses.	-Algunas organizaciones han abogado por restringir su uso a los niños con “mayor riesgo”, pero ninguna herramienta de evaluación del riesgo de caries ha sido validada en el ámbito de la atención primaria, ni los estudios existentes demuestran que las herramientas utilizadas, pueden diferenciar entre los niños que desarrollarán caries dental y los que no. -No hay evidencia clara sobre el incremento de caries al realizar el barnizado cada 6 meses versus una vez al año.
2-. Caries: Suministro de suplementos orales de flúor para prevenir caries dental.	A partir de los 6 meses de edad para niños cuyo suministro de agua es deficiente en fluoruro.	-Ningún estudio ha abordado específicamente la dosis y el momento de la administración. -Todos los niños corren un riesgo potencial de caries dental. Aquellos cuyo suministro de agua principal es deficiente en fluoruro (<0.6 ppm F) corren un riesgo particular. -No existen herramientas de detección multivariante validadas para determinar qué niños tienen un mayor riesgo de caries dental. -Hay una serie de factores individuales que elevan el riesgo, tales como. exposición frecuente al azúcar, alimentación inadecuada con biberón, defectos de desarrollo del esmalte dental, sequedad de boca y antecedentes de caries previa. Los factores maternos y familiares también pueden aumentar el riesgo de los niños, estando entre éstos la higiene oral deficiente, nivel socioeconómico bajo, caries materna reciente, caries en hermanos y picoteo frecuente. Los factores adicionales asociados con la caries dental en niños pequeños incluyen la falta de acceso a la atención dental; medidas preventivas inadecuadas, como la falta de uso de pastas dentales que contengan flúor; y la falta de conocimiento de los padres sobre la salud oral. -La mayor prevalencia y gravedad de la caries dental se encuentran entre los niños de minorías y económicamente desfavorecidos.
3-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Aplicable a tipos de piel clara.
4-. Ambliopía: Examen visual para detectarla o identificar sus factores de riesgo.	Al menos una vez al año	-Los factores de riesgo para la ambliopía incluyen estrabismo; errores refractivos elevados no corregidos (p. ej., miopía, hipermetropía y astigmatismo); anisometropía y opacidad de los medios. Los factores de riesgo adicionales asociados con ambliopía, estrabismo o errores de refracción incluyen antecedentes familiares de primer grado, prematuridad, bajo peso al nacer, abuso de sustancias por parte de la madre, tabaquismo materno durante el embarazo y bajos niveles de educación de los padres.

7.3-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 5-9 años del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Obesidad: Evaluar presencia de obesidad y/o remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-Las intervenciones conductuales integrales e intensivas con 26 horas de contacto o más durante 2 a 12 meses, han demostrado contribuir a la pérdida de peso y con 52 horas de contacto o más han demostrado contribuir con una mayor pérdida de peso y algunas mejoras en los factores de riesgo cardiovascular y metabólico. -La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
2-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
3-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco.. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco, a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

7.4-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras, del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diaria- mente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	La frecuencia óptima de detección para las personas que tienen un mayor riesgo de infección por sífilis no está bien establecida. Mejores que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-Los estudios iniciales sugieren que la detección de la infección por sífilis en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) o personas que viven con el VIH mejora cuando la detección se realiza cada 3 meses en comparación con una vez al año. -Los HSH y los hombres y mujeres que viven con el VIH, tienen el mayor riesgo de contraer la sífilis. -Al decidir qué personas examinar para la sífilis, los médicos deben tener en cuenta la prevalencia de la infección en las comunidades a las que sirven, así como otros factores sociodemográficos que pueden estar asociados con un mayor riesgo de infección por sífilis, tales como antecedentes de encarcelamiento, antecedentes de trabajo sexual comercial, ciertos grupos raciales/étnicos y ser un hombre menor de 29 años, así como variaciones regionales que están bien descritas
4-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
6-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
7-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	-No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses) *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
9-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
10-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Obesidad: Evaluar presencia de obesidad y/o remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	-No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-Las intervenciones conductuales integrales e intensivas con 26 horas de contacto o más durante 2 a 12 meses, han demostrado contribuir a la pérdida de peso y con 52 horas de contacto o más han demostrado contribuir con una mayor pérdida de peso y algunas mejoras en los factores de riesgo cardiovascular y metabólico. -La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
12-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
13-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.5-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	La frecuencia óptima de detección para las personas que tienen un mayor riesgo de infección por sífilis no está bien establecida. mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-Los estudios iniciales sugieren que la detección de la infección por sífilis en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) o personas que viven con el VIH mejora cuando la detección se realiza cada 3 meses en comparación con una vez al año. -Los HSH y los hombres y mujeres que viven con el VIH, tienen el mayor riesgo de contraer la sífilis. -Al decidir qué personas examinar para la sífilis, los médicos deben tener en cuenta la prevalencia de la infección en las comunidades a las que sirven, así como otros factores sociodemográficos que pueden estar asociados con un mayor riesgo de infección por sífilis, tales como antecedentes de encarcelamiento, antecedentes de trabajo sexual comercial, ciertos grupos raciales/étnicos y ser un hombre menor de 29 años, así como variaciones regionales que están bien descritas
4-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
6-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoría conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
7-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses) *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
9-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2 % o más representan del 47 % al 95 % de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
11-. Obesidad: Evaluar presencia de obesidad y/o remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-Las intervenciones conductuales integrales e intensivas con 26 horas de contacto o más durante 2 a 12 meses, han demostrado contribuir a la pérdida de peso y con 52 horas de contacto o más han demostrado contribuir con una mayor pérdida de peso y algunas mejoras en los factores de riesgo cardiovascular y metabólico. -La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
12-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
13-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.6--. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-.Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3--. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
4-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	- Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. - La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. - Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
6-. Obesidad: Evaluar presencia de obesidad y/o remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	- No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	- Las intervenciones conductuales integrales e intensivas con 26 horas de contacto o más durante 2 a 12 meses, han demostrado contribuir a la pérdida de peso y con 52 horas de contacto o más han demostrado contribuir con una mayor pérdida de peso y algunas mejoras en los factores de riesgo cardiovascular y metabólico. - La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. - Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. - Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
7-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	- No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	- Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. - El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
8-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	- La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. - Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. - Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.7-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
5-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
6-. Obesidad: Evaluar presencia de obesidad y/o remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-Las intervenciones conductuales integrales e intensivas con 26 horas de contacto o más durante 2 a 12 meses, han demostrado contribuir a la pérdida de peso y con 52 horas de contacto o más han demostrado contribuir con una mayor pérdida de peso y algunas mejoras en los factores de riesgo cardiovascular y metabólico. -La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco, a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
8-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.8-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
4-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses) *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres y hombres transgénero sexualmente activos.
6-. Incompatibilidad Rh: Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presentan por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Prevención de Preeclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal., la multiparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.
9-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.
10-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
12-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
13-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-.iabetes gestacional: Despistaje de diabetes.	A las 24 semanas de gestación o después para mejorar los resultados maternos y fetales.	-Varios factores aumentan el riesgo de una mujer de desarrollar diabetes gestacional, incluida la obesidad, el aumento de la edad materna, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes familiares de diabetes y la pertenencia a un grupo étnico que tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (ascendencia hispana, indígena, del sur o del este de Asia o de las islas del Pacífico). -Los factores asociados con un menor riesgo de desarrollar diabetes gestacional incluyen la edad menor de 25 a 30 años, la etnia caucásica, un índice de masa corporal (IMC) de 25 o menos, la ausencia de antecedentes familiares (en un pariente de primer grado) de diabetes y de intolerancia a la glucosa o resultados adversos del embarazo relacionados con la diabetes gestacional. -El riesgo en diferentes grupos raciales / étnicos puede deberse en parte a factores de riesgo social como el bajo nivel socioeconómico o el racismo estructural, aunque estas asociaciones no se examinan en la evidencia actual.
15-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo	Embarazo.
16-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
17-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
18-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
19- Depresión Perinatal: Proporcionar o remitir a las embarazadas y/o puérperas que tengan un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcanzan un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional y complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.
20-. Preeclampsia: Despistaje con medida de presión arterial, proteinuria y marcadores toxémicos.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si una paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, ésta debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Toda mujer embarazada está en riesgo de preeclampsia y debe ser examinada. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, la multiparidad, la obesidad, la raza afrodescendiente, el bajo nivel socioeconómico y la edad materna avanzada.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
21-. Incompatibilidad Rh: Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
22-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos. -La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
23-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
24-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	

7.9-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
4-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses) *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
6-. Incompatibilidad Rh: Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presentan por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Prevención de Preeclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal, la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.
9-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.
10-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
12-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
13-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-.Diabetes gestacional: Despistaje de diabetes.	A las 24 semanas de gestación o después para mejorar los resultados maternos y fetales.	-Varios factores aumentan el riesgo de una mujer de desarrollar diabetes gestacional, incluida la obesidad, el aumento de la edad materna, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes familiares de diabetes y la pertenencia a un grupo étnico que tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (ascendencia hispana, indígena, del sur o del este de Asia o de las islas del Pacífico). -Los factores asociados con un menor riesgo de desarrollar diabetes gestacional incluyen la edad menor de 25 a 30 años, la etnia caucásica, un índice de masa corporal (IMC) de 25 o menos, la ausencia de antecedentes familiares (en un pariente de primer grado) de diabetes y de intolerancia a la glucosa o resultados adversos del embarazo relacionados con la diabetes gestacional. -El riesgo en diferentes grupos raciales / étnicos puede deberse en parte a factores de riesgo social como el bajo nivel socioeconómico o el racismo estructural, aunque estas asociaciones no se examinan en la evidencia actual.
15-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.
16-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
17-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
18-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
19- Depresión Perinatal: Proporcionar o remitir a las embarazadas y/o puérperas que tengan un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcanzan un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional y complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.
20-. Preeclampsia: Despistaje con medida de presión arterial, proteinuria y marcadores totémicos.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si una paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, ésta debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Toda mujer embarazada está en riesgo de preeclampsia y debe ser examinada. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, la nuliparidad, la obesidad, la raza afrodescendiente, el bajo nivel socioeconómico y la edad materna avanzada.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
21-. Incompatibilidad Rh: Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
22-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos. -La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
23-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
24-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	

7.10- Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
4-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Incompatibilidad Rh: Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
- Sifilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sifilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sifilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Prevención de Preeclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	-Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal., la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.
8-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia)
10-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
11-.Diabetes gestacional: Despistaje de diabetes.	A las 24 semanas de gestación o después para mejorar los resultados maternos y fetales.	-Varios factores aumentan el riesgo de una mujer de desarrollar diabetes gestacional, incluida la obesidad, el aumento de la edad materna, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes familiares de diabetes y la pertenencia a un grupo étnico que tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (ascendencia hispana, indígena, del sur o del este de Asia o de las islas del Pacífico). -Los factores asociados con un menor riesgo de desarrollar diabetes gestacional incluyen la edad menor de 25 a 30 años, la etnia caucásica, un índice de masa corporal (IMC) de 25 o menos, la ausencia de antecedentes familiares (en un pariente de primer grado) de diabetes y de intolerancia a la glucosa o resultados adversos del embarazo relacionados con la diabetes gestacional. -El riesgo en diferentes grupos raciales / étnicos puede deberse en parte a factores de riesgo social como el bajo nivel socioeconómico o el racismo estructural, aunque estas asociaciones no se examinan en la evidencia actual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.
13-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
14-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
16- Depresión Perinatal: Proporcionar o remitir a las embarazadas y/o puérperas que tengan un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcanzan un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional y complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.
17-. Preeclampsia: Despiñaje con medida de presión arterial, proteinuria y marcadores toxémicos.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si una paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, ésta debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Toda mujer embarazada está en riesgo de preeclampsia y debe ser examinada. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, la nuliparidad, la obesidad, la raza afrodescendiente, el bajo nivel socioeconómico y la edad materna avanzada.
18-. Incompatibilidad Rh: Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
20-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco, a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

7.11 -. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diaria- mente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
4-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Incompatibilidad Rh: Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
6-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Prevención de Preeclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal., la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.
8-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
10-.esorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
11-.Diabetes gestacional: Despistaje de diabetes.	A las 24 semanas de gestación o después para mejorar los resultados maternos y fetales.	-Varios factores aumentan el riesgo de una mujer de desarrollar diabetes gestacional, incluida la obesidad, el aumento de la edad materna, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes familiares de diabetes y la pertenencia a un grupo étnico que tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (ascendencia hispana, indígena, del sur o del este de Asia o de las islas del Pacífico). -Los factores asociados con un menor riesgo de desarrollar diabetes gestacional incluyen la edad menor de 25 a 30 años, la etnia caucásica, un índice de masa corporal (IMC) de 25 o menos, la ausencia de antecedentes familiares (en un pariente de primer grado) de diabetes y de intolerancia a la glucosa o resultados adversos del embarazo relacionados con la diabetes gestacional. -El riesgo en diferentes grupos raciales / étnicos puede deberse en parte a factores de riesgo social como el bajo nivel socioeconómico o el racismo estructural, aunque estas asociaciones no se examinan en la evidencia actual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo	Embarazo.
13-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
14-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hayvidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
16- Depresión Perinatal: Proporcionar o remitir a las embarazadas y/o puérperas que tengan un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcanzan un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional y complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.
17-. Preeclampsia: Despiñaje con medida de presión arterial, proteinuria y marcadores toxémicos.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si una paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, ésta debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Toda mujer embarazada está en riesgo de preeclampsia y debe ser examinada. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, la nuliparidad, la obesidad, la raza afrodescendiente, el bajo nivel socioeconómico y la edad materna avanzada.
18-. Incompatibilidad Rh: Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
20-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco, a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

7.12-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-.HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales andes sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
4-Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
6-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Cáncer de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
9-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
11-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
12-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
14-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. -Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	-Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
15-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
17-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
18-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
20-Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
21-. Morbilidad y mortalidad por obesidad: Remitir a las mujeres con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	IMC ≥ 30
22-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Ver Consideraciones clínicas	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

7.13-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
4-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
6-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presentan por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
8-. Cáncer de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPro. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
9-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
11-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
12-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodilisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
14-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. -Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
15-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre para ECV de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
17-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
18-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	-No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
20-Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
21-. Morbilidad y mortalidad por obesidad: Remitir a las mujeres con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	IMC ≥ 30.
22-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Ver Consideraciones clínicas	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

7.14-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
4-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
5-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Cáncer de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
9-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
10-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. -Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	- Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. - La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. - Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
12-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	- No se encontró evidencia sobre para ECV de detección de LTBI. - Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	- El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). - Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
13-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	- La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. - Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. - Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
14-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	- Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. - Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. - Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. - No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
16-. Morbilidad y mortalidad por obesidad: Remitir a las mujeres con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	IMC ≥30.
17-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Ver Consideraciones clínicas.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

7.15-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
4-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
5-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Cáncer de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyler-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
9-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodíalisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
10-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. -Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	-Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	- Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. - La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. - Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
12-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	- No se encontró evidencia sobre para ECV de detección de LTBI. - Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	- El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). - Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
13-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	- La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. - Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. - Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
14-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	- Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. - Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. - Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. - No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
16-. Morbilidad y mortalidad por obesidad: Remitir a las mujeres con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	IMC ≥ 30 .
17-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Ver Consideraciones clínicas.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

7.16--. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. HIV: Despidtaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales andes sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
5-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
6-. Incompatibilidad Rh: Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco, a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
9-. Prevención de Preclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	Mujeres con antecedentes de preclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal., la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preclampsia y la etnia afrodescendiente.
10-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Cáncer de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyler-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
12-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
14-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.
15-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen únicos. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. -Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
16-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
17-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre para ECV de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
18-. Depresión Perinatal: Proporcionar atención o remitir a las embarazadas o puérperas que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcancen un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional, complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.
19-. Preeclampsia: Detectar preeclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de la presión arterial durante todo el embarazo, además de proteinuria y marcadores de toxemia para el último trimestre.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si un paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, la lectura debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Todas las mujeres embarazadas están en riesgo de preeclampsia y deben ser examinadas. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, nuliparidad, obesidad, etnia afrodescendiente, bajo nivel socioeconómico y edad materna avanzada. -La preeclampsia es más frecuente entre las mujeres afrodescendientes.
20-. Incompatibilidad Rh: Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
21-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
22-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
23-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
24-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
25-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	-Ver Consideraciones clínicas	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

7.17-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. HIV: Despiñaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales andales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
5-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
6-. Incompatibilidad Rh: Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco, a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
9-. Prevención de Preclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	Mujeres con antecedentes de preclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal., la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preclampsia y la etnia afrodescendiente.
10-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Cáncer de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
12-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
14-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.
15-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
16-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	-No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
17-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
18-. Depresión Perinatal: Proporcionar atención o remitir a las embarazadas o puérperas que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcanzan un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional, complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.
19-. Preeclampsia: Detectar preeclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de la presión arterial durante todo el embarazo, además de proteinuria y marcadores de toxemia para el último trimestre.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si un paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, la lectura debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Todas las mujeres embarazadas están en riesgo de preeclampsia y deben ser examinadas. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, nuliparidad, obesidad, etnia afrodescendiente, bajo nivel socioeconómico y edad materna avanzada. -La preeclampsia es más frecuente entre las mujeres afrodescendientes.
20-. Incompatibilidad Rh: Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
21-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
22-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
23-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
24-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
25-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Ver Consideraciones clínicas	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

7.18-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. HIV: Despiñaje con ELISA de IV generación	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
5-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
6-. Incompatibilidad Rh: Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco, a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar. -Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal, la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.
9-. Prevención de Preclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.
10-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Cáncer de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
12-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
14-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
15-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.
17-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
18-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
19-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Depresión Perinatal: Proporcionar atención o remitir a las embarazadas o puérperas que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcancen un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional, complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos. -Todas las mujeres embarazadas están en riesgo de preeclampsia y deben ser examinadas. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, nuliparidad, obesidad, etnia afrodescendiente, bajo nivel socioeconómico y edad materna avanzada. -La preeclampsia es más frecuente entre las mujeres afrodescendientes.
21-. Preeclampsia: Detectar preeclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de la presión arterial durante todo el embarazo, además de proteinuria y marcadores de toxemia para el último trimestre.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si un paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, la lectura debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
22-. Incompatibilidad Rh: Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
23-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
24-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
25-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
26-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
27-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
28-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Ver Consideraciones clínicas	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

7.19-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. HIV: Despiñaje con ELISA de IV generación	-Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
5-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
6-. Incompatibilidad Rh: Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
9-. Prevención de Preclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	-Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal, la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.
10-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Cáncer de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyler-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
12-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
14-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
15-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.
17-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
18-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
19-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Depresión Perinatal: Proporcionar atención o remitir a las embarazadas o puérperas que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcancen un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional, complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos. -Todas las mujeres embarazadas están en riesgo de preeclampsia y deben ser examinadas. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, nuliparidad, obesidad, etnia afrodescendiente, bajo nivel socioeconómico y edad materna avanzada. -La preeclampsia es más frecuente entre las mujeres afrodescendientes.
21-. Preeclampsia: Detectar preeclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de la presión arterial durante todo el embarazo, además de proteinuria y marcadores de toxemia para el último trimestre.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si un paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, la lectura debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
22-. Incompatibilidad Rh: Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
23-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
24-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
25-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
26-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
27-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
28-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Ver Consideraciones clínicas.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

7.20--. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
2-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
3-.HIV: Despistaje con ELISA de IV generación	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales andales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
4-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses) *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
6-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presentan por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco, a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
8-. Cáncer de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
9-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
11-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
12-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
14-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
15-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
17-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
18-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
20-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
21-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

7.21-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, no embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (HRHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilestilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
3-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
4-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
6-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses) *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
8-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
9-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Cáncer de mama en mujeres entre 40-49 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con riesgo alto, pueden comenzar la detección bienal entre los 40 y 49 años. El número de muertes evitadas es menor que el de las mujeres mayores y el número de resultados falsos positivos y biopsias innecesarias es mayor. Es probable que el equilibrio entre los beneficios y los daños mejore a medida que las mujeres pasen de los 40 a los 50 años. -Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como "sobrediagnóstico"). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretatamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Cáncer de mama (Continuación).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
12-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
13-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Cáncer de Colon: Despiñaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba in inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
15-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despiñaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
16-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
17-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
18-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
19-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
21-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
22-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. -Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiático.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
23-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
24-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
25-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
26--. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
27-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
28--. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el bronceado (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.22-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (HRHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilestilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
3-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
4-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
6-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
7-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Cáncer de mama en mujeres entre 40-49 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con riesgo alto, pueden comenzar la detección bienal entre los 40 y 49 años. El número de muertes evitadas es menor que el de las mujeres mayores y el número de resultados falsos positivos y biopsias innecesarias es mayor. Es probable que el equilibrio entre los beneficios y los daños mejore a medida que las mujeres pasen de los 40 a los 50 años. -Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como “sobrediagnóstico”). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretatamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (<i>Continúa</i>).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Cáncer de mama (Continuación).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
10-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
11-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
13-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
14-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	- Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. - La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. - Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
16-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	- No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. - Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	- El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). - Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
17-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	- Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. - Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. - Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. - Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.
19-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
21-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
22-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
23-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el bronceado (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.23-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, no embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (HRHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilestilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
3-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
4-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
6-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
7-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Cáncer de mama en mujeres entre 40-49 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con riesgo alto, pueden comenzar la detección bienal entre los 40 y 49 años. El número de muertes evitadas es menor que el de las mujeres mayores y el número de resultados falsos positivos y biopsias innecesarias es mayor. Es probable que el equilibrio entre los beneficios y los daños mejore a medida que las mujeres pasen de los 40 a los 50 años. -Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como "sobrediagnóstico"). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretatamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Cáncer de mama (Continuación).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
10-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
11-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
13-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
14-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
16-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
17-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiático.
19-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
21-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
22-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
23-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.24--. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femininas, embarazadas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (HRHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilestilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia materna, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
3-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
4-. Hepatitis B en embarazadas: Detección de la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) en mujeres embarazadas.	-Solicitar una prueba para HBsAg en la primera visita prenatal. -Las mujeres con un estado de HBsAg desconocido o con factores de riesgo nuevos o continuos para la infección por VHB, deben ser examinadas en el momento de la admisión a un hospital u otro entorno de parto.	-Los factores de riesgo para VHB incluyen el uso de drogas inyectables, una infección de transmisión sexual o la procedencia de países con alta prevalencia de VHB. -En los niños, la principal fuente de infección es la transmisión perinatal al nacer. -Los nuevos casos de VHB entre los adultos se transmiten en gran medida a través del uso de drogas inyectables o las relaciones sexuales, pero los casos más frecuentes de infección son infecciones crónicas por exposición que ocurren en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. HIV: Despiñaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
6-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
7-. Incompatibilidad Rh(D): Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
8-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
10-. Prevención de Preclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal., la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.
11-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
13-. Cáncer de mama en mujeres entre 40-49 años: Mamografía de detección (Continúa).	Cada 2 años.	-Las mujeres con riesgo alto, pueden comenzar la detección bienal entre los 40 y 49 años. El número de muertes evitadas es menor que el de las mujeres mayores y el número de resultados falsos positivos y biopsias innecesarias es mayor. Es probable que el equilibrio entre los beneficios y los daños mejore a medida que las mujeres pasen de los 40 a los 50 años. -Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como “sobrediagnóstico”). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretratamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Cáncer de mama en mujeres entre 40-49 años: Mamografía de detección (Continuación).	Cada 2 años.	-La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.
14-. Cáncer de Colon: Despiñaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba in inmunológica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba in inmunológica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
15-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despiñaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
17-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.
18-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
20-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
21-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
22-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
23-. Depresión Perinatal: Proporcionar atención o remitir a las embarazadas o puérperas que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcanzan un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional, complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.
24-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.
25-. Preeclampsia: Detectar preeclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de la presión arterial durante todo el embarazo, además de proteinuria y marcadores de toxemia para el último trimestre.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si un paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, la lectura debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Todas las mujeres embarazadas están en riesgo de preeclampsia y deben ser examinadas. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, nuliparidad, obesidad, etnia afrodescendiente, bajo nivel socioeconómico y edad materna avanzada. -La preeclampsia es más frecuente entre las mujeres afrodescendientes.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
26-. Incompatibilidad Rh(D): Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
27-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
28-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
29-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
30-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
31-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.25-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, embarazadas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (HRHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilestilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
3-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
4-. Hepatitis B en embarazadas: Detección de la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) en mujeres embarazadas.	-Solicitar una prueba para HBsAg en la primera visita prenatal. -Las mujeres con un estado de HBsAg desconocido o con factores de riesgo nuevos o continuos para la infección por VHB, deben ser examinadas en el momento de la admisión a un hospital u otro entorno de parto.	-Los factores de riesgo para VHB incluyen el uso de drogas inyectables, una infección de transmisión sexual o la procedencia de países con alta prevalencia de VHB. -En los niños, la principal fuente de infección es la transmisión perinatal al nacer. -Los nuevos casos de VHB entre los adultos se transmiten en gran medida a través del uso de drogas inyectables o las relaciones sexuales, pero los casos más frecuentes de infección son infecciones crónicas por exposición que ocurren en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. HIV: Despiñaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
6-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
7-. Incompatibilidad Rh(D): Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
8-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
10-. Prevención de Preeclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal., la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.
11-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
13-. Cáncer de mama en mujeres entre 40-49 años: Mamografía de detección (Continúa).	Cada 2 años.	-Las mujeres con riesgo alto, pueden comenzar la detección bienal entre los 40 y 49 años. El número de muertes evitadas es menor que el de las mujeres mayores y el número de resultados falsos positivos y biopsias innecesarias es mayor. Es probable que el equilibrio entre los beneficios y los daños mejore a medida que las mujeres pasen de los 40 a los 50 años. -Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como “sobrediagnóstico”). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretratamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Cáncer de mama en mujeres entre 40-49 años: Mamografía de detección (Continuación).	Cada 2 años.	La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.
14-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
15-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
17-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.
18-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
20-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.
21-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
22-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
23-. Depresión Perinatal: Proporcionar atención o remitir a las embarazadas o puérperas que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcancen un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional, complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.
24-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.
25-. Preclampsia: Detectar preclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de la presión arterial durante todo el embarazo, además de proteinuria y marcadores de toxemia para el último trimestre.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si un paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, la lectura debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Todas las mujeres embarazadas están en riesgo de preclampsia y deben ser examinadas. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preclampsia (particularmente preclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, nuliparidad, obesidad, etnia afrodescendiente, bajo nivel socioeconómico y edad materna avanzada. -La preclampsia es más frecuente entre las mujeres afrodescendientes.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
26-. Incompatibilidad Rh(D): Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
27-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
28-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
29-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
30-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
31-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.26-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (HRHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilestilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
3-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
4-. Hepatitis B en embarazadas: Detección de la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) en mujeres embarazadas.	-Solicitar una prueba para HBsAg en la primera visita prenatal. -Las mujeres con un estado de HBsAg desconocido o con factores de riesgo nuevos o continuos para la infección por VHB, deben ser examinadas en el momento de la admisión a un hospital u otro entorno de parto.	-Los factores de riesgo para VHB incluyen el uso de drogas inyectables, una infección de transmisión sexual o la procedencia de países con alta prevalencia de VHB. -En los niños, la principal fuente de infección es la transmisión perinatal al nacer. -Los nuevos casos de VHB entre los adultos se transmiten en gran medida a través del uso de drogas inyectables o las relaciones sexuales, pero los casos más frecuentes de infección son infecciones crónicas por exposición que ocurren en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
6-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
7-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Incompatibilidad Rh(D): Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
9-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
10-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
11-. Prevención de Preeclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal., la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre >100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o >10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.
13-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
		-Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Cáncer de mama en mujeres entre 40-49 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con riesgo alto, pueden comenzar la detección bienal entre los 40 y 49 años. El número de muertes evitadas es menor que el de las mujeres mayores y el número de resultados falsos positivos y biopsias innecesarias es mayor. Es probable que el equilibrio entre los beneficios y los daños mejore a medida que las mujeres pasen de los 40 a los 50 años. -Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como “sobrediagnóstico”). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretatamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
16-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
17-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. oclulta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
19-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
20-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
21-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
22-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	-Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
23-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
24-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
25-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
26-. Depresión Perinatal: Proporcionar atención o remitir a las embarazadas o puérperas que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcanzan un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional, complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
27-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.
28-. Preeclampsia: Detectar preeclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de la presión arterial durante todo el embarazo, además de proteinuria y marcadores de toxemia para el último trimestre.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si un paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, la lectura debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Todas las mujeres embarazadas están en riesgo de preeclampsia y deben ser examinadas. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preeclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preeclampsia (particularmente preeclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, nuliparidad, obesidad, etnia afrodescendiente, bajo nivel socioeconómico y edad materna avanzada. -La preeclampsia es más frecuente entre las mujeres afrodescendientes.
29-. Incompatibilidad Rh(D): Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
30-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
31-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
32-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
33-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
34-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
35-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.27-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años femeninas, embarazadas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (HRHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilestilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Lactancia: Proporcionar intervenciones para promover la lactancia maternal, incluyendo a la pareja de la mujer, otros miembros de la familia y amigos.	-Durante el embarazo y después del parto (¿?). -No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Esta recomendación no se aplica en circunstancias en las que existen contraindicaciones para la lactancia (por ejemplo, ciertas condiciones médicas maternas o trastornos metabólicos infantiles, como la galactosemia).
3-. Defectos del tubo neural: Suministrar diariamente 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 µg) de ácido fólico.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Las mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural tienen un mayor riesgo de tener un embarazo afectado; sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en ausencia de antecedentes personales o familiares.
4-. Hepatitis B en embarazadas: Detección de la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) en mujeres embarazadas.	-Solicitar una prueba para HBsAg en la primera visita prenatal. -Las mujeres con un estado de HBsAg desconocido o con factores de riesgo nuevos o continuos para la infección por VHB, deben ser examinadas en el momento de la admisión a un hospital u otro entorno de parto.	-Los factores de riesgo para VHB incluyen el uso de drogas inyectables, una infección de transmisión sexual o la procedencia de países con alta prevalencia de VHB. -En los niños, la principal fuente de infección es la transmisión perinatal al nacer. -Los nuevos casos de VHB entre los adultos se transmiten en gran medida a través del uso de drogas inyectables o las relaciones sexuales, pero los casos más frecuentes de infección son infecciones crónicas por exposición que ocurren en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
6-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
7-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Incompatibilidad Rh(D): Repetir las pruebas de anticuerpos Rh(D) a todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas a las 24 a 28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo.	Repetir las pruebas a las 24-28 semanas de gestación.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
9-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
10-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
11-. Prevención de Preeclampsia: Usar 81 mg/día de Aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Una vez al día, después de las 12 semanas de gestación.	-Mujeres con antecedentes de preeclampsia previa, diabetes e hipertensión crónica tienen el mayor riesgo de preeclampsia. Otros factores de riesgo incluyen la gestación multifetal, la concepción utilizando tecnología de reproducción asistida, la enfermedad autoinmune, la enfermedad renal., la nuliparidad, el alto índice de masa corporal antes del embarazo, los antecedentes familiares de preeclampsia y la etnia afrodescendiente.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Bacteriuria asintomática: Urocultivo.	Una vez, en la primera visita prenatal o a las 12 a 16 semanas de gestación, lo que ocurra primero.	-Un urocultivo que muestre > 100,000 UFC/ml de un solo uro patógeno o > 10,000 UFC/ml si el patógeno es estreptococo del grupo B indica tratamiento. -Esta recomendación no se aplica a las mujeres que tienen afecciones médicas o del tracto urinario crónicas, como la enfermedad renal en etapa terminal; tienen catéteres urinarios permanentes, stunts urinarios o lesiones de la médula espinal, están hospitalizadas; residen en una institución o que son receptores de trasplantes. -El riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática varía según la edad, el sexo y el estado del embarazo. Los cambios fisiológicos tanto en mujeres embarazadas como en mujeres mayores aumentan el riesgo de bacteriuria asintomática y una infección del tracto urinario. -En general, los hombres tienen un bajo riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática, aunque las tasas aumentan con la edad avanzada. -Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar bacteriuria asintomática.
13-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Cáncer de mama en mujeres entre 40-49 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con riesgo alto, pueden comenzar la detección bienal entre los 40 y 49 años. El número de muertes evitadas es menor que el de las mujeres mayores y el número de resultados falsos positivos y biopsias innecesarias es mayor. Es probable que el equilibrio entre los beneficios y los daños mejore a medida que las mujeres pasen de los 40 a los 50 años. -Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como “sobrediagnóstico”). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretratamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
16-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
17-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunológica para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunológica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunológica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
19-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
20-. Peso inadecuado: Intervenciones efectivas de asesoramiento conductual destinadas a promover el aumento de peso saludable y prevenir el aumento excesivo de peso gestacional en el embarazo.	Durante todo el embarazo.	Embarazo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
21-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
22-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
23-. Violencia de Género: Evaluar la violencia de pareja íntima (IPV), remitiendo a las mujeres que dan positivo a servicios de apoyo continuo.	No hay evidencias sobre los intervalos apropiados para la detección.	-Toda mujer en edad reproductiva corre un riesgo potencial de IPV y debe someterse a pruebas de detección. -La exposición a la violencia en la niñez, la edad temprana, el desempleo, el abuso de sustancias, las dificultades maritales y las dificultades económicas, aumentan el riesgo de IPV. -Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) de detección e intervenciones para IPV a menudo detectan IPV actual o IPV en el último año.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
24-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
25-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
26-. Depresión Perinatal: Proporcionar atención o remitir a las embarazadas o puerperas que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a intervenciones de asesoramiento.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes de depresión, síntomas depresivos actuales (que no alcanzan un umbral de diagnóstico), antecedentes de abuso físico o sexual, embarazo no planificado o no deseado, eventos estresantes de la vida, falta de apoyo social y financiero, violencia de pareja, diabetes pregestacional o gestacional, complicaciones durante el embarazo, la paternidad adolescente, el bajo nivel socioeconómico, la falta de apoyo social y factores genéticos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
27-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.
28-. Preclampsia: Detectar preclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de la presión arterial durante todo el embarazo, además de proteinuria y marcadores de toxemia para el último trimestre.	-Las mediciones de la presión arterial deben obtenerse durante cada visita de atención prenatal durante todo el embarazo. -Si un paciente tiene una lectura de presión arterial elevada, la lectura debe confirmarse con mediciones repetidas. -La evaluación diagnóstica adicional y el monitoreo clínico están indicados para pacientes con presión arterial elevada en múltiples mediciones.	-Todas las mujeres embarazadas están en riesgo de preclampsia y deben ser examinadas. -Las condiciones clínicas importantes asociadas con un mayor riesgo de preclampsia incluyen antecedentes de eclampsia o preclampsia (particularmente preclampsia de inicio temprano), un resultado adverso previo del embarazo, afecciones comórbidas maternas (incluida la diabetes tipo 1 o 2 antes del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes), gestación multifetal, nuliparidad, obesidad, etnia afrodescendiente, bajo nivel socioeconómico y edad materna avanzada. -La preclampsia es más frecuente entre las mujeres afrodescendientes.
29-. Incompatibilidad Rh(D): Tipificación de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos.	Primera visita prenatal.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
30-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
31-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
32-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas ricas en azúcares o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
33-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
34-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
35-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.28-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años femeninas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (HRHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilestilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
3-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
5-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
6-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPro. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como “sobrediagnóstico”). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretratamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/bcrisktool), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Cáncer de mama (Continuación).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
9-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
10-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
12-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
13-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
15-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. - Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
17-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias. -En adultos de 60 a 69 años que tienen un riesgo de ECV a 10% o más a 10 años la decisión debe ser individual. -Las personas que no tienen un mayor riesgo de sangrado, tienen una esperanza de vida de al menos 10 años y están dispuestas a tomar aspirina en dosis bajas diariamente durante al menos 10 años tienen más probabilidades de beneficiarse. Las personas que dan un valor más alto a los beneficios potenciales que a los daños potenciales pueden optar por iniciar una dosis baja de aspirina. -La evaluación del riesgo de ECV debe incluir la determinación de la edad, sexo, etnia, nivel de colesterol total, nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, presión arterial sistólica, tratamiento de la hipertensión, diabetes y tabaquismo. -Se puede encontrar una versión en línea de la calculadora de riesgos ACC/AHA athttp://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/. -Los factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal (GI) con el uso de aspirina incluyen dosis más altas y mayor duración de uso, antecedentes de úlceras gastrointestinales o dolor gastrointestinal superior, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal, enfermedad hepática grave y trombocitopenia. Otros factores que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal o intracraneal con el uso de aspirina en dosis bajas incluyen la anticoagulación concurrente o el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), la hipertensión no controlada, el sexo masculino y la edad avanzada. -Esta recomendación se aplica a los adultos que tienen un mayor riesgo de ECV y un riesgo promedio de CCR. Las personas que tienen un mayor riesgo de ECV y se sabe que tienen un mayor riesgo de CCR (por ejemplo, las personas con antecedentes familiares o personales de CCR o poliposis adenomatosa familiar) deben consultar a su proveedor de atención médica.
19-. Enfermedad cardiovascular y cáncer colo-rectal: Iniciar aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de ECV y CCR.	-Se desconoce la dosis óptima para prevenir los eventos de ECV. 81 mgrs por día es la más comúnmente prescrita. -Evaluar los factores de riesgo de ECV y sangrado a partir de los 50 años y periódicamente a partir de entonces, así como cuándo se detectan o cambian por primera vez las ECV y los factores de riesgo de sangrado.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
21-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.29-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años femeninas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (hrHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilstilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
3-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
5-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
6-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPro. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como "sobrediagnóstico"). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretratamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/bcrisktool), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Cáncer de mama (Continuación).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
9-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
10-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
12-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
13-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
15-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. - Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
17-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias. -En adultos de 60 a 69 años que tienen un riesgo de ECV a 10% o más a 10 años la decisión debe ser individual. -Las personas que no tienen un mayor riesgo de sangrado, tienen una esperanza de vida de al menos 10 años y están dispuestas a tomar aspirina en dosis bajas diariamente durante al menos 10 años tienen más probabilidades de beneficiarse. Las personas que dan un valor más alto a los beneficios potenciales que a los daños potenciales pueden optar por iniciar una dosis baja de aspirina. -La evaluación del riesgo de ECV debe incluir la determinación de la edad, sexo, etnia, nivel de colesterol total, nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, presión arterial sistólica, tratamiento de la hipertensión, diabetes y tabaquismo. -Se puede encontrar una versión en línea de la calculadora de riesgos ACC/AHA athttp://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/. -Los factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal (GI) con el uso de aspirina incluyen dosis más altas y mayor duración de uso, antecedentes de úlceras gastrointestinales o dolor gastrointestinal superior, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal, enfermedad hepática grave y trombocitopenia. Otros factores que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal o intracraneal con el uso de aspirina en dosis bajas incluyen la anticoagulación concurrente o el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), la hipertensión no controlada, el sexo masculino y la edad avanzada. -Esta recomendación se aplica a los adultos que tienen un mayor riesgo de ECV y un riesgo promedio de CCR. Las personas que tienen un mayor riesgo de ECV y se sabe que tienen un mayor riesgo de CCR (por ejemplo, las personas con antecedentes familiares o personales de CCR o poliposis adenomatosa familiar) deben consultar a su proveedor de atención médica.
19-. Enfermedad cardiovascular y cáncer colo-rectal: Iniciar aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de ECV y CCR.	-Se desconoce la dosis óptima para prevenir los eventos de ECV. 81 mgrs por día es la más comúnmente prescrita. -Evaluar los factores de riesgo de ECV y sangrado a partir de los 50 años y periódicamente a partir de entonces, así como cuándo se detectan o cambian por primera vez las ECV y los factores de riesgo de sangrado.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
21-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.30--. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años femeninas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (hrHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilstilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
3-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol). -Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
5-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	
6-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco, a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
8-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como "sobrediagnóstico"). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretratamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Cáncer de mama (Continuación)	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
11-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
12-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
14-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
15-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	-Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
17-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
18-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. - Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.
20-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
21-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
22-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
23-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
24-. Enfermedad cardiovascular y cáncer colo-rectal: Iniciar aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de ECV y CCR.	-Se desconoce la dosis óptima para prevenir los eventos de ECV. 81 mgrs por día es la más comúnmente prescrita. -Evaluar los factores de riesgo de ECV y sangrado a partir de los 50 años y periódicamente a partir de entonces, así como cuándo se detectan o cambian por primera vez las ECV y los factores de riesgo de sangrado.	-En adultos de 60 a 69 años que tienen un riesgo de ECV a 10% o más a 10 años la decisión debe ser individual. -Las personas que no tienen un mayor riesgo de sangrado, tienen una esperanza de vida de al menos 10 años y están dispuestas a tomar aspirina en dosis bajas diariamente durante al menos 10 años tienen más probabilidades de beneficiarse. Las personas que dan un valor más alto a los beneficios potenciales que a los daños potenciales pueden optar por iniciar una dosis baja de aspirina. -La evaluación del riesgo de ECV debe incluir la determinación de la edad, sexo, etnia, nivel de colesterol total, nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, presión arterial sistólica, tratamiento de la hipertensión, diabetes y tabaquismo. -Se puede encontrar una versión en línea de la calculadora de riesgos ACC/AHA athttp://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/. -Los factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal (GI) con el uso de aspirina incluyen dosis más altas y mayor duración de uso, antecedentes de úlceras gastrointestinales o dolor gastrointestinal superior, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal, enfermedad hepática grave y trombocitopenia. Otros factores que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal o intracraneal con el uso de aspirina en dosis bajas incluyen la anticoagulación concurrente o el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), la hipertensión no controlada, el sexo masculino y la edad avanzada. -Esta recomendación se aplica a los adultos que tienen un mayor riesgo de ECV y un riesgo promedio de CCR. Las personas que tienen un mayor riesgo de ECV y se sabe que tienen un mayor riesgo de CCR (por ejemplo, las personas con antecedentes familiares o personales de CCR o poliposis adenomatosa familiar) deben consultar a su proveedor de atención médica.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
25-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
26-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.31 -. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años femininas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de cuello uterino: Detectar cáncer de cuello uterino.	Cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años y cada 3 años para las mujeres de 30 a 65 años con citología cervical sola, cada 5 años con pruebas de alto riesgo del virus del papiloma humano (HRHPV) solas, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (cotesting).	-Todas las mujeres de 21 a 65 años de edad están en riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la posible exposición a tipos de VPH de alto riesgo (HRPV) a través de las relaciones sexuales y deben ser examinadas. -Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cuello uterino, incluida la infección por VIH, un sistema inmunitario comprometido, la exposición en el útero al dietilestilbestrol y el tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer de cuello uterino. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento individualizado.
2-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
3-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.	Al inicio y durante el tercer trimestre del embarazo.	-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
5-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
6-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
8-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como "sobrediagnóstico"). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretratamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa. -Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Cáncer de mama (Continuación).		-Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
11-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
12-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
13-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
15-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
16-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	-Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
17-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar. -Las pruebas de detección deben suspenderse una vez que una persona no ha fumado durante 15 años o desarrolla un problema de salud que limita sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa. -El tabaquismo y la edad avanzada son los 2 factores de riesgo más importantes para el cáncer de pulmón. El riesgo de cáncer de pulmón en las personas que fuman aumenta con la cantidad acumulada y la duración del tabaquismo y con la edad, pero disminuye con el aumento del tiempo desde que dejaron de fumar para las personas que anteriormente fumaban. -Los hombres afrodescendientes tienen una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Las mujeres afrodescendientes tienen una incidencia menor que las mujeres caucásicas. Es probable que estas diferencias estén relacionadas con las diferencias en la exposición al tabaquismo (es decir, la prevalencia del tabaquismo) y la exposición relacionada a carcinógenos en los cigarrillos. Las diferencias también pueden estar relacionadas con otros factores de riesgo social. -Otros factores de riesgo para el cáncer de pulmón incluyen exposiciones ambientales, radioterapia previa, otras enfermedades pulmonares (no cancerosas) y antecedentes familiares. Un menor nivel de educación también se asocia con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Debe usarse la edad y el historial de tabaquismo para determinar la elegibilidad de las pruebas de detección en lugar de modelos de predicción de riesgos más elaborados porque no hay pruebas suficientes para evaluar si la detección basada en modelos de predicción de riesgos mejoraría los resultados en relación con el uso de los factores de riesgo de la edad y los antecedentes de tabaquismo para una implementación amplia en la atención primaria.
18-. Cáncer de pulmón: Realizar despistaje con tomografía computarizada de dosis baja (LDCT) en adultos de 50 a 80 años que tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes-año y actualmente fuman o han dejado de fumar antes de 15 años.	Anual.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
20-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. - Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
21-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
22-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
23-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
24-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
25-. Enfermedad cardiovascular y cáncer colo-rectal: Iniciar aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de ECV y CCR.	-Se desconoce la dosis óptima para prevenir los eventos de ECV. 81 mgrs por día es la más comúnmente prescrita. -Evaluar los factores de riesgo de ECV y sangrado a partir de los 50 años y periódicamente a partir de entonces, así como cuándo se detectan o cambian por primera vez las ECV y los factores de riesgo de sangrado.	-En adultos de 60 a 69 años que tienen un riesgo de ECV a 10% o más a 10 años la decisión debe ser individual. -Las personas que no tienen un mayor riesgo de sangrado, tienen una esperanza de vida de al menos 10 años y están dispuestas a tomar aspirina en dosis bajas diariamente durante al menos 10 años tienen más probabilidades de beneficiarse. Las personas que dan un valor más alto a los beneficios potenciales que a los daños potenciales pueden optar por iniciar una dosis baja de aspirina. -La evaluación del riesgo de ECV debe incluir la determinación de la edad, sexo, etnia, nivel de colesterol total, nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, presión arterial sistólica, tratamiento de la hipertensión, diabetes y tabaquismo. -Se puede encontrar una versión en línea de la calculadora de riesgos ACC/AHA athttp://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/. -Los factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal (GI) con el uso de aspirina incluyen dosis más altas y mayor duración de uso, antecedentes de úlceras gastrointestinales o dolor gastrointestinal superior, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal, enfermedad hepática grave y trombocitopenia. Otros factores que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal o intracraneal con el uso de aspirina en dosis bajas incluyen la anticoagulación concurrente o el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), la hipertensión no controlada, el sexo masculino y la edad avanzada. -Esta recomendación se aplica a los adultos que tienen un mayor riesgo de ECV y un riesgo promedio de CCR. Las personas que tienen un mayor riesgo de ECV y se sabe que tienen un mayor riesgo de CCR (por ejemplo, las personas con antecedentes familiares o personales de CCR o poliposis adenomatosa familiar) deben consultar a su proveedor de atención médica.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
26-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
27-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.32-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años femeninas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres y hombres transgénero sexualmente activos.
4-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
6-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7- Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como "sobrediagnóstico"). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretatamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.
8- Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8- Cáncer de mama (Continuación).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa. -Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
9-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
11-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
12-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.
13-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
15-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	-Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
16-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
17-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
18-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. - Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.
19-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
21-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
22-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
23-. Obesidad: Ofrecer o remitir a adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Adultos con un IMC ≥30.
24-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
25-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.33-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años femeninas, sexualmente activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres y hombres transgénero sexualmente activos.
4-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
6-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años: Mamografía de detección.	Cada 2 años.	-Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como "sobrediagnóstico"). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretatamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual.
8-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Cáncer de mama (Continuación).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa. -Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supere su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
10-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
11-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
12-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
14-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodialisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
15-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
17-. Cáncer de pulmón: Realizar despistaje con tomografía computarizada de dosis baja (LDCT) en adultos de 50 a 80 años que tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes-año y actualmente fuman o han dejado de fumar antes de 15 años.	Anual.	-Las pruebas de detección deben suspenderse una vez que una persona no ha fumado durante 15 años o desarrolla un problema de salud que limita sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa. -El tabaquismo y la edad avanzada son los 2 factores de riesgo más importantes para el cáncer de pulmón. El riesgo de cáncer de pulmón en las personas que fuman aumenta con la cantidad acumulada y la duración del tabaquismo y con la edad, pero disminuye con el aumento del tiempo desde que dejaron de fumar para las personas que anteriormente fumaban. -Los hombres afrodescendientes tienen una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Las mujeres afrodescendientes tienen una incidencia menor que las mujeres caucásicas. Es probable que estas diferencias estén relacionadas con las diferencias en la exposición al tabaquismo (es decir, la prevalencia del tabaquismo) y la exposición relacionada a carcinógenos en los cigarrillos. Las diferencias también pueden estar relacionadas con otros factores de riesgo social. -Otros factores de riesgo para el cáncer de pulmón incluyen exposiciones ambientales, radioterapia previa, otras enfermedades pulmonares (no cancerosas) y antecedentes familiares. Un menor nivel de educación también se asocia con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Debe usarse la edad y el historial de tabaquismo para determinar la elegibilidad de las pruebas de detección en lugar de modelos de predicción de riesgos más elaborados porque no hay pruebas suficientes para evaluar si la detección basada en modelos de predicción de riesgos mejoraría los resultados en relación con el uso de los factores de riesgo de la edad y los antecedentes de tabaquismo para una implementación amplia en la atención primaria.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
19-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. - Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.
20-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
21-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
22-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
23-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
24-. Obesidad: Ofrecer o remitir a adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Adultos con un IMC ≥30.
25-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
26-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.34-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años femeninas, sexualmente no activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HsgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HsgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HsgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
5-. Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años: Mamografía de detección (Continúa).	Cada 2 años.	-Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como “sobrediagnóstico”). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretratamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años (Continuación).	Cada 2 años.	-La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años. -Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual. -Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo.
6-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Cáncer de mama (Continuación).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa. -Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
8-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
10-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
11-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregateados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
13-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
14-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
16-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
17-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Obesidad: Ofrecer o remitir a adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Adultos con un IMC ≥ 30 .
19-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
20-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.35--. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años femeninas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPro. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.
5-. Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años: Mamografía de detección (Continúa).	Cada 2 años.	-Las mujeres con un riesgo promedio pueden iniciar la detección bienal entre los 50 a 74 años. -De todos los grupos de edad, las mujeres de 60 a 69 años tienen más probabilidades de evitar la muerte por cáncer de mama a través de la mamografía. -Además de los resultados falsos positivos y las biopsias innecesarias, todas las mujeres que se someten a mamografías de detección regulares corren el riesgo de diagnosticar y tratar el cáncer de mama no invasivo e invasivo que de otro modo no se habría convertido en una amenaza para su salud, o incluso aparente, durante su vida (conocido como “sobrediagnóstico”). -Comenzar la mamografía a una edad más temprana y la detección con más frecuencia puede aumentar el riesgo de sobrediagnóstico y posterior sobretratamiento. -Las mujeres con un padre, hermano o hijo con cáncer de mama tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y, por lo tanto, pueden beneficiarse más que las mujeres de riesgo promedio al comenzar las pruebas de detección a los 40 años. -La mamografía bienal proporciona el mejor equilibrio general de beneficio y daños. -La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, dada la mayor carga de enfermedad y la probabilidad potencial de beneficio, las mujeres de 40 a 49 años que tienen un pariente de primer grado conocido (padre, hijo o hermano) con cáncer de mama pueden considerar iniciar la detección antes de los 50 años.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Cáncer de mama en mujeres entre 50-74 años (Continuación).	Cada 2 años.	-Las calculadoras de riesgo, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (Disponible en www.cancer.gov/BCRISKTOOL), tienen una buena calibración entre los resultados previstos y reales en grupos de mujeres, pero no son precisos para predecir el riesgo de cáncer de mama de una mujer individual. -Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa.
6-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Cáncer de mama (Continuación).		-Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial. -Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	
8-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.
9-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos. -Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
11-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.		Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
13-. Cáncer de pulmón: Realizar despistaje con tomografía computarizada de dosis baja (LDCT) en adultos de 50 a 80 años que tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes-año y actualmente fuman o han dejado de fumar antes de 15 años.	Anual.	-Las pruebas de detección deben suspenderse una vez que una persona no ha fumado durante 15 años o desarrolla un problema de salud que limita sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa. -El tabaquismo y la edad avanzada son los 2 factores de riesgo más importantes para el cáncer de pulmón. El riesgo de cáncer de pulmón en las personas que fuman aumenta con la cantidad acumulada y la duración del tabaquismo y con la edad, pero disminuye con el aumento del tiempo desde que dejaron de fumar para las personas que anteriormente fumaban. -Los hombres afrodescendientes tienen una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Las mujeres afrodescendientes tienen una incidencia menor que las mujeres caucásicas. Es probable que estas diferencias estén relacionadas con las diferencias en la exposición al tabaquismo (es decir, la prevalencia del tabaquismo) y la exposición relacionada a carcinógenos en los cigarrillos. Las diferencias también pueden estar relacionadas con otros factores de riesgo social. -Otros factores de riesgo para el cáncer de pulmón incluyen exposiciones ambientales, radioterapia previa, otras enfermedades pulmonares (no cancerosas) y antecedentes familiares. Un menor nivel de educación también se asocia con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Debe usarse la edad y el historial de tabaquismo para determinar la elegibilidad de las pruebas de detección en lugar de modelos de predicción de riesgos más elaborados porque no hay pruebas suficientes para evaluar si la detección basada en modelos de predicción de riesgos mejoraría los resultados en relación con el uso de los factores de riesgo de la edad y los antecedentes de tabaquismo para una implementación amplia en la atención primaria.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
15-. Prediabetes y/o diabetes: Detectar pre diabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas.	La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre los indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. en personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. - Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, y con un IMC más bajo en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
17-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
18-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Obesidad: Ofrecer o remitir a adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Adultos con un IMC ≥30.
20-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
21-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.36-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años femeninas, sexualmente activas y no fumadoras del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
2-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
4-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
5-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa. -Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Cáncer de mama (Continuación).		-Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
7-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
8-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
9-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.
11-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
12-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodialis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
14-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
15-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
17-Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
18-. Obesidad: Ofrecer o remitir a adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Adultos con un IMC ≥ 30 .
19-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
21-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.37-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años femeninas, sexualmente activas y fumadoras, del P.A.A.I.S. según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
2-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
4-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
5-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (<i>Continúa</i>).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa. -Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Cáncer de mama (Continuación).		-Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
7-. Gonorrea: Despistaje para gonorrea.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
8-. Clamidia: Realizar despistaje para clamidia en todas las mujeres sexualmente activas con riesgo alto de infección.	No hay estudios sobre los intervalos de detección, por lo que debe evaluarse a los pacientes cuyos antecedentes sexuales revelan factores de riesgo nuevos o persistentes desde el último resultado negativo de la prueba.	-La edad es un fuerte predictor del riesgo de infecciones por clamidia y gonococo y las tasas más altas de infección en mujeres ocurren entre los 15-24 años. Las mujeres de 25 años o más corren un mayor riesgo si tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con parejas concurrentes o una pareja sexual que tiene una ITS, practican el uso inconsistente del condón cuando no están en una relación mutuamente monógama o tienen una ITS anterior o coexistente. El intercambio de sexo por dinero o drogas y el historial de encarcelamiento también se asocian con un mayor riesgo. -Los médicos deben tener en cuenta la epidemiología local y orientación para determinar quién corre un mayor riesgo.
9-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.
11-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
12-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodialis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
14-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
15-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
17-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
18-. Obesidad: Ofrecer o remitir a adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Adultos con un IMC ≥ 30 .
19-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
21-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.38-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años femeninas, sexualmente no activas y no fumadoras, del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
2-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
3-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa. -Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Cáncer de mama (Continuación).		-Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
6-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.
7-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
9-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
11-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
12-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
13-. Obesidad: Ofrecer o remitir a adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Adultos con un IMC ≥ 30 .

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Cáncer de Colon: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
15-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
16-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.39-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años femeninas, sexualmente no activas y fumadoras del P.A.A.I.S., según EL USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
2-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
3-. Cánceres asociados a Ca de mama: Evaluar a las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario, trompas o peritoneal o que tengan una ascendencia asociada con mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2 (BRCA1/2) con una breve herramienta de evaluación del riesgo familiar adecuada. -Las mujeres con un resultado positivo en la herramienta de evaluación de riesgos deben recibir asesoramiento genético y si se indica después del asesoramiento, pruebas genéticas.	-Una vez que las mujeres hayan alcanzado la edad de consentimiento (18 años). -Una revisión exhaustiva al menos cada 5 a 10 años).	-Las herramientas de evaluación del riesgo familiar son precisas para identificar a las mujeres con mayor probabilidad de < las mutaciones BRCA1/2. Estas incluyen la familia Ontario History Assessment Tool, Manchester Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree Assessment Tool, Question Family History Screening Tool, International Breast Cancer Intervention Study instrument (Tyrer-Cuzick) y versiones breves de BRCAPRO. -Estas herramientas deben usarse para guiar las derivaciones a asesoramiento genético. -Las personas deben considerar su sexo al nacer para determinar qué recomendación se aplica mejor a ellas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Cáncer de mama: Indicar medicamentos como Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa para reducir el riesgo, a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama y un bajo riesgo de efectos adversos de los medicamentos (Continúa).	Aunque no se dispone de pruebas sobre el mejor intervalo para reevaluar el riesgo y las indicaciones de los medicamentos para reducir el riesgo, un enfoque pragmático sería repetir la evaluación del riesgo cuando hay un cambio significativo en los factores de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, cuando a un miembro de la familia se le diagnostica cáncer de mama o cuando hay un nuevo diagnóstico de hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ en la biopsia de mama.	-Al considerar la prescripción de medicamentos, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. -Consultar para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo. -Hay varios métodos disponibles para identificar a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, incluidas las herramientas formales de evaluación clínica del riesgo o la evaluación de los factores de riesgo de cáncer de mama sin utilizar una herramienta formal. -Numerosas herramientas de evaluación de riesgos, como la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estiman el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. -No existe un punto de corte único para definir un mayor riesgo para todas las mujeres. -Las mujeres con mayor riesgo, como aquellas con al menos un 3% de riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años, es probable que obtengan más beneficios que daños de medicamentos para reducir el riesgo y se les debe ofrecer estos medicamentos si su riesgo de daños es bajo. -Algunas mujeres con menor riesgo de cáncer de mama también han sido incluidas en ensayos que documentan un menor riesgo de cáncer de mama al tomar Tamoxifeno, Raloxifeno o inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, al equilibrar los daños asociados con estos medicamentos, el beneficio neto será menor entre las mujeres con menor riesgo. -Alternativamente, los médicos pueden usar combinaciones de factores de riesgo (incluidos algunos factores de riesgo no incluidos en las herramientas de evaluación de riesgos, pero que habrían permitido la inscripción en algunos de los ensayos de reducción de riesgos) para identificar a las mujeres con mayor riesgo. -Algunos ejemplos de combinaciones de múltiples factores de riesgo en mujeres con mayor riesgo incluyen (pero no se limitan a) la edad de 65 años o más con 1 primer grado pariente con cáncer de mama; 45 años o más con más de 1 pariente de primer grado con cáncer de mama o 1 pariente de primer grado que desarrolló cáncer de mama antes de los 50 años; 40 años o más con un pariente de primer grado con cáncer de mama bilateral; presencia de hiperplasia ductal o lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ en una biopsia previa. -Las mujeres que no tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, como las mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, o las mujeres con un bajo riesgo de cáncer de mama a 5 años no se les deben ofrecer medicamentos de forma rutinaria para reducir el riesgo de cáncer de mama, ya que el riesgo de daños de estos medicamentos probablemente supera su beneficio potencial.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Cáncer de mama (Continuación).		-Al considerar la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de mama, el beneficio potencial de la reducción del riesgo de cáncer de mama debe equilibrarse con los daños potenciales de los efectos adversos de los medicamentos. Consulte a continuación para obtener más información sobre los daños potenciales de los medicamentos para reducir el riesgo.
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
6-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.
7-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
9-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Osteoporosis: Detección de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los factores de riesgo para las fracturas incluyen la edad, el bajo índice de masa corporal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo actual, el uso prolongado de corticosteroides, las fracturas previas y los antecedentes de caídas en el último año. -Los médicos deben tener en cuenta que la presencia de un factor de riesgo determinado o una cierta edad no representa un umbral de riesgo particular. -Aunque el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas generalmente aumenta con la edad, la presencia de múltiples factores de riesgo a una edad más temprana puede indicar que el perfil de riesgo-beneficio es favorable para la detección con pruebas de medición ósea.
11-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
12-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
13-. Obesidad: Ofrecer o remitir a adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más a intervenciones conductuales intensivas y multicomponentes.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Adultos con un IMC ≥ 30 .

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Cáncer de Colon: Despiñaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
15-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
16-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.40-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
2-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	La frecuencia óptima de detección para las personas que tienen un mayor riesgo de infección por sífilis no está bien establecida. Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-Los estudios iniciales sugieren que la detección de la infección por sífilis en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) o personas que viven con el VIH mejora cuando la detección se realiza cada 3 meses en comparación con una vez al año. -Los HSH y los hombres y mujeres que viven con el VIH, tienen el mayor riesgo de contraer la sífilis. -Al decidir qué personas examinar para la sífilis, los médicos deben tener en cuenta la prevalencia de la infección en las comunidades a las que sirven, así como otros factores sociodemográficos que pueden estar asociados con un mayor riesgo de infección por sífilis, tales como antecedentes de encarcelamiento, antecedentes de trabajo sexual comercial, ciertos grupos raciales/étnicos y ser un hombre menor de 29 años, así como variaciones regionales que están bien descritas

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
4-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
6-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
7-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

7.41 -. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
2-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	La frecuencia óptima de detección para las personas que tienen un mayor riesgo de infección por sífilis no está bien establecida. Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-Los estudios iniciales sugieren que la detección de la infección por sífilis en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) o personas que viven con el VIH mejora cuando la detección se realiza cada 3 meses en comparación con una vez al año. -Los HSH y los hombres y mujeres que viven con el VIH, tienen el mayor riesgo de contraer la sífilis. -Al decidir qué personas examinar para la sífilis, los médicos deben tener en cuenta la prevalencia de la infección en las comunidades a las que sirven, así como otros factores sociodemográficos que pueden estar asociados con un mayor riesgo de infección por sífilis, tales como antecedentes de encarcelamiento, antecedentes de trabajo sexual comercial, ciertos grupos raciales/étnicos y ser un hombre menor de 29 años, así como variaciones regionales que están bien descritas

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
4-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
6-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
7-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

7.42-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
2-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
4-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

7.43-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 10-14 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
2-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
4-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

7.44-- Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
5-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
6-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
8-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
10-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
11-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
13-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
14-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

7.45-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
5-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
6-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
8-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
10-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
11-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
12-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
14-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
15-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

7.46-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
4-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
6-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
8-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
9-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
10-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
12-. Obesidad: Calcular el índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

7.47-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 15-19 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
4-. Trastorno depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
6-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
8-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
9-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
10-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	-No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
12-. Obesidad: Calcular el índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

7.48-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
5-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
6-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
8-. Enfermedad Cardio-vascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
9-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
11-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
12-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
14-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
16-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
17-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

7.49-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
5-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
6-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
8-. Enfermedad Cardio-vascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
9-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
11-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
12-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
14-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
16-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
17-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

7.50-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
6-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
8-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
9-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
11-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas ricas en azúcares o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
12-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
14-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

7.51 -. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 20-49 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
6-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
8-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
9-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
11-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas ricas en azúcares o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
12-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultra- violeta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.
14-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

7.52-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
3-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres y hombres transgénero sexualmente activos.
5-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
8-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodíalisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
10-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
11-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Prediabetes y diabetes tipo 2: Detectar en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes a intervenciones preventivas efectivas.	Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre. -El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes que entre los caucásicos. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. -La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. Una diferencia en la composición de la grasa corporal en las personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. -Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y con un IMC más bajo en personas asiáticas.–Los datos sugieren que un IMC de 23 o más puede ser un punto de corte apropiado en personas asiáticas.
13-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
15-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riosasas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
16-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
17-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad. -En adultos de 60 a 69 años que tienen un riesgo de ECV a 10% o más a 10 años la decisión debe ser individual. -Las personas que no tienen un mayor riesgo de sangrado, tienen una esperanza de vida de al menos 10 años y están dispuestas a tomar aspirina en dosis bajas diariamente durante al menos 10 años tienen más probabilidades de beneficiarse. Las personas que dan un valor más alto a los beneficios potenciales que a los daños potenciales pueden optar por iniciar una dosis baja de aspirina. -La evaluación del riesgo de ECV debe incluir la determinación de la edad, sexo, etnia, nivel de colesterol total, nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, presión arterial sistólica, tratamiento de la hipertensión, diabetes y tabaquismo. -Se puede encontrar una versión en línea de la calculadora de riesgos ACC/AHA athttp://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/. -Los factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal (GI) con el uso de aspirina incluyen dosis más altas y mayor duración de uso, antecedentes de úlceras gastrointestinales o dolor gastrointestinal superior, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal, enfermedad hepática grave y trombocitopenia. Otros factores que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal o intracraneal con el uso de aspirina en dosis bajas incluyen la anticoagulación concurrente o el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), la hipertensión no controlada, el sexo masculino y la edad avanzada. -Esta recomendación se aplica a los adultos que tienen un mayor riesgo de ECV y un riesgo promedio de CCR. Las personas que tienen un mayor riesgo de ECV y se sabe que tienen un mayor riesgo de CCR (por ejemplo, las personas con antecedentes familiares o personales de CCR o poliposis adenomatosa familiar) deben consultar a su proveedor de atención médica.
18-. Enfermedad cardiovascular y cáncer colo-rectal: Iniciar aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de ECV y CCR.	-Se desconoce la dosis óptima para prevenir los eventos de ECV. 81 mgrs por día es la más comúnmente prescrita. -Evaluar los factores de riesgo de ECV y sangrado a partir de los 50 años y periódicamente a partir de entonces, así como cuándo se detectan o cambian por primera vez las ECV y los factores de riesgo de sangrado.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
19-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
20-. Cáncer de próstata: Someter a los hombres de 55 a 69 años a exámenes periódicos de detección de antígeno prostático específico (PSA) para el cáncer de próstata, discutiendo con ellos sobre los posibles beneficios y daños de la detección e incorporar sus valores y preferencias en la decisión.	No hay información de frecuencia de servicio actualmente disponible.	-Las pruebas de detección ofrecen un pequeño beneficio potencial de reducir la probabilidad de muerte por cáncer de próstata en algunos hombres. Sin embargo, muchos hombres experimentarán daños potenciales de la detección, incluidos los resultados falsos positivos que requieren pruebas adicionales y una posible biopsia de próstata; sobre diagnóstico y sobre tratamiento; así como complicaciones del tratamiento, como incontinencia y disfunción eréctil. - Al determinar si este servicio es apropiado en casos individuales, los pacientes y los médicos deben considerar el equilibrio de beneficios y daños sobre la base de los antecedentes familiares, etnia, las afecciones médicas comórbidas, los valores del paciente sobre los beneficios y daños de las pruebas de detección y los resultados específicos del tratamiento y otras necesidades de salud. Los médicos no deben evaluar a los hombres que no expresan una preferencia por la detección.
21-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.53-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
3-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
5-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
6-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
8-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
10-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
12-. Cáncer de pulmón: Realizar despistaje con tomografía computarizada de dosis baja (LDCT) en adultos de 50 a 80 años que tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes-año y actualmente fuman o han dejado de fumar antes de 15 años.	Anual.	-Las pruebas de detección deben suspenderse una vez que una persona no ha fumado durante 15 años o desarrolla un problema de salud que limita sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa. -El tabaquismo y la edad avanzada son los 2 factores de riesgo más importantes para el cáncer de pulmón. El riesgo de cáncer de pulmón en las personas que fuman aumenta con la cantidad acumulada y la duración del tabaquismo y con la edad, pero disminuye con el aumento del tiempo desde que dejaron de fumar para las personas que anteriormente fumaban. -Los hombres afrodescendientes tienen una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Las mujeres afrodescendientes tienen una incidencia menor que las mujeres caucásicas. Es probable que estas diferencias estén relacionadas con las diferencias en la exposición al tabaquismo (es decir, la prevalencia del tabaquismo) y la exposición relacionada a carcinógenos en los cigarrillos. Las diferencias también pueden estar relacionadas con otros factores de riesgo social. -Otros factores de riesgo para el cáncer de pulmón incluyen exposiciones ambientales, radioterapia previa, otras enfermedades pulmonares (no cancerosas) y antecedentes familiares. Un menor nivel de educación también se asocia con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Debe usarse la edad y el historial de tabaquismo para determinar la elegibilidad de las pruebas de detección en lugar de modelos de predicción de riesgos más elaborados porque no hay pruebas suficientes para evaluar si la detección basada en modelos de predicción de riesgos mejoraría los resultados en relación con el uso de los factores de riesgo de la edad y los antecedentes de tabaquismo para una implementación amplia en la atención primaria.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Prediabetes y diabetes tipo 2: Detectar en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes a intervenciones preventivas efectivas.	Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre. -El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes que entre los caucásicos. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. -La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. Una diferencia en la composición de la grasa corporal en las personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. -Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y con un IMC más bajo en personas asiáticas.-Los datos sugieren que un IMC de 23 o más puede ser un punto de corte apropiado en personas asiáticas.
14-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
16-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
17-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
19-. Enfermedad cardiovascular y cáncer colo-rectal: Iniciar aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de ECV y CCR.	-Se desconoce la dosis óptima para prevenir los eventos de ECV. 81 mgrs por día es la más comúnmente prescrita. -Evaluar los factores de riesgo de ECV y sangrado a partir de los 50 años y periódicamente a partir de entonces, así como cuándo se detectan o cambian por primera vez las ECV y los factores de riesgo de sangrado.	-En adultos de 60 a 69 años que tienen un riesgo de ECV a 10% o más a 10 años la decisión debe ser individual. -Las personas que no tienen un mayor riesgo de sangrado, tienen una esperanza de vida de al menos 10 años y están dispuestas a tomar aspirina en dosis bajas diariamente durante al menos 10 años tienen más probabilidades de beneficiarse. Las personas que dan un valor más alto a los beneficios potenciales que a los daños potenciales pueden optar por iniciar una dosis baja de aspirina. -La evaluación del riesgo de ECV debe incluir la determinación de la edad, sexo, etnia, nivel de colesterol total, nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, presión arterial sistólica, tratamiento de la hipertensión, diabetes y tabaquismo. -Se puede encontrar una versión en línea de la calculadora de riesgos ACC/AHA athttp://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/. -Los factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal (GI) con el uso de aspirina incluyen dosis más altas y mayor duración de uso, antecedentes de úlceras gastrointestinales o dolor gastrointestinal superior, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal, enfermedad hepática grave y trombocitopenia. Otros factores que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal o intracraneal con el uso de aspirina en dosis bajas incluyen la anticoagulación concurrente o el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), la hipertensión no controlada, el sexo masculino y la edad avanzada. -Esta recomendación se aplica a los adultos que tienen un mayor riesgo de ECV y un riesgo promedio de CCR. Las personas que tienen un mayor riesgo de ECV y se sabe que tienen un mayor riesgo de CCR (por ejemplo, las personas con antecedentes familiares o personales de CCR o poliposis adenomatosa familiar) deben consultar a su proveedor de atención médica.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
20-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	-Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
21- Cáncer de próstata: Someter a los hombres de 55 a 69 años a exámenes periódicos de detección de antígeno prostático específico (PSA) para el cáncer de próstata, discutiendo con ellos sobre los posibles beneficios y daños de la detección e incorporar sus valores y preferencias en la decisión.	No hay información de frecuencia de servicio actualmente disponible.	-Las pruebas de detección ofrecen un pequeño beneficio potencial de reducir la probabilidad de muerte por cáncer de próstata en algunos hombres. Sin embargo, muchos hombres experimentarán daños potenciales de la detección, incluidos los resultados falsos positivos que requieren pruebas adicionales y una posible biopsia de próstata; sobre diagnóstico y sobre tratamiento; así como complicaciones del tratamiento, como incontinencia y disfunción eréctil. - Al determinar si este servicio es apropiado en casos individuales, los pacientes y los médicos deben considerar el equilibrio de beneficios y daños sobre la base de los antecedentes familiares, etnia, las afecciones médicas comórbidas, los valores del paciente sobre los beneficios y daños de las pruebas de detección y los resultados específicos del tratamiento y otras necesidades de salud. Los médicos no deben evaluar a los hombres que no expresan una preferencia por la detección.
22-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.54-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
3-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar. -Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	
6-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
8-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
10-. Prediabetes y diabetes tipo 2: Detectar en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes a intervenciones preventivas efectivas.	Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre. -El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes que entre los caucásicos. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. -La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. Una diferencia en la composición de la grasa corporal en las personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. -Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y con un IMC más bajo en personas asiáticas. -Los datos sugieren que un IMC de 23 o más puede ser un punto de corte apropiado en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
12-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
13-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad. -En adultos de 60 a 69 años que tienen un riesgo de ECV a 10% o más a 10 años la decisión debe ser individual. -Las personas que no tienen un mayor riesgo de sangrado, tienen una esperanza de vida de al menos 10 años y están dispuestas a tomar aspirina en dosis bajas diariamente durante al menos 10 años tienen más probabilidades de beneficiarse. Las personas que dan un valor más alto a los beneficios potenciales que a los daños potenciales pueden optar por iniciar una dosis baja de aspirina. -La evaluación del riesgo de ECV debe incluir la determinación de la edad, sexo, etnia, nivel de colesterol total, nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, presión arterial sistólica, tratamiento de la hipertensión, diabetes y tabaquismo. -Se puede encontrar una versión en línea de la calculadora de riesgos ACC/AHA athttp://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/. -Los factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal (GI) con el uso de aspirina incluyen dosis más altas y mayor duración de uso, antecedentes de úlceras gastrointestinales o dolor gastrointestinal superior, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal, enfermedad hepática grave y trombocitopenia. Otros factores que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal o intracraneal con el uso de aspirina en dosis bajas incluyen la anticoagulación concurrente o el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), la hipertensión no controlada, el sexo masculino y la edad avanzada. -Esta recomendación se aplica a los adultos que tienen un mayor riesgo de ECV y un riesgo promedio de CCR. Las personas que tienen un mayor riesgo de ECV y se sabe que tienen un mayor riesgo de CCR (por ejemplo, las personas con antecedentes familiares o personales de CCR o poliposis adenomatosa familiar) deben consultar a su proveedor de atención médica.
15-. Enfermedad cardiovascular y cáncer colo-rectal: Iniciar aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de ECV y CCR.	-Se desconoce la dosis óptima para prevenir los eventos de ECV. 81 mgrs por día es la más comúnmente prescrita. -Evaluar los factores de riesgo de ECV y sangrado a partir de los 50 años y periódicamente a partir de entonces, así como cuándo se detectan o cambian por primera vez las ECV y los factores de riesgo de sangrado.	

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	- Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. - La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
17-. Cáncer de próstata: Someter a los hombres de 55 a 69 años a exámenes periódicos de detección de antígeno prostático específico (PSA) para el cáncer de próstata, discutiendo con ellos sobre los posibles beneficios y daños de la detección e incorporar sus valores y preferencias en la decisión.	No hay información de frecuencia de servicio actualmente disponible.	- Las pruebas de detección ofrecen un pequeño beneficio potencial de reducir la probabilidad de muerte por cáncer de próstata en algunos hombres. Sin embargo, muchos hombres experimentarán daños potenciales de la detección, incluidos los resultados falsos positivos que requieren pruebas adicionales y una posible biopsia de próstata; sobre diagnóstico y sobre tratamiento; así como complicaciones del tratamiento, como incontinencia y disfunción eréctil. - Al determinar si este servicio es apropiado en casos individuales, los pacientes y los médicos deben considerar el equilibrio de beneficios y daños sobre la base de los antecedentes familiares, etnia, las afecciones médicas comórbidas, los valores del paciente sobre los beneficios y daños de las pruebas de detección y los resultados específicos del tratamiento y otras necesidades de salud. Los médicos no deben evaluar a los hombres que no expresan una preferencia por la detección.
18-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	- La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. - Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. - Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.55. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 50-60 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. HIV: Despistaje con ELISA de IV generación.		-Todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años deben ser examinados. -Hay una serie de factores que aumentan el riesgo, entre éstos mujeres con parejas que tienen contacto sexual de hombre a hombre, el uso de drogas inyectables, tener relaciones sexuales anales sin condón, tener relaciones sexuales vaginales sin condón y con más de 1 pareja cuyo estado de VIH se desconoce, intercambiar sexo por drogas o dinero (sexo transaccional), tener otras ITS o una pareja sexual con una ITS y tener una pareja sexual que vive con el VIH o está en una categoría de alto riesgo.
3-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
4-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
6-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
8-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
10-. Prediabetes y diabetes tipo 2: Detectar en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes a intervenciones preventivas efectivas.	Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre. -El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes que entre los caucásicos. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. -La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. Una diferencia en la composición de la grasa corporal en las personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. -Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y con un IMC más bajo en personas asiáticas. -Los datos sugieren que un IMC de 23 o más puede ser un punto de corte apropiado en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
12-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
13-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
15-. Enfermedad cardiovascular y cáncer colo-rectal: Iniciar aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de ECV y CCR.	-Se desconoce la dosis óptima para prevenir los eventos de ECV. 81 mgrs por día es la más comúnmente prescrita. -Evaluar los factores de riesgo de ECV y sangrado a partir de los 50 años y periódicamente a partir de entonces, así como cuándo se detectan o cambian por primera vez las ECV y los factores de riesgo de sangrado.	-En adultos de 60 a 69 años que tienen un riesgo de ECV a 10% o más a 10 años la decisión debe ser individual. -Las personas que no tienen un mayor riesgo de sangrado, tienen una esperanza de vida de al menos 10 años y están dispuestas a tomar aspirina en dosis bajas diariamente durante al menos 10 años tienen más probabilidades de beneficiarse. Las personas que dan un valor más alto a los beneficios potenciales que a los daños potenciales pueden optar por iniciar una dosis baja de aspirina. -La evaluación del riesgo de ECV debe incluir la determinación de la edad, sexo, etnia, nivel de colesterol total, nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, presión arterial sistólica, tratamiento de la hipertensión, diabetes y tabaquismo. -Se puede encontrar una versión en línea de la calculadora de riesgos ACC/AHA athttp://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/. -Los factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal (GI) con el uso de aspirina incluyen dosis más altas y mayor duración de uso, antecedentes de úlceras gastrointestinales o dolor gastrointestinal superior, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal, enfermedad hepática grave y trombocitopenia. Otros factores que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal o intracraneal con el uso de aspirina en dosis bajas incluyen la anticoagulación concurrente o el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), la hipertensión no controlada, el sexo masculino y la edad avanzada. -Esta recomendación se aplica a los adultos que tienen un mayor riesgo de ECV y un riesgo promedio de CCR. Las personas que tienen un mayor riesgo de ECV y se sabe que tienen un mayor riesgo de CCR (por ejemplo, las personas con antecedentes familiares o personales de CCR o poliposis adenomatosa familiar) deben consultar a su proveedor de atención médica.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Enfermedad Cardiovascular en personas sin factores de riesgo: Individualizar la decisión de ofrecer o referir a adultos sin obesidad que no tienen hipertensión, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes a asesoramiento conductual para promover una dieta saludable y actividad física.	Al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o una combinación equivalente de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, y también actividades de fortalecimiento al menos dos veces por semana.	-Los factores de riesgo comunes para ECV son hipertensión arterial, dislipidemia, niveles anormales de glucosa en sangre o diabetes. -La evidencia existente indica un beneficio positivo pero pequeño del asesoramiento conductual para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) en esta población. Las personas que están interesadas y listas para hacer cambios de comportamiento pueden ser más propensas a beneficiarse de la consejería conductual.
17- Cáncer de próstata: Someter a los hombres de 55 a 69 años a exámenes periódicos de detección de antígeno prostático específico (PSA) para el cáncer de próstata, discutiendo con ellos sobre los posibles beneficios y daños de la detección e incorporar sus valores y preferencias en la decisión.	No hay información de frecuencia de servicio actualmente disponible.	-Las pruebas de detección ofrecen un pequeño beneficio potencial de reducir la probabilidad de muerte por cáncer de próstata en algunos hombres. Sin embargo, muchos hombres experimentarán daños potenciales de la detección, incluidos los resultados falsos positivos que requieren pruebas adicionales y una posible biopsia de próstata; sobre diagnóstico y sobre tratamiento; así como complicaciones del tratamiento, como incontinencia y disfunción eréctil. - Al determinar si este servicio es apropiado en casos individuales, los pacientes y los médicos deben considerar el equilibrio de beneficios y daños sobre la base de los antecedentes familiares, etnia, las afecciones médicas comórbidas, los valores del paciente sobre los beneficios y daños de las pruebas de detección y los resultados específicos del tratamiento y otras necesidades de salud. Los médicos no deben evaluar a los hombres que no expresan una preferencia por la detección.
18-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.56. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.
4-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
6-. Aneurisma de aorta abdominal: Ecografía abdominal para la detección de aneurisma aórtico abdominal (AAA) en hombres de 65 a 75 años que alguna vez han fumado.	Una vez.	-Los factores de riesgo para AAA incluyen la edad avanzada, el sexo masculino, el tabaquismo y tener un pariente de primer grado con un AAA. La recomendación varía según el sexo, la edad y el historial de tabaquismo del paciente. "Fumar alguna vez" se define comúnmente como fumar 100 o más cigarrillos.
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
8-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
10-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodialis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
11-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
13-. Prediabetes y diabetes tipo 2: Detectar en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes a intervenciones preventivas efectivas.	Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre. -El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre indígenas, asiáticas, hispanos/latinos y afrodescendientes que entre los caucásicos. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. -La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. Una diferencia en la composición de la grasa corporal en las personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. -Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y con un IMC más bajo en personas asiáticas. -Los datos sugieren que un IMC de 23 o más puede ser un punto de corte apropiado en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
15-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
17-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
18-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para la obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
19-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.57-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres y hombres transgénero sexualmente activos.
4-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
6-. Aneurisma de aorta abdominal: Ecografía abdominal para la detección de aneurisma aórtico abdominal (AAA) en hombres de 65 a 75 años que alguna vez han fumado.	Una vez.	Los factores de riesgo para AAA incluyen la edad avanzada, el sexo masculino, el tabaquismo y tener un pariente de primer grado con un AAA. La recomendación varía según el sexo, la edad y el historial de tabaquismo del paciente. "Fumar alguna vez" se define comúnmente como fumar 100 o más cigarrillos.
7-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
8-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
9-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
10-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodialis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
11-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.
13-. Cáncer de pulmón: Realizar despistaje con tomografía computarizada de dosis baja (LDCT) en adultos de 50 a 80 años que tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes-año y actualmente fuman o han dejado de fumar antes de 15 años.	Anual.	-Las pruebas de detección deben suspenderse una vez que una persona no ha fumado durante 15 años o desarrolla un problema de salud que limita sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa. -El tabaquismo y la edad avanzada son los 2 factores de riesgo más importantes para el cáncer de pulmón. El riesgo de cáncer de pulmón en las personas que fuman aumenta con la cantidad acumulada y la duración del tabaquismo y con la edad, pero disminuye con el aumento del tiempo desde que dejaron de fumar para las personas que anteriormente fumaban. -Los hombres afrodescendientes tienen una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Las mujeres afrodescendientes tienen una incidencia menor que las mujeres caucásicas. Es probable que estas diferencias estén relacionadas con las diferencias en la exposición al tabaquismo (es decir, la prevalencia del tabaquismo) y la exposición relacionada a carcinógenos en los cigarrillos. Las diferencias también pueden estar relacionadas con otros factores de riesgo social. -Otros factores de riesgo para el cáncer de pulmón incluyen exposiciones ambientales, radioterapia previa, otras enfermedades pulmonares (no cancerosas) y antecedentes familiares. Un menor nivel de educación también se asocia con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Debe usarse la edad y el historial de tabaquismo para determinar la elegibilidad de las pruebas de detección en lugar de modelos de predicción de riesgos más elaborados porque no hay pruebas suficientes para evaluar si la detección basada en modelos de predicción de riesgos mejoraría los resultados en relación con el uso de los factores de riesgo de la edad y los antecedentes de tabaquismo para una implementación amplia en la atención primaria.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Prediabetes y diabetes tipo 2: Detectar en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes a intervenciones preventivas efectivas.	Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre. -El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre indígenas, asiáticas, hispanos/latinos y afrodescendientes que entre los caucásicos. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. -La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. Una diferencia en la composición de la grasa corporal en las personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. -Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y con un IMC más bajo en personas asiáticas. -Los datos sugieren que un IMC de 23 o más puede ser un punto de corte apropiado en personas asiáticas.
15-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
16-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C >190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
17-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
18-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
19-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
20-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.58-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunoquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
4-. Aneurisma de aorta abdominal: Ecografía abdominal para la detección de aneurisma aórtico abdominal (AAA) en hombres de 65 a 75 años que alguna vez han fumado.	Una vez.	-Los factores de riesgo para AAA incluyen la edad avanzada, el sexo masculino, el tabaquismo y tener un pariente de primer grado con un AAA. La recomendación varía según el sexo, la edad y el historial de tabaquismo del paciente. "Fumar alguna vez" se define comúnmente como fumar 100 o más cigarrillos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
6-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.
7-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
9-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
10-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregateados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Prediabetes y diabetes tipo 2: Detectar en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes a intervenciones preventivas efectivas.	Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre. -El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes que entre los caucásicos. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. -La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. Una diferencia en la composición de la grasa corporal en las personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. -Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y con un IMC más bajo en personas asiáticas. -Los datos sugieren que un IMC de 23 o más puede ser un punto de corte apropiado en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
13-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
14-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
15-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
16-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.59-. Plan de despistaje preventivo para pacientes entre 61-70 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
2-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
3-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
4-. Aneurisma de aorta abdominal: Ecografía abdominal para la detección de aneurisma aórtico abdominal (AAA) en hombres de 65 a 75 años que alguna vez han fumado.	Una vez.	-Los factores de riesgo para AAA incluyen la edad avanzada, el sexo masculino, el tabaquismo y tener un pariente de primer grado con un AAA. La recomendación varía según el sexo, la edad y el historial de tabaquismo del paciente. "Fumar alguna vez" se define comúnmente como fumar 100 o más cigarrillos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
6-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.
7-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodíalisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
9-. Hepatitis C: Serología para el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con alto riesgo de infección.	-Examen único. -Examinar periódicamente a las personas con riesgo. Hay pruebas limitadas para determinar con qué frecuencia se deben evaluar a las personas con mayor riesgo.	Las personas con riesgo continuo de infección por el VHC son aquellas con uso de drogas inyectables pasadas o actuales.
10-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Cáncer de pulmón: Realizar despistaje con tomografía computarizada de dosis baja (LDCT) en adultos de 50 a 80 años que tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes-año y actualmente fuman o han dejado de fumar antes de 15 años.	Anual.	-Las pruebas de detección deben suspenderse una vez que una persona no ha fumado durante 15 años o desarrolla un problema de salud que limita sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa. -El tabaquismo y la edad avanzada son los 2 factores de riesgo más importantes para el cáncer de pulmón. El riesgo de cáncer de pulmón en las personas que fuman aumenta con la cantidad acumulada y la duración del tabaquismo y con la edad, pero disminuye con el aumento del tiempo desde que dejaron de fumar para las personas que anteriormente fumaban. -Los hombres afrodescendientes tienen una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Las mujeres afrodescendientes tienen una incidencia menor que las mujeres caucásicas. Es probable que estas diferencias estén relacionadas con las diferencias en la exposición al tabaquismo (es decir, la prevalencia del tabaquismo) y la exposición relacionada a carcinógenos en los cigarrillos. Las diferencias también pueden estar relacionadas con otros factores de riesgo social. -Otros factores de riesgo para el cáncer de pulmón incluyen exposiciones ambientales, radioterapia previa, otras enfermedades pulmonares (no cancerosas) y antecedentes familiares. Un menor nivel de educación también se asocia con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Debe usarse la edad y el historial de tabaquismo para determinar la elegibilidad de las pruebas de detección en lugar de modelos de predicción de riesgos más elaborados porque no hay pruebas suficientes para evaluar si la detección basada en modelos de predicción de riesgos mejoraría los resultados en relación con el uso de los factores de riesgo de la edad y los antecedentes de tabaquismo para una implementación amplia en la atención primaria.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
12-. Prediabetes y diabetes tipo 2: Detectar en adultos de 35 a 70 años que tienen sobrepeso u obesidad. Ofrecer o derivar a los pacientes a intervenciones preventivas efectivas.	Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre.	-La evidencia sobre el intervalo de detección óptimo para adultos con un resultado inicial normal de la prueba de glucosa es limitada. Los estudios de cohortes y modelos sugieren que la detección cada 3 años puede ser un enfoque razonable para adultos con niveles normales de glucosa en sangre. -El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más fuertes para desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, los antecedentes familiares, los antecedentes de diabetes gestacional, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y los factores dietéticos y de estilo de vida. -La prevalencia de diabetes es mayor entre indígenas, asiáticos, hispanos/latinos y afrodescendientes que entre los caucásicos. -Las disparidades en la prevalencia de la diabetes son el resultado de una variedad de factores. Un gran cuerpo de evidencia demuestra fuertes asociaciones entre la prevalencia de la diabetes y factores sociales como el estado socioeconómico, el entorno alimentario y el entorno físico. -La mayor prevalencia de diabetes en personas asiáticas puede estar relacionada con diferencias en la composición corporal. Una diferencia en la composición de la grasa corporal en las personas asiáticas resulta en una subestimación del riesgo basada en los umbrales de IMC utilizados para definir el sobrepeso. -Los médicos deben considerar la detección a una edad más temprana en personas de grupos con incidencia y prevalencia desproporcionadamente altas o en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, o antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y con un IMC más bajo en personas asiáticas. -Los datos sugieren que un IMC de 23 o más puede ser un punto de corte apropiado en personas asiáticas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Ateromatosis: Usar en adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), es decir, enfermedad arterial coronaria sintomática o accidente cerebrovascular isquémico, una estatina a dosis baja-moderada para la prevención de eventos de ECV y mortalidad cuando se cumplan todos los siguientes criterios: Edad entre 40 y 75 años de edad; existencia de 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de eventos de ECV a 10 años requieren un cribado universal de lípidos en adultos de 40 a 75 años. -Los adultos que cumplen con los siguientes criterios están en mayor riesgo: Edad entre 40 y 75 años, 1 o más factores de riesgo de ECV (Dislipidemia, diabetes, hipertensión o tabaquismo) y un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular del 10% o más. -A los efectos de esta recomendación, la dislipidemia se define como un nivel de LDL-C superior a 130 mg/dL o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) inferior a 40 mg/dL (para convertir los valores de HDL-C en mmol/L, multiplique por 0,0259). La mayoría de los participantes inscritos en ensayos de uso de estatinas para la prevención de ECV tenían un nivel de LDL-C de 130 a 190 mg/dL o un diagnóstico de diabetes; la hipertensión y el tabaquismo también fueron comunes entre los participantes del ensayo. -Las personas con un nivel de LDL-C superior a 190 mg/dL generalmente se excluyeron de la participación en el ensayo, ya que no se consideró apropiado asignarlas al azar a placebo. Por lo tanto, estas recomendaciones no se refieren a las personas con niveles muy altos de colesterol (es decir, LDL-C > 190 mg / dL) o hipercolesterolemia familiar, ya que se excluyeron de la mayoría de los ensayos de prevención.
14-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
15-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
16-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
17-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.60-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años masculinos, sexualmente activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
2-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
4-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
6-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
8-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
9-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
11-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
12-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
14-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
15-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.61 -. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años masculinos, sexualmente activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
2-. Infección por HIV: Ofrecer profilaxis previa a la exposición (PrEP) con terapia antirretroviral efectiva a personas con alto riesgo de contraer el VIH.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las personas en riesgo de infección por el VIH incluyen: *Hombres que tienen sexo con hombres, personas en riesgo por contacto heterosexual y personas que se inyectan drogas (Dentro de estos grupos, ciertos factores de riesgo o comportamientos pueden poner a las personas en alto riesgo de infección por el VIH, tales como hombres que tienen sexo con hombres, son sexualmente activos y tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante (En una relación sexual con una pareja que vive con el VIH), uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, una ITS con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6 meses. *Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen 1 de las siguientes características: Una pareja sexual serodiscordante, uso inconsistente de condones durante las relaciones sexuales con una pareja cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce y que corre un alto riesgo (p. ej., una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses). *Personas que se inyectan drogas y tienen 1 de las siguientes características: Uso compartido de equipos de inyección de drogas, riesgo de adquisición sexual del VIH. *Personas que practican sexo transaccional, personas que son traficadas para el trabajo sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres y mujeres hombres transgénero sexualmente activos.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
3-. Sífilis: Realizar VDRL en personas con mayor riesgo de infección.	-Tan pronto como sea posible cuando se presenten por primera vez a la atención. -Si una mujer no ha recibido atención prenatal antes del parto, debe hacerse la prueba en el momento en que se presenta para el parto. -Mujeres que tienen como pareja hombres que tienen sexo con hombres o que viven con el VIH pueden beneficiarse de exámenes de detección cada 3 meses.	-En la mayoría de los casos de sífilis congénita, las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal, pero no fueron examinadas ni tratadas para la sífilis lo suficientemente temprano durante el embarazo para prevenir la transmisión al feto. -No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
4-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
5-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
6-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
7-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
8-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
9-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
10-. Infecciones de transmisión sexual: Asesoramiento conductual para todos los adolescentes sexualmente activos y para los adultos que tienen un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todos los adolescentes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de ITS debido a las altas tasas de ellas en este grupo de edad y deben recibir intervenciones de asesoramiento conductual. -Los grupos con mayor riesgo de ITS incluyen aquellos que actualmente tienen una ITS o que fueron diagnosticados con una en el último año, no usan condones de manera constante, tienen múltiples parejas sexuales o tienen parejas sexuales dentro de poblaciones con una alta prevalencia de ITS. -Las poblaciones con una alta prevalencia de ITS incluyen personas que buscan pruebas de ITS o asisten a clínicas de ITS; minorías sexuales y de género; personas que viven con el VIH, se inyectan drogas, han intercambiado sexo por dinero o drogas, o han ingresado a centros penitenciarios y algunos grupos minoritarios raciales/étnicos.
11-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
12-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
13-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.
14-. Cáncer Colorrectal: Despistaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HsgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HsgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
15-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevos (lunares) y nevos atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.62-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años masculinos, sexualmente no activos y no fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
2-. Tabaquismo: Realizar Intervenciones, asesorías y educación breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Todo joven se considera en riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco. Se deben proporcionar intervenciones para prevenir el inicio del consumo de tabaco a todos los jóvenes que aún no han comenzado a consumir productos de tabaco, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo. -El sexo masculino, raza blanca, no ir a la escuela, área rural, tener padres con menor nivel de educación, padres fumadores, tener amigos de la infancia que fuman, constituyen factores de riesgo para iniciar a fumar.
3-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
4-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
6-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
7-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
9-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
10-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticos (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Cáncer Colorrectal: Despiñaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
12-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

7.63-. Plan de despistaje preventivo para pacientes mayores de 70 años masculinos, sexualmente no activos y fumadores del P.A.A.I.S., según el USPSTF

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
1-. Hipertensión arterial: Toma periódica de presión arterial.	-Cada año para quienes no tienen riesgo. -Con menos frecuencia (Cada 3 a 5 años) para quienes no tienen mayor riesgo de hipertensión y con una lectura previa normal de la presión arterial. -Obtener mediciones de la presión arterial fuera del entorno clínico para la confirmación diagnóstica antes de comenzar el tratamiento.	-Todos los adultos deben ser examinados para detectar hipertensión. -Los factores de riesgo que aumentan el riesgo de una persona para la afección incluyen la edad avanzada, la etnia afrodescendiente, los antecedentes familiares, el exceso de peso y la obesidad, los hábitos de estilo de vida (falta de actividad física, estrés y consumo de tabaco) y los factores dietéticos (dieta alta en grasas o sodio, dieta baja en potasio o consumo excesivo de alcohol).
2-. Tabaquismo: Preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco, aconsejarles que dejen de usar tabaco y proporcionarles intervenciones conductuales y la farmacoterapia aprobada para dejar de fumar.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	No hay información de factores de riesgo actualmente disponible.
3-. Desorden depresivo mayor (MDD): Despistaje con sistemas adecuados para garantizar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y un seguimiento adecuado.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Las causas del MDD no se conocen por completo y es probable que impliquen una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. -Los siguientes factores de riesgo podrían ayudar a identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo: Sexo femenino, antecedentes familiares (especialmente maternos) de depresión, episodio previo de depresión, otros problemas de salud mental o de comportamiento, enfermedad médica crónica, sobrepeso y obesidad, abuso o negligencia infantil, exposición a eventos traumáticos (incluidos los desastres naturales), pérdida de un ser querido o una relación romántica, los conflictos familiares, la incertidumbre sobre la orientación sexual, el bajo nivel socioeconómico y el bajo rendimiento académico.
4-. Caídas: Prevención con intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que tienen un mayor riesgo de éstas.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	Este grupo de población tiene mayor riesgo de caídas.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
5-. Enfermedad Cardiovascular en personas con factores de riesgo: Ofrecer o referir a adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular a programas de asesoramiento conductual para promover una dieta y actividad física saludables.	No hay información actualmente disponible sobre frecuencia del servicio.	-Los adultos de 18 años o más con mayor riesgo de ECV, son aquellos con 1 o más de los siguientes factores: Hipertensión o presión arterial elevada, dislipidemia, factores de riesgo mixtos o múltiples, como el síndrome metabólico o un riesgo estimado de ECV a 10 años de $\geq 7,5\%$. -Esta recomendación no se aplica a adultos con otros factores de riesgo cardiovascular modificables conocidos, como niveles anormales de glucosa en sangre, obesidad y tabaquismo.
6-. Hepatitis B: Serología para el virus de la hepatitis B (VHB) en personas con alto riesgo de infección.	-La detección periódica puede ser útil en pacientes con riesgo continuo de transmisión del VHB (Usuarios activos de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes que reciben hemodiálisis o terapia citotóxica o inmunosupresora (por ejemplo, quimioterapia para enfermedades malignas e inmunosupresión relacionada con el trasplante de órganos y para trastornos reumatológicos y gastroenterológicos) que no reciben vacunas, pacientes con resultados negativos de HBsAg que no han recibido la serie de vacunas contra el VHB. -El juicio clínico debe determinar la frecuencia de las pruebas de detección, ya que no se han encontrado pruebas adecuadas para determinar los intervalos de detección específicos.	-Un factor de riesgo importante para la infección por VHB es el país de origen ya que el riesgo de infección por VHB varía sustancialmente según el país. Las personas nacidas en países con una prevalencia de infección por VHB del 2% o más representan del 47% al 95% de las personas con infección crónica por VHB). -Otro factor de riesgo importante para la infección por VHB es la falta de vacunación en la infancia.
7-. Tuberculosis: Detección de la infección tuberculosa latente (LTBI) en poblaciones con mayor riesgo a través de PPD y BK seriados.	-No se encontró evidencia sobre la frecuencia óptima de detección de LTBI. -Dependiendo de los factores de riesgo específicos, la frecuencia de las pruebas de detección podría variar desde la detección de 1 sola vez entre las personas que tienen bajo riesgo de exposición futura a la tuberculosis hasta la detección anual entre las que están en riesgo continuo de exposición.	-El aumento del riesgo de LTBI basado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad activa y el aumento del riesgo de exposición incluye a las personas que nacieron en, o son antiguos residentes de zonas con mayor prevalencia de tuberculosis y las personas que viven en, o han vivido en, entornos congregados de alto riesgo (Por ejemplo, refugios para personas sin hogar y centros correccionales). -Los médicos pueden consultar a sus departamentos de salud locales o estatales para obtener más información sobre las poblaciones en riesgo en su comunidad, porque los patrones demográficos locales pueden variar.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
8-. Alcoholismo: Detectar el consumo de alcohol poco saludable y proporcionar intervenciones breves de asesoramiento conductual para reducir el consumo de alcohol poco saludable.	No hay evidencia adecuada para recomendar un intervalo de detección óptimo para el consumo de alcohol no saludable en adultos.	-Se incluyen las bebidas riesgosas o peligrosas. -Las intervenciones breves de asesoramiento conductual reducen el consumo de alcohol poco saludable en adultos de 18 años o más, incluidas las mujeres embarazadas. -Las intervenciones efectivas de consejería conductual varían en sus componentes específicos, administración, duración y número de interacciones. -No se pudo identificar características o componentes específicos de la intervención que se asociaron claramente con mejores resultados.
9-. Drogas de abuso: Interrogar sobre el uso de drogas de abuso. Ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y la atención adecuada.	-La detección debe implementarse cuando se puedan ofrecer o derivar servicios. -La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas poco saludables, no a analizar muestras biológicas.	-Los factores de riesgo incluyen tener entre 18 y 25 años, sexo masculino, tener una condición de salud mental, trastorno de personalidad o estado de ánimo, o dependencia de la nicotina o el alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual, negligencia de los padres u otra adversidad en la infancia o adicción a las drogas o al alcohol en un pariente de primer grado. -Los factores asociados con el uso indebido de medicamentos recetados incluyen antecedentes de uso de otras drogas, enfermedades mentales, dolor y un mayor acceso a los medicamentos recetados. -Los factores asociados con el uso prenatal de medicamentos incluyen un trastorno de salud mental, violencia interpersonal y antecedentes familiares de uso de sustancias.
10-. Obesidad: Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y evaluar obesidad y remitir a programas de intervención conductual intensivos e integrales para promover mejoras en el estado del peso.	No hay evidencia con respecto a los intervalos de detección apropiados. La altura y el peso, necesarios para el cálculo del IMC, deben medirse rutinariamente durante las visitas de mantenimiento de la salud.	-La obesidad de los padres, mala nutrición, bajos niveles de actividad física, sueño inadecuado, conductas sedentarias, bajos ingresos familiares, diabetes materna, tabaquismo materno, aumento de peso gestacional y crecimiento infantil rápido constituyen factores de riesgo para obesidad. -Una disminución de la actividad física en los niños pequeños es un factor de riesgo para la obesidad más adelante en la adolescencia. -Algunos factores tales como diferencias raciales/étnicas y genéticas y no genéticas (p. ej., estatus socioeconómico, ingesta de bebidas azucaradas y comida rápida, y tener un televisor en el dormitorio), inciden en la prevalencia de la obesidad.

Recomendación	Frec. de la actividad	Inform. sobre el factor de riesgo
11-. Cáncer Colorrectal: Despiñaje con prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT), prueba inmunquímica fecal (FIT), prueba de ADN en heces (Tanto el gFOBT de alta sensibilidad como el FIT detectan sangre en las heces), Colonografía computarizada, Sigmoidoscopia flexible y colonoscopia.	-Prueba de Guayacolato de alta sensibilidad para sangre oculta en heces (HSgFOBT) o prueba inmunquímica fecal (FIT) cada año. -DNA-FIT en heces cada 1 a 3 años. -Colonografía computarizada cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 5 años. -Sigmoidoscopia flexible cada 10 años + FIT anual. -Colonoscopia de detección cada 10 años.	-La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer colorrectal, con tasas de incidencia que aumentan con la edad y casi el 94% de los nuevos casos de cáncer colorrectal que ocurren en adultos de 45 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer colorrectal son más altas en adultos negros, indígenas y personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal (incluso en ausencia de cualquier síndrome hereditario conocido, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar), hombres y personas con otros factores de riesgo (como obesidad, diabetes, tabaquismo a largo plazo y consumo de alcohol poco saludable). -A todos los adultos de 45 años o más se les deben ofrecer exámenes de detección, incluso si estos factores de riesgo están ausentes.
12-. Cáncer de piel: Asesorar sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta en niños con tipos de piel claros para reducir el riesgo de cáncer de piel.	Promover comportamientos de protección solar para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, evitando la exposición excesiva y directa al sol, usando protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más; sombreros, anteojos de sol o ropa protectora contra el sol; buscando sombra durante el mediodía (10 am a 4 pm) y evitando el uso de bronceado en interiores.	-La exposición a la radiación ultravioleta durante la niñez y la adolescencia aumenta el riesgo de cáncer de piel más adelante en la vida, especialmente cuando se produce un daño más grave. -Las personas con un tipo de piel clara (color de cabello y ojos claros, pecas, aquellas que se queman fácilmente con el sol) tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Las personas que usan camisas de bronceado y aquellas con antecedentes de quemaduras solares o cáncer de piel previo también tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de piel. -Otros factores que aumentan el riesgo incluyen un mayor número de nevus (lunares) y nevus atípicos, antecedentes familiares de cáncer de piel, infección por VIH y antecedentes de haber recibido un trasplante de órganos.

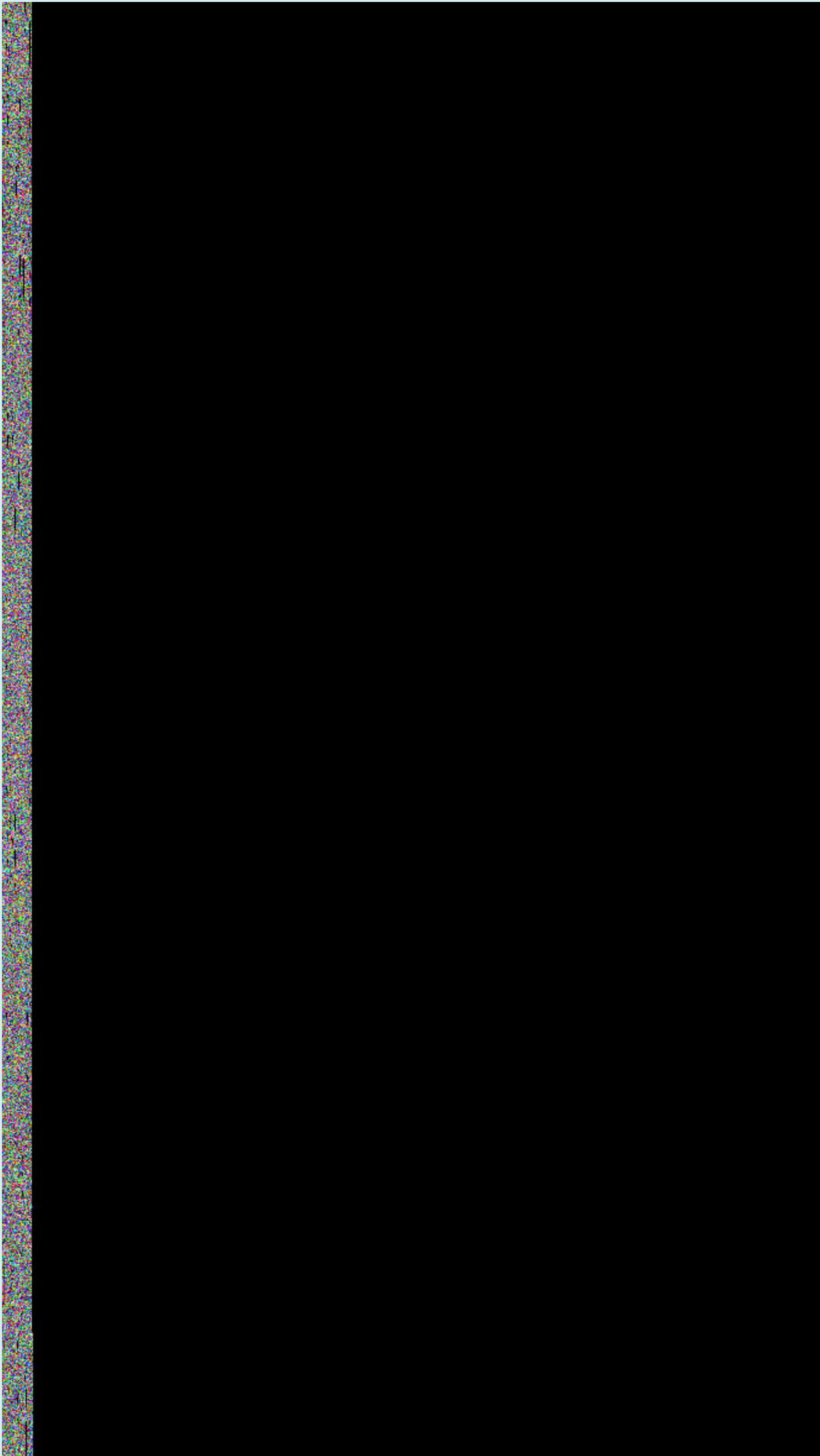
ANEXO 8

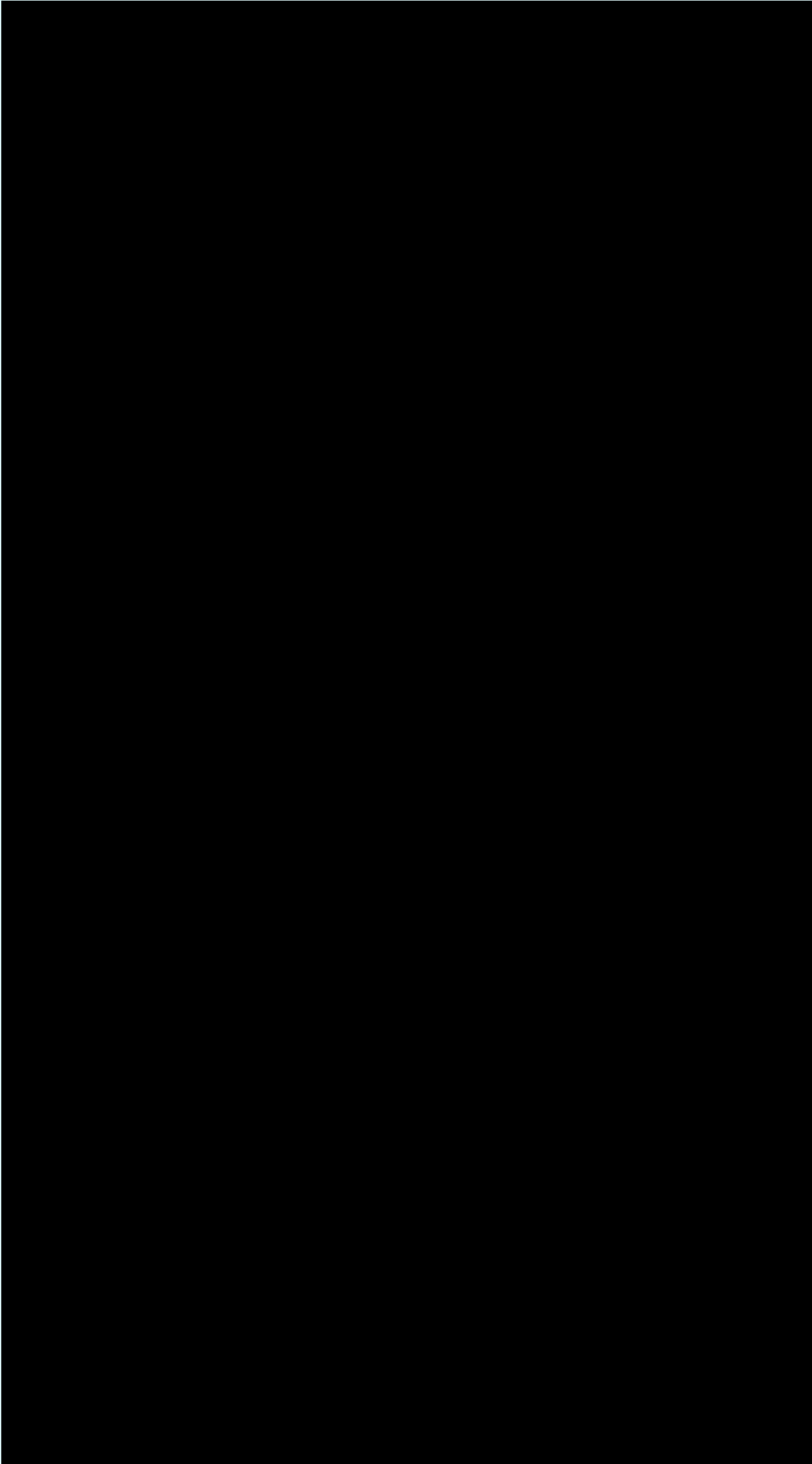
8. Planes específicos de prevención y control de enfermedades

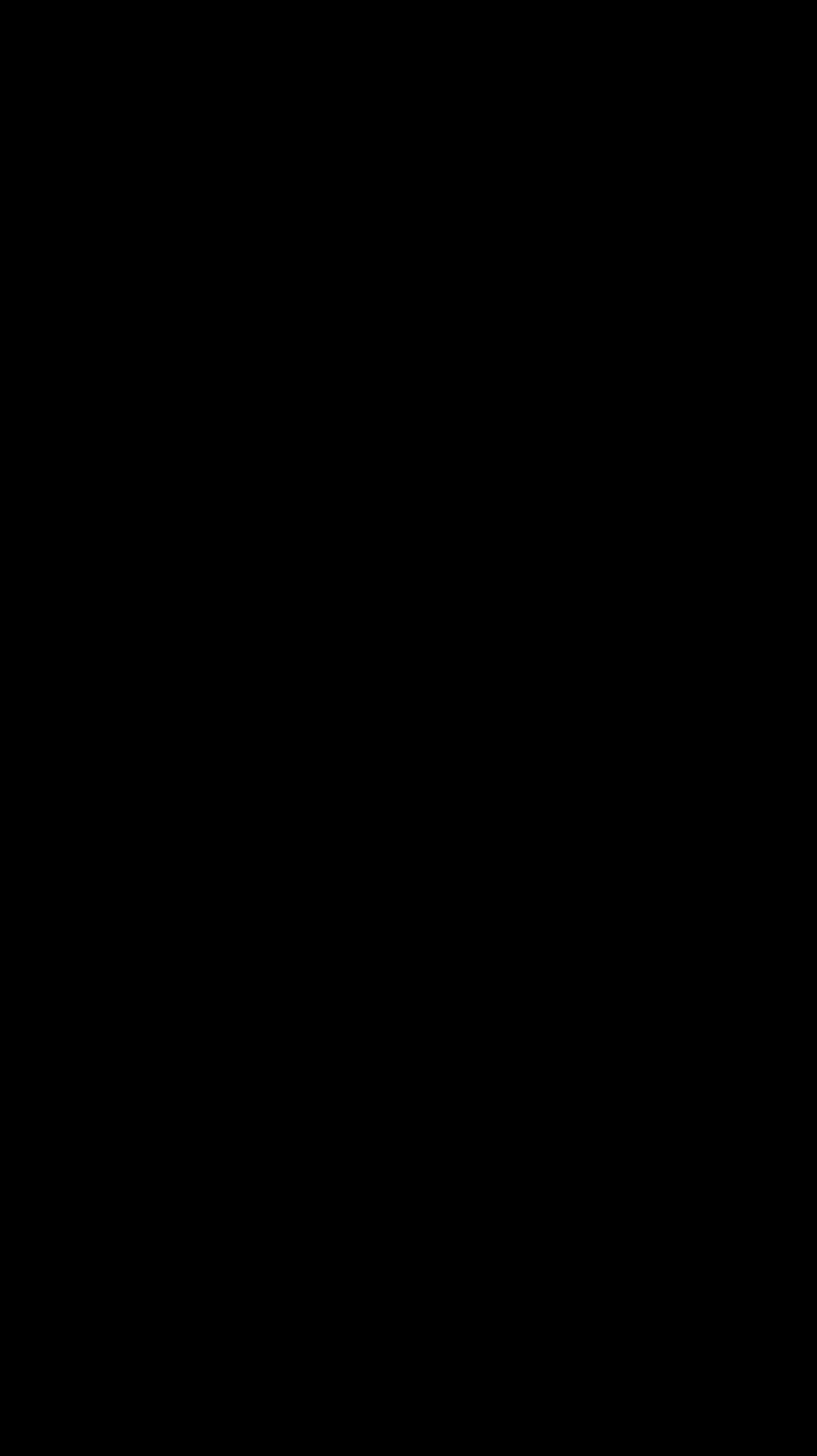
8.1-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan ampliado de inmunizaciones

Grupo de atención	Acción	Criterio diagnóstico	Actividades	Observaciones
Toda la población	-Alcanzar y mantener amplia cobertura de vacunación de la población perteneciente a cada UBPS. -Reducir la morbilidad de las enfermedades prevenibles por vacunas. -Erradicar y controlar las enfermedades inmunoprevenibles. -Asegurar la disponibilidad de vacunas de los esquemas nacionales de vacunación. -Establecer estrategias claras y bien definidas, que permitan vacunar la totalidad de la población programada.	-Tarjeta de vacunación de cada paciente. -Enfermedades a prevenir: Poliomielitis, Sarampión, Tétanos, Difteria, Tosferina, Parotiditis, Tuberculosis, Rubeola, Fiebre amarilla, Meningitis, Neumonía por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B, Hepatitis B, Covid 19.	-Aplicar las estrategias de vacunación para alcanzar los objetivos del P.A.I. sugeridas por el MPPS (Vacunación institucional, casa a casa, vacunación por concentración, campañas o jornadas de vacunación, operación barrido). -Creación de punto de vacunación o vacunatorio en la clínica el cual reúna los requerimientos para la actividad, clínica, iluminación, equipo de refrigeración. -Educación permanente a la comunidad sobre la importancia de la vacunación. -Coordinación con los otros programas de salud a fin de prestar un servicio integral. -Adecuada ubicación y señalización del servicio de vacunación. -Permanente suministro de biológicos y jeringas. -Adecuar la cadena de frío: equipos indispensables para almacenar, conservar, y trasladar las vacunas de un lugar a otro (refrigeradores, cuarto frío, cajas frías, termos y termómetros). -Capacitación de los ejecutores de la estrategia en el registro de los datos, conservación de la cadena de frío y manipulación adecuada de los biológicos. -Identificación de la vacuna y jeringa utilizada (lote, fecha de fabricación y caducidad, uso de diluyentes, dosis, vía de administración y persona que aplica la vacuna. -Garantizar que cada paciente tenga su tarjeta de vacunación. -Crear archivo de vacunación en cada consultorio donde estén dispensarizados el 100% de los pacientes con dos componentes: • Activo: año en curso, distribuido por los 12 meses. • Pasivo: una década, distribuido por los años sucesivos hasta completar los 10 años.	La cobertura de inmunizaciones es un indicador importante para monitorear la calidad del servicio y orientar iniciativas para el control de enfermedades.

Referencias bibliográficas: 101 - 105.







8.2-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención a lactantes y preescolares

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
-Población en general. -Población con riesgo de presentar trastornos y enfermedades mentales, riesgo suicida y adicciones.	-Niños, adolescentes, adultos y ancianos en hogares disfuncionales. -Enfermos psiquiátricos (trastorno bipolar, esquizofrenia). -Alcohólicos o con riesgo según criterios de cantidad y frecuencia. -Adictos (psicofármacos, marihuana, opioides, cocina y derivados). -Suicidas, comportamiento suicida y riesgo suicida). -Abandono y disfunción familiar.	-Contribuir a garantizar el derecho a la salud mental de los venezolanos, -Potenciar capacidades, en individuos y colectivos, para mantenerse sanos, mediante la Promoción de la Salud Mental. -Participación de la comunidad y de los demás sectores del área, sobre los factores de riesgo determinantes que conllevan al desarrollo de enfermedades mentales, suicidio y adicciones. -Fortalecer la Atención para el manejo y control de las Enfermedades Mentales, suicidio y las Adicciones, desde la etapa pre clínica hasta la rehabilitación, contando con la participación y corresponsabilidad de la familia y la comunidad. -Desarrollar el Sistema Información en Salud Mental, que contemple la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Mentales, suicidio y Adicciones, sus factores protectores de vida y los factores de riesgo de estas patologías.	La Línea de Atención en Salud Mental. Diagnóstico del 100% de enfermedades mentales. -La atención de la salud mental deberá incluirse en la cobertura de salud del programa. -Los tratamientos psicológicos, los medicamentos y las intervenciones del estilo de vida deben incluirse en los beneficios del programa. -Incentivar la investigación epidemiológica y social, en el área de la Salud Mental.	-Potenciar capacidades, en individuos y colectivos, para mantenerse sanos, mediante la Promoción de la Salud Mental. -Detección precoz de trastornos, enfermedades mentales, riesgo suicida, suicidio y adicciones en consultas de primer nivel de atención, familias, escuelas, centros de trabajo y comunidades del área de influencia del establecimiento de atención primaria. -Diseño y ejecución de prácticas colectivas que inciden sobre el desarrollo saludable de la personalidad, incluyendo la cultura del amor y la solidaridad humana, la satisfacción adecuada de las necesidades, la actividad física y el esparcimiento, el automanejo adecuado del stress y su control colectivo en sociedad, con la participación de la comunidad. -Identificación de factores predisponentes de trastornos, enfermedades mentales, riesgo suicida, suicidio y adicciones. en consultas de primer nivel de atención, familias, escuelas, centros de trabajo y comunidades del área de influencia del establecimiento de atención primaria. -Identificación de trastornos, enfermedades, riesgo suicida, suicidio y adicciones. mentales en todas las etapas del ciclo de vida, en la familia, en las consultas de primer nivel de Atención y el resto de la red de servicios, con énfasis en la población infanto-juvenil y mayores de 60 años. -Capacitación continua del personal en las pautas y procedimientos del Programa.	-Generación de procesos de transformación cultural. -Modificación de hábitos y estilos de vida que puedan afectar la salud mental, propiciar adicciones y riesgos suicidas.	

Referencias bibliográficas: 101 -105.

8.3-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención al escolar

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Estudiantes de educación básica y media.	Evaluaciones médicas periódicas que incluyan: peso, talla, agudeza visual y auditiva, salud bucal y estado nutricional.	Promover la salud integral de los estudiantes.	Realizar evaluaciones médicas al 100% de los estudiantes al inicio de cada año escolar.	Implementar jornadas de salud escolar en coordinación con el Ministerio de Salud.	Estudiantes de educación básica y media.	Evaluaciones médicas periódicas que incluyan: peso, talla, agudeza visual y auditiva, salud bucal y estado nutricional.
Estudiantes en riesgo de desnutrición o malnutrición.	Índice de Masa Corporal (IMC) por debajo o por encima de los percentiles establecidos para la edad y sexo.	Garantizar una nutrición adecuada que favorezca el aprendizaje y desarrollo.	Reducir en un 20% la prevalencia de desnutrición y malnutrición en estudiantes en un período de 2 años.	Implementar programas de alimentación escolar balanceada.	Estudiantes en riesgo de desnutrición o malnutrición.	Índice de Masa Corporal (IMC) por debajo o por encima de los percentiles establecidos para la edad y sexo.
Estudiantes con dificultades de aprendizaje o comportamiento.	Evaluaciones psicopedagógicas y observaciones en el aula.	Identificar y brindar apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.	Detectar y atender al 100% de los estudiantes con dificultades en un período de 3 años.	Capacitar a docentes en estrategias de enseñanza inclusivas.	Estudiantes con dificultades de aprendizaje o comportamiento.	Evaluaciones psicopedagógicas y observaciones en el aula.
Estudiantes en riesgo de enfermedades infectocontagiosas.	Historial de vacunación incompleto o ausente.	Prevenir brotes de enfermedades prevenibles por vacunación en el entorno escolar.	Lograr que el 95% de los estudiantes tengan su esquema de vacunación completo en 2 años.	Coordinar con autoridades de salud para jornadas de vacunación en escuelas.	Estudiantes en riesgo de enfermedades infectocontagiosas.	Historial de vacunación incompleto o ausente.
Estudiantes en entornos con riesgo de violencia o abuso.	Reportes de violencia escolar, familiar o comunitaria.	Garantizar un ambiente seguro y protector para el desarrollo de los estudiantes.	Reducir en un 30% los casos reportados de violencia en el entorno escolar en 3 años.	Implementar programas de educación en valores y resolución pacífica de conflictos.	Estudiantes en entornos con riesgo de violencia o abuso.	Reportes de violencia escolar, familiar o comunitaria.

Referencias bibliográficas: 101 - 105.

8.4-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan de atención a adolescentes

Población	Criterio DX	Objetivo	Metas	Actividades	Observaciones
Va dirigido a toda la población del área de influenza niños, adolescentes, adultos y tercera edad.	-Realizar historia clínica, anamnesis completa donde se recojan datos de pesquisas de exposición a dicho virus. -Pruebas diagnósticas: combinando la evidencia clínica con los resultados de la tomografía computarizada (TC) de tórax y la RT-PCR. -Muestras de secreciones, hisopado nasal.	-Disminuir y detener la transmisión, evitar brotes y retrasar la propagación del virus. -Proporcionar una atención optimizada para todos los pacientes, especialmente los enfermos graves. -Minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la actividad económica. -Consolidar un sistema de información sencillo que llegue a los usuarios del servicio.	-Apoyar el fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud para identificar y proporcionar atención a pacientes de manera temprana y limitar la propagación del virus. -Asegurar una respuesta coordinada y oportuna entre los diferentes sectores.	-Desarrollar e implementar una campaña de información y educación que incluya: las medidas de protección tanto a nivel personal como familiar; la prevención de infecciones por el nuevo coronavirus. -Capacitar al personal de salud sobre el manejo clínico de casos, incluyendo los protocolos específicos para niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. -Prevenir y mitigar los impactos secundarios de la COVID-19.	Este programa va dirigido a toda la población del área de influenza, pero en especial a la de 0-14 años, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, tercera edad y población indígena.

Referencias bibliográficas: 101 -105.

8.5.-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención al adulto

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
-Adultos de 18-64 años. -Adultos mayores de 40 años.	-Evaluación de factores de riesgo cardiovascular (presión arterial, colesterol, glucosa). -Tamizaje de cáncer (mamografía, citología, pruebas de próstata).	-Reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. -Detectar y tratar tempranamente el cáncer en población adulta.	-Disminuir en un 20% la prevalencia de hipertensión y diabetes en la población general en 5 años. -Aumentar en un 30% la cobertura de tamizaje de cáncer en población objetivo en 3 años.	-Realizar tamizajes anuales de presión arterial, colesterol y glucosa. -Educación sobre dieta y ejercicio saludable. -Implementar campañas de detección temprana y promover la autoexploración contra el cáncer.	-Porcentaje de adultos con factores de riesgo controlados. -% de personas en edades objetivo con tamizajes de cáncer actualizados.	-Priorizar áreas de difícil acceso. -Integrar al personal de salud local y campañas de sensibilización.
Adultos con enfermedades crónicas.	Evaluación y monitoreo de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias).	-Mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas. -Reducir la incidencia de enfermedades respiratorias causadas por factores ambientales	-90% de personas con enfermedades crónicas bajo control en 3 años. -Disminuir en un 15% la prevalencia de enfermedades respiratorias en 5 años.	-Programas de seguimiento y control de enfermedades crónicas, con entrega de medicamentos y asesoría nutricional. -Campañas para reducir el tabaquismo y exposición a factores de riesgo ambientales. Evaluaciones ambientales en áreas de alta exposición.	-Porcentaje de pacientes crónicos que cumplen con los controles y tratamientos. -Porcentaje de adultos con reducción en el consumo de tabaco y menor exposición a factores de riesgo.	-Incluir a familiares y cuidadores en las actividades educativas para reforzar el cuidado en el hogar. -Establecer alianzas con el sector ambiental para asegurar ambientes más limpios y reducir la exposición a contaminantes.
Mujeres adultas en edad fértil.	Tamizaje de salud sexual y reproductiva, incluyendo prevención de ITS.	Mejorar el acceso y el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva.	80% de mujeres adultas en edad fértil con acceso a métodos anticonceptivos y control de ITS.	Promoción de la salud sexual, distribución de anticonceptivos y realización de pruebas para la detección de ITS en centros de salud.	Porcentaje de mujeres con acceso adecuado a servicios de salud reproductiva.	Incluir a hombres en las campañas de concientización sobre salud sexual para una mayor cobertura y sensibilización social.
Trabajadores y adultos en riesgo laboral.	Evaluación de riesgos laborales y capacitación sobre prácticas seguras.	Reducir el riesgo de accidentes y enfermedades ocupacionales.	100% de los trabajadores con acceso a programas de prevención y seguridad en 2 años.	-Implementación de capacitaciones sobre seguridad laboral y medidas preventivas según el tipo de actividad. -Evaluaciones periódicas del estado de salud de los trabajadores.	Porcentaje de trabajado- res capacitados en seguridad y salud laboral.	Colaborar con empresas y organizaciones laborales para establecer protocolos de seguridad y chequeos médicos anuales.

Referencias bibliográficas: 101 - 105.

8.6-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención al adulto mayor

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Adultos mayores de 60 años en comunidades urbanas y rurales.	Evaluaciones médicas periódicas que incluyan: presión arterial, glucemia, índice de masa corporal (IMC), agudeza visual y auditiva, y estado nutricional.	Promover la salud integral y el envejecimiento activo.	Realizar evaluaciones médicas al 80% de los adultos mayores en un período de 2 años.	Implementar jornadas de salud comunitarias en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud.	Adultos mayores de 60 años en comunidades urbanas y rurales.	Evaluaciones médicas periódicas que incluyan: presión arterial, glucemia, índice de masa corporal (IMC), agudeza visual y auditiva, y estado nutricional.
Adultos mayores en riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).	Antecedentes familiares, hábitos de vida poco saludables, y resultados de evaluaciones médicas que indiquen riesgo.	Prevenir y controlar las ECNT como hipertensión, diabetes y obesidad.	Reducir en un 15% la incidencia de ECNT en adultos mayores en un período de 3 años.	Implementar programas de promoción de estilos de vida saludables.	Adultos mayores en riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).	Antecedentes familiares, hábitos de vida poco saludables, y resultados de evaluaciones médicas que indiquen riesgo.
Adultos mayores con limitaciones funcionales o discapacidades.	Evaluaciones funcionales que determinen el nivel de autonomía y necesidad de apoyo.	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía.	Incrementar en un 20% la participación de adultos mayores en programas de rehabilitación y apoyo en 2 años.	Establecer centros de rehabilitación y terapia ocupacional.	Adultos mayores con limitaciones funcionales o discapacidades.	Evaluaciones funcionales que determinen el nivel de autonomía y necesidad de apoyo.
Adultos mayores en situación de vulnerabilidad social o económica.	Evaluaciones socioeconómicas que identifiquen carencias y necesidades.	Garantizar el acceso a servicios básicos y protección social.	Lograr que el 90% de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad accedan a programas de asistencia en 3 años.	Implementar programas de asistencia económica y alimentaria.	Adultos mayores en situación de vulnerabilidad social o económica.	Evaluaciones socioeconómicas que identifiquen carencias y necesidades.
Adultos mayores en riesgo de aislamiento social o depresión.	Evaluaciones psicológicas y sociales que identifiquen signos de aislamiento o depresión.	Fomentar la integración social y el bienestar emocional.	Reducir en un 25% los casos de depresión y aislamiento en adultos mayores en 3 años.	Crear clubes y centros de encuentro para adultos mayores.	Adultos mayores en riesgo de aislamiento social o depresión.	Evaluaciones psicológicas y sociales que identifiquen signos de aislamiento o depresión.
Adultos mayores de 60 años.	Evaluación de riesgo de caídas y funcionalidad física.	Disminuir la incidencia de caídas y mejorar la movilidad en adultos mayores.	Reducir en un 20% los accidentes por caídas en adultos mayores en 3 años.	Implementación de programas de actividad física adaptada, revisión de medicamentos, y ajustes en el hogar para reducir el riesgo de caídas.	Porcentaje de adultos mayores que reportan menor incidencia de caídas.	Porcentaje de adultos mayores que reportan menor incidencia de caídas.

Referencias bibliográficas: 101 -105.

8.7-.- Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención materno-neonatal

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observación(es)
-Mujeres embarazadas hasta 42 días después del parto. -Recién nacidos hasta los 28 días de edad.	-Prueba de embarazo positiva. -Ecografía. -Historia Clínica. -Certificado de nacimiento.	-Control prenatal en todas las embarazadas. -Vacunación completa en todas las embarazadas. -Evolución pondoestatural apropiada. -Prevenir y/o tratar precoz y adecuadamente las infecciones gineco urinarias. -Prevenir, tratar y/o direccionar precozmente la placenta previa, el oligoamnio, el retraso del crecimiento intrauterino y la hipertensión arterial inducida por el embarazo. -Minimizar la morbilidad materna y neonatal. -Prevenir el aborto. -Instauración de método anticonceptivo o esterilización quirúrgica en multiparas de alto riesgo. -Minimizar el número de cesáreas.	-100% de cobertura en consultas prenatales. -Realizar 12 consultas prenatales en cada mujer embarazada. -Cobertura de vacunación del 100% en embarazadas y neonatos. -Nacidos vivos con peso mayor igual a 2,5 kgrs. -100% de partos institucionales.	-Realizar consultas pre natales periódicas. -Realizar control periódico de talla y peso. -Suministrar ácido fólico y hierro desde el primer trimestre. -Sugerir una dieta equilibrada, rica en fibra, hierro, calcio, grasas omega-3, etc. -Toma periódica de presión arterial. -Realización periódica de exámenes. -Inducir el abandono o suspensión de los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y la cafeína. -Promover una visita previa al ginecólogo para hacer una revisión y recibir las primeras recomendaciones. -Indicar ejercicio físico moderado como el yoga, pilates, natación o caminar. -Cumplir esquema de vacunaciones. -Sugerir cuidar la higiene íntima y extremar las medidas higiénicas en general, incluyendo evitar ingerir frutas ni verduras sin lavar y carnes poco cocinadas a menos que se congelen previamente a -22°C durante 10 días. -Sugerir evitar, en la medida de lo posible, exposiciones a agentes químicos ambientales. -Evitar medicamentos innecesarios. -Referir a consulta especializada los casos de alto riesgo obstétrico.	-Proporción de partos complicados: Número de partos complicados/ Número total de partos. -Muertes maternas/100 mil nacidos vivos. -Cobertura de parto institucional. 12q -Muerte neonatos/100 nacidos vivos.	

Referencias bibliográficas: 101 -105.

8.8-- Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de planificación familiar

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observación(es)
-Hombres y mujeres en edad reproductiva, aparejados o no. -Adolescentes (10-19 años). -Mujeres en edad fértil (15-49 años). -Hombres jóvenes y adultos (15-49 años). -Poblaciones rurales y comunidades indígenas. -Personas en situación de vulnerabilidad.	-Inicio temprano de vida sexual. -Falta de acceso a información y métodos anticonceptivos. -Uso inadecuado o nulo de métodos anticonceptivos. -Alta tasa de embarazos no planificados. -Escasa participación en la planificación familiar. -Conocimiento limitado sobre métodos anticonceptivos. -Barreras geográficas y culturales para el acceso a servicios. -Alta tasa de embarazos no planificados.	-Reducir embarazos no deseados en adolescentes. -Postergar el embarazo en los jóvenes. -Aumentar el uso de métodos anticonceptivos modernos. -Fomentar la corresponsabilidad en la planificación familiar. -Garantizar el acceso a servicios de planificación familiar culturalmente apropiados. -Reducir las brechas de acceso a planificación familiar en poblaciones vulnerables. -Brindar a la familia información esencial, efectiva y de calidad para orientarle y ayudarlo a valorar la planificación familiar. -Ayudar a las familias a elegir y a usar el método de planificación familiar que mejor se ajuste a sus necesidades. Poder elegir cuándo es el momento idóneo para tener un hijo. -Orientar a la familia sobre la necesidad de referencia. -Postergar el periodo inter parto. Poder determinar el intervalo de tiempo entre embarazos; es decir, la diferencia de edad entre los hermanos.	-Disminuir en un 20% los embarazos en adolescentes para 2026. -Aumentar el uso de métodos anticonceptivos modernos. -Fomentar la corresponsabilidad en la planificación familiar. -Asegurar la cobertura del 70% en acceso a planificación familiar en estas comunidades para 2026. -Reducir en un 50% las barreras identificadas para 2026. -Embarazos luego de los 18 años o hasta terminar los estudios. -Periodo inter embarazo de 2 años. -Familias de 3-4 hijos.	-Charlas educativas en escuelas. -Distribución de preservativos y anticonceptivos de emergencia. -Campañas de sensibilización en comunidades. -Implementación de consultas de planificación familiar. -Talleres de sensibilización sobre paternidad responsable. -Distribución de preservativos en puntos clave. -Formación de promotores de salud comunitarios. -Establecimiento de puntos móviles de atención médica. -Establecimiento de centros de atención gratuita. -Desarrollo de alianzas con ONGs para distribución masiva. -Brindar educación sexual. El asesoramiento antes de la concepción, durante el embarazo y el parto. -El tratamiento de la infertilidad. -Suministrar anticonceptivos a los jóvenes o parejas que no desean hijos. -Promover el uso del preservativo como método de doble protección contra el embarazo no deseado y la transmisión de enfermedades sexuales.	-Tasa de embarazos en adolescentes. -Participación en talleres educativos. -Tasa de uso de métodos anticonceptivos. -Asistencia a consultas de planificación familiar. -Número de hombres participantes en actividades. -Uso de preservativos reportado en encuestas. -Tasa de acceso a métodos anticonceptivos en comunidades rurales. -Promotores capacitados. -Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio. -Número de barreras eliminadas.	-Enfatizar la promoción del consentimiento informado y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos. -Incorporar estrategias de atención integral con enfoque de género. -Promover campañas de comunicación para romper estereotipos de género. -Respetar las cosmovisiones y tradiciones de estas comunidades, incorporando mediadores culturales. -Priorizar la confidencialidad y el trato digno para todos los usuarios.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observación(es)
-Hombres y mujeres en edad reproductiva, apareados o no. -Adolescentes (10-19 años). -Mujeres en edad fértil (15-49 años). -Hombres jóvenes y adultos (15-49 años). -Poblaciones rurales y comunidades indígenas. -Personas en situación de vulnerabilidad.	-Falta de acceso a servicios por barreras económicas, sociales o políticas. -Desigualdad de género acentuada	-Programar el número de hijos que se desean. -Evitar un embarazo no deseado y conseguirlo en el momento en el que la pareja o la mujer lo deseen. -Prevenir y tratar las enfermedades de transmisión sexual (ETS). -Mejorar la calidad de vida. -Reducir la mortalidad infantil y los problemas de salud en la madre. -Aumentar la supervivencia infantil. -Limitar los nacimientos a los años de mejor salud del período reproductivo de la mujer. -Prevenir la infección por VIH y el nacimiento de bebés infectados y huérfanos. -Disminución de abortos peligrosos y embarazos no deseados. -Disminución del embarazo en adolescentes. -Reducir la tasa de abandono escolar. -Apoyar a las personas en la toma de decisiones y contribuir en su información sobre su salud sexual y reproductiva, su derecho a decidir sobre su reproducción, tener o no descendencia, el número y el momento para tenerla. -Reducir la prematuridad y el bajo peso al nacer.		-Aplicar métodos anticonceptivos naturales (Coito interrumpido, método del ritmo o del calendario, método Billings o del moco cervical, medición de la temperatura basal), métodos de barrera (Preservativo, el diafragma, el capuchón cervical, la esponja vaginal y el dispositivo intrauterino o DIU), los métodos hormonales (Píldora anticonceptiva, el implante subdérmico, la inyección anticonceptiva, el anillo vaginal, la postday, los parches anticonceptivos, etc.) y los métodos permanentes (Vasectomía y la ligadura de trompas). -Inducción para tratamientos de reproducción asistida para tratar la infertilidad. -Enseñar a la mujer a calcular sus días fértiles y a mantener relaciones sexuales sin protección durante estos días.	-Cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico en instituciones públicas de salud. -Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. -Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. -Tasa de vasectomías en hombres de 20 a 64 años de edad -Participación masculina en el uso de métodos anticonceptivos.	

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observación(es)
-Hombres y mujeres en edad reproductiva, aparejados o no. -Adolescentes (10-19 años). -Mujeres en edad fértil (15-49 años). -Hombres jóvenes y adultos (15-49 años). -Poblaciones rurales y comunidades indígenas. -Personas en situación de vulnerabilidad.		-Mejorar la condición y el empoderamiento de las mujeres, su desarrollo personal y su ingreso a la fuerza laboral.. -Contribuir a la reducción de la pobreza y a mejorar el desarrollo económico. -Disminuir los costos asociados a la atención médica. -Contribuir a la sostenibilidad ambiental. -Incentivar la paternidad activa y elegida, así como la responsabilidad del hombre en la planificación familiar y la anticoncepción. -Retrasar el primer embarazo, espaciar los nacimientos y limitar definitivamente los mismos al alcanzar el tamaño deseado de la familia. -Prevenir embarazos no planeados. -Preservar la fertilidad en edad reproductiva.				

Referencias bibliográficas: 101 - 105.

8.9-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observación(es)
Personas desplazadas internas y refugiados.	-Falta de acceso a servicios básicos (salud, alimentación, educación). -Altos niveles de inseguridad. -Intensa movilidad espacial, migración.	-Garantizar acceso integral a servicios básicos y protección social. -Crear competencias de interculturalidad en el personal de salud. -Garantizar la traducción y comprensión de los mensajes -Garantizar el acceso y la utilización de servicios a la salud del migrante. -Garantizar la atención de salud de los grupos vulnerables entre los migrantes (mujeres, indígenas, menores de edad y adultos mayores). -Sensibilizar a los prestadores de servicios con la cultura de los migrantes. -Involucrar a los países de origen y destino en la protección de la salud de los migrantes. -Proteger los derechos humanos, sociales y de salud de los migrantes. -Atención especial a los migrantes más vulnerables (mujeres, ancianos, indígenas y menores). -Reducir los riesgos que enfrentan los migrantes.	Lograr que el 90% de las personas desplazadas accedan a servicios básicos en 2026.	-Creación de centros de atención integral en zonas fronterizas. -Distribución de kits de emergencia. -Enfocar los programas de promoción y prevención, así como de control de enfermedades crónicas, sin descuidar las infecciosas, en los factores de riesgo de tipo conductual (prevención del consumo de alcohol, tabaco y alimentos dañinos), así como la promoción de la actividad física y control de presión arterial, obesidad y control de la enfermedad, la prevención terciaria a través de la rehabilitación y los cuidados paliativos. -Promover la participación comunitaria delegando autonomía o gestión a los servicios. -Desarrollar actividades de sensibilización cultural hacia los migrantes. -Promover la participación de los propios grupos de migrantes en su atención. -Enfatizar los planes de prevención y control de las patologías más probables entre los migrantes, tales como ETS, VIH/SIDA, salud mental, enfermedades crónico degenerativas, abuso de tabaco, drogas y alcohol y enfermedades propias de la mujer como cáncer cérvico uterino y cáncer de mama. -Brindar servicios de traducción. -Brindar un Programa para disminuir la vulnerabilidad de las mujeres esposas de migrantes. -Aplicar fórmulas de asignación geográfica basadas en necesidades. -Usar subsidios cruzados a favor de los más pobres. -Usar fórmulas de asignación geográfica basadas en necesidades y vinculadas a la descentralización de los servicios.	-Número de beneficiarios atendidos. -Cantidad de kits distribuidos.	Asegurar coordinación entre el gobierno, ACNUR y ONGs.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observación(es)
Personas con discapacidad.	Barreras físicas, sociales y económicas para el acceso a servicios y oportunidades.	Promover la inclusión y el acceso igualitario a servicios de salud y protección social.	Incrementar en un 70% la accesibilidad a servicios para personas con discapacidad para 2026.	-Adaptación de espacios públicos y servicios médicos. -Capacitación al personal en inclusión y trato digno.	-Porcentaje de espacios adaptados. -Satisfacción de los usuarios en encuestas.	Incorporar enfoque basado en derechos humanos y participación activa de la comunidad.
Mujeres en situación de violencia de género.	-Altas tasas de violencia física, psicológica o sexual. -Falta de acceso a redes de apoyo y refugios.	-Proteger y empoderar a mujeres en situación de violencia, asegurando su seguridad y bienestar integral.	Proteger y empoderar a mujeres en situación de violencia, asegurando su seguridad y bienestar integral.	-Establecimiento de refugios temporales. -Programas de empoderamiento económico y psicológico.	-Número de mujeres atendidas en refugios. -Cantidad de casos de violencia atendidos por servicios sociales.	Priorizar la confidencialidad, la empatía y el respeto durante la atención.
Niños, niñas y adolescentes en riesgo.	-Exposición a trabajo infantil, abuso o abandono. -Falta de acceso a educación y servicios de salud.	Proteger los derechos de los niños y garantizar su acceso a entornos seguros y servicios básicos.	Disminuir en un 50% los casos de abuso y abandono reportados para 2026.	-Campañas de sensibilización en comunidades. -Fortalecimiento de los sistemas de protección infantil.	-Tasa de casos reportados y atendidos. -Porcentaje de niños en entornos seguros.	Asegurar la colaboración con UNICEF y consejos comunales.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observación(es)
Adultos mayores en situación de pobreza.	-Vejez, ancianidad o edad avanzada. -Falta de acceso a pensiones y servicios básicos. -Altos niveles de abandono y maltrato.	Garantizar la seguridad alimentaria, acceso a salud y protección social de los adultos mayores.	Incrementar en un 80% la cobertura de servicios básicos para adultos mayores para 2026.	-Creación de programas de apoyo alimentario. -Atención médica domiciliaria para personas en situación crítica -Prevención terciaria, particularmente rehabilitación. -Inmunización para las enfermedades infecciosas. -Atención continua que se orienta a prevenir un mayor deterioro en la capacidad funcional para mantener las capacidades y la interacción social el mayor tiempo posible. -Satisfacer las incapacidades crónicas a través de cuidadores formales (profesionales y para profesionales, terapeutas tradicionales y voluntarios) o informales (familia y amigos). Por medio de servicios: cuidado personal, actividades domésticas y extra-domésticas, aparatos de apoyo, aplicación de la más avanzada tecnología, como sistemas de alerta de urgencias y de recordatorio de medicamentos y las modificaciones arquitectónicas en los hogares, en la comunidad o en instituciones, para minimizar, restaurar o compensar la falta de independencia física o de funcionamiento mental.	-Número de adultos mayores beneficiados. -Reducción de denuncias de maltrato.	Incluir estrategias intersectoriales con enfoque comunitario.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observación(es)
Comunidades indígenas en zonas rurales.	-Altos niveles de pobreza y exclusión. -Barreras culturales y geográficas para acceder a servicios. -Etnicidad, indígenas, nativos.	-Garantizar el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, promoviendo su inclusión social y económica. -Articular la medicina tradicional con la medicina convencional. -Adaptar los servicios de salud a la cultura local y de los diversos grupos étnicos, para mejorar la aceptación y del impacto. -Lograr un enfoque intercultural como estrategia central para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud de los indígenas. -Garantizar la traducción y comprensión de los mensajes	Garantizar el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, promoviendo su inclusión social y económica.	-Establecimiento de brigadas de salud interculturales. -Promoción de programas educativos bilingües. -Capacitar a los miembros de la comunidad. -Capacitar a los terapeutas tradicionales como apoyo. -Sensibilizar y capacitar al personal de salud para el trabajo intercultural con énfasis en el personal de enfermería. -Adaptar los servicios a la cultura local y de los grupos étnicos. -Capacitar a los indígenas como agentes comunitarios o pares, remunerados o voluntarios incluso en el nivel técnico y profesional, principalmente en enfermería y medicina. -Mejorar la calidad de la interacción entre el personal de salud y los indígenas. -Sensibilizar y capacitar al personal de salud sobre competencias culturales que le permitan conocer, entender y respetar la cultura de las comunidades indígenas. -Enseñar los conceptos de la medicina tradicional a practicantes de ciencias de la salud. -Dar un enfoque intercultural al recurso humano, a la organización y a la infraestructura de los servicios. -Realizar modificaciones arquitectónicas y de servicios a los espacios para hacerlos compatibles con la cultura indígena. -Relacionar la cosmovisión indígena al tratamiento.	-Número de comunidades atendidas. -Participación en programas educativos y de salud.	Respetar la cosmovisión indígena, trabajando con líderes comunitarios.
Grupos en pobreza extrema.	-Pobreza y condiciones de desigualdad.	-Garantizar la atención integral en salud a los grupos más desposeídos. -Impedir los gastos catastróficos en salud.				

Referencias bibliográficas: 106-110.

8.10-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de enfermedades infecto-contagiosas (salmonelosis, brucelosis, hepatitis, EDA)

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Comunidades rurales y urbanas en riesgo.	Diagnóstico clínico y confirmación por laboratorio de salmonelosis, brucelosis, hepatitis y enfermedades diarreicas agudas.	Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas.	Disminuir en un 20% la incidencia de estas enfermedades en 5 años.	Implementar programas de educación sanitaria sobre higiene personal y alimentaria.	Comunidades rurales y urbanas en riesgo.	Diagnóstico clínico y confirmación por laboratorio de salmonelosis, brucelosis, hepatitis y enfermedades diarreicas agudas.
Trabajadores del sector agropecuario.	Exposición ocupacional y pruebas serológicas positivas para brucelosis.	Prevenir la transmisión ocupacional de brucelosis.	Capacitar al 100% de los trabajadores en medidas preventivas en 3 años.	Ofrecer talleres sobre prácticas seguras en el manejo de animales.	Trabajadores del sector agropecuario.	Exposición ocupacional y pruebas serológicas positivas para brucelosis.
Niños menores de 5 años.	Diagnóstico clínico de enfermedad diarreica aguda y evaluación de deshidratación.	Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas.	Lograr que el 90% de los casos reciban tratamiento adecuado en 2 años.	Distribuir sales de rehidratación oral (SRO) en centros de salud.	Niños menores de 5 años.	Diagnóstico clínico de enfermedad diarreica aguda y evaluación de deshidratación.
Manipuladores de alimentos.	Evaluaciones sanitarias y certificaciones de salud.	Garantizar la inocuidad de los alimentos.	Certificar al 100% de los manipuladores en buenas prácticas de higiene en 2 años.	Implementar cursos obligatorios de manipulación de alimentos. Realizar inspecciones sanitarias periódicas en establecimientos.	-Porcentaje de manipuladores certificados. -Número de inspecciones realizadas.	Establecer sanciones para el incumplimiento de las normativas sanitarias.
Población general	Serologías positivas para hepatitis y antecedentes de contacto con casos confirmados.	Prevenir la transmisión de hepatitis.	Vacunar al 95% de la población susceptible en 5 años.	Realizar campañas masivas de vacunación.	Población general	Serologías positivas para hepatitis y antecedentes de contacto con casos confirmados.

Referencias bibliográficas: 111 -115.

8.11-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de enfermedades crónicas (ETS/VIH/SIDA, enfermedades respiratorias -EPOC, TB, AB-, enfermedades cardiovasculares -HTA, ICC, arritmias, enfermedad vascular periférica-, enfermedad renal crónica, enfermedades hematológicas -anemias, linfomas, leucemia-, enfermedades autoinmunes -lupus, artritis reumatoide-

Población	Criterio DX	Objetivo	Metas	Actividades	Observaciones
Va dirigido a todas las edades, sexo, raza y a población de más alto riesgo.	-Historia clínica detallada, dirigida a la detección de neoplásicos de manera oportuna, precoz y efectiva, investigando los factores predisponentes, ciclos de vida, características familiares y ambientales. -Examen físico. -Pesquisas (ca de cuello uterino, próstata) -Estudios como: Ecogramas, Mamografía, Tomografía -Laboratorio: marcadores, tumorales.	-Disminuir al máximo la morbilidad y mortalidad. -Promocionar la salud en individuos, para que se mantengan sanos. -Actuar sobre los factores de riesgos predisponentes, educando e informando a la población. -Fortalecer las redes de atención para el manejo y control de neoplásicos. -Fortalecer el sistema de información para la prevención y control de enfermedades neoplásicas. -Mejorar la formación del personal de salud, en lo referente a promoción de estilo y condiciones de vida, prevención y tratamiento integral de los neoplásicos.	-Reducir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades neoplásicas a través de la prevención, promoción y tratamiento. -Capacitación continua del personal de salud. -Fortalecer la atención médica de las enfermedades neoplásicas.	-Promover la transformación cultural de modos, condiciones y estilo de vida. -Charlas y plan educativo para mejorar la alimentación. -Promover actividad física. -Impartir educación e información sobre factores ambientales predisponentes a enfermedades neoplásicas.	Este programa debe hacer mayor enfoque en la población de más alto riesgo.

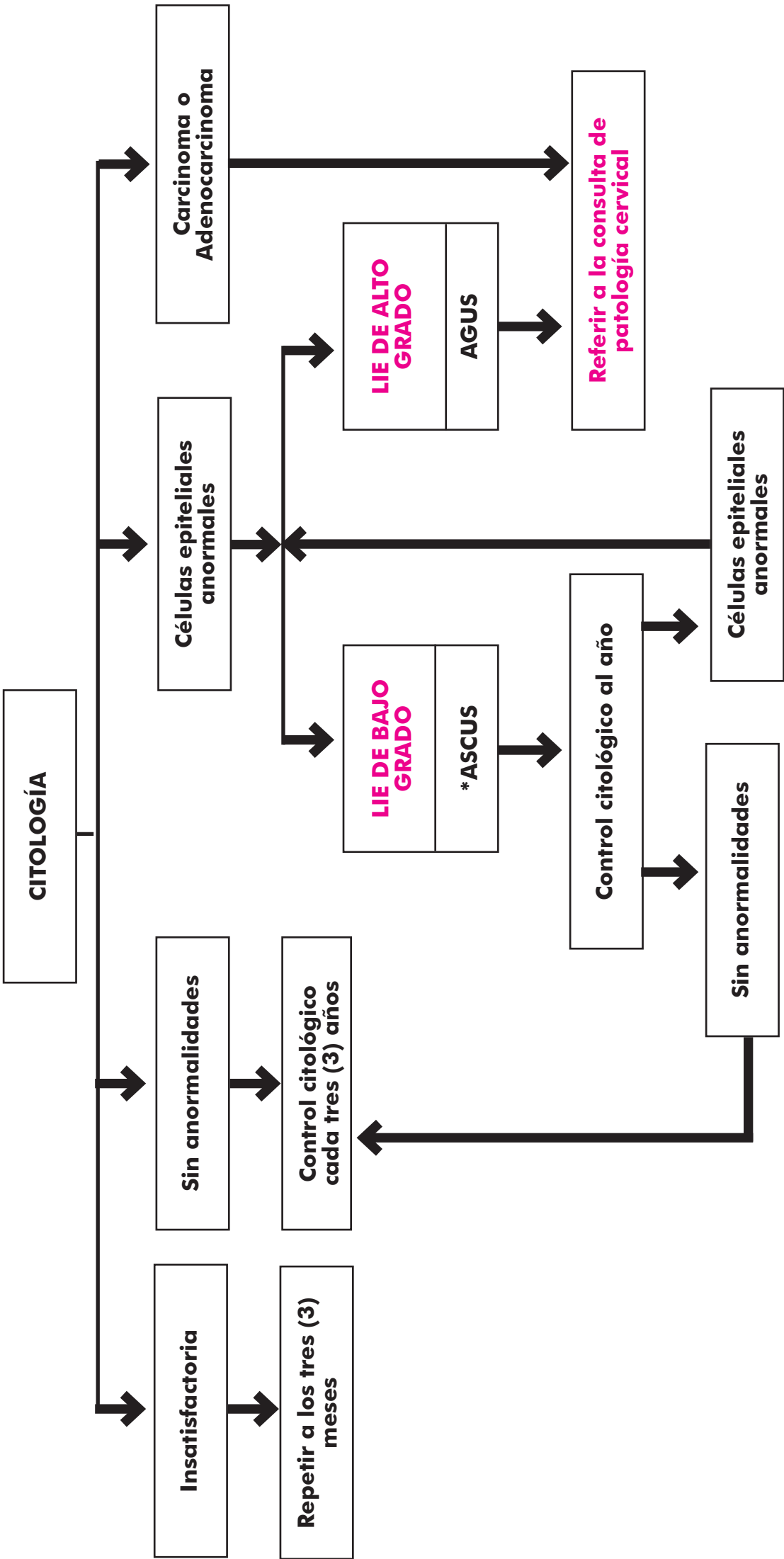
Referencias bibliográficas: 101 -105.

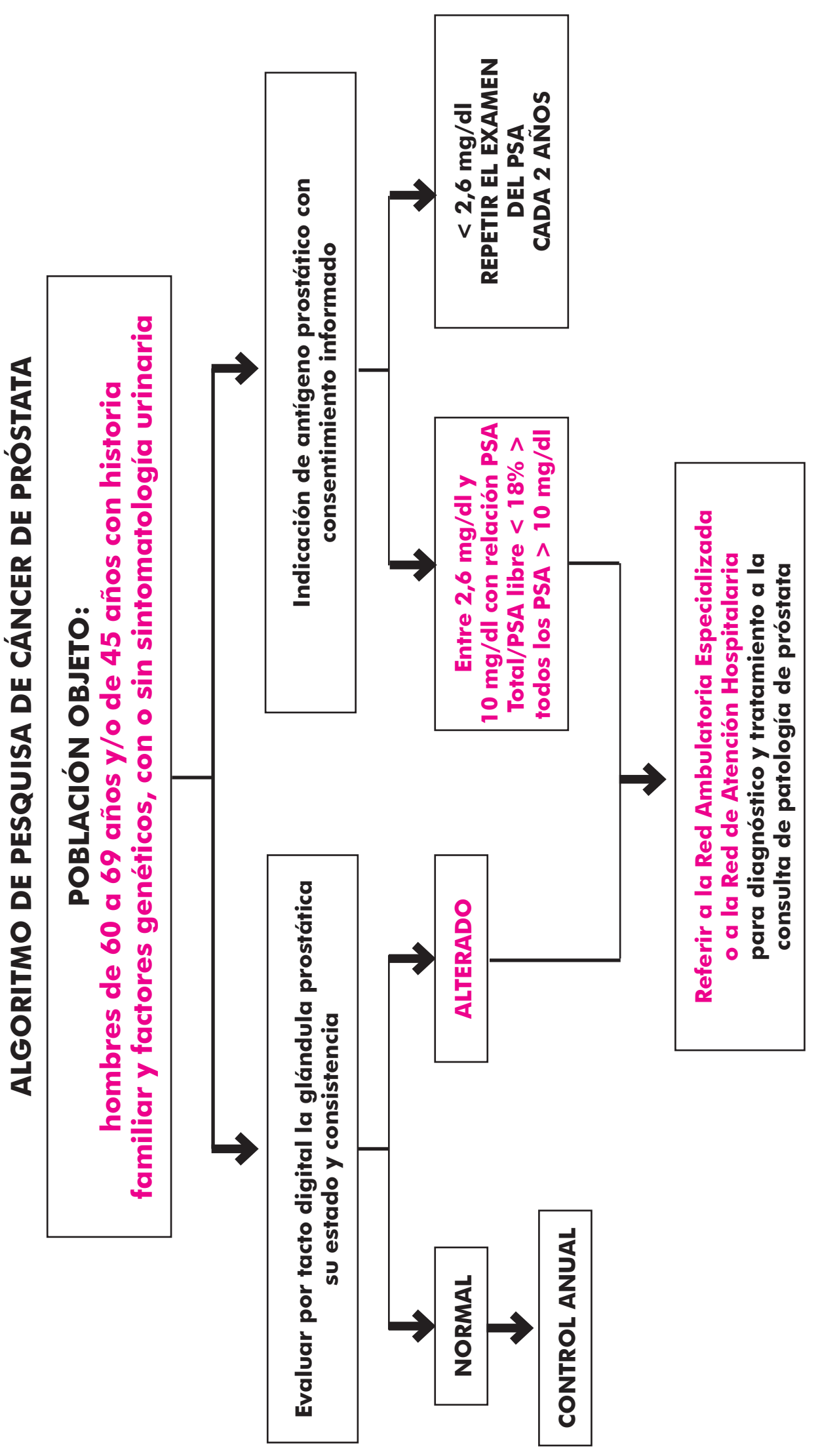
8.12-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de enfermedades neoplásicas (Ca de mama, Ca de cuello cérvico-uterino, próstata)

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años sin síntomas previos, historia familiar o mutaciones, ubicadas en zonas urbanas y rurales.	-Mamografía bilateral y ecograma mamario. -Sospecha: nódulo palpable, secreción. -Biopsia confirmaría.	Detectar lesiones precoces para reducir la mortalidad en 30% (meta OPS).	-Tamizaje del 70% de las mujeres de 40 a 69 años. -Diagnosticar el 80% en estadíos I y II.	-Implementar programas de tamizaje. -Capacitar al personal de salud en detección temprana. -Campañas de concientización.	-Porcentaje de mujeres tamizadas. -Tasa de detención de casos en estadíos tempranos. -Cobertura mamografía.	-La detección temprana mejora el pronóstico y supervivencia. -Integrar al programa nacional Mujer segura.
Cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 21 años sexualmente activas.	Papanicolaou cada 3 años. -Colposcopia. -Biopsia.	Prevenir vía vacunación HPV (70% casos). -Tamizaje para lesiones precancerosas.	-Vacunación HPV >80% adolescentes. -Papanicolaou 70% (35-45 años). -Incidencia <10/100.	-Vacunación VPH. -Papanicolaou/HPV cada 3-5 años. -Tratamiento precáncer.	-Porcentaje de positividad VPH. -Porcentaje de mujeres tratadas. -Cobertura vacunación.	-La prevención contra VPH es clave en la prevención primaria (90% prevenible). -Tamizaje.
Cáncer de próstata en hombres de 50 a 69 años.	-PSA >4 ng/mL + tacto rectal. -RM multiparamétrica. -Biopsia Gleason. -PSA 4-10: 25% probabilidad cáncer.	Detectar precozmente lesiones malignas.	PSA anual. >50 riesgo alto; mortalidad <25/100. 0 >65 años.	-PSA + tacto hombres entre 50-69 años. -Biopsia guiada PSA>4 guiada. -Programas de educación y sensibilización.	Porcentaje PSA elevado detectado; estadío al diagnóstico: sobrevida 5 años	Subregistro en hombres.
Cáncer colon rectal en adultos ≥50 años; alto riesgo: obesidad, dieta baja en fibra (prevalente en costas).	-Colonoscopia cada 10 años ≥50. -Prueba de sangre oculta en heces anual. -Sigmoidoscopia.	Reducir incidencia 20% de casos en la población.	-50% colonoscopia ≥50. -Cobertura colonoscopia 40% >50 años. -Adenomas detectados 60%; mortalidad <15/100.	-Detección de sangre oculta en heces anual. -Colonoscopia cada 10 años. -Campañas para consumo de dieta rica en fibra, antitabaco.	Porcentaje de adenomas detectados.	Dieta caribeña baja en fibras como factor de riesgo.

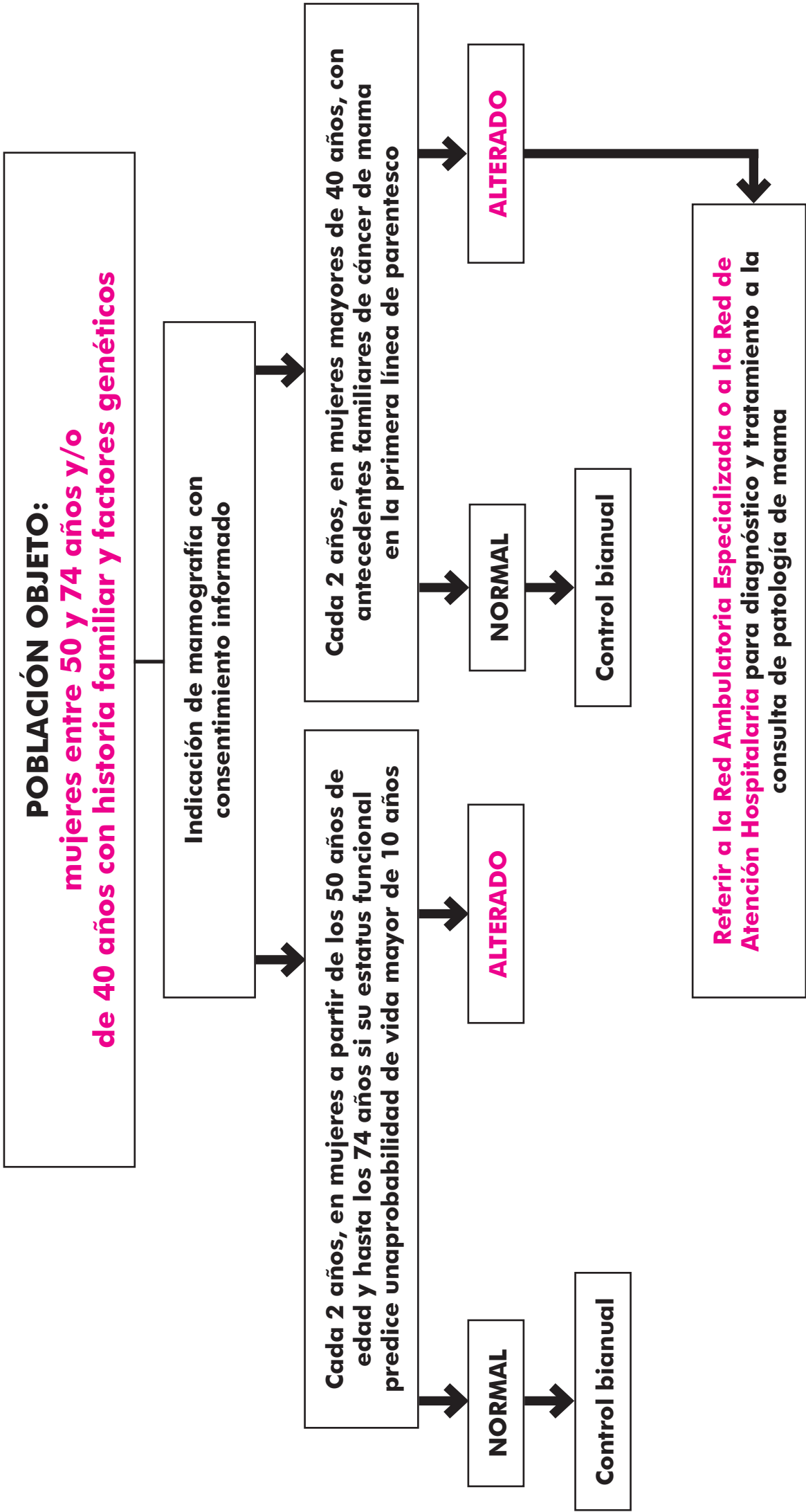
Referencias bibliográficas: 116-118.

ALGORITMO DE PESQUISA DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO





ALGORITMO DE PESQUISA DE CÁNCER DE MAMA



8.13-.- Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo para el manejo y control de las zoonosis (rabia, leptospirosis, accidentes ofídicos)

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
-Comunidades rurales y agrícolas. -Trabajadores agrícolas y pecuarios. -Comunidades en áreas selváticas. -Población en áreas periurbanas. -Personal de salud en contacto con zoonosis. -Población general en áreas endémicas.	-Diagnóstico clínico y pruebas de laboratorio para leptospirosis y rabia en casos sospechosos. -Identificación de factores de riesgo para leptospirosis y contacto con animales sin vacunación. -Diagnóstico de exposición a mordeduras de animales y síntomas de accidentes ofídicos. -Detección de brotes de rabia en animales domésticos y pruebas de laboratorio en casos de contacto sospechoso. -Evaluación de riesgo para el personal de salud en contacto con casos de zoonosis.	-Reducir la incidencia de leptospirosis y rabia humana y canina. -Prevenir la transmisión de leptospirosis y rabia entre trabajadores. -Disminuir la incidencia y mortalidad por accidentes ofídicos. -Prevenir la transmisión de la rabia a través de la vacunación y control animal. -Proteger al personal de salud de la exposición a zoonosis como rabia y leptospirosis. -Educar a niños y adolescentes sobre la prevención de zoonosis en áreas rurales.	- Disminuir en un 30Porcentaje la incidencia de leptospirosis y rabia en comunidades rurales en 5 años. -100Porcentaje de trabajadores en áreas agrícolas y pecuarias capacitados en prevención en 3 años. -Reducir en un 25Porcentaje los accidentes ofídicos en comunidades en áreas selváticas en 5 años. -100Porcentaje de animales domésticos en áreas periurbanas vacunados contra la rabia en 3 años. -100Porcentaje del personal de salud capacitado y con equipos de protección adecuados en 2 años. -Lograr que el 90Porcentaje de los niños y adolescentes en áreas rurales conozcan sobre prevención de zoonosis en 3 años.	-Implementar campañas de vacunación animal contra la rabia, desratización en áreas de alto riesgo, y charlas educativas sobre prevención. -Capacitación en medidas de bioseguridad y prácticas higiénicas para evitar el contacto con roedores y otros animales portadores. -Campañas de educación sobre primeros auxilios en caso de mordeduras de serpientes, y la creación de brigadas de salud para atención rápida en zonas remotas. -Realizar campañas de vacunación antirrábica en animales domésticos (perros y gatos) y capacitación a la población sobre el manejo seguro de animales callejeros. -Capacitación en el uso de equipos de protección personal (EPP), manejo seguro de pacientes infectados, y actualización en protocolos de exposición a zoonosis. -Charlas educativas en escuelas rurales sobre la prevención de zoonosis y el manejo seguro de animales.	-Porcentaje de reducción de casos de leptospirosis y rabia en comunidades rurales. -Porcentaje de trabajadores capacitados en prevención de zoonosis. -Porcentaje de reducción de accidentes ofídicos y Porcentaje de casos atendidos en menos de 2 horas. -Porcentaje de animales vacunados y Porcentaje de reducción de casos de rabia en áreas periurbanas. -Porcentaje de personal de salud capacitado y Porcentaje de reducción de exposiciones a zoonosis.	-Coordinar con autoridades de salud y agricultura para mejorar el control de roedores y la vacunación de animales domésticos. -Integrar la capacitación en bioseguridad en programas de salud ocupacional para trabajadores del sector agrícola. -Priorizar áreas de difícil acceso y fortalecer las redes de emergencia en zonas de alta incidencia de accidentes ofídicos. -Coordinar con gobiernos municipales para asegurar la disponibilidad de vacunas y mejorar el control de animales en situación de calle. -Asegurar la disponibilidad de EPP y actualizaciones periódicas sobre los protocolos de bioseguridad para el personal médico y sanitario en áreas de riesgo. -Involucrar a docentes y padres en las actividades educativas para maximizar la sensibilización en la comunidad sobre la prevención de zoonosis.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
-Comunidades rurales y agrícolas. -Trabajadores agrícolas y pecuarios. -Comunidades en áreas selváticas. -Población en áreas periurbanas. -Personal de salud en contacto con zoonosis. -Población general en áreas endémicas.	-Tamizaje de exposición a roedores y contacto con animales sin vacunación. -Monitoreo de brotes de zoonosis (Rabia, leptospirosis, accidentes ofídicos) y evaluación de riesgos ambientales.	-Crear conciencia sobre la prevención y control de zoonosis en la población general.	-Lograr que el 80% de la población en áreas endémicas conozca las medidas de prevención en 3 años.	-Distribución de material educativo y programas de concientización. -Campañas de información a nivel nacional sobre la prevención de zoonosis, prácticas de higiene en el hogar y el manejo seguro de animales y fauna local.	-Porcentaje de niños y adolescentes informados y reducción en contactos de riesgo. -Porcentaje de población informada y reducción de casos en áreas de alto riesgo.	-Utilizar medios de comunicación y redes sociales para una difusión masiva de las recomendaciones de prevención en áreas con alta incidencia de zoonosis.

Referencias bibliográficas: 119-120.

8.14-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de accidentes y hechos violentos

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Conductores y peatones en áreas urbanas y rurales.	Estadísticas de accidentes de tránsito y evaluaciones de comportamiento vial.	Reducir la incidencia de accidentes de tránsito.	Disminuir en un 20% los accidentes de tránsito en 5 años.	-Implementar campañas de educación vial. -Fortalecer la señalización y mantenimiento de vías. -Realizar operativos de control de velocidad y consumo de alcohol.	-Porcentaje de reducción en accidentes reportados. -Número de campañas realizadas.	Es esencial coordinar con autoridades locales y organizaciones comunitarias para asegurar la efectividad de las intervenciones.
Comunidades en zonas con alta incidencia de violencia.	Reportes policiales y de salud sobre hechos violentos.	Prevenir y reducir los hechos violentos en comunidades vulnerables.	Reducir en un 25% los casos de violencia comunitaria en 3 años.	-Implementar programas de resolución pacífica de conflictos. -Establecer espacios seguros para jóvenes y actividades recreativas. -Fortalecer la presencia policial comunitaria.	-Porcentaje de reducción en casos de violencia. -Número de programas implementados.	Involucrar a líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales en la planificación y ejecución de las actividades.
Trabajadores en sectores de alto riesgo (construcción, manufactura).	Evaluaciones de seguridad laboral y reportes de accidentes laborales.	Mejorar la seguridad laboral y reducir accidentes en el trabajo.	Disminuir en un 15% los accidentes laborales en 2 años.	-Capacitar a trabajadores en prácticas seguras y uso de equipos de protección. -Implementar inspecciones regulares de seguridad en el lugar de trabajo.	-Porcentaje de reducción en accidentes laborales. -Número de trabajadores capacitados.	Es fundamental la colaboración con empleadores y sindicatos para promover una cultura de seguridad laboral.
Estudiantes de educación básica y media.	Evaluaciones de entornos escolares y reportes de incidentes.	Promover entornos escolares seguros y libres de violencia.	Reducir en un 30% los incidentes de violencia escolar en 3 años.	-Implementar programas de educación en valores y convivencia. -Establecer protocolos claros para la prevención y atención de casos de bullying.	-Porcentaje de reducción en incidentes reportados. -Número de programas educativos implementados.	Involucrar a padres, docentes y estudiantes en la creación de un ambiente escolar positivo.
Población general en áreas propensas a desastres naturales.	Evaluaciones de riesgo y planes de emergencia locales.	Fortalecer la resiliencia comunitaria ante desastres naturales.	Lograr que el 90% de las comunidades en riesgo tengan planes de emergencia en 2 años.	-Capacitar a la población en primeros auxilios y respuesta ante emergencias. -Desarrollar simulacros de evacuación y planes comunitarios de respuesta.	-Porcentaje de comunidades con planes de emergencia. -Número de personas capacitadas.	Es crucial la coordinación con organismos de protección civil y autoridades locales para la implementación efectiva de las actividades.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Trabajadores de la industria manufacturera y construcción	Evaluaciones médicas periódicas que incluyan: pruebas de función pulmonar, audiometrías, y análisis de exposición a sustancias químicas.	Identificar y reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y auditivas ocupacionales.	Disminuir en un 15% los casos de enfermedades respiratorias y auditivas en 3 años.	-Implementar programas de monitoreo ambiental en el lugar de trabajo. -Proporcionar equipos de protección personal (EPP) adecuados. -Capacitar a los trabajadores en prácticas seguras y uso correcto de EPP.	-Porcentaje de reducción en casos reportados. -Número de trabajadores capacitados.	Es esencial realizar seguimiento continuo y ajustar las medidas según los resultados obtenidos.
Personal de salud en hospitales y clínicas	Evaluaciones de salud que incluyan pruebas de detección de enfermedades infecciosas y análisis de estrés laboral.	Prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas y reducir el estrés laboral.	Lograr que el 100% del personal de salud reciba formación en prevención de infecciones y manejo del estrés en 2 años.	-Implementar protocolos de bioseguridad estrictos. -Ofrecer talleres de manejo del estrés y autocuidado. -Proporcionar acceso a servicios de apoyo psicológico.	-Porcentaje de personal capacitado. -Número de talleres realizados.	Fomentar una cultura organizacional que priorice la salud mental y el bienestar del personal.
Trabajadores agrícolas y ganaderos	Exámenes médicos que incluyan pruebas de función hepática y renal, y detección de intoxicaciones por pesticidas.	Reducir la exposición a pesticidas y prevenir intoxicaciones.	Capacitar al 90% de los trabajadores en el uso seguro de pesticidas en 2 años.	-Realizar campañas de educación sobre manejo seguro de agroquímicos. -Promover el uso de alternativas menos tóxicas y prácticas agrícolas sostenibles.	-Porcentaje de trabajadores capacitados. -Incidencia de casos de intoxicación reportados.	Involucrar a las comunidades y líderes locales para asegurar la adopción de prácticas seguras.
Empleados de oficinas y centros de atención al cliente	Evaluaciones ergonómicas y análisis de quejas musculoesqueléticas.	Prevenir trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo.	Reducir en un 20% las quejas relacionadas con ergonomía en 3 años.	-Implementar programas de ergonomía laboral. -Proporcionar mobiliario adecuado y ajustable. -Ofrecer pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.	-Porcentaje de reducción en quejas reportadas. -Número de estaciones de trabajo adaptadas ergonómicamente.	Es fundamental realizar evaluaciones periódicas y ajustar las medidas según las necesidades de los trabajadores.
Conductores de transporte público y de carga	Evaluaciones médicas que incluyan pruebas de visión, audición y detección de trastornos del sueño.	Mejorar la salud y seguridad de los conductores para prevenir accidentes laborales.	Lograr que el 95% de los conductores reciban evaluaciones médicas anuales en 2 años.	-Implementar programas de salud ocupacional específicos para conductores. -Ofrecer talleres sobre hábitos de vida saludables y manejo del estrés.	-Porcentaje de conductores evaluados médicamente. -Incidencia de accidentes laborales relacionados con la salud.	Coordinar con empresas de transporte y sindicatos para facilitar la participación en los programas.

Referencias bibliográficas: 122 - 125.

8.15-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de enfermedades tropicales (chagas, dengue, malaria, paludismo, toxoplasmosis)

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Enfermedad de Chagas: Poblaciones en áreas endémicas, especialmente en viviendas precarias.	Serología (ELISA, HAI); microscopía en fase aguda.	Reducir la transmisión vectorial y congénita.	Disminuir en 50% la incidencia para 2030.	-Control de vectores (fumigación). -Mejora de viviendas. -Tamizaje en bancos de sangre y embarazadas.	-Número de viviendas intervenidas. -Casos nuevos reportados.	La educación comunitaria es esencial para la prevención.
Dengue: Población general en zonas endémica.	Detección de antígenos NS1 ; serología IgM/IgG; PCR en tiempo real.	Disminuir la incidencia y mortalidad.	Reducir en 25% la incidencia para 2030.	-Eliminación de criaderos de mosquitos. -Campañas de sensibilización. -Vigilancia epidemiológica activa.	Índice de infestación de Aedes aegypti. -Tasa de incidencia de dengue.	La participación comunitaria es clave en el control del vector.
Malaria: Poblaciones en regiones endémicas y viajeros a estas zonas.	Gota gruesa; prueba rápida de diagnóstico; PCR.	Eliminar la transmisión local.	Reducir en 75% los casos autóctonos para 2030.	-Distribución de mosquiteros impregnados. -Fumigación intradomiciliaria. -Tratamiento oportuno de casos.	-Porcentaje de hogares con mosquiteros. -Número de casos autóctonos.	La resistencia a antimaláricos debe ser monitoreada constantemente.
Toxoplasmosis: Mujeres embarazadas; inmunodeprimidos.	Serología (IgM, IgG); PCR en casos específicos.	Prevenir infecciones congénitas y en inmunodeprimidos.	Tamizaje del 80% de embarazadas para 2030.	-Educación sobre manejo de alimentos. -Control de poblaciones felinas. -Tamizaje prenatal.	-Porcentaje de embarazadas tamizadas. -Casos de toxoplasmosis congénita.	La higiene alimentaria es fundamental en la prevención.

Referencias bibliográficas: 126-130.

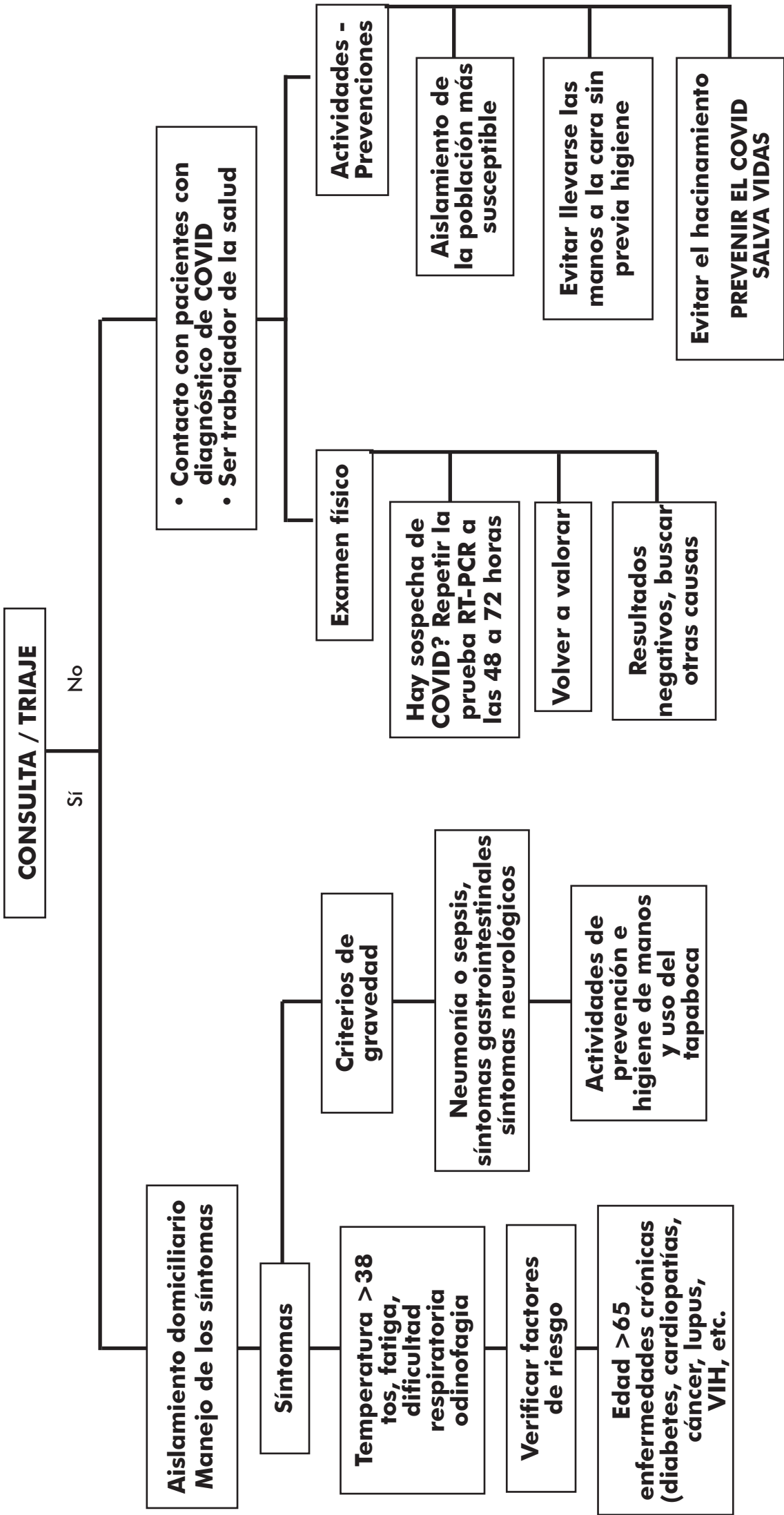
8.16-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de infecciones por coronavirus

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Población general.	Síntomas respiratorios agudos como tos, fiebre, dificultad para respirar; contacto con casos confirmados de COVID-19; resultados positivos en pruebas de detección del virus	Reducir la transmisión comunitaria del coronavirus.	Disminuir en un 50% los casos nuevos en un período de 6 meses.	-Promover el uso adecuado de mascarillas. -Fomentar el distanciamiento físico de al menos 1 metro. -Implementar campañas de higiene de manos. -Capacitación en el uso correcto de EPP -Establecer protocolos de prevención y control de infecciones (PCI). -Proveer acceso a EPP de calidad.	-Tasa de incidencia de casos nuevos. -Porcentaje de uso de mascarillas en espacios públicos. -Número de campañas educativas realizadas.	La OMS recomienda evitar las "tres C": espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos.
Personal de salud.	Exposición a pacientes con COVID-19; síntomas compatibles; resultados positivos en pruebas diagnósticas.	Proteger al personal de salud y prevenir brotes nosocomiales.	Lograr que el 100% del personal utilice equipos de protección personal (EPP) adecuados.	-Realizar pruebas masivas y periódicas. -Aislar casos confirmados y sospechosos. -Mejorar la ventilación y desinfección de espacios.	-Porcentaje de personal capacitado. -Disponibilidad de EPP en unidades de salud. -Número de infecciones nosocomiales registradas.	La OMS destaca la importancia de la higiene de manos y otras prácticas eficaces para prevenir infecciones.
Personas en instituciones cerradas (asilos, cárceles, etc.).	Presencia de casos confirmados o sospechosos dentro de la institución; síntomas respiratorios en residentes.	Prevenir brotes en instituciones cerradas.	Implementar medidas de control en el 100% de las instituciones identificadas.		-Número de brotes en instituciones. -Porcentaje de instituciones con protocolos activos. -Tasa de positividad en pruebas realizadas.	La ventilación adecuada es esencial para reducir la transmisión en espacios cerrados.
Personas con enfermedades crónicas y adultos mayores.	Diagnóstico previo de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias; edad superior a 60 años.	Reducir la morbilidad y mortalidad en grupos vulnerables.	Vacunar al 90% de esta población en un período de 6 meses.	-Priorizar la vacunación en estos grupos. -Proveer información sobre medidas de protección adicionales. -Facilitar acceso a servicios médicos.	-Porcentaje de vacunación en el grupo objetivo. -Tasa de hospitalización y mortalidad en estos grupos.	La OMS enfatiza la protección de los más vulnerables para salvar vidas. La OMS pide evitar las "tres C": espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Viajeros internacionales.	Historial de viajes a zonas con alta transmisión; síntomas compatibles al ingreso al país.	Prevenir la importación y exportación de casos.	Implementar controles en el 100% de los puntos de entrada internacionales.	-Establecer puntos de control sanitario en aeropuertos y fronteras. -Requerir pruebas negativas antes del ingreso. -Implementar cuarentenas cuando sea necesario.	-Número de casos detectados en puntos de entrada. -Porcentaje de viajeros cumplidores de protocolos.	La OMS recomienda medidas específicas para viajeros según la situación epidemiológica.

Elaboración propia con base en las referencias 131-132.

ALGORITMO DEL COVID-19



8.17-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y manejo de la salud mental

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
-Población en general. -Población con riesgo de presentar trastornos y enfermedades mentales, riesgo suicida y adicciones.	.Niños, adolescentes, adultos y ancianos en hogares disfuncionales. -Enfermos Psiquiátricos (trastorno bipolar, esquizofrenia). -Alcohólicos o con riesgo según criterios de cantidad y frecuencia. -Adictos (psicofármacos, marihuana, opioides, cocina y derivados). -Suicidas, (comportamiento suicida y riesgo suicida). -Abandono y disfunción familiar.	-Contribuir a garantizar el derecho a la salud mental de los venezolanos. -Potenciar capacidades, en individuos y colectivos, para mantenerse sanos, mediante la Promoción de la Salud Mental. -Participación de la comunidad y de los demás sectores del área, sobre los factores de riesgo determinantes que conllevan al desarrollo de enfermedades mentales, suicidio y adicciones. -Fortalecer la atención para el manejo y control de las Enfermedades Mentales, suicidio y las Adicciones, desde la etapa pre clínica hasta la rehabilitación, contando con la participación y corresponsabilidad de la familia y la comunidad. -Desarrollar el Sistema de Información en Salud Mental, que contemple la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Mentales, Suicidio y Adicciones, sus factores protectores de vida y los factores de riesgo de estas patologías.	-La Línea de Atención en Salud Mental. -Diagnóstico del 100% de enfermedades mentales. -La atención de la salud mental deberá incluirse en la cobertura de salud del programa. -Los tratamientos psicológicos, los medicamentos y las intervenciones del estilo de vida deben incluirse en los beneficios del programa. Incentivar la investigación epidemiológica y social, en el área de la Salud Mental	-Potenciar capacidades, en individuos y colectivos, para mantenerse sanos, mediante la Promoción de la Salud Mental. -Detección precoz de trastornos, enfermedades mentales, riesgo suicida, suicidio y adicciones en consultas de primer nivel de atención, familias, escuelas, centros de trabajo y comunidades del área de influencia del establecimiento de atención primaria. -Diseño y ejecución prácticas colectivas que inciden sobre el desarrollo saludable de la personalidad, incluyendo la cultura del amor y la solidaridad humana, la satisfacción adecuada de las necesidades, la actividad física y el esparcimiento, el automanejo adecuado del stress y su control colectivo en sociedad, con la participación de la comunidad. -Identificación de factores predisponentes de trastornos, enfermedades mentales riesgo suicida, suicidio y adicciones. en consultas de primer nivel de atención, familias, escuelas, centros de trabajo y comunidades del área de influencia del establecimiento de atención primaria. -Identificación de trastornos, enfermedades, riesgo suicida, suicidio y adicciones. mentales en todas las etapas del ciclo de vida, en la familia, en las consultas de primer nivel de Atención y el resto de la red de servicios, con énfasis en la población infanto-juvenil y mayores de 60 años. -Capacitación continúa del personal en las pautas y procedimientos del Programa.	-Generación de procesos de transformación cultural. -Modificación de hábitos y estilos de vida que puedan afectar la salud mental, propiciar adicciones y riesgos suicidas.	

Referencias bibliográficas: 101 - 105.

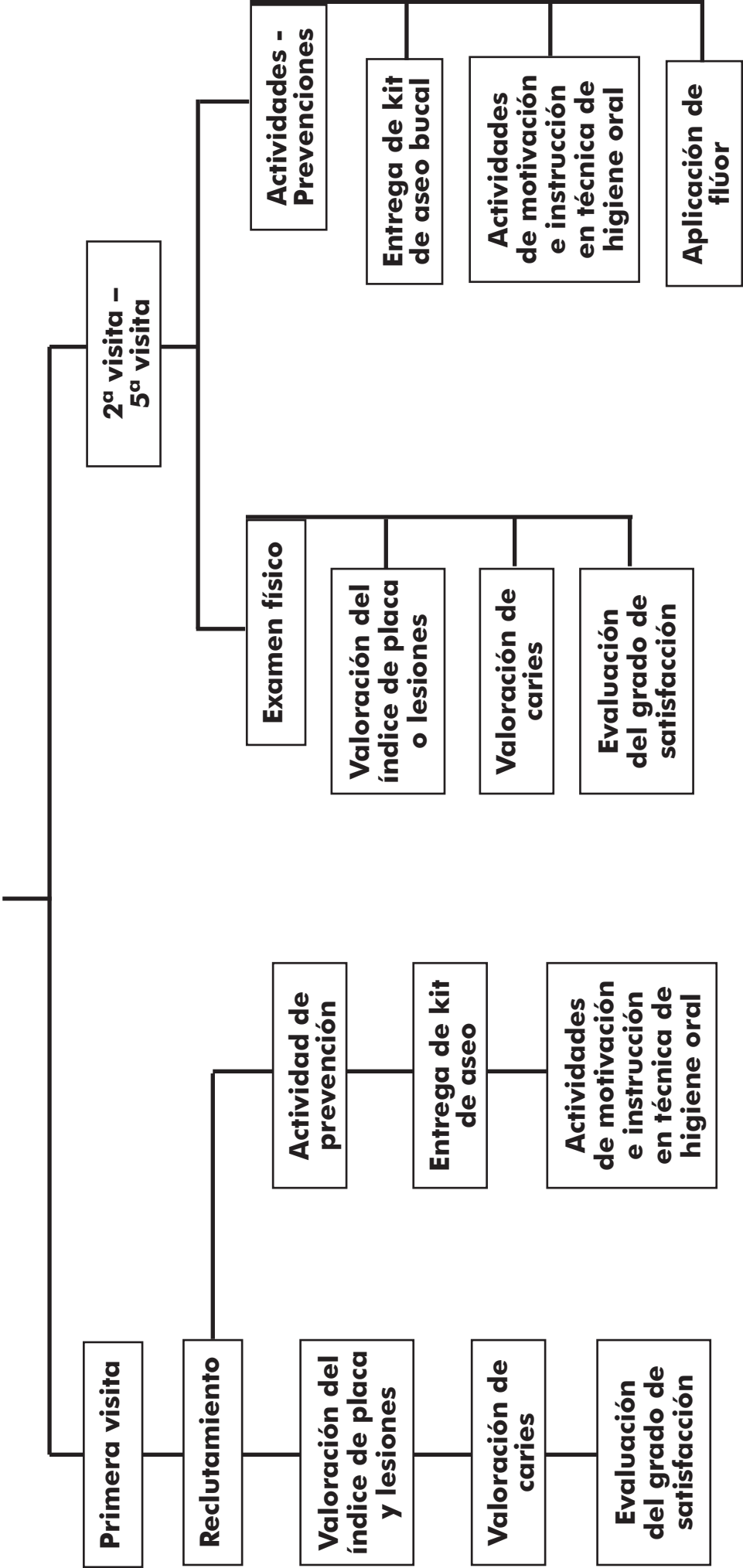
8.18--. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y manejo de la salud bucal

Población	Criterio DX	Objetivo	Metas	Actividades	Observaciones
Va dirigido a toda la población del área de influencia niños, adolescentes, adultos y tercera edad.	-Realizar historia clínica odontológica, donde se recojan datos de pesquisas de caries y prótesis dentales, se investigue modo y estilo de vida, tipo de alimentación, hábitos de higiene bucal, paladar hendido. -Chequeo anual preventivo de salud bucal y tratamiento.	-Fortalecer a través de la información y educación el autocuidado bucal. -Difundir, educar y comunicar conocimientos dirigido a una mejor salud bucal, detectando las principales enfermedades bucodentales. -Capacitación continua del área y de todo el personal de la misma. -Bridar atención odontológica interna para la detección temprana de placas bacterianas y lesiones benignas. -Consolidar un sistema de información sencillo que llegue a los usuarios del servicio.	Fortalecer todo lo relacionado con salud bucal, relativo a la promoción de estilo y condiciones de vida, prevención y tratamiento de las enfermedades bucales y su rehabilitación.	-Realizar promoción y prevención a nivel familiar y educacional sobre la salud bucal (charlas y consultas). -Realizar charlas educativas e informativas para mejorar el régimen alimentario e higiene bucal. -Realizar en los planteles de educación charlas de promoción y prevención de enfermedades bucales con la finalidad de mantener salud bucal. -Vigilar y controlar el proceso de fluoración de la sal. -Brindar los cuidados primarios, la restauración y rehabilitación a los usuarios del servicio. -Realizar atención oportuna de las urgencias, con sistemas efectivos de referencia y contrarreferencia. -Capacitación continua del personal de atención de salud bucal.	Este programa va dirigido a toda la población del área de influencia, pero en especial a la de 0-14 años, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, tercera edad y población indígena.

Referencias bibliográficas: 101 - 105.

ALGORITMO DE SALUD BUCAL

CRONOGRAMA



8.19-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y manejo de adicciones

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
-Población en general. -Población con riesgo de presentar trastornos y enfermedades mentales, riesgo suicida y adicciones	-Niños, adolescentes, adultos y ancianos en hogares disfuncionales. -Enfermos Psiquiátricos (trastorno bipolar, esquizofrenia). -Alcohólicos o con riesgo según criterios de cantidad y frecuencia. -Adictos (psicofármacos, marihuana, opioides, cocina y derivados). -Suicidas, comportamiento suicida y riesgo suicida). -Abandono y disfunción familiar.	-Contribuir a garantizar el derecho a la salud mental de los venezolanos. -Potenciar capacidades, en individuos y colectivos, para mantenerse sanos, mediante la Promoción de la Salud Mental. -Participación de la comunidad y de los demás sectores del área, sobre los factores de riesgo determinantes que conllevan al desarrollo de enfermedades mentales, suicidio y adicciones. -Fortalecer la Atención para el manejo y control de las Enfermedades Mentales, suicidio y las Adicciones, desde la etapa pre clínica hasta la rehabilitación, contando con la participación y corresponsabilidad de la familia y la comunidad. -Desarrollar el Sistema Información en Salud Mental, que contemple la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Mentales, suicidio y Adicciones, sus factores protectores de vida y los factores de riesgo de estas patologías.	-La Línea de Atención en Salud Mental. -Diagnóstico del 100% de enfermedades mentales. -La atención de la salud mental deberá incluirse en la cobertura de salud del programa. -Los tratamientos psicológicos, los medicamentos y las intervenciones del estilo de vida deben incluirse en los beneficios del programa. -Incentivar la investigación epidemiológica y social, en el área de la Salud Mental.	-Potenciar capacidades, en individuos y colectivos, para mantenerse sanos, mediante la Promoción de la Salud Mental. -Detección precoz de trastornos, enfermedades mentales, riesgo suicida, suicidio y adicciones en consultas de primer nivel de atención, familias, escuelas, centros de trabajo y comunidades del área de influencia del establecimiento de atención primaria. -Diseño y ejecución prácticas colectivas que inciden sobre el desarrollo saludable de la personalidad, incluyendo la cultura del amor y la solidaridad humana, la satisfacción adecuada de las necesidades, la actividad física y el esparcimiento, el automanejo adecuado del stress y su control colectivo en sociedad, con la participación de la comunidad. -Identificación de factores predisponentes de trastornos, enfermedades mentales riesgo suicida, suicidio y adicciones. en consultas de primer nivel de atención, familias, escuelas, centros de trabajo y comunidades del área de influencia del establecimiento de atención primaria. -Identificación de trastornos, enfermedades, riesgo suicida, suicidio y adicciones. mentales en todas las etapas del ciclo de vida, en la familia, en las consultas de primer nivel de Atención y el resto de la red de servicios, con énfasis en la población infanto-juvenil y mayores de 60 años. -Capacitación continúa del personal en las pautas y procedimientos del Programa.	-Generación de procesos de transformación cultural. -Modificación de hábitos y estilos de vida que puedan afectar la salud mental, propiciar adicciones y riesgos suicidas.	

Referencias bibliográficas: 101 - 105.

8.20-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control nutricional

Población	Criterio DX	Objetivo	Metas	Actividades	Observaciones
Va dirigido a toda la población del área de influencia niños, adolescentes, adultos, embarazadas y la tercera edad, tengan estés alguna patología o no.	-Realizar historia nutricional donde se recojan datos, como peso talla y mediciones corporales para conocer la distribución de masa y grasa corporal, valores bioquímicos y clínicos que permitan determinar deficiencias nutricionales en el paciente. -Revisión de pacientes por consulta sucesiva o consulta de primera vez.	-Brindar asistencia y control nutricional para disminuir el índice de cualquier enfermedad de índole alimentario dentro del área de influencia. -Difundir, educar y comunicar la importancia y consecuencias de no tener una alimentación saludable. -Capacitación continua del área y de todo el personal de la misma. -Bridar atención nutricional a pacientes con déficit o aumento de peso, hipertensión diabetes, enfermedades metabólicas y todas aquellas no transmisibles que tengan relación con la conducta alimentaria. -Consolidar un sistema de información sencillo y continuo que promueva la asistencia a control nutricional.	Afianzar la importancia de una alimentación saludable y controlada para el bienestar de la salud nutricional en cualquier etapa de la vida y cualquier patología encontrada en los pacientes del área de influencia que garantiza la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos planteados por el programa.	-Realizar promoción del servicio de atención nutricional (sesiones educativas y consultas). -Realizar jornadas de evaluación nutricional para motivar a las personas a su chequeo y control nutricional. -Realizar en las instituciones educativas jornadas de educación promoción y prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. -Vigilar y controlar la evolución de cada paciente o cada grupo familiar atendido. -Realizar atención oportuna de las urgencias, con sistemas efectivos de remisión a cualquier especialidad que requiera la patología del paciente. -Capacitación continua del personal en relación a los pasos a seguir para la atención control nutricional.	Este programa va dirigido a toda la población del área de influencia, pero en especial a poblaciones vulnerables como niños y adolescentes entre 0-14 años, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, tercera edad y población indígena.

Elaboración propia con base en las referencias 101-105.

8.21-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de salud ambiental

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Comunidad en general, especialmente zonas urbanas con alta densidad poblacional.	Alta exposición a contaminantes ambientales (aire, agua, residuos) y nivel de afectación por enfermedades respiratorias y dérmicas.	Reducir los niveles de exposición a contaminantes ambientales y mejorar la calidad de vida.	Reducción del 20% de casos de enfermedades relacionadas a la exposición ambiental en 5 años.	Campañas de concientización, jornadas de limpieza, instalación de estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Número de estaciones de monitoreo instaladas, cantidad de campañas realizadas.	Fomentar la participación comunitaria para sostenibilidad.
Trabajadores de la salud y empleados en instalaciones públicas.	Evaluación de los niveles de exposición a agentes biológicos y químicos en el ambiente de trabajo.	Mejorar las condiciones ambientales de los espacios de trabajo en el sector público.	Reducir el riesgo de exposición en un 30% en los próximos 3 años.	Implementar el uso de EPP adecuado, capacitación sobre manejo de agentes, auditorías ambientales periódicas.	Número de capacitaciones realizadas, porcentaje de uso de EPP, resultados de auditorías.	Integrar el plan con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.
Estudiantes de centros educativos en áreas de alto riesgo ambiental.	Índices de contaminación en áreas cercanas y niveles de enfermedades respiratorias o dérmicas.	Promover un ambiente escolar saludable y reducir el impacto de la contaminación en la salud infantil.	Disminución de casos de enfermedades respiratorias en estudiantes en un 15% en 2 años.	Monitoreo ambiental en las escuelas, campañas de educación ambiental, creación de espacios verdes.	Cantidad de monitoreos realizados, nivel de participación estudiantil, número de espacios verdes creados.	Involucrar a las comunidades educativas en la gestión ambiental.
Poblaciones vulnerables (niños, ancianos y personas con condiciones preexistentes) en zonas industriales y rurales.	Altos índices de morbilidad por contaminación del aire y agua, casos de enfermedades crónicas asociadas.	Minimizar la exposición a contaminantes industriales y mejorar las condiciones ambientales locales.	Reducción del 25% en enfermedades asociadas en un plazo de 5 años.	Medición periódica de calidad del agua y del aire, campañas de sensibilización en el manejo de residuos, programas de salud preventiva.	Resultados de monitoreo de calidad del agua y aire, participación en campañas, acceso a servicios de salud preventiva.	Fomentar el empoderamiento comunitario para asegurar continuidad en el tiempo.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Residentes en áreas con problemas de saneamiento.	Detección de enfermedades de origen hídrico y alto nivel de contaminación por desechos sólidos.	Garantizar un ambiente saludable mediante la mejora del saneamiento y manejo de residuos.	Reducción del 50% de enfermedades de origen hídrico en 3 años.	Implementar sistemas de saneamiento, campañas de educación sobre manejo de residuos, apoyo a la construcción de infraestructura adecuada.	Cantidad de sistemas de saneamiento implementados, reducción en enfermedades de origen hídrico.	Requiere colaboración interinstitucional y comunitaria para mantener infraestructura
Usuarios y trabajadores de servicios de salud en áreas afectadas por vectores.	Niveles de infestación de vectores en hospitales y centros de salud.	Reducir la propagación de enfermedades vectoriales dentro y fuera de los centros de salud.	Lograr la disminución de enfermedades vectoriales en un 30% en 2 años.	Campañas de fumigación, instalación de redes protectoras, monitoreo de vectores en espacios críticos.	Número de fumigaciones realizadas, reducción de vectores en centros de salud.	Coordinar con autoridades locales y nacionales para continuidad de campañas.

Referencias bibliográficas: 133-135.

8.22-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención y control de los trastornos del neurodesarrollo

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Niños y adolescentes de 0-18 años.	Diagnóstico según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) y la CIE-11.	Reducir la prevalencia de trastornos del neurodesarrollo en la población infantil.	Identificar al menos el 70% de los casos en etapa inicial.	-Capacitar al personal médico y educativo en detección temprana. -Realizar tamizajes en centros educativos y pediátricos.	-Porcentaje de niños tamizados anualmente. -Porcentaje de niños diagnosticados en etapa temprana.	Realizar actualización anual de criterios diagnósticos.
Madres embarazadas y población femenina en edad fértil.	Criterios de riesgo según historia médica, antecedentes familiares y factores sociales.	Promover el cuidado prenatal adecuado para reducir factores de riesgo de trastornos del neurodesarrollo.	90% de embarazadas con acceso a servicios de salud prenatal 70% con atención temprana en caso de diagnóstico.	-Promover campañas de educación prenatal. -Implementar controles prenatales regulares. -Realizar tamizaje de riesgos genéticos	-Porcentaje de mujeres embarazadas con controles prenatales. -Porcentaje de identificación de riesgos prenatales.	Fomentar la inclusión de factores de riesgo en registros médicos.
Profesores y personal educativo.	Conocimiento de signos tempranos de trastornos del neurodesarrollo.	Crear conciencia y habilidades para la identificación temprana en el entorno educativo.	90% de instituciones educativas con personal capacitado 70% de docentes con herramientas de detección.	-Desarrollar talleres de formación para educadores. -Proporcionar guías y protocolos de actuación para detección en el aula. -Establecer comunicación entre escuelas y servicios de salud.	-Porcentaje de personal educativo capacitado. -Porcentaje de niños referidos por docentes. -Cantidad de talleres realizados.	Revisión y actualización bianual de programas de capacitación educativa.
Sistema de salud pública.	Diagnóstico clínico basado en guías OMS y del Ministerio de Salud de Venezuela.	Fortalecer la capacidad del sistema de salud para atender adecuadamente a niños con trastornos del neurodesarrollo.	Establecer al menos un centro de atención en cada región con recursos para atención especializada.	-Establecer unidades de atención multidisciplinarias en centros de salud pública. -Capacitar a personal en intervenciones especializadas. -Proveer medicación y apoyo terapéutico adecuado.	-Porcentaje de unidades de atención establecidas. -Porcentaje de personal de salud capacitado en intervenciones. -Acceso a medicación y terapia	Establecer un sistema de monitoreo para la eficiencia en el uso de recursos y tiempos de atención.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Familias y cuidadores.	Criterios de apoyo familiar según guías de OMS.	Brindar apoyo psicosocial y orientación a familias de niños con trastornos del neurodesarrollo.	.90% de familias de niños con diagnóstico reciben apoyo psicosocial. -Acceso a redes de apoyo comunitario.	-Organizar grupos de apoyo y talleres familiares. -Proveer orientación sobre estrategias de intervención en casa. -Establecer redes de apoyo con centros de salud y servicios educativos.	-Porcentaje de familias que participan en talleres. -Cantidad de grupos de apoyo establecidos. -Porcentaje de seguimiento familiar realizado.	Asegurar la sostenibilidad de grupos de apoyo y redes comunitarias.
Comunidad en general.	Fomento de la concientización sobre los trastornos del neurodesarrollo.	Sensibilizar a la comunidad para reducir el estigma asociado a los trastornos del neurodesarrollo.	70% de la comunidad informada a través de campañas de concientización.	-Realizar campañas de concientización en medios de comunicación. -Organizar eventos educativos comunitarios. -Implementar actividades informativas en centros comunitarios y de salud.	-Porcentaje de campañas realizadas. -Porcentaje de personas alcanzadas por campañas. -Porcentaje de participación en eventos comunitarios.	Evaluar anualmente el impacto de las campañas a nivel comunitario.

Referencias bibliográficas: 136-138.

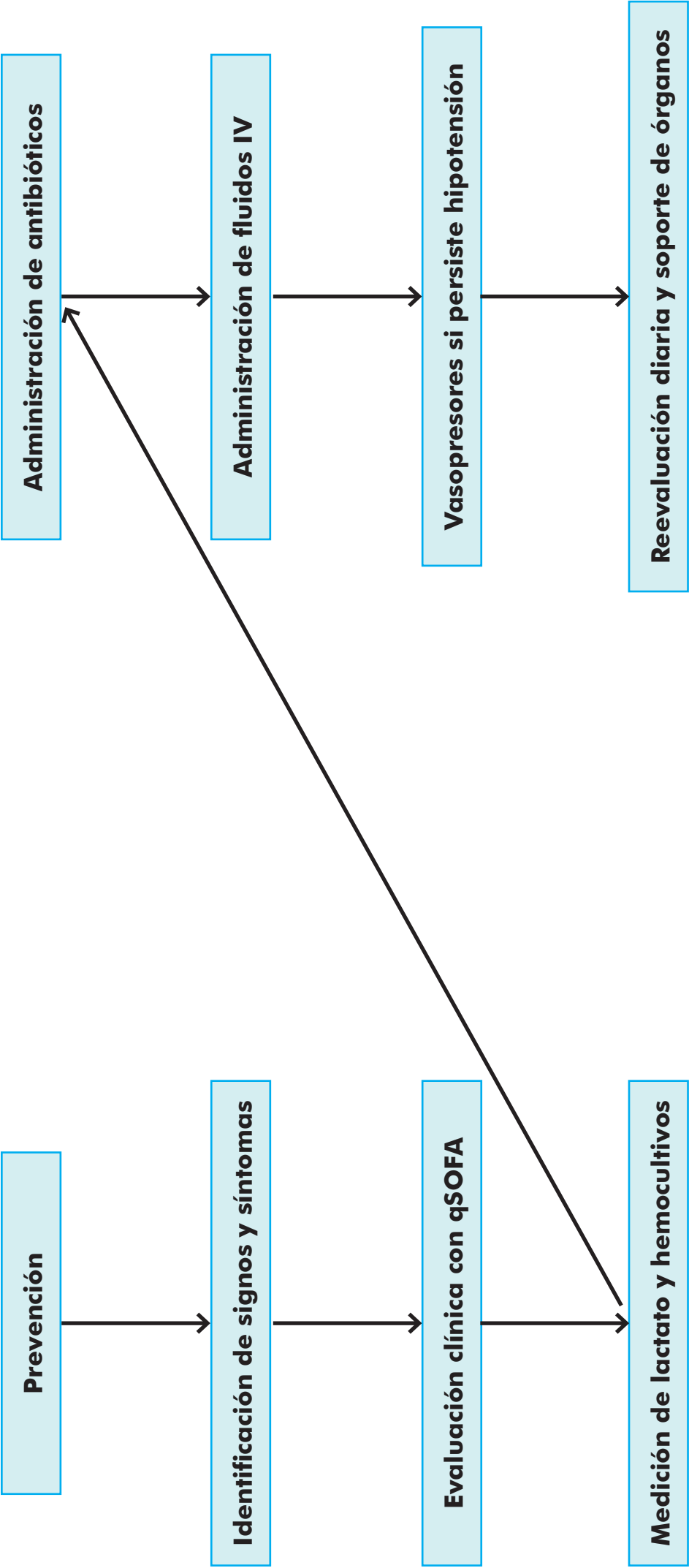
8.23-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan de prevención, diagnóstico y manejo precoz de la sepsis

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
-Comunidad en general. -Pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, EPOC, enfermedades cardiovasculares). -Adultos mayores (65+ años) y neonatos. -Pacientes hospitalizados con infecciones (neumonía, infecciones de heridas, etc.). -Mujeres embarazadas y posparto.	-Signos de infección y criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS): frecuencia cardíaca elevada, fiebre o hipotermia, frecuencia respiratoria aumentada, leucocitosis o leucopenia. -Evaluación de síntomas como fiebre, dolor, confusión, signos de infección en pacientes con condiciones crónicas. -Identificación de síntomas inespecíficos de sepsis: confusión en adultos mayores, hipotermia en neonatos. -Identificación temprana de sepsis en pacientes con infecciones confirmadas y criterios de SIRS.	-Detectar y tratar la sepsis en etapas iniciales para mejorar el pronóstico. -Reducir el riesgo de sepsis en pacientes con enfermedades crónicas. -Aumentar la identificación precoz de sepsis en grupos vulnerables. -Prevenir el desarrollo de sepsis en pacientes con infecciones hospitalarias. -Prevenir sepsis en el contexto del embarazo y posparto. -Aumentar la detección temprana de sepsis en niños con infecciones comunes. -Concienciar a la población sobre la importancia de la detección y manejo temprano de sepsis.	-Reducir la mortalidad por sepsis en un 20% en áreas de alto riesgo. -80% de pacientes crónicos evaluados para sepsis en cada consulta o ingreso. -90% de adultos mayores y neonatos con sospecha de sepsis evaluados en las primeras 3 horas. -70% de reducción de casos de sepsis en pacientes hospitalizados con infecciones. -100% de mujeres con signos de infección en embarazo evaluadas para sepsis. -90% de niños con infecciones y síntomas de sepsis evaluados en las primeras 2 horas de consulta. -Aumentar el conocimiento de la población sobre sepsis en un 50%.	-Realizar higiene de manos adecuada y frecuente para prevenir infecciones. -Asegurar la inmunización contra patógenos comunes que pueden causar sepsis, como neumococos e influenza. -Tratar de manera oportuna y adecuada las infecciones locales para evitar su progresión a sepsis. -Mantener técnicas asépticas en la inserción y manejo de catéteres y otros dispositivos invasivos. -Estar alerta a síntomas como fiebre, frecuencia cardíaca elevada, respiración rápida, confusión y disminución de la producción de orina. -Utilizar herramientas como el qSOFA y SOFA para identificar pacientes en riesgo. -Iniciar lo antes posible antibióticos de amplio espectro tras la obtención de muestras para cultivos. Extraer al menos dos conjuntos de hemocultivos antes de iniciar la terapia antibiótica. -Medición de lactato sérico para detectar hipoperfusión tisular. -Aplicar precozmente hipotensores si la hipotensión persiste después de la administración de fluidos para mantener una presión arterial media (PAM) $\geq$ 65 mmHg. -Reevaluar el estado hemodinámico: Monitorear signos vitales, producción de orina y repetir la medición de lactato si estaba elevado inicialmente.	-Tasa de mortalidad por sepsis en áreas de alto riesgo. -Porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas evaluados para sepsis. -Tiempo promedio de detección desde la presentación de los síntomas hasta el diagnóstico. -Tasa de incidencia de sepsis en pacientes con infecciones confirmadas. -Porcentaje de mujeres embarazadas y posparto evaluadas para sepsis ante signos de infección. -Tiempo promedio de evaluación desde el ingreso hasta el diagnóstico en pediatría. -Nivel de conocimiento de la comunidad sobre los síntomas y riesgos de sepsis.	-Realizar auditorías regulares para evaluar el cumplimiento del protocolo de detección. -Monitorear de cerca las tasas de infección en esta población. -Realizar controles continuos en pacientes de alto riesgo en estos grupos etarios. -Capacitación continua del personal en manejo de infecciones hospitalarias y prevención de sepsis. -Realizar auditorías mensuales para garantizar la evaluación de sepsis en esta población.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
-Comunidad en general. -Pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, EPOC, enfermedades cardiovasculares). -Adultos mayores (65+ años) y neonatos. -Pacientes hospitalizados con infecciones (neumonía, infecciones de heridas, etc.). -Mujeres embarazadas y posparto.	-Monitoreo de fiebre, dolor abdominal, frecuencia cardíaca y otros signos de infección en el contexto perinatal. -Identificación de sepsis a través de síntomas como dificultad respiratoria, fiebre persistente, letargo. Fiebre, dolor, signos de infección o respuesta inflamatoria en cualquier contexto.			-Reevaluar diariamente la necesidad de continuar con antibióticos y ajustar el tratamiento según los resultados de cultivos y la evolución clínica. -Prevenir las complicaciones, implementando precozmente medidas para prevenir trombosis venosa profunda, úlceras por presión y otras complicaciones asociadas. -Implementar protocolos de detección temprana, capacitar al personal en reconocer signos de sepsis. -Incorporar la evaluación de síntomas de sepsis en cada consulta de pacientes con enfermedades crónicas. -Capacitación en detección de síntomas atípicos de sepsis en poblaciones vulnerables, con énfasis en adultos mayores y neonatos. -Implementar protocolos de monitoreo frecuente en pacientes con infecciones hospitalarias y establecer un plan de manejo rápido. -Incluir la evaluación de sepsis en el protocolo de manejo de infecciones en el embarazo y el posparto. -Capacitar a pediatras y personal de enfermería en la detección temprana de signos de sepsis en niños con infecciones respiratorias o de piel. -Realizar campañas de educación en la comunidad sobre los signos y riesgos de la sepsis y cuándo buscar ayuda médica.		-Mantener protocolos de detección rápida en áreas de pediatría y urgencias. -Incluir medios de comunicación y redes sociales en las campañas de concienciación para alcanzar a un público amplio.

Referencias bibliográficas: 139-141.

ALGORITMO GRÁFICO PARA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO PRECOZ DE LA SEPSIS



8.24-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan preventivo de atención a la ciudadanía

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Personas.	Realizar una evaluación individual de la situación social, aislamiento emocional y de salud de la persona, identificando factores de riesgo psicosocial y necesidades específicas.	-Promover el bienestar biopsicosocial-espiritual de la persona, mediante un enfoque holístico, y fomentar el autocuidado. -Fortalecer los recursos personales para que el individuo desarrolle una adaptación positiva ante situaciones de crisis o dificultades.	Lograr que el 75% de los usuarios atendidos presenten mejoras en su bienestar biopsicosocial y espiritual.	-Investigar sobre los factores psicosociales que inciden en la salud de la persona y en el tratamiento de los problemas que surgen con relación a las situaciones de enfermedad. -Completar el diagnóstico con la dimensión social. -Evaluación inicial y diagnóstico social. -Realizar evaluaciones, exámenes psicosociales y espirituales iniciales y, hacer derivaciones para terapia individual, familiar o grupal si es necesario. -Estudiar a la persona e identificar las redes de relaciones (familia, institución, situación de marginación o exclusión). -Elaborar informes sociales y visitas a las personas y organismos según el caso. -Identificar factores que ponen a las personas en riesgo de sufrir violencia. -Realizar remisión de la persona de acuerdo a la situación-problema social. -Brindar protección a las personas de sufrir violencia como víctima o perpetrador. -Elaborar estrategias que modifiquen los factores de riesgo y protección para evitar que se produzca algún tipo de violencia. -Educar a la persona para disminuir la violencia y sus consecuencias. -Brindar acompañamiento, apoyo y seguimiento biopsicosocio-espiritual mediante un enfoque holístico y, el autocuidado de la persona, según sea necesario. -Abogar por el derecho de la persona a la autodeterminación, a la toma de su propia decisión, basada en recomendaciones de tratamiento.	-Número de personas que reporten mejoría en su salud emocional. -Número de informes sociales realizados. -Número de vistas realizadas. -Número de víctimas atendidas y protegidas. -Número de perpetradores/as de la violencia remitidos a las instancias legales y/o de tratamiento correspondientes. -Número de cursos, talleres, conversatorios educativos realizados. -Número de personas atendidas. -Número de personas y sus familias que asumieron estilos de vida saludables. -Número de personas que participan en los grupos socio-terapéuticos. -Plan socio terapéutico. -Monitoreo del Plan socio terapéutico. -Informe de cumplimiento de actividades.	

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Personas				-Identificar las potencialidades de las personas en la prevención de enfermedades y el autocuidado. -Fortalecer las capacidades de las personas en la prevención de la enfermedad y el autocuidado. -Educar y promocionar la salud de la persona. -Orientar a la persona en técnicas de manejo del estrés. -Brindar atención personalizada y confidencial, adaptando las intervenciones a las características y necesidades de cada persona. -Promover en las personas y sus familias estilos de vida saludables. -Facilitar la creación de redes de apoyo. -Crear grupos socio-terapéuticos. -Identificación de causas de incumplimiento de tratamiento o falta de adhesión a su plan de prevención. -Diseñar y ejecutar plan socio terapéutico en los casos identificados. -Remitir a otra disciplina cuando sea necesario. Elaborar informe de nivel de cumplimiento y enviar para su análisis a la coordinación de APS		
Familias y pequeños grupos.	Realizar una evaluación de la dinámica de la familia y pequeños grupos existentes, para identificar factores de riesgo y de protección en sus entornos, con respecto a la salud.	-Fortalecer la cohesión familiar y pequeños grupos. -Investigar sobre la dinámica familiar y pequeños grupos, su situación socio-económica-cultural.	-Lograr en un 80% la cohesión y el apoyo entre los miembros de la familia. -Reducir los factores de riesgo social en al menos un 20%.	-Investigar sobre la dinámica familiar, la situación socio-económica, psico-social y redes de apoyo de la familia, pequeños grupos y el entorno, que inciden en el proceso salud-enfermedad. -Analizar la dinámica familiar, la situación económica, y las redes de apoyo del entorno de la familia y pequeños grupos. -Detectar factores de riesgo y de protección en el entorno familiar. -Prevenir factores de riesgo en familiares de usuarios con problemática de salud mental específicamente.	-Número de familias o grupos que manifiestan satisfacción familiar (Encuestas de satisfacción familiar). -Número de personas con situaciones de salud mental atendidas. -Número de familias y grupos que manifiestan cohesión familiar y apoyo mutuo (Encuestas de cohesión familiar).	

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Familias y pequeños grupos.		-Mejorar la cohesión y el apoyo entre los miembros de la familia. -Fomentar una estructura familiar que transite y se adapte positivamente a situaciones de salud o crisis. -Promover la resiliencia y el apoyo mutuo en la familia y pequeños grupos. -Reducir los factores de riesgo social en el entorno familiar.		-Orientar y fortalecer los vínculos que permitan la unidad familiar y capacitar a sus miembros para que aseguren la salud. -Realizar visitas domiciliarias para observar y evaluar la dinámica familiar y de grupos. -Precisar la variedad de las diferentes etnias (Barí, Wayuu, Añú, Yukpa, Japrerí), creencias culturales, prácticas y valores que caracterizan el sistema familiar y pequeños grupos. -Identificar factores de riesgo y recursos protectores en la familia y pequeños grupos. -Involucrar a todos los miembros de la familia en las actividades de prevención de la salud. -Promover la participación activa de los miembros de la familia y grupos para asegurar la efectividad de las intervenciones. -Facilitar estrategias de comunicación y actividades de apoyo mutuo adaptadas a las necesidades de la familia y grupos. -Elaborar planes de tratamiento conjuntamente con la persona, la familia y el equipo interdisciplinario para resolver la situación de salud. -Orientar a las personas, familias y pequeños grupos estilos de vida saludables. -Identificar las fortalezas de las familias y pequeños grupos para desarrollar estilos de vida saludables. -Desarrollar terapia socio familiar cuando se identifique su necesidad en cuanto al ámbito de salud física o mental.	-Número de familias y grupos participantes. -Número de talleres y atención familiar y grupal. -Número de planes conjuntos de tratamiento. -Lista de las fortalezas. -Número de personas atendidas.	
	Realizar una evaluación de la dinámica de la familia y pequeños grupos existentes, para identificar factores de riesgo y de protección en sus entornos, con respecto a la salud.					

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Comunidades		-Promocionar la salud, prevención de las enfermedades y la participación de los miembros de la comunidad. -Fortalecer el nivel de atención primaria, su integración en la comunidad, red de servicios y su integración en la comunidad. -Promocionar la salud y la prevención de enfermedades. -Fortalecer la participación comunitaria en el ámbito de la salud. -Mejorar el capital social de la comunidad. -Realizar investigaciones sobre las características socio-económicas y culturales los miembros de la comunidad y la dinámica social de ésta.	-Realizar al menos 6 campañas de promoción de salud comunitaria cada año. -Establecer contacto con al menos el 50% de los líderes comunitarios. -Lograr la participación de al menos el 50% de los miembros de la comunidad y organizaciones de la comunidad. -Realizar al menos 4 talleres sobre prácticas saludables en mes. -Elaborar y ejecutar al menos 2 proyectos de investigación en el año.	-Organizar campañas de promoción, prevención y participación de la comunidad en el ámbito de la atención primaria de la salud, en los espacios públicos de la comunidad. -Identificar a los líderes comunitarios para incorporarlos a la promoción de la salud. -Identificar las necesidades específicas de salud en los miembros de la comunidad coordinando esfuerzos de intervención. -Identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud de los miembros de la comunidad. -Fortalecer la participación de los miembros de la comunidad en el desarrollo de acciones de promoción, prevención, protección, conservación y recuperación de la salud, basada en sus necesidades. -Valorar riesgos, identificar problemas y priorizar las intervenciones. -Movilizar y empoderar a los miembros de la comunidad. -Trabajar con líderes comunitarios en el fortalecimiento de la atención primaria en salud, en la comunidad. -Fomentar la participación de los miembros de la comunidad en el ámbito de salud. -Asegurar a los miembros de la comunidad, el acceso equitativo a los servicios de salud. -Realizar talleres y eventos de sensibilización sobre prácticas saludables y prevención de enfermedades. -Fomentar un entorno saludable y una cohesión social inclusiva en la comunidad.	-Número de campañas de promoción realizadas. -Informe de resultados. -Porcentaje de líderes de la comunidad involucrados. -Número de casos gestionados. -Personas y usuarios asesorados. -Informe de necesidades y problemas de salud (encuesta). -Número de recursos y servicios brindados. -Guía actualizada de Recursos Sociales y de Salud de la Localidad (GRSL). -Talleres, seminarios educativos realizados. -Programas de mejoramiento de la salud. -Número de campañas educativas realizadas. -Lista de factores de riesgo o de violencia. -Banco de datos de los recursos comunitarios disponibles. -Número de voluntarios formados. -Equipo de TS y profesionales de salud informados sobre los recursos existentes en la localidad. -Personas y usuarios asesorados. -Articulación con las instituciones. -Número de proyectos de investigación en el año	
	Realizar una evaluación participativa con la comunidad para identificar factores de riesgo y barreras en el acceso a servicios de salud.					

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Comunidades				-Promover entornos saludables y seguros que faciliten el bienestar a los miembros de la comunidad. -Impulsar la inclusión social y la equidad en el acceso a servicios de salud. -Detectar y priorizar las necesidades y situaciones problemas de salud de los miembros de la comunidad. -Identificar factores de violencia o riesgo que puedan presentarse en la comunidad. -Educar a los miembros de las comunidades para disminuir la violencia y sus consecuencias. -Analizar la información de oferta y demanda de servicios de salud del área de influencia que permita proponer alternativas de atención a situaciones de salud. -Monitorear y evaluar los programas diseñados y ejecutados por el equipo de Trabajadores Sociales y los realizados conjuntamente con las demás unidades funcionales del Programa de Atención Primaria de Salud. -Planear, programar, ejecutar y evaluar procesos e intervenciones sociales y organizar el quehacer profesional en tiempos y movimientos planificados. -Gestionar y coordinar intra y extra institucionalmente recursos de diverso orden a fin de responder a los objetivos de trabajo. -Identificar los recursos disponibles, priorizar las intervenciones. -Organizar la comunidad. -Formar y capacitar voluntarios y auxiliares para ejecutar acciones de salud. -Identificar redes sociales.		
	Realizar una evaluación participativa con la comunidad para identificar factores de riesgo y barreras en el acceso a servicios de salud.					

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Comunidades.	Realizar una evaluación participativa con la comunidad para identificar factores de riesgo y barreras en el acceso a servicios de salud.			-Educar a los miembros de la comunidad, para la salud. -Elaborar programas orientados a mejorar la salud de los miembros de la comunidad. -Elevar las capacidades y habilidades personales para el fomento del autocuidado de los miembros de la comunidad. -Fomentar las redes y grupos sociales que sean referentes de actitudes, valores y conductas positivas promotoras de salud. -Orientar y capacitar a los miembros de la comunidad sobre el uso de recursos institucionales y o comunitarios que puedan contribuir a que los individuos alcancen mejor calidad de vida. -Participar con el equipo interdisciplinario en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población de la comunidad. -Brindar aportes en la solución de problemas de salud de los miembros de la comunidad, a partir de las investigaciones. -Estudiar las variables socioeconómicas y culturales que inciden en la salud de los miembros de la comunidad atendida y sus consecuencias sociales. -Plantear temas de sondeo, exploración e investigación referentes a aspectos sociales económicos y culturales asociados a condiciones específicas de salud.		

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
- Grupos de especial vulnerabilidad por dependencia funcional y pérdida de autonomía: *Personas Mayores: independientes funcionalmente, con riesgo de aumento de dependencia funcional o deterioro cognitivo. *Personas Mayores dependientes funcionalmente o con demencia. *Enfermos mentales y sus familias. *Personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y múltiple. *Personas con patologías crónicas invalidantes o con estigma social (VIH, TBC, drogadicción, esclerosis múltiple, alcoholismo, etc). - Grupos de especial vulnerabilidad por su situación social: *Mujeres en situaciones de conflicto o desventaja social. *Víctimas de violencia doméstica. *Niños, niñas y adolescentes en situación de pre-riesgo y riesgo social. *Población inmigrante. *Población joven y adulta en exclusión social extrema, que presentan problemas de salud. *Personas de la comunidad LGBT.	- Personas o usuarios en los que presentan necesidades de salud y sociales, debido a los cambios sociales, políticos, entre otros, que no son atendidas por los servicios de salud. - Complejidad y crisis de la red de servicios públicos, privados y la diversificación de los tipos de servicios de salud. - Necesidad de coordinación entre los profesionales de APS y los profesionales de Trabajo Social, para establecer canales entre las instituciones y técnicos que intervienen en la atención de las personas o comunidad para realizarlo de manera integral e integradora.	- Brindar atención integral a las necesidades sociales y sanitarias que se presentan simultáneamente en las personas de la comunidad, brindando protección y atención a la salud de estos. - Articular la actuación de los sistemas de salud y los sociales: instituciones de ámbito social y sanitario que intervienen con los usuarios con necesidades sociales y sanitarias	- Atender 70% de personas que requieren de servicios sociales y de salud. - Establecer coordinación social y de salud para atender los casos de las personas o usuarios con necesidades sociales y de salud. - Lograr la participación de la población vulnerable en programas de atención primaria de salud..	- Gestionar los casos: valoración social. - Plan de intervención. - Determinación de recursos y servicios a los que se puede acceder. - Coordinar con el Equipo de APS, relaciones con distintas entidades e instituciones de la comunidad. - Actualizar las características e información de los distintos recursos sociales, las formas de acceso y los profesionales en APS. (Programa de Orientación de casos). - Conocer y analizar la dinámica, coordinación de los recursos existentes y, las redes o relaciones existentes en el ámbito local. - Diseñar estrategias para la coordinación socio-sanitaria, teniendo como base el trabajo con el equipo de AP. Tomando en cuenta las prioridades del Servicio de la Salud. Estrategias: *Inclusión en sesiones de formación del equipo. *Creación de comisiones socio-sanitarias o grupos de trabajo. *Coordinar, tomando en cuenta aquellos grupos de población que deben verse beneficiados según las necesidades de Salud y las prioridades. *Organizar y ejecutar actividades y estrategias que permitan trabajar de manera conjunta con otras entidades de la zona. *Evaluar el proceso de actuación: reflexión-acción-cumplimiento de objetivos, mediante instrumentos de registro de indicadores de evaluación necesarios.	- Número de casos gestionados. - Número de recursos y servicios brindados. - Guía actualizada de Recursos Sociales y de salud de la localidad. - Equipo de TS y profesionales de salud informados sobre los recursos existentes en la localidad. - Personas y usuarios asesorados. - Articulación con las instituciones	

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
-Personas cuidadoras informales en salud. -Personas cuidadoras de personas con dependencia.	Personas cuidadores informales que presentan necesidad de intervención social y de salud.	-Brindar atención a las necesidades sociales y de salud mediante programas de intervención. -Mejorar la calidad de vida e incremento del bienestar de las personas cuidadoras de personas con dependencia.		-Elaborar programas de intervención dirigidos a los cuidadores informales. -Talleres para mejorar las competencias como cuidadores informales. -Identificar las fortalezas y debilidades de la función cuidadora, el riesgo de descuido del cuidador, la depresión, el aislamiento y otros signos paralizantes. -Brindar un espacio donde las personas cuidadoras compartan experiencias con otras personas en situaciones similares. -Brindar herramientas útiles para disminuir sus malestares, dificultades y conflictos.	-Número de programas diseñados y ejecutados. -Número de talleres realizados.	
Personas que forman parte del programa APS que luego de su diagnóstico integral y plan de abordaje, se detecte incumplimiento al tratamiento o falta de adhesión a su plan preventivo	-Personas que forman parte del programa APS que luego de su diagnóstico integral y plan de abordaje, se detecte incumplimiento al tratamiento o falta de adhesión a su plan preventivo -Personas que forman parte del programa de APS que han recibido algún servicio de manera permanente posterior al primer año de ejecución.	-Identificar las causas de incumplimiento o adhesión al tratamiento o a su plan de salud. -Elaborar un plan de re-direccionamiento. -Establecer un programa de monitoreo sobre el nivel de satisfacción de los usuarios en los servicios recibidos a nivel de la atención primaria. -Diagnosticar las necesidades de formación y atención del personal que forma parte del programa APS -Desarrollar ciclos de charlas y talleres mensuales de formación, manejo del estrés y otros aspectos de interés.	-Lograr que el 80% de las personas identificadas cumplan con su plan integral de salud. -Lograr que la exclusión de personas del programa de APS no supere el 10% del total de la población atendida. -Mantener un nivel de atención satisfactorio alrededor del 75% de los usuarios del servicio recibido en el programa APS. -Lista de necesidades de formación y atención	-Realizar entrevista personal y familiar. -Realizar informe social. -Discutir el caso multidisciplinariamente. -Elaborar plan de re-direccionamiento. -Hacer seguimiento. -Tomar decisión sobre la permanencia o no en el programa. -Diseño de Instrumentos. -Aplicación de instrumentos. -Análisis y discusión con el equipo de salud los resultados. -Elaboración de informe ejecutivos. -Tomar medidas de ajuste necesarios. Encuesta de necesidades. -Charlas de mejoramiento personal y profesional.	-Número de casos identificados -Número de casos abordados -Número de casos reincorporados a su plan. -Nivel de cumplimiento de adhesión al tratamiento. -Nivel de cumplimiento de su plan de salud. -Niveles de satisfacción de usuarios del servicio de APS. -Número de charlas y talleres. -Número de participantes al ciclo de charlas y talleres.	

Elaboración propia con base en las referencias 101-105.

8.25-. Programa de atención primaria en salud del P.A.A.I.S. Plan rehabilitación y prevención secundaria

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Personas con enfermedades cardiovasculares.	Diagnóstico confirmado de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca.	Reducir la incidencia de eventos cardiovasculares secundarios y mejorar la calidad de vida.	Disminuir en un 20% la tasa de hospitalización por eventos cardiovasculares en 5 años.	-Implementar programas de rehabilitación cardíaca. -Promover la actividad física supervisada. -Educación en hábitos de vida saludables.	-Número de pacientes que completan programas de rehabilitación. -Tasa de reingreso hospitalario por eventos cardiovasculares.	Integrar estos programas en el sistema de salud pública para garantizar el acceso universal.
Personas con diabetes mellitus.	Diagnóstico de diabetes tipo 1 o 2	Prevenir complicaciones discapacitantes como neuropatías, retinopatías y amputaciones.	Reducir en un 15% la incidencia de complicaciones mayores en 5 años.	-Educación en autocontrol de la glucemia. -Programas de ejercicio físico adaptado. -Monitoreo regular de complicaciones.	-Porcentaje de pacientes con niveles de HbA1c dentro de rangos óptimos. -Número de amputaciones relacionadas con diabetes.	Fomentar la participación activa de los pacientes en su autocuidado.
Personas con accidentes cerebrovasculares (ACV).	Historia clínica de ACV isquémico o hemorrágico.	Mejorar la funcionalidad y prevenir recurrencias.	Aumentar en un 25% la independencia funcional de los pacientes en 3 años.	-Terapias de rehabilitación multidisciplinarias. -Control estricto de factores de riesgo (hipertensión, diabetes). -Educación en prevención secundaria.	-Escala de funcionalidad (ej. Barthel). -Tasa de recurrencia de ACV.	Necesidad de equipos multidisciplinarios especializados.

Población objeto	Criterios diagnósticos	Objetivos	Metas	Actividades	Indicadores	Observaciones
Personas con lesiones medulares.	Lesión traumática o no traumática de la médula espinal.	Maximizar la independencia y prevenir complicaciones secundarias.	Lograr que el 50% de los pacientes retomen actividades laborales o educativas en 5 años.	-Programas de rehabilitación integral. -Adaptación del entorno y ayudas técnicas. -Apoyo psicológico y social.	-Porcentaje de reinserción laboral o educativa. -Incidencia de complicaciones como úlceras por presión.	Importancia de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Personas con enfermedades respiratorias crónicas.	Diagnóstico de EPOC, asma severa o fibrosis pulmonar.	Mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida.	Reducir en un 10% las hospitalizaciones por exacerbaciones en 3 años.	-Programas de rehabilitación pulmonar. -Educación en manejo de dispositivos inhalatorios. -Entrenamiento en técnicas de respiración.	-Número de hospitalizaciones por exacerbaciones. -Mejoría en pruebas de función pulmonar.	Integrar programas en atención primaria para mayor alcance.
Personas con enfermedades reumáticas crónicas.	Diagnóstico de artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico u otras.	Mantener la movilidad y prevenir deformidades.	Disminuir en un 15% la progresión de la discapacidad en 5 años.	-Terapias físicas y ocupacionales. -Educación en protección articular. -Acceso a tratamientos farmacológicos adecuados.	-Evaluaciones periódicas de movilidad articular. -Calidad de vida reportada por el paciente.	Necesidad de acceso a medicamentos de alto costo.
Personas con discapacidades auditivas y visuales.	Diagnóstico de pérdida auditiva o visual significativa.	Facilitar la integración social y laboral.	Aumentar en un 30% el uso de ayudas técnicas adecuadas en 4 años.	-Programas de detección temprana. -Provisión de audífonos, lentes y otros dispositivos. -Capacitación en habilidades de comunicación.	-Número de dispositivos entregados. -Nivel de satisfacción del usuario con las ayudas técnicas.	Importancia de campañas de sensibilización y eliminación de estigmas.

Referencias bibliográficas: 142-144.

Bibliografía (Anexo 8)

1. World Health Organization. Service Availability and Readiness Assessment (SARA). Reference Manual. Ginebra: WHO; 2014 [citado 11 abr 2025]. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-HSI-2014.5-Rev.1>

2. Ministerio del Poder Popular para la Salud (Venezuela). Fundamentos de las normas de los programas de salud [Internet]. Caracas: MPPS, Viceministerio de Redes de Salud Colectiva; 2012 [citado 9 mar 2026]. Disponible en: <https://mpps.gob.ve/viceministerio-de-salud-colectiva/>

3. Álvarez Sintés R. Temas de Medicina General Integral. Vol. I, Salud y Medicina [Internet]. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2001 [citado 9 mar 2026]. Disponible en: https://files.sld.cu/santiagonavas/files/2012/03/medicina_gral_tomo1.pdf

4. Ministerio del Poder Popular para la Salud (Venezuela). Guía de Programas de Salud, priorizados para el equipo básico de salud, en la red de atención comunal [Internet]. Caracas: MPPS; 2017 [citado 9 mar 2026]. Disponible en: https://campus.paho.org/sites/default/files/guia_practica_racs_17_10_17-5.pdf

5. Ministerio de Salud (Venezuela). Programa de Salud Pública en Venezuela [Internet]. Caracas: MPPS; 2010 [citado 9 mar 2026]. Disponible en: <https://joelcaraballo.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/08/presentacion3b3n-sobre-programas-de-salud-en-venezuela.pdf>

6. IMSS-Bienestar. SIESABI, Sistema Educativo de Salud para el Bienestar: Cursos virtuales [Internet]. Chile: SIESABI; 2024 [citado 9 mar 2026]. Disponible en: <https://educacion.imssbienestar.gob.mx/siesabi-aulavirtual/>

7. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). Manual para la protección de grupos vulnerables en emergencias humanitarias. Disponible en: <https://www.who.int>

8. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2022). Directrices para la atención de personas refugiadas y desplazadas internas. Disponible en: <https://www.unhcr.org>

9. Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), República Bolivariana de Venezuela. (2023). Plan Nacional para la Protección de Grupos Vulnerables. Caracas, Venezuela.

10. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2021). Protección de niños y niñas en situaciones de crisis y emergencia. Disponible en: <https://www.unicef.org>.

11. Naciones Unidas (ONU). (2022). Marco de Asistencia para la Protección de Grupos Vulnerables en América Latina y el Caribe. Disponible en: <https://www.un.org>.

12. Organización Mundial de la Salud. (2021). "Salmonella (no tifoidea)". Recuperado de [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/salmonella-\(non-typhoidal\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/salmonella-(non-typhoidal)).

13. Organización Mundial de la Salud. (2021). "Brucelosis". Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/brucellosis>

14. Organización Mundial de la Salud. (2021). "Hepatitis B". <https://www.paho.org/es/temas/hepatitis>

15. Organización Mundial de la Salud. (2017). "Enfermedades diarreicas". Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>

16. Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. (2019). "Plan Nacional de Salud 2019-2025". Recuperado de <http://www.mpps.gob.ve/>.

17. Organización Mundial de la Salud. "Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema de salud pública". 2020. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014107>.

18. Organización Panamericana de la Salud. "Plan de acción sobre la prevención y el control del cáncer cervicouterino 2018-2030". 2018. <https://www.paho.org/es/documentos/plan-accion-sobre-prevencion-control-cancer-cervicouterino-2018-2030-0>

19. Ministerio del Poder Popular para la Salud. "Programa Nacional de Oncología". 2016. <https://www.paho.org/es/noticias/2-12-2016-ministerio-salud-apuesta-por-atencion-integral-oncologica-venezuela>

20. Organización Mundial de la Salud. (2021). Control y prevención de zoonosis: Estrategias para prevenir enfermedades zoonóticas transmisibles. Recuperado de sitio web de la OMS. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses>

Programa Autogestionado de Atención Integral de Salud (P.A.A.I.S.)

21. Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela. (2022). Programa nacional de control de zoonosis.
22. Organización Mundial de la Salud. (2018). "Informe mundial sobre prevención de las lesiones causadas por el tránsito". Recuperado de https://www.who.int/violence_injury
23. Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. (1998). "Norma Oficial Venezolana del Programa de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos". Recuperado de <https://es.slideshare.net/slideshow/norma-oficial-venezolana-del-programa-prevencion-de-accidentes-y-hechos-violentos-del-ministerio-de-sanidad-y-asistencia-social-1998/21217348>
24. Organización Panamericana de la Salud. (2022). "Informe País Venezuela 2022". Recuperado de <https://www.paho.org/es/documentos/informe-pais-venezuela-2022>
25. Organización Mundial de la Salud. (2017). "Protección de la salud de los trabajadores". Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/protecting-workers'-health>
26. Organización Panamericana de la Salud. (2015). "Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores 2015-2025". Recuperado de <https://www.paho.org/es/documentos/plan-accion-sobre-salud-trabajadores-2015-2025>
27. Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. (2019). "Normas Técnicas de Salud Ocupacional". Recuperado de <http://www.mpps.gob.ve/>.
28. Organización Mundial de la Salud. "Enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana)". [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-\(ameri](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(ameri) can-trypanosomiasis).
29. Organización Mundial de la Salud. "Dengue y dengue grave". <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>.
30. Organización Mundial de la Salud. "Paludismo". <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malaria>.
31. Organización Mundial de la Salud. "Toxoplasmosis". <https://www.who.int/es/health-topics/toxoplasmosis>.
32. Ministerio del Poder Popular para la Salud. "Plan Nacional de Salud 2014-2019". <https://es.slideshare.net/slideshow/plan-nacional-de-salud-2014-2019/23062014/48707734>.
33. Organización Mundial de la Salud. "La OMS publica el primer informe mundial sobre prevención y control de infecciones". 6 de mayo de 2022.
34. <https://www.who.int/es/news/item/06-05-2022-who-launches-first-ever-global-report-on-infection-prevention-and-control>
35. Organización Mundial de la Salud. "Orientaciones técnicas sobre la COVID-19". https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO_2019-nCoV_surveillance_variants
36. Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2021). Reporte de Medio Ambiente y Salud Pública. ONU Medio Ambiente. Recuperado de ONU Medio Ambiente. <https://www.unep.org/es/resources/informe-anual-de-2021>
37. Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. (2022). Lineamientos y políticas en salud ambiental. República Bolivariana de Venezuela. <https://mpps.gob.ve/mpps-mantiene-activos-programas-de-salud-ambiental-en-el-pais/>
38. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). Salud ambiental: estrategia global para mejorar la salud pública mediante la gestión ambiental. OMS. https://www.who.int/es/health-topics/environmental-health#tab=tab_1
39. Organización Mundial de la Salud. (2022). Guía para la atención de los trastornos del neurodesarrollo en servicios de salud. OMS. <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/dcf73611-9e0f-4d5c-85f6-85a58b0da6de/content>
40. Ministerio del Poder Popular para la Salud, República Bolivariana de Venezuela. (2021). Plan Nacional de Salud Mental y Prevención de los Trastornos Neuropsiquiátricos. <https://mpps.gob.ve/salud-mental-que-es-y-por-que-es-importante/>
41. American Psychiatric Association. (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-5. <https://www.federaciocatalanatdah.org/wp-content/uploads/2018/12/dsm5-manualdiagnosticoestadisticodelostrastornosmentales-161006005112.pdf>
42. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Improving the Prevention, Diagnosis and Clinical Management of Sepsis. Ginebra: OMS. <https://www.who.int/activities/improving-the-prevention-diagnosis-and-clinical-management-of-sepsis>
43. Foro Mundial de la Sepsis. (2017). Sepsis 2020: Prevention, Diagnosis, and Clinical Management of Sepsis. <https://sepsisforum.org/activities/>
44. U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF). (2020). USPSTF Screening Guidelines and Recommendations. Disponible en <https://www.uspreventiveservice-staskforce.org/uspstf/home>
45. Organización Mundial de la Salud. "Rehabilitación en los sistemas de salud: guía de acción". 2019. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241515986>
46. Organización Panamericana de la Salud. "Rehabilitación". Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/rehabilitacion>
47. Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. "Plan Nacional de Salud de Venezuela. II Edición". Disponible en: <https://www.academia.edu/38827678/PLAN>

El Programa de Atención Primaria en Salud (APS) del Sistema Local de Salud del Hospital de la Misericordia "Dr. Gustavo Pineda" constituye uno de los cinco componentes del Proyecto Autogestionado de Atención Integral de Salud (P.A.A.I.S.), el cual comprende cinco programas: APS, Atención Pre Hospitalaria y Traslado de Pacientes, Atención Hospitalaria, Rehabilitación-Prevención Secundaria y Cuidados Paliativos. Su elaboración ha estado a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales comprometidos con una visión integradora de la salud, centrada en el ser humano y orientada por el principio del derecho universal a una atención digna, equitativa y continua.

Este programa asume la APS como la estrategia central para organizar los servicios de salud en torno al primer nivel de atención, garantizando accesibilidad, resolutivez y participación comunitaria. En tal sentido, se inspira en los postulados de Keer White, que resaltan la racionalidad en la distribución del esfuerzo sanitario, así como en el modelo de niveles de prevención desarrollado por Leavell y Clark, que amplía la mirada del sistema más allá de lo asistencial, hacia lo promocional y lo preventivo.

El programa se estructura en torno a los cinco niveles de prevención: la promoción de la salud y la protección específica e inespecífica, de modo de fortalecer las capacidades individuales y colectivas para el autocuidado y la prevención de enfermedades; la detección precoz y tratamiento oportuno, a los efectos de interrumpir tempranamente el curso natural de las patologías; la limitación del daño, mediante intervenciones terapéuticas eficaces y seguras y la rehabilitación integral, para favorecer la recuperación funcional y la reinserción social de las personas afectadas.

Bajo esta perspectiva, el programa se estructura en torno a los cinco niveles de prevención: la promoción de la salud y la protección específica e inespecífica, de modo de fortalecer las capacidades individuales y colectivas para el autocuidado y la prevención de enfermedades; la detección precoz y tratamiento oportuno, a los efectos de interrumpir tempranamente el curso natural de las patologías; la limitación del daño, mediante intervenciones terapéuticas eficaces y seguras y la rehabilitación integral, para favorecer la recuperación funcional y la reinserción social de las personas afectadas.

Se agregan los cuidados paliativos a los fines de ampliar la atención integral más allá de los parámetros actuales, incluyendo aquellas situaciones en las cuales la medicina no puede ofrecer opciones curativas y se demanda minimizar el sufrimiento y permitir una muerte digna.

La implementación del programa prioriza acciones comunitarias, intersectoriales y participativas, con énfasis en la atención domiciliaria, la educación para la salud, la vigilancia epidemiológica activa y la articulación con redes sociales e institucionales. Se busca así construir una APS resolutive, centrada en las personas, culturalmente pertinente, adaptada a las realidades de cada territorio, y garantizar todos los principios de la práctica sanitaria, especialmente el de la universalidad.

En resumen, este documento representa una apuesta concreta por un modelo de salud orientado a la equidad, la eficiencia y la prevención, en el marco de un sistema sanitario que reconozca a la atención primaria como puerta de entrada, eje articulador y garante de continuidad en el cuidado integral de la salud de la población.